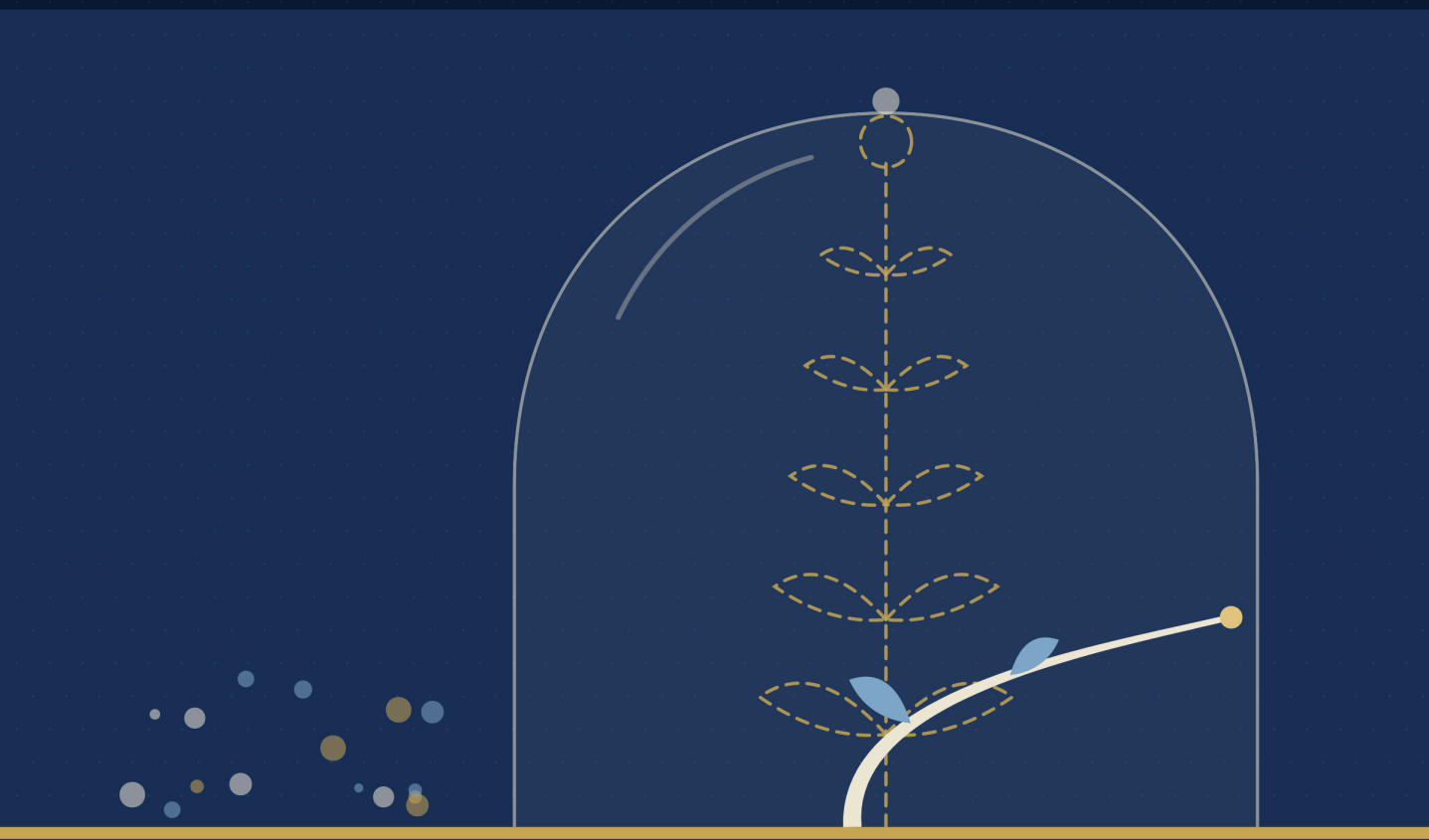
SDE UNIVERSES
德麦国际专著 · 第 538 号

被照顾得很好之后

精准的善意怎样替生命先定了答案



陈晓艳 著

德麦国际出版社
Demai International Press

德麦国际专著 · 第 538 号

被照顾得很好之后

精准的善意怎样替生命先定了答案

陈晓艳　著

德麦国际出版社
Demai International Press · Singapore

出　版　信　息

书名	《被照顾得很好之后》
副题	精准的善意怎样替生命先定了答案
英文书名	After Being Well Cared For: How Precise Kindness Settles Life's Answers in Advance
著者	陈晓艳
出版	德麦国际出版社（Demai International Press）· 新加坡
编号	德麦国际专著第 538 号
ISBN	979-8-90690-989-3
定价	US$20.00
开本	170 mm × 240 mm
字数	约 20 万字（前言、导论、编序、九章与结语正文 195,753 个汉字；附录另计）
版次	2026 年 11 月第 1 版

成书说明：本书是研究性专著初版，由作者在 SDE Universes 学员专栏发表的九篇论文与一篇实践手册熔铸而成。全书母题在王德生老师指导下从作者的论文中归纳而出、由作者认定；正文由 AI（Claude）协作撰写，十路执笔者分章写成，再经三审统稿回改。同一底座的执笔者与审校者不能互作独立证据；本书没有经过独立学术评审。

书中养老机构与诊室里的人物和情节，或为作者田野观察经匿名与合成处理的材料，或为原论文为说明论证而设的构造性案例，各章已逐一标明，不指认任何真实的机构和个人；本书不报告任何调查数字。各章的证伪条件都写成了可观察的情形，均未经执行。全书结构：前言；导论；三编九章；结语；附录；版本说明。

版权所有　侵权必究

精准的善意抢先替生命定下“好”的样子；替得越久，生命越长不出自己的答案。

——全书母题

作者介绍

陈晓艳，生物学博士，高级健康管理师，大学教师；王德生博士终身学员，系统研修三视角理论与 SDE 发生学，把生成性的生命观带进健康管理、教育教学与科研实践。她在 SDE　Universes 学员专栏发表论文一百九十余篇，此前著有德麦国际专著第 65 号《家庭教育的智慧》、第 75 号《空白不是零》、第 208 号《陈晓艳讲海德格尔：普通人也能明白》、第 523 号《陈晓艳谈「懂」》等。

王德生，博士，SIO 本体论与 SDE 发生学的创立者，新加坡德麦国际创始人。早年在湘潭大学、中国科学院学习与研究计算数学，后任新加坡南洋理工大学数学系教员；2015 年起推广三视角方法论，2024 年提出 SIO 本体论与意义三律，后凝练为 SDE 发生学。本书由他指导。

成书说明

这是一本研究性专著的初版，请按它实际做到的范围来读。

从哪里来。本书的底子是作者 2026 年 7 月在学员专栏发表的九篇论文：养老照护三篇（请别替我活完这一生、被照料得很好的空无、被捧起的灰），“精准医疗与慢病发生学”中的六篇（听到海底、身体的叙事失权、发生权代管、逆火、纠缠的代价、溃散后何以为序），以及实践手册《养护身体的暗能力》（改写为附录）。这本书把它们拆开、重写、重新排列，按“看不见—抢先替定—长不出”三步组织起来。全书母题“精准的善意抢先替生命定下‘好’的样子；替得越久，生命越长不出自己的答案”不在任何一篇旧作里，是九篇合起来以后得出的判断，由这本书自己负责；结语中“各章之间的张力”一节是新写的。

谁写的。母题在王德生老师指导下归纳、由作者认定；正文由十路 AI 执笔者按总纲分章写成，一审、二审逐章进行，三审与统稿由统稿的一路完成。写作与审校用的是同一个底座，能查出前后矛盾，查不出共有的盲点。

哪些做过检验，哪些没有。各章都写了本章的证伪条件，导论写了全书层面的证伪条件，都是可以观察的情形，但都还没有执行。原论文中未给出处的统计数字与说法，书中照原文转述并在相应处说明，没有替它补出处；各章参考文献取自原论文所列书目。

正文字数。前言、导论、编序、九章与结语的正文实计 195,753 个汉字；章题、节题、表格、参考文献与附录不计入。

前言

本书由陈晓艳于二〇二六年七月发表在 SDE　Universes 学员专栏的九篇论文熔铸而成：养老照护三篇（《请别替我活完这一生》《被照料得很好的空无》《被捧起的灰》），以及“精准医疗与慢病发生学”频道中的六篇（《听到海底》《身体的叙事失权》《发生权代管》《逆火》《纠缠的代价》《溃散后，何以为序？》）。附录取材于同期发表的实践手册《养护身体的暗能力》。九篇论文原本各自成篇，分别讨论养老机构、智慧养老、临床指南、基因检测、靶向治疗与慢性病管理中的具体困境；放在一起读，它们指向同一个判断，本书把它压成一句话作为全书的脊梁：精准的善意抢先替生命定下“好”的样子；替得越久，生命越长不出自己的答案。

全书据此分为三编。第一编“看不见”，讨论照护与医疗系统为什么越精准、越周到，越看不见生命自己正在给出的答案；第二编“抢先替定”，讨论看不见之后，系统怎样在叙事、决定权与判断三个层次上先替生命写好答案；第三编“替得越久”，讨论替定为何注定落空、健康的判准能否交还给生命自己，以及当一个人什么都长不出来时，照护最后要守住的是什么。全书以养老开篇，以养老收尾，中间是医疗；读者可以看到，老人与病人处在同一种处境里。

关于材料，需要预先说明两点。其一，书中引用的养老机构与诊室中的人物和情节，有的出自作者的田野观察，经过匿名与合成处理；有的是原论文为说明论证而设的构造性案例。各章在使用时已逐一标明，它们服务于理论建构，不构成系统性的实证数据。其二，书中转引的统计数字与临床研究均沿用原论文的表述，凡原文未给出处者，本书未予补出，留待后续核验。

本书的写作得到王德生老师的指导，谨此致谢。

导论

被照顾得很好之后

◆ 一、两个场景

先从一条走廊的尽头说起。在一家养老机构里，一位老人每天下午坐在固定的位置上，望向窗外。护理员走过去，轻声问：“您需要什么吗？要不要喝水？要不要我陪您去走走？”老人摇摇头，目光收回来，说：“没事。”这两个字一出口，就在护理员当天的服务记录表上闭合成一个无事件的空白。没有人做错任何事：问话是周到的，记录是合规的，老人的血压、三餐与用药也都在范围之内。可是在那个瞬间里，老人为什么偏偏坐在这个窗口而不是另一个窗口，他望出去时身体忽然往前探了一下又缩回来，这个动作里有没有他正在触及、却连自己也说不清的某个东西，都随着“没事”两个字一起被咽了下去。护理员隐约觉得哪里不对，却没有语言可以装下这种感觉，表格上也没有一个字段可以填写。交接班时她没有提起，因为没有任何指标被触发。

这一幕在更精细的照护系统里会变得更加清晰。再看一座配备全套智能设备的养老社区。本书所据的论文记录过这样一位老人：七十八岁，退休小学教师，入住五年。起初她对新环境充满新鲜感，手环让她觉得“有人时刻关心着自己”，音箱每天推送的戏曲选段让她惊喜，系统依据她的步态分析推荐了太极班，她也乐意去。大约一年后，她的日子形成了一套完全由系统配置的节奏：早上八点，音箱提醒测血压；十点，推送当日活动建议；下午三点，应用弹出用药提醒；晚上七点，依据“情绪波动指数”的轻度升高，推送一份怀旧老歌歌单。一切都在运转，所有功能都正常，她却越来越沉默。她曾想借一本植物图鉴来辨认社区花园里的花草，这个念头从未被系统捕捉到，因为她身上没有“植物学兴

趣”这个标签。护理员发现她常常长时间坐在窗边，什么也不做。被问到近况，她说：“挺好的，什么都不缺。就是……感觉日子像别人替我过的。”（这一案例及本书所引的养老机构材料，取自作者在多家机构的田野观察，人物经过匿名与合成处理，用于理论建构，不构成系统性的实证数据。）田野中另有老人把自己形容为“一件被照顾得很好的展览品，什么都不缺，但什么都跟我没有太大关系”。

第二个场景发生在医院和诊室里。本书第五章以一位类风湿关节炎患者林女士的十二年病程为分析主线。她三十四岁确诊，第一年曾自己记录晨僵时长与疼痛评分，试过严格的无麸质饮食和针刺，发现面食似乎与症状加重相关，而针刺能在几小时内带来有限的缓解。随后风湿科医生严肃地告知，现在不是自己试的时候了，她开始了规范治疗。2012年，她使用生物制剂近一年，疾病活动度评分从6.1降到2.8，达到临床缓解标准，化验单上的炎症指标全部落回正常范围。可是她反复告诉医生，自己“并不觉得好了”：“指标是下来了，但人总是很累，那种累不是关节疼的累，是整个人像被抽空了一样。”医生看了化验单，温和地解释：“指标都很好，可能是你太紧张了。”医生没有说她撒谎，只是把她的感受重新归了类，从一条关于身体状态的信息，变成了一种需要管理的情绪反应。此后她逐渐学会了只汇报晨僵多少分钟这类可以被化验单印证的内容，那些说不清的感觉不再被提交。到2018年的一次随访，她平静地说出了一句话：“那会儿我知道自己哪里不好。现在，我得看化验单才知道自己好不好。”

两个场景相隔很远，一个在养老院的窗前，一个在风湿科的诊室，里面的人却处在同一种处境。老人没有受到虐待，没有被忽视，甚至没有被强迫做任何事；林女士的病被控制得很好，指标漂亮，治疗路径合乎指南。他们的周围都是认真的、有专业能力的、怀着善意的人和系统。然而在两个人身上，有某种东西悄悄不见了：一个人不再能说出自己正在朝哪里走，另一个人不再能说出自己好了没有。本书要回答的就是这个问题：这种丢失是怎样在“照顾得很好”的条件

下发生的。第六章设想了一个更短的瞬间：一位四十二岁的软件工程师（依据公共卫生资料与临床报道构造的复合个案）在每日吞下低剂量药片时手在半空停了一下。他没有被诊断出任何疾病，各项指标都在正常范围，只因一份多基因风险评分把他划入了“高风险者”。那半秒钟的迟疑，与窗前的“没事”和诊室里的“得看化验单”，说的是同一件事。

◆ 二、一个母题：精准的善意与生命的答案

全书的判断可以压成一句话：**精准的善意抢先替生命定下“好”的样子；替得越久，生命越长不出自己的答案**。这句话里有三个词需要先说明。“精准”指的是当代照护与医疗共同的技术理想：用传感器、数据画像、基因检测、指南路径与靶向药物，把每一个人的状态识别得更细、响应得更准。“善意”指的是这套理想背后并无恶意可言，它出自缓解痛苦、预防风险、尊重个体差异的诚恳愿望，并且常常取得了实际的成效。“替定”是本书的总概念，指外部系统抢在生命自己之前，替它定下“好”的样子与抵达的路径。需求清单是一种替定，风险预警是一种替定，指南路径、靶点、数据阈值、标准稳态也都是替定。它们各自出现在不同的层面，下文会逐一展开，但在结构上是同一件事。

替定与通常所说的“剥夺”“强迫”“家长作风”有一个重要的区别。剥夺预设了被剥夺者原有一份东西，强迫预设了被强迫者有一个相反的意愿，家长作风预设了家长与孩子在判断上的落差。这些说法所描述的情形当然存在，也已经被反复批评。本书关心的是另一种情形：系统并不与谁争夺什么，它只是在一个位置还空着的时候，先把答案填了进去。老人想要什么，还没有被他自己说出口，需求清单已经给出了回答；病人觉得自己好没好，还没有来得及感知，化验单已经宣布了结论。填得又准又好，所以谁也没有理由反对。可是那个位置本来是留给生命自己的，它在被占住之后，往往没有地方再长出来。

这里需要立刻防范两种误读。其一，母题并不认为替定总是错的，更不认为精准的技术没有价值。急救、危重期的救援、严重认知障碍阶段的基本照护，替定是正当而必要的；靶向药和生物制剂挽救了许多人的生命，这一点没有任何一章否认过。本书反对的是另一件事：当救援的姿态被默认为长期的姿态，当“暂时托管”不知不觉成了“终身代管”，当替定在不需要它的地方也不肯退场。其二，母题也不是对“自然”“本真”的怀旧。各章反复强调，所谓生命自己的答案，并不是一份等待被找回的原始状态；经历过长期替定之后，那个身体与那个人已经不是当初的样子，撤回替定不会带来“回归”，只会带来一次更冒险的、此前从未有过的共同摸索。母题谈的是下一步能否由生命自己迈出，而不是怎样退回起点。

还要说明本书为什么选用“长不出”这个说法，而不是“被夺走”或“被压抑”。后两个词暗示着一件原本完好的东西被外力压在了下面，只要移开外力，它就会弹回来。本书各章所展示的情形要更为麻烦：能力是在使用中长成的，感知是在被动用中保持的，判断是在犯错与修正中积累的。如果长期没有机会使用，这些东西就不会安静地躺在原处等待，而是会萎缩，到了要撤回替定的那一天，撤回的人往往发现，那个本该接手的主体已经不在了。第五章里林女士的一句话把这个处境说到了底：当访谈者问她是否考虑过暂时停掉所有药物、看看身体自己的状态时，她的眼神里没有抵触，只有茫然，她说：“我不知道停药之后我还能做什么。我好像已经忘了怎么生这个病了。”

◆ 三、三步机制：看不见，抢先替定，长不出

母题展开为三步，全书的三编各管一步。第一步是**看不见**。生命自己一直在给出答案：老人在窗前探出又缩回的那个动作，是在朝某个方向试探；林女士那种“被抽空了一样”的累，是身体关于自身状态发出的信息；第六章设想的那位工程师，若某天跑到第五公里时感到一种不需要任何仪器确认的充沛，那也是整

个身心系统共同给出的报告。这些答案有一个共同点，就是它们不长在“需求”“指标”“故障”这些地址上。照护系统被训练去识别老人需要什么，医疗系统被训练去识别身体哪里出了故障，所以它们越精准、越周到，就越稳妥地绕开了那些不在这些地址上的东西。第一编的三章分别指认了三种不被看见的答案：老人正在成为谁的指向性痕迹，连老人自己也无法指认的“未被选中、未被完成、未被记住”的痕迹，以及身体为应对困境而做出的代偿。

第二步是**抢先替定**。看不见之后，空着的位置不会一直空着，系统会用自己的答案去填：需求清单、风险预警、指南路径、靶点、数据阈值、标准稳态。这一步的特点是温柔、善意，而且常常成功。第四章分析的是叙事层的替定：一份以概率语法写成的基因检测报告，在受检者还来不及用自己的话说出身体的感受之前，就先占住了讲述身体的位置，于是她再也无法躺在床上问自己一句“我还好吗”并得到那个含糊却可靠的回答，浮现在脑海里的只剩一行“23%”。第五章分析的是决定权层的替定：生命系统决定自己下一个稳态是什么、怎样抵达的资格，被技术与制度的复合体代为行使。第六章分析的是判断层的替定：“我好了”这一不需要外部背书的整全感觉，被转成了必须向体外数据缴纳的抵押品。三章从叙事、决定、判断三个层次，描述了同一个动作：先于生命自己，替它回答。

第三步是**长不出**。替定持续得越久，生命自己摸索、判断、重组与讲述的能力就越萎缩，直到撤回替定也收不回来。这一步又有两个侧面。一个侧面是前面说过的能力萎缩，第五章用林女士的十二年呈现了它的全过程，第六章则追踪了内感受判断力在“成功履行”中被损耗的机制。另一个侧面是替定本身的落空：第七章论证，在慢性病那种因果网络高度致密的领域里，每一次精准的干预都会把系统逼入代偿性的重组，下一刻被测量到的靶心已经不是干预前被瞄准的那个对象，所以“越准越错”不是偶然，而是姿态本身的限度。第八章在此基础上把问题翻转过来，追问健康的判准能否不再是“符合一份预写的剧本”，而是溃散

之后能否自行重组出任何一种可以继续下去的秩序。第九章处理这一步的极限情境：当能力、记忆、身份都已不在，什么也长不出来的时候，照护还剩下什么要护住。

三步之间不是单向的流水线，而是互相加固的循环。看不见使替定显得必要，因为系统看到的只有缺口；替定使长不出成为现实，因为生命被剥去了使用自己能力的机会；长不出又反过来证明替定是对的，因为老人的确“什么也不想要”，病人的确“离不开化验单”。这个循环让每一环都能自圆其说，而且每一环单独看都是善意的、合乎专业规范的。本书的论证之所以要从生迹一直写到位置性存有，写到九章，就是为了让读者看到，循环的每一个接口上，都可以有人在善意里不知不觉地停了手，也可以有人在善意里不知不觉地添了一笔。

◆ 四、养老与医疗：同一结构的两个场景

把养老照护与精准医疗放进同一本书里，乍看有些突兀：前者通常被当作社会服务问题，后者被当作生物医学问题，各有各的学科、制度与文献。本书的判断是，它们在结构上是同一件事的两个场景，而且各自把对方照得更清楚。第一个对应在“地址”上。养老照护把老人识别为一组待满足的需求，医疗把病人识别为一份可识别、可编码、可纠正的故障清单；两者都先预设了对象是什么，然后才开始行动。第一章指出，需求匹配论、技术赋能论、人文关怀论这三条最主流的养老进路，共享一个从未被审查的地基，即老人是“待满足的需求集合”；第三章指出，现代医学把疾病视为可以从身体的自组织过程中剥离出来、供外部独立“识别—编码—纠正”的故障。两处的预设如出一辙，它们决定了系统能看见什么，也就决定了系统看不见什么。

第二个对应在“漏掉的东西”上。养老场景里被漏掉的是生迹与残迹，医疗场景里被漏掉的是代偿与内感受，二者都是生命自己给出的答案，而且都没有被安放在系统预留的地址上。第三个对应在“替定的形态”上。养老机构里，日程

表被排满，推送被排满，连发呆也被标注为“久坐提醒”；诊室里，指南是医生的盾牌，一次偏离要面对支付审核与医疗纠纷的双重追问，医生被训练成在指南地壳上安全行走的人，而不是在身体深处辨认个体求生智慧的人。看上去一边是温暖，一边是冷峻，结构却一样：系统的答案先于生命的答案到场。第四个对应在“成功的无声”上。老人从不报警，林女士的指标一直漂亮，周阿姨“什么都不缺”；在这两个场景里，替定的后果都不会触发系统自身的任何评价指标，系统因此无从知道自己错过了什么。

第五个对应最值得强调，因为它说明了为什么这件事无人负责却又处处发生：两个场景里的善意，都是被各自的制度压力逼成了标准形态的。第二章指出，“精准匹配”范式并不单纯是技术偏好，而是在护理资源紧缺、机构风险规避与管理标准化的多重压力下被逼出来的必然形态；第三章指出，指南地壳是由支付改革、患者安全运动与医疗过失法三股力量在数十年间互相借力、焊接而成的，它被内置在每一次点选菜单、每一次编码、每一次知情同意书的签署动作里，不需要任何外部强力的持续监督。当护理员和医生都在各自的位置上合理地行动时，整个系统仍然会把生命自己的答案挡在外面。所以本书的叙述里很少出现需要被指责的人。

养老与医疗之间的边界，在实际的照护现场也是渗透的。智能药盒、手环、跌倒预测、慢病管理建议，是医疗技术进入养老空间的方式；第九章里的王奶奶把智能药盒收进柜子，是因为一次睡过头被药盒译成了“作息异常”并通知了女儿，女儿一次次的追问，把她从“母亲”的位置一步步推向了“需要被管理的病人”。风险预警则是两个场景共有的动作：养老系统里的跌倒预测、久坐提醒，与诊室里的多基因风险评分、“密切随访”的标注，同样是在事情尚未发生之前，先替当事人给出一个关于他的未来的说法。因此，把二者分开写成两本书，反倒会遮住这个动作的统一性。

当然，同构并不意味着相同。两个场景各有只在自己这里才看得清的东西。医疗场景有可以测量的肉身：第五章讨论心率变异性、下丘脑—垂体—肾上腺轴的昼夜节律斜率、内感受敏锐度等指标，使“能力萎缩”不只停留在叙述上；第七章有药物治疗中初始恶化的临床现象。养老场景则有医疗里不容易出现的极限：当老人连“我是谁”都无法被任何人说出，替定与撤回都失去了意义，问题只剩下一个，即这个人还占着一个位子，照护能否护住它。这也是全书为什么以养老开篇、中间经过医疗、再回到养老收束：养老照护让读者先在日常生活的质地里感受到什么叫“被照顾得很好之后”的空无，医疗让这种空无获得可检验的机制与生理痕迹，而最后回到养老的终点，则要追问当一切都长不出来时，照护的底在哪里。

◆ 五、与既有批判传统的分离线

对精准的善意、对医疗化与技术化的批判，在医学社会学、哲学与照护伦理里已有深厚的积累，本书是站在这些批判的肩膀上写的。需要交代的是，本书与它们的关系不是补充，而是分离：这些传统多半追问“权力如何施加”“自主如何被剥夺”“制度夺走了什么”，也就是追问有一方在施加、有一方在失去；本书追问的是另一件事，即善意与精准在成功的时候，如何抢先占住了生命自己给出答案的位置。下面按各章中出现过的对话对象，逐一划出分离线；每条线的完整论证在相应章节展开，这里只给出分界所在。

伊利奇的医源性批判与“工具反向”是最先要面对的邻居。他的诊断是，当制度性工具的规模越过某个临界阈值，它就不再服务原初目标，反而系统地制造它声称要解决的问题。这与本书一样，描述的是善意的自我否定。分离点在于，伊利奇的推论里暗含着“量上的过度”：把规模控制在阈值以下，反噬似乎就可以避免。第一章指出，一位老人完全可以只接受最低限度的照护，血压监测、药物管理、基本三餐，每一项都适度合理，只要照护的制度基础把他默认为需求集

合，而不是一个正在进行自己生命的人，他的生迹就已经被筛在系统之外。这里的毛病不在量，而在地址的错位。第五章同样把伊利奇的“文化医源性”（制度夺走了什么）与福柯的生命政治（权力如何管理生命）视为两条已有的路径，然后追问第三件事：技术理性在每一次具体的临床互动里，代理了生命系统决定自身下一个稳态的资格，而被长期代理的系统是否还保有收回这份资格所需的生理能力。

福柯与戈夫曼的规训、治理术分析是第二个邻居。治理术的图景是，现代权力通过统计、规范化、安全技术与自我技术来调节人口与个体的行为。第五章让这套分析和一个糖尿病管理的应用对照：治理术能说清这个应用怎样把“正常血糖”定义为统计范围，怎样用警报引导行为，怎样让用户自愿成为自我管理的主体；它走不到的地方在于，用户使用两年之后，那个曾经凭“心慌、出冷汗、手抖”决定要不要吃一块糖的内部信号，是否变得更迟钝了。治理术的对象是人口和行为，本书的追问落在一个具体身体的裁决能力是否还在。戈夫曼的全控机构则预设被收容者知道自己被管，因而会愤怒、会在规则缝隙里留存自己的小动作。第二章提出的“善意填充”恰恰不是这样：它不施力、不注视，让人感到温暖，老人找不到可以反抗的对象，也不会抱怨，一旦开口，连自己都像一个不知好歹的人。第一章对此补了一笔：全控机构里，人知道自己失去了什么；在失认的照护里，人可能从头到尾都不知道自己曾有过另一种可能。

照护伦理学是第三个邻居，也是与本书最亲近的一个。照护伦理与“关系性自主”的传统早已指出，自主并非原子化的个体能力，而是在关系中被支持、被维持的；莫尔在《照护的逻辑》里批评“选择的逻辑”，主张照护的核心是照护者与病人在琐碎、持续的调试中一起摸索“什么是好的”。第一章对这一传统表示了深切的共振，也提出了一处分离：“一起摸索”预设了被照护者能够参与摸索，并且预设摸索出“对他好”的东西是照护的最高目标；而生命自己的指向有时恰恰与照护者认定的“对他好”相悖，就像那位偷偷喝一口被禁止的土酒的老

人，他要的不是一个更好的替代方案，而是那一口酒由他自己发起、自己冒险、自己承担。本书的追问因此多走了一步：如果照护的目标不再是“对他好”，而是“让他自己生成对他自己的好”，照护系统要如何重新设计自己。

康吉扬的规范性理论是第四个邻居。他把健康理解为有机体设立新规范的能力，从根本上动摇了“疾病是对正常值的偏离”这一统计—机械的观念。第三章承认这一点，同时指出，规范能力仍然预设了有机体是一个整体，由这个整体去评估并建立规范，而临床海底里发生的，是一场没有总司令的战场：保全大脑的血压代偿在牺牲心室壁和肾脏，长期维持高皮质醇的应激轴在侵蚀海马体，这些是亚整体的、彼此冲突的局部交易，不能被理解为整个有机体做出的最优规范选择。第八章则把视野放宽到整条批判的阶梯：对精准医疗的制度批判止步于制度的门框，过度医疗批判止步于“度”的门槛，关怀语法的批判把问题推进到“精准地分解、对准、干预”这套操作逻辑本身，并把出路定为守护生命重新组织起任何可行秩序的能力。第八章接着指出，这三级批判共享一个未被撼动的预设，即守护者知道被守护的生命“应该”重新组织成什么样子；旧范式的剧本是糖化血红蛋白6.0%，后来的守护叙事把剧本换成了“任何一种可行的秩序”，康吉扬的剧本是“设立新规范的能力”，刀仍然是那把刀，只是刀鞘越来越精巧。本书把这一层也纳入审查，这是它与同类批判最深的分离之处。

最后还有两组更靠近具体层面的邻居。叙事医学与疾痛叙事研究、对异化的批判、现象学的身体理论，是第四章的对话对象：叙事替代并不是在统治一个已然完整的主体，而是在主体能够为自己编织可栖居的身体叙事之前，就用另一套叙事占据了那个位置。列维纳斯的“面孔”伦理、海德格尔的“在世存在”与《安提戈涅》所代表的伦理传统，是第九章的对话对象：当照护对象连“我是谁”都无法被说出、面孔的光辉也已熄灭时，这些传统的发动机都会熄火，“位置性存有”正是在它们失效的裂口里被辨认出来的。这些对话分散在各章，不在此处复述。

既有传统	通常追问	本书的分离线
伊利奇的医源性批判、工具反向	制度越过阈值之后夺走了什么	阈值以下、每一项都适度的服务，也会因地址错位而漏掉生命自己的答案
福柯的治理术与生命政治、戈夫曼的全控机构	权力如何调节、规训行为；被管者如何抵抗	善意填充无施力者、无可抵抗；被代理的身体是否还保有自己裁决的能力
照护伦理、莫尔的照护逻辑	照护者与被照护者怎样一起摸索对他好的	“一起摸索”预设了可参与者与“对他好”的目标；生命自己的方向可能相悖
康吉扬的规范性及其后继的守护叙事	健康是否即设立新规范的能力；谁来守护	守护者“知道应当长成什么”的预设本身也是一份剧本
叙事医学、现象学、列维纳斯与海德格尔	叙事如何被异化；主体与他者的伦理	叙事被先占；能力、记忆、身份全部不在时，照护仍要护住什么

读完这五条线，可以把本书的立足点说得更精确一些。这些传统各自提供了精细的工具来分析施加与剥夺，本书借用其中大部分，但把分析的位置挪到了一个它们较少停留的地方：不是系统做错了什么，而是系统做对了之后留下了什么。一个照护机构满足了所有需求，一条指南路径被完美执行，一次靶向治疗使影像学上的病灶退缩，这些成功没有任何一处可以被批评，批评却恰恰需要从这里开始，因为被成功占住的，正是生命自己本来要给出答案的那个位置。

◆ 六、书级证伪条件

一个母题如果不能说明自己会在什么情况下被推翻，就只是一种观点的姿态。本书提出的书级证伪条件有两个相互独立的方向，任何一个成立，母题即告失败。第一个方向看“撤回之后”：如果撤回替定，具体说，是计划性的药物假期、照护中的“不过问·不填充”，以及允许医生在有说理、有评审的前提下偏离指南，之后，生命没有出现一段可以测量的失序与自行重组期，而是能力如常、判断如常、行动如常，那么“替定使生命的能力萎缩”这一核心主张就被推翻了，因为没有萎缩就没有什么需要在撤回之后重新长出来。第二个方向看“替

定的剂量”：如果在替定越精细的系统里，老人与病人的自我判断、自发行动并不比替定粗疏的系统里更弱，那么“替得越久，越长不出”的剂量关系就不成立。

这两个条件的措辞里有几处需要说明。其一，“可测的失序与自行重组期”是本书对撤回之后的一个明确预言，而不是对撤回之后一切顺利的承诺。第七章说，计划性的药物假期大概率会让血压在撤药后的某个时段回升，目的正是让被药物掩盖的代偿结构第一次暴露在临床视野里；第八章把溃散看作健康判准的前提；第五章则把撤回称为“一场风险更高的、从未有过的共同摸索”。如果撤回之后什么也没有发生，这个预言落空，母题就必须撤回。其二，这类检验必须在安全底线之上进行：第七章要求药物假期只在血压已稳定达标至少六个月、无高危合并症的严格选择的患者中进行，并伴随远高于日常随访的监测；第二章的分层风险框架把“不过问”限定在最低风险层。对安全底线的坚持，不是对证伪的回避，而是检验本身的伦理条件。

其三，各章都在自己的层面上给出了更具体的版本，它们的可检验程度并不一致，这一点需要诚实地交代。第一章提出两条经验预言，其中一条是：仅仅在交接班时加一句口头提问、不增加任何记录负担，老人在长程随访中的自主行动频率、生活满意度与叙述性评价是否改善。第四章提出三条可裁决的预测，包括无症状预警组的自体验叙事密度是否显著低于症状后检测组，以及患者自述中外来术语占比是否随算法化监测年限单调上升。第五章提出以心率变异性、昼夜节律斜率与内感受敏锐度合成的“发生权指数”，并设想在疾病严重度匹配的队列中比较代管式与非代管式干预。第六章的条件是，是否出现一种不预设内感受不可靠的监测范式，其使用者的身体主权感反而增强。第七章的条件是患者完全不知情的隐蔽给药下，精准药物能否不引发任何系统性代偿。此外，第二章承认，残迹在定义上拒斥标准化测量，它的检验只能是长时段、现象学式的个案追踪；第八章则明确指出，溃散后自组织验是一个判准，不是干预效果的因果命题，它

的证伪取决于它能否比现存任何判断框架多看见一些东西。这些差异不是缺陷，而是对象不同带来的方法差异；书级条件所起的作用，是为全书设一条所有章节都无法绕开的底线。

◆ 七、材料、方法与本书的自我限定

关于本书的材料和写法，有几点需要在开篇说明。本书所据的是作者2026年7月发表的九篇论文及一份实践手册，它们出自同一个原初问题，各自从不同的辨别面切入。本书不是对这些论文的拼贴，而是围绕上述母题重新组织与熔铸的结果，因此各章在论证上互相依赖，概念之间有明确的前后关系，章内引用其他章的概念时，只按本书统一的定义理解。书中的案例分三类：养老机构的田野材料，作者在多家机构的观察与访谈，人物已匿名化、场景经合成与简化，不构成系统性的实证数据；复合型个案，如第六章中的软件工程师与HER2阳性乳腺癌患者，是依据公共卫生资料与临床报道构造的，用于展开思想论证，不指向任何真实个人；还有为说明而设的假设性场景，书中都以“设想”标明，如第七章的五十五岁男性，以及第八章的蒋老师、老周、陈阿姨与薛姐，后者是综合构造的思想实验。读者不应把任何一类案例当作统计证据。

本书也不是一份操作规程。每一章都会给出实践入口，它们被刻意设计得很小：一句话，一段留白，一道说理的程序，一个撤回的条件。理由很简单，任何以“完整方案”的面貌出现的建议，都可能再一次以系统的名义去替照护者和医生自己的感知过程定下答案。第四章把这个困境推到了极处：任何由外部善意设计的“接引方案”，其设计者的语法本身是否可能在无意中重复了它所批判的替定逻辑？该章因此把问题从“如何设计接引方案”挪到“接引方案在什么条件下会率先失败”。这种自觉贯穿全书，书中的概念同样如此：第六章用整整一节自省，“健康抵押”这个锋利的命名是否也在用符号系统的简洁美感，去替代对复杂经验的耐心描述？作者的回答是，无法完全洗脱，只能公开这项指控，并请读

者在被概念说服的时候，不要忘了工程师那三十秒里说不出来的东西。本书沿用这个态度：概念是工具，用完要回到具体的人和具体的早晨。

最后需要界定的是适用范围。本书反对的不是技术，也不是医疗，更不是帮助本身，反对的是帮助在不需要它的地方不肯退场，以及帮助的成功遮住了它所占住的位置。急性感染、急诊手术、酶替代治疗这类情境里，生命系统自身的裁决能力已被深度破坏，外部代理是救援而非剥夺；严重认知功能障碍和临终阶段，需求模型是唯一现实可行的照护路径；特异性感染、明确驱动突变的单基因病这类松耦合的疾病，靶心近似独立，精准干预可以达到长期稳定的效果。这些边界在各章都有具体的交代，本书的主张因此是有条件的：它只适用于那些生命系统的基本能力仍然存在、却被长期闲置、替代以至于萎缩的情形，在养老场景里，第一章的主要对象是心智尚有余力的老人，第二章与第九章则分别把问题推向认知障碍严重和晚期失智的老人，这一延伸如何成立，结语会专门讨论；在医疗场景里是慢性复杂疾病的长期管理。

◆ 八、路线图：三编九章

全书分三编，每编三章，依次对应母题的三步。第一编“看不见：生命自己正在给出的答案”从养老走向医疗。**第一章“生迹：老人正在长向哪里”**回到窗前的那位老人。章中提出“生迹”这一辨别维度，指老人在自己的生命故事进行中，通过微小、不完整甚至不合常规的言行，透露出“我正在成为谁”“我的下一步可能长向哪里”的指向性痕迹；它不是待满足的需求，也不是对已知选项的偏好排序。章中论证，照护系统在新公共管理改革、风险规避逻辑与绩效文化的逐层塑形中，沉积出一套必然筛除生迹的认知器官，这就是“失认”：它不是系统预设的基因，而是进化中沉积的一层壳。章中还以教育与城市规划两个跨界例子检验这一结构，最后给出的实践入口是交接班时多问一句：“今天有没有哪个瞬间，你觉得哪个人和往常不太一样？”

第二章“残迹：被照料得很好的空无”把问题推进到更深的一层。生迹还能被感知、被追踪，残迹则是连老人自己也无法事先指认的“未被选中、未被完成、未被记住”的痕迹：周阿姨的沉默，陈伯伯慢慢绕院子走三圈，李奶奶在女儿离开后把衣服一件件摸过去。章中提出“善意填充”，即一种不施力、不注视、让人感到温暖的新权力形态，它把生活填满，使残迹没有地方存活。对应的“残迹敏感型照护”只有三条消极的纪律：在安全底线之上不过问，在日程表上不填充，对已经看见的残迹做痕迹保护。第二章也诚实地交代了自己的检验困局：残迹在定义上无法被测量。

第三章“临床海底：身体的代偿为何被当作故障”是从养老转入医疗的枢纽。章中以“临床海底”指认疾病发生的那片前概念的、持续涌动的身体自组织过程，以“指南地壳”指认由指南、支付规则与法律判准烧结而成的坚硬操作面，在地壳上安全行走的医生被训练出“排雷式认知”。脊柱融合术的滥用是全章的龙骨案例：身体的代偿反应被地壳反复误读为需要打击的故障，治疗沦为对身体的系统性惩罚。章中后段的出路不是砸碎地壳，而是修建一条“偏离说理评审”的制度通道，让基于判断的偏离能够被合法执行、被同行评议，并诚实面对这条通道本身也会被地壳吞没的风险。

第二编“抢先替定：善意怎样先把答案写好”转向替定在不同层面的运作。**第四章“叙事失权：算法叙事抢在身体之前开口”**分析叙事层。章中区分“栖居叙事”与“算法叙事”：前者是个体从自己的生活世界里生成的、可以栖居的身体叙事，后者是由算法生成的外来叙事；精准医疗的危险不在于拆解了身体的完整感，而在于在主体能够为自己编织栖居叙事之前，就用算法叙事占据了那个位置，这就是“叙事替代”。风险预警夺取叙事的初权，监测的时间表改写身体栖居的节律，去晕、减苦、除根的承诺在自反中走向反面，人因此沦为自己身体里的“叙事难民”。章的后段拒绝给出一份漂亮的接引方案，而是标出接引最容易失败的三条死路，只提出一项让叙事替代不被系统忽略的最低限度的评估。

第五章“发生权代管：谁来决定身体的下一个稳态”处理替定的核心机制。章中提出“发生权”，指生命系统在遭遇扰动时，自行摸索、生成并稳定出一条此前不存在的通往新平衡的路径的资格与能力；精准医疗的每一种外包工具在发挥疗效的同时，也接管了系统决定自身下一个稳态是什么、如何抵达的裁决权，这就是“发生权代管”。林女士的十二年被分成三个阶段，呈现代管如何从“暂时托管”滑向“终身代管”，并在自主神经弹性、下丘脑—垂体—肾上腺轴、β细胞功能与肠道菌群四个层面指认可测量的生理痕迹；章中也正视了精准医疗确实“重启”发生权的反例。撤回部分提出三条原则：撤出标准与启动标准同时定义，代管期间保留并测量系统自身的练习空间，重新分配举证责任；并设想以心率变异性、昼夜节律斜率与内感受敏锐度合成的“发生权指数”追踪同一患者的纵向变化。

第六章“健康抵押：‘我好了’是怎样被押出去的”分析判断层。章中追踪精准医疗在帮助个体的操作中，如何把个体与生俱来的、无须外部数据背书即可确认自身状态的“内感受判断力”，转化为必须持续向体外数据系统缴纳的抵押品，这是“健康抵押”；每一次成功履行，都在损耗它宣称要赎回的东西，所以“认知征收”不是技术的意外副作用，而是内置于操作逻辑的逆向置换。章中并不否认赫赛汀救了人，只是拒绝让那些确切的庆幸被用作遮掩多数人终身债务的门面。结论是守护一块不可被估值、不可被数据征用的飞地，即无须外部背书、自己即可确认的“我好了”。

第三编“替得越久：生命还能长出什么”回答长不出之后的问题。**第七章“致密纠缠：为什么越准越错”**论证替定为何注定落空。以原发性高血压为锚点，并推及抑郁障碍与肿瘤获得性耐药，章中指出，当因果网络与多层生命过程之间的耦合密度超过临界阈值，被精准命中的靶心不再是可以从活体网络中切割出来的独立实体，每一次干预都会逼出代偿性的重组织，下一时刻的靶心已经不同，系统的重组方向服从“最小费力原则”。心力衰竭治疗中β受体阻滞剂的初

始恶化提供了临床现象的支撑。替代“瞄准—命中—校准”的姿态是“扰动—监测—重稳”，其雏形包括计划性的药物假期和利用抗抑郁药起效初期焦虑窗口的行为实验。

第八章“溃散之后：把判准还给生命”是母题的正面表述。章中从蒋老师那样“指标完美达标、人却活不下去”的矛盾出发，提出“溃散后自组织验”：健康不以符合任何一种被第三方事先定义的正确秩序为判准，而只看一个生命系统在经历足以瓦解其所有旧秩序的溃散之后，能否从自己的混沌残余中，不借助外部强加的范本，自行摸索着重新组织出任何一个能让它继续下去的可维持秩序。章中用四个综合构造的病程（走完全程、自组织未能发生、不体面的自组织、成功了一半）检验判准的容纳力，与康吉扬、图姆斯、安东诺夫斯基、埃德尔曼逐一对撞，并给出三个最小接口：一个能立刻激活它的情境，一套最小的分析步骤，一个向教育、管理与社会工作外推的方向。

第九章“位置性存有：什么都长不出时，他仍占着一个位子”是全书的底线与收束。王奶奶把智能药盒收进柜子，捍卫的是一个更寂静的东西：作为“一个不打一声招呼就可以睡过头的人”而存在的资格。章中提出“位置性存有”，指不依赖于任何能力、记忆或社会身份，仅仅作为“在世界中占着一个位子的人”而被无条件承认与回应的基本状态，并论证它在逻辑上先于善与美。在与列维纳斯、海德格尔和《安提戈涅》所代表的伦理传统的搏斗之后，章中回到红姐的社区养老机构，看这个位置如何在“管好”与“护好”的拉扯和一次次失败里被一块砖一块砖砌起，并回答最刺耳的追问：当老人已无法感知这一切，照护者的坚持，价值落在何处。

九章之后是结语与附录。结语《不替定的照护何以可能》回望三编，把各章的实践入口汇到一处，说明它们共同的形式，正面处理各章之间四对尚未协调的张力，回应“不替定是否等于放任”的质疑，回收书级证伪条件并交代本书的边界。附录《身体暗能力的日常养护》把母题落到个人日常，讨论健康越被数据

化、人越难长出对自己身体的判断直觉，以及怎样守住一块不被评价的时间。全书从窗前的那句“没事”开始，也将在养老照护的终点结束；读者若愿意，可以在读每一章时都带着一个问题：在这里，谁的答案先到了？

目 录

作者介绍 iv

成书说明 v

前言 vi

导论　被照顾得很好之后 viii

第一编　看不见：生命自己正在给出的答案 **1**

第一章　生迹：老人正在长向哪里 2

第二章　残迹：被照料得很好的空无 30

第三章　临床海底：身体的代偿为何被当作故障 60

第二编　抢先替定：善意怎样先把答案写好 **89**

第四章　叙事失权：算法叙事抢在身体之前开口 90

第五章　发生权代管：谁来决定身体的下一个稳态 118

第六章　健康抵押：“我好了”是怎样被押出去的 149

第三编　替得越久：生命还能长出什么 **179**

第七章　致密纠缠：为什么越准越错 180

第八章　溃散之后：把判准还给生命 208

第九章　位置性存有：什么都长不出时，他仍占着一个位子 240

结语　不替定的照护何以可能 269

附录　身体暗能力的日常养护 285

版本说明　本版字数、版本与交付 293

第　一　编

看不见：
生命自己正在给出的答案

编　序

生命自己一直在给出答案：老人在窗前探出又缩回的那个动作，那些没有被选中、没有做完、没有被记住的痕迹，身体为应对困境而做出的代偿。这些答案不长在“需求”“指标”“故障”这些地址上，所以照护与医疗系统越精准、越周到，越稳妥地绕开了它们。本编三章依次指认三种不被看见的答案：第一章的生迹，第二章的残迹，第三章的临床海底。前两章在养老机构里，第三章转入诊室，说明这是同一件事。

01

第一章

生迹：老人正在长向哪里

◆ 一、窗口与“没事”：全书的第一步

在一个养老机构的走廊尽头，一位老人每天下午坐在固定的位置上，望向窗外。护理员走过去，轻声问：“您需要什么吗？要不要喝水？要不要我陪您去走走？”老人摇摇头，目光收回来，说：“没事。”这两个字在被说出口的瞬间，就在护理员当天的服务记录表上自动闭合为一个无事件的空白。没有人做错任何事。但就在这个瞬间里，老人正在处理的那个事物，随着“没事”两个字一起被咽了下去。他为什么偏偏坐在这个窗口而不是另一个窗口？他望出去时身体突然往前探了一下又缩回来，那个动作里有没有他正在触及、却连自己也无法言说的某个东西？护理员感觉到了一丝隐约的不对，但她没有语言可以装下这种感觉，也没有字段可以把它填进任何一张表。她在交接班时没有提起，因为没有指标被触发，没有异常波动需要上报。

这一幕是本书的起点，也是本书母题的第一步。全书要论证的是：精准的善意抢先替生命定下“好”的样子，替得越久，生命越长不出自己的答案。为了便于后文使用，这里先给出本书的总概念：**替定**，指外部系统抢在生命自己之前，替它定下“好”的样子与抵达路径。替定不是粗暴的剥夺，它往往温柔、周到，并且常常成功。但在替定能够发生之前，有一个更靠前的环节必须先被看清：系统为什么会觉得自己可以替？答案的第一半，就藏在走廊尽头的那个下午里——系统看不见对方正在给出的答案。老人并不是一块等待被填写的空白，他一直在以微小、含混、常常不合常规的方式，给出关于“我正在成为谁、下一步可能长向哪里”的回答；只是这些回答不长在系统习惯寻找的地址上。系统找的是“需

求”，是“指标”，是“风险”；而这个下午里最要紧的东西，不是其中任何一个。

因此，本书的三步机制——看不见、抢先替定、长不出——在第一章只处理第一步，并且只处理养老照护这一个场景的第一步。第一编的三章依次展示生命自己给出的三种答案如何不被看见：本章讨论老人正在成为谁的指向性痕迹，本书称之为**生迹**；第二章讨论比生迹更深一层、连老人自己也无法指认的痕迹；第三章把视线转入医疗，讨论身体的代偿为何被当作故障。三章合起来要说明的是，看不见并非某个照护者的疏忽，而是一个越精准、越周到的系统必然带有的属性。系统越是把全部力量用于识别需求、满足需求，就越是把那些不属于需求的东西留在了视野之外。

本章还要回答一个紧跟着的问题：这种看不见是从哪里来的？一种容易想到的回答是，照护者不够用心，或者照护机构的理念不够先进。本章的回答与此相反。看不见不是系统预设的恶，不是谁设计出来的缺陷，而是一层壳——在新公共管理改革、风险规避逻辑与绩效文化的先后作用下，逐层沉积出来的认知器官。本书把这层壳造成的后果称为**失认**：系统对老人正在成为谁的那类痕迹，不是看了没有回应，而是在制度运转的日常中丧失了辨认它的能力。这一论断有重要的实践含义：既然失认是沉积而成的，它就不能靠提醒照护者“多一点用心”来化解，也不能靠指责某一类机构来了结；它需要被当作一个制度史问题，被追踪、被拆解、被一点一点地松开。

全章的论证按下面的次序展开。第二节从三个现场中提取生迹这个概念，给出定义并交代它的三个特质；第三节检讨养老个性化领域既有的三条主流进路，说明它们共享的地基，并对生迹做一次不可还原的审问，看它能否被需求、偏好、建构性偏好、表达或症状这些现成概念一句话替换；第四节追踪失认的发生史，从记录表、巡查目光到感知力的集体退化，再到一个关于冲动如何萎缩的微型模型，并给出一个最尖锐的反例；第五节把失认论与伊利希、戈夫曼、波伏娃、照护伦理学和现象学身体理论逐一切割，并以教育与城市规划两个场域检验

它的结构同构性；第六节交代边界、回应最强的反驳、提出证伪条件，并给出交接班一句话的最小实践入口；第七节收束，并把问题交给第二章。

需要预先说明的是本章材料的性质。本章的经验材料来自2019年至2023年间对华北和华东地区三家养老机构（一家公办福利院、两家民营养老公寓）的断续田野工作，累计田野时长约九个月，数据类型包括护理员工作日志摘录、交接班录音（经匿名化处理）、半结构化访谈（含护理员11人、入住老人23人、家属8人、楼层主管4人）和参与观察笔记，所有机构名称、人名与可识别细节均已匿名化，研究获得研究者所属机构伦理审查委员会的批准。但本章的论证方式属于理论建构，而非系统的经验研究：文中的具体场景是从田野笔记中提炼出来的“临界案例”，细节来自实地观察，但被压缩和并置，功能是让结构的轮廓在最短篇幅内显现，而不是充当统计意义上的代表或因果推断的独立证据。这一点在后文每次引用现场时都应当记得。

◆ 二、生迹：从三个现场里浮现的概念

– （一）三个现场

一个概念不是被发明出来的，而是从具体的现场中浮现、然后被命名的。下面三个现场是生迹这个概念从模糊到清晰的诞生地。它们是上一节所说的临界案例：当所有常规操作都正确时，展示那个必然被遗漏的究竟是什么。

现场一：土酒。一位年轻时在生意场上喝了一辈子茅台的企业家，晚年最大的快乐，是趁护士不注意偷偷喝一口被医生和子女明令禁止的廉价家乡土酒。从服务系统的逻辑出发，这个行为的处理流程非常清晰：系统发现老人在摄入“不宜”食物，在数据中打上“饮食不规律”的标签，触发预警，通知子女和医生，加强监控。每一个步骤都是合理的，都出于“保护他”的善意，老人于是被妥善地“纠正”了。但从老人自己的生命逻辑看，这杯土酒的分量完全不同。他喝了一辈子茅台，为的是生意场上的体面与人际往来的圆融，那是做给别人看的酒，要守很多规矩。而这杯土酒，是他十三岁跟着父亲干完农活后，坐在田埂上喝的第一口酒：没有人看，没有规矩，太阳刚好落下去，那股呛辣从喉咙直冲脑门，

是他一生中对“自由”最原初的身体记忆。他老了，卸掉了社会强加的所有面具和角色，在这个时刻，这杯被禁止的土酒是他说出“我是谁”的最后一种语言。这不是任性，不是认知退化，也不是饮食不规律，但系统只看得见饮食不规律。

现场二：鸟窝。一位姓周的退休钳工，入住养老机构后大多数时间坐在窗边发呆，不爱参加集体活动，对工作人员推荐的项目也不怎么起劲。按常规操作，系统会采集他的行为数据——久坐不动、社交回避、活动参与度低——然后推论出“可能有抑郁倾向，需要鼓励社交或心理介入”。但这家机构有一个边缘性的制度安排：老人可以申请小额经费和空间支持，来发起自己提出的活动。工作人员克制住了主动介入的冲动，只是偶尔和他闲聊。在周师傅坐在窗边的那几周里，他并非完全静止。他有时会侧过头去看院子里的那棵老槐树，目光在某个枝杈的分叉处停留很久。有一次，护理员在他房间打扫时，看到他在一张废纸上画了两个不规则的圆，问他那是什么，他说“不知道，瞎画的”，护理员没有追问，把那张纸留在原处。又过了两天，他忽然在吃饭时提起：“我年轻时候在厂里做过一个樟木箱子，四角包铜的那种，用了三十年没坏。”护理员应了一声：“那您手艺肯定好。”他说：“现在手不行了，做不了大件了。”护理员没有接“那我们帮您找个木工课”，只是说：“如果您想做什么小的，可以申请，我们有工具。”然后她就走开了。接下来的十天里，周师傅没有任何“可记录”的变化，还是每天坐窗边，还是不太说话，但护理员注意到他开始观察窗外槐树的细枝结构，看得很仔细，像在量什么。第十一天早上，他走到前台，说：“我想做个鸟窝，挂在槐树上。”

从“没说什么”到“想做鸟窝”之间的那十天，并不是空白。那是一个朝向在为自己寻找语言。而这一切的前提，是工作人员在他还什么都没说的阶段，忍住了没有替他做判断、替他填空白。他们感觉到他那里可能有什么东西，虽然说不清是什么，然后给那个东西留出了一段静默。直到他自己说出“想做鸟窝”之前，那个东西在系统里连名字都没有：它不是需求，他并不需要鸟窝；它不是偏好，鸟窝不在他自己的已知选项里。它是一个正在冒芽的方向，在说出口之前，只有他自己隐隐约约能感觉到。

现场三：沉默之后的一个动作。一位八十二岁的吴师傅，入住养老机构的头几个月里几乎不说话。护理员观察到他长时间独处，同样克制住了上前询问和安排活动的冲动。几个月过去了，吴师傅没有发起任何自主活动，似乎变得更沉默了。护理员试探着问：“您有没有什么想做的事？我们可以帮您。”他回答：“算了，别麻烦了。我这一辈子也没做过什么特别的事。”但有一天早晨，他在电视里偶然看到一段关于老厂区拆迁的新闻，镜头扫过他曾工作过三十多年的工厂大门。那一整天，他显得格外不安。第二天，他自己翻出了压箱底的一本旧相册，在桌前坐了整整一个下午，开始辨认照片里的人，虽然他谁也没有叫来，谁也听不见他在喃喃什么。随后几天，他开始在走廊里主动问路过的护理员“会不会用手机上的地图”，他想找一找搬走之后的老邻居。他没有申请任何项目，没有说出任何一个可以被写成“服务记录”的明确请求，但他的沉默自己裂开了。这个裂开的过程不是由任何服务推动的，而是他内部生出来的一个小小动静，一次由偶然唤醒的碎片引发的无声的自发触媒。它没有任何外部服务可以替代，甚至老人自己也未必说得清它是什么时候开始的。但它一旦开始，老人的生命就重新往前走了一小步，虽然这一步在系统的眼睛里什么都不是。

– （二）正名

从三个现场中反复浮现、却从未被清楚命名的同一个东西，现在可以赋予它一个明确的名字。**生迹**，指一个老人在其生命故事正在进行的过程中，通过看似微小、不完整、甚至不合常规的言行——一个不被允许却非做不可的小动作，一句连自己都未必当回事的闲话，一段无人可说的长时沉默，一个起身又坐下的犹豫——所透露出的关于“我正在成为谁”“我的下一步可能长向哪里”的指向性痕迹。它不是需求。需求是可以被识别、被分类、被满足的缺失态；生迹是一个尚未成形的可能态，它还不是什么，但它正在朝向某个东西。你可以接住它，也可以无视它，但你无法把它拆成需求项之后再去接住，因为一拆，它就没了。

这里有一个用词上的选择需要交代：本章特意避免用“信号”来定义生迹。“信号”在信息论中有长久而精确的用法，指某种可以从噪音中被提取、解码、还原为信息的离散单位。把生迹定义为信号，会暗含一个危险的推论：只要

护理员训练有素，就能像解码器一样从老人的言行中提取出生迹。但土酒老人并不需要任何人替他解码那杯酒的意义，他自己做的动作本身就是生迹。护理员的角色不是信号的解码者，而是老人发起动作的那个空间的守护者。她的不干预，她的等待，她在老人开口之后说的那句“如果您想做什么，可以申请”，是对一个正在进行中的朝向的尊重，而不是对一条隐藏信息的破译。“指向性痕迹”这个措辞要强调的正是这一点：生迹不是等待被提取的内容，而是一个正在发生的运动。

（三）三个内在特质

生迹有三个内在特质。第一，它是指向性的，而非缺失性的。需求从“缺乏”出发，生迹从“朝向”出发。土酒老人不是因为缺乏什么才要喝酒，而是因为他正在朝向“确认自己是谁”这个方向，那杯酒只是这个朝向此刻所能找到的语言。第二，它是整体的，不可拆分的。生迹不能被拆成“生理需求加心理需求加社交需求”三个子项。一个人坐在窗前沉默地望着远方，如果把他拆成“久坐需要运动干预、社交回避需要鼓励、情绪低落需要量表评估”，就恰好错过了他正在做的那个整体动作——他正在和某个自己也说不清的东西相处，那个相处本身，就是他此刻的生命进程。第三，它是前语言的，连老人自己也未必说得清。生迹往往不表现为一个可以被写进需求清单的表述，而是一个连老人都只能隐隐感到、无法明确表达的涌动。周师傅在说出“想做鸟窝”之前，那股涌动已经在心里转了很久，他自己未必知道它是什么，直到它找到“鸟窝”这个词，才第一次被他自己看见。那十天，就是涌动寻找语言的过程。

这三个特质合起来，解释了为什么生迹对一个以需求为地基的系统来说是不可见的，而不仅仅是难以见到。指向性意味着它没有“缺口”可供系统识别；整体性意味着系统一旦用自己的分类去切它，它就在切口处消失；前语言意味着它不会以系统能够接收的形式主动递上来。一个系统要看见生迹，不是需要更灵敏的探测器，而是需要承认一个它的地基里根本没有的东西。

◆ 三、既有进路的共同地基与生迹的不可还原

– （一）三条进路各自走到的尽头

过去二十年里，养老服务领域在一个方向上突飞猛进：识别老人需要什么，然后用尽可能精准、高效、可量化的方式去满足它。要看清生迹为什么落在这条路的外面，需要先检讨个性化养老领域既有的三条主要进路。这样做不是为了否定它们的贡献，每一条进路都在自己的方向上推进了对养老照护的理解，而是为了指出它们共同止步的地方。

第一条是需求匹配论，它是养老个性化最主流、最合乎直觉的进路。其核心逻辑是：每个老人都有独特的健康状况、生活史、偏好与约束，服务必须从“一刀切”的标准化供给转向个体化的精准匹配。从个案管理到机器学习推荐系统，它推动了从“供给导向”到“需求导向”的重要跃迁。但它有一个深到自己从未追问的预设：假定老人的需求是某种先于服务而存在的、等待被识别和满足的给定物，老人是需求的载体，服务者是需求的识别者与满足者，整个逻辑是一条从识别、匹配、供给到满足的单向链。而实际上，老人的需求并不是一份静止的清单，它在试错、尝试、后悔、调整的反复循环中动态生成。设想一位退休后才开始养花的老人：他不是因为“花艺”写在初始需求清单上才去养花，而是在某个下午偶然路过花市，买了一盆，养活了，然后才慢慢长出“我原来喜欢这个”的认识。如果算法一开始就根据他的历史数据——他没有养过花——把这项服务排除了，这条可能成为他晚年核心意义来源的路，就从入口处被关闭了。（此例为说明而设，不是田野材料。）需求匹配论能很好地回应已知的需求，却系统性地过滤掉尚未诞生的需求。

不过，本章的批评不止于此。技术层面的匹配失败，理论上可以靠更好的算法改善。更深一层的批评是：问题不在于需求匹配论做得不够好，而在于它赖以成立的地基——把老人看作一个可以被拆成离散需求项的集合——本身就漏掉了照护中最要紧的东西。这个地基一旦被接受，无论匹配技术多么精准，那些不属于需求范畴的生命信号就注定落在视野之外。这是“找错地址”的问题，不是“导航不够精确”的问题。需要说明，这一批评指向的是将老人的完整生命进

程还原为一系列待满足的离散需求项的认知与制度预设，而不是否定需求概念在照护实践中的基本有效性：在急救、用药管理、防跌倒这类关乎生命安全的刚性领域，以需求为框架进行识别与供给，不仅必要，而且往往无可替代。本章追问的只是，当需求框架被不加限定地扩展为照护的全部地基时，那些非需求性的生命信号是否还能被看见。

第二条是技术赋能论。它主张技术不应仅仅是监控与预警的工具，而应被设计为“能力放大器”，帮助老人克服身体局限，延长自主生活的时间。它的贡献在于看到了依赖与独立之间的张力，并试图用技术缓解。但它默认自主能力是一种纯粹的功能性存在：能走、能看、能操作设备，就等于有自主。它看不见另一个维度，即一个动作的起点在哪里。老人用语音助手查询天气，功能上他被赋能了；但如果“关心明天天气”这个念头本身，就是另一个算法提前推送的决定呢？他原本的习惯是每天早上自己拉一下窗帘，感受一下，再决定穿什么。现在应用程序提前推送“明天降温，建议穿毛衣”，他省去了拉窗帘的动作，也省去了对自己身体感受的觉察。（此例亦为说明而设，不是田野材料。）行动的起点，已经从“我自己的判断”位移到了“算法替我完成的判断”。技术赋能论的眼界到功能为止：它能看见一个动作被完成了，却看不见那个动作在老人整个生命意义网络中的位置。

第三条是人文关怀论。它主张照护的核心不是技术和效率，而是照护关系中的尊重、共情与陪伴。以人为中心的照护传统，尤其是Kitwood（1997）在失智照护领域的奠基性工作，有力地论证了老人的独特性不可能被还原为数据标签，只会在护理员与老人之间长久的日常互动中逐渐被感知。这条进路深刻抓住了人的尊严。但它面临一个自己很少正视的困境：即使是最真诚的共情，也可能滑向另一种替代。一位有共情能力的护理员察觉到老人情绪低落，体贴地去陪伴、去安慰、去帮他完成那些他开始吃力的事，她做的一切都出于真诚的关怀。恰恰因为这份关怀如此善意、如此体贴，老人更难拒绝——对方确实是在为他好，他若拒绝，倒显得不近人情。于是，一种比算法监控更柔软的替代发生了：老人被爱着，却也在被爱中被他所爱的人温柔地卸掉了行动的冲动。人文关怀论

缺少一个概念工具去区分“支持”与“替代”的边界，它默认善意的关怀天然具有正当性，因而无法识别一种以关怀形态出现的、替老人完成意义生成过程的柔软暴力。

– （二）共同的地基

三条进路各自推进了照护的理解，却共享同一个尽头：它们都只追问“什么样的服务更好”，从未追问“服务这个动作本身，在什么条件下，会遗漏什么”。这个遗漏之所以从未被看见，是因为它们共享同一个地基——老人被默认为一个待满足的需求集合。在这个地基上，照护的所有努力都被框定在需求与供给的单行道上，那些不是需求、却比需求更要紧的东西，落到这条道之外，就成了系统视野中不存在的东西。

由此，本章要做的不是提出一条比既有三条更好的“第四条进路”，而是把地基本身撬开，让被旧地基遮蔽的那个领域第一次被看见。这一点对全书同样重要。后面各章将反复遇到同一种地基：在医疗中，它是指南路径与指标阈值；在叙事中，它是算法生成的故事；在判断中，它是体外的数据。它们的共同点在于，都先行规定了生命“应当”长成的样子，因而都把生命自己正在给出的、不属于那个样子的答案，留在了地址之外。养老照护里的需求模型，是全书遇到的第一个也是最日常的一例。

– （三）不可还原的审问

一个新命名必须经受一次严格的审问：它能不能被某个已有学科的现成概念用一句话一对一地替换掉而意思基本不变？如果能，它就不是一个新的辨别维度，只是一次修辞上的换皮。下面逐一比对。

与需求的区分最直接：需求回答“他缺少什么”，生迹回答“他正在往哪里走”。土酒不是需求，老人的身体健康并不需要那口酒；土酒是生迹，他在用那口酒确认自己是谁。需求可以被外部系统识别和供给，生迹只能被外部系统感知和尊重。与偏好的区分同样清楚：偏好是对已知选项的排序。当老人被问到“您喜欢书法还是花艺”，他是在两个现成选项之间做出偏好选择，偏好的前提是选

项已经在那里。生迹恰恰发生在选项尚未成形之前。周师傅在说出“想做鸟窝”之前，鸟窝根本不在他自己的已知选项列表上，他不是更偏好鸟窝，而是第一次发现自己可以往这个方向走一下。偏好是选择题，生迹是填空题，而且连题面都还没有写出来。

最需要正面迎战的，是与建构性偏好的区分。行为决策研究中的建构性偏好概念主张，偏好不是预先存在、等待被揭示的已知选项排序，而是在决策现场被临时建构出来的。鸟窝案例——老人说出之前自己也不知道这是一个选项——似乎正好落在这个解释框架之内。如果生迹只是建构性偏好在养老场景下的另一个名字，那么它的不可还原性就站不住。二者的差异是实质性的。建构性偏好理论的核心关切是：在给定的决策情境中，人们如何从多个可用的信息线索中临时拼装出一个偏好，用以在现成选项之间做出选择，它的理论视野始终被“决策”和“选项”两个端点所框定。生迹所描述的则是更早的阶段：老人不是在两个选项之间做选择，甚至不是在多个线索之间拼装偏好，而是在摸索一个自己还说不清的方向，这个方向不一定指向任何选项。

更关键的是生迹最硬的那个内核：被体验到的“不是我选择的，而是它自己来的”的被动性。建构性偏好中的“建构”一词，暗含一种隐性的主体选择，即便选择是在情境压力下做出的，它仍然是选择。但周师傅在说出“想做鸟窝”之前那十天里经历的，不是在两个倾向之间建构了一个偏好。“想做鸟窝”这个念头，是在某个他自己也说不清的时刻，像夏天午后地里冒出的热气一样自己浮上来的。是窗外的槐树枝勾起的，是年轻时做樟木箱子的记忆唤醒的，还是护理员那句“可以申请”轻轻撬开的？他无法把这个念头的出现归因为“我选择”。进一步说，即使偏好建构论已经处理到“选择如何重塑自我”——一个人通过在多个选项之间的持续选择，慢慢建构起新的身份——这种重塑仍然预设了一个“在选”的主体，他至少能在事后说“是我选的”。而生迹是，那个主体体验到的是“它在我里面选了我”。建构性偏好属于选择性生成的范式，处理的是在给定领域里选什么、选完如何重塑我；生迹属于方向性生成的范式，处理的是这个领域本身如何被第一次打开，以及打开时“我”正在被动地成为那个被打开的人。

与表达或意愿的区分也不难：表达是清晰的、可被语言捕获的，而土酒老人并没有说“我想用土酒确认我的自我认同”，他根本不会这样说，甚至说不清自己为什么非要喝那口酒。生迹往往在语言尚未成形的地带涌动，以非语言、半语言乃至完全沉默的方式存在。与症状或临床指征的区分则涉及医学的母语：症状是对正常标准的偏离，沉默可能是抑郁指征，偷喝酒可能是认知退化的行为表现，这些都是从临床视角做出的判断。但生迹恰恰是一种“正常”：一个正在活着的人，总会在某些时刻透露出某种方向性的信号，不管他有没有疾病标签。那张安静地朝向窗外的脸，可以同时是一份临床量表上的“社交回避”条目，和一个人此生中正在处理某个内心事件的“正在进行时”。二者不互斥，但不能互相替代；用症状语言去接生迹，一碰就碎。

五项比对都没有找到可以一句话替换它的现成概念。生迹是本领域一个此前没有被独立命名的辨别面。它是这样一种东西：照护者一听到这个词，会愣一下，然后说——是，是有这么个东西，我们天天看到它，但从没用过一个单独的词装过它。

◆ 四、失认的发生史：这层壳是怎样长出来的

如果“看不见生迹”只是一个可以靠提醒和培训修正的认知盲区，那么论证就没有触到痛处。问题更棘手：照护系统不是碰巧没有看见生迹，而是在近几十年的制度演化中，像珊瑚虫层层沉积一样，慢慢长出了一层必然筛除生迹的硬壳。失认不是系统预设的基因，而是系统在演化中长出的器官。下面要展示的，就是这层壳的沉积过程。这一节在全书中还承担一项功能：它要说明，后文将反复出现的“善意的替定”并非来自某种恶意，它的认识前提是在制度的日常运转中被一层一层制造出来的。

– （一）第一层沉积：记录表从辅助记忆凝固成劳动的唯一度量

先从一张看似平常的护理员记录表说起。许多人以为这张表从一开始就是今天的样子——生命体征数据、三餐进食量、用药确认、康复训练时长，外加“异常事件记录”——仿佛它天生就是照护工作的脊骨。但把它放回二十年的时间里

看，会发现它经历了一场深刻的质变。大约在本世纪初，养老院的记录制度还相当松散。护理员的交接班主要是口头进行：“张奶奶今天胃口不太好”“李爷爷昨晚睡得不踏实”，有时写在值班日志的空白处，有时干脆不写。那时的记录表主要是辅助记忆的工具，它帮护理员记下该做的事，但没有人用它来定义“什么算工作”。照护者与老人之间的大量互动——坐在床边听老人讲一段旧事，陪老人一起看一会儿窗外，在老人沉默时什么都不说、只是坐在旁边——被默认为工作的一部分，尽管它们无法被量化。

但在接下来的十五到二十年里，几股力量合在一起，把这张记录表凝固成了衡量劳动的唯一单位。第一股力量是新公共管理改革进入养老服务领域：政府购买服务、第三方评估、星级评定，一系列制度要求机构必须用“可审计”的方式证明服务已经发生。第二股力量是机构内部的人力成本压力：护理员与老人的配比常年紧张，管理者需要用某种方式证明每一分钱花得值。第三股力量最细微，也最致命：工伤责任纠纷和家属投诉的增加，使机构越来越依赖书面记录来证明“我们该做的都做了”。记录不再是“帮我记住”，而是“保护我，证明我没有失职”。

三层力量叠加，记录表的性质就变了，它不再是辅助护理员工作的一张纸，而成了一面只反射可量化劳动的镜子。设想这样一个下午：护理员坐在老人身边，听她断断续续讲了四十分钟年轻时的旧事，老人说到某个地方落了泪，护理员没有打断，只是应着，陪着沉默。这一个下午在服务记录表上是一整块空白，护理员必须在交班前为它补填若干条目。她可以写“提供情感陪伴一次”，但这条记录和“协助进食”“测量血压”在统计表上没有任何质的区别。那个下午实际发生的事——老人第一次向另一个人说出了一件藏了几十年的事，这件事在她心里松动了，她那天晚饭吃得多了一些，虽然她自己也没察觉——没有任何一行格子装得下。同一个护理员，如果这天下午没有陪聊，而是完成了三项可以明确记录的工作：测了两次血压，协助完成了康复训练，记录了用药，系统会认为这后一个下午更“高效”，因为它生成了更多可量化的产出。这不是因为她不善良，也不是因为她冷漠，而是因为她在这个系统里生存下去的唯一方式，就是把

精力集中在可以被记录的事情上。到第二个月，她会更少坐到老人旁边去。没有人命令她这样做，是表格替她做了决定——不是在命令的层面，而是在定义“什么算有用”的层面。

这就是第一层沉积：记录制度从软到硬的钙化。它并不禁止照护者感知生迹，但它把感知生迹所需要的那种无目的、无产出、无记录的时间，在绩效定义上变成了“不饱和的工作”。这不是筛子把坏东西过滤掉了，而是把照护者感知“老人正在进行生命进程”所需要的最基本的生态条件，也就是不被绩效目光盯着的、可以空转的、没有产出的空白时间，给堵死了。

（二）第二层沉积：巡查的目光成为第二重滤网

如果说记录制度是第一层钙化，巡查逻辑就是第二层：它把表格化的“什么算工作”变成每日每时的、带着权力目光的现场纪律。一位楼层主管在走廊里巡视，看到一位护理员正坐在老人身边静静地听，手里没有血压计，没有在记录，没有在操作任何设备。主管未必当场批评她，但心里会记下一笔：这个员工的时间管理可能还可以改进。同一时间，走廊另一头，另一位护理员正在麻利地测量血压、填写表格、分发药物，主管走过去，点了点头，这个护理员“在状态”。

需要指出，巡查的目光本身也是被塑造的。这位主管并不是天生看不见倾听的价值。她做护理员的时候，也许比现在任何一位下属都更擅长陪老人说话。但升为主管之后，她被要求递交月度管理报告，上面列着本楼层的服务完成率、异常事件响应速度、老人满意度平均分，生迹不在这些字段里。她不是不想看见，而是看不见她没有被要求看见的东西，她的眼睛已经被绩效指标训练过，就像护理员的手被记录表训练过一样。一个月后，前一位护理员在绩效面谈中被建议“提升工作效率”。她没有办法为自己辩解，因为她无法说“那个下午，我觉得我接住了老人的一个东西，虽然我说不清那是什么”，这句话在绩效面谈中是无效的。她不会说，因为她知道这不会被理解。于是第二层钙化完成了：巡查逻辑让“空白”在职业生涯的意义上变成了风险。护理员不是被禁止感知生迹，她只是开始自动地、无意识地避免那些会让自己在主管眼里显得“不在工作状

态”的行为。这种自我规训比任何明文禁令都有效，因为它从内部调适了照护者的注意力组织方式：一个训练有素的护理员，眼睛自动扫向可以量化的指标——血压、进食量、活动次数——落在指标缝隙里的东西，她连“看见”的动作都省掉了。

（三）第三层沉积：反馈塌缩与感知力的集体退化

前两层沉积解释了为什么生迹的信息在生产端和监督端被系统性地切断。但还有更深的一层：当生迹的信息流被长期切断之后，照护者和被照护者双方都发生了一种更深刻的退化——他们丧失了感知生迹的器官。先看家属沟通这个环节。即使一位护理员确实感知到了生迹，觉察到老人最近有些不一样，眼神比前几天亮了一些，似乎心里有事，这份感知在抵达家属的途中仍要经过一道翻译墙。家属每月收到的报告上印着各项指标的趋势图：血压控制情况、活动参与次数、饮食规律性评分。没有一份报告会写下这样一行字：“您父亲这个月自发翻看了几次旧相册，虽然什么都没做成，但那段时间他的眼神是这半年来最亮的。”

问题还不止于翻译损耗。当前两层已经系统性地截断了生迹的信息流之后，家属沟通面临的就不再是“信息丰富但需要翻译”，而是“根本没有任何生迹信息可以翻译”。家属即便诚恳地问一句“我母亲这些天心情怎么样”，护理员手头能给出的回答也只能是她记录过的那些——生命体征平稳，三餐正常，参加了两次集体活动。那个在窗前坐了半个下午、后来自己翻出旧相册的动静，没有进入过任何一条记录，护理员自己也已在交接班的忙碌中淡忘了它，她无法告诉家属任何东西。

更深的退化还在后面。当照护者与被照护者双方都在长期的失认中被“社会化”为只关注需求指标时，他们丧失的不只是信息通道，更是感知力的共同衰减。一个护理员，如果连续三年每天的工作都是填表、测量、分发药物，不是她不愿意陪老人说说话，而是“陪说话”那根神经因为长期不被调用，已经退化了，就像一个从不训练听力的音乐学生，不是他不想听出绝对音高，而是耳朵已

经长不出那个分辨力。同样，一个老人如果连续三年每天被问的都是“您今天感觉怎么样？血压正常吗？需要什么吗？”，他也会慢慢学会只回答这些。不是他不再有生迹，而是他的生迹发出装置，也就是用微小的动作、模糊的语言、沉默的朝向去表达内在涌动的能力，因为长期没有回音而变得迟钝了。生迹是一个双向的感知回路，既需要护理员有接住的能力，也需要老人有发出的能力，而长期失认同时消磨了这两端。

– （四）三层沉积的合拢：自锁循环

三层钙化合拢，照护系统在生迹这个维度上就完成了一个事实上的自锁循环：生产端不让它被记录，监督端不让它被正当地花时间，反馈端因此完全收不到任何关于“老人除了指标之外还在发生什么”的信号；而双方感知力的共同退化，又使得即使制度突然为生迹留出空间，照护者和被照护者也已经不知道该往那个空间里放什么。这是一个丧失了自我纠正可能的信息生态——不是任何一个角色不想知道老人的生迹，而是这套制度的日常运转自动地把生迹变成了系统感知之外的东西。系统自信运转良好，因为指标上没有异常；而老人的眼神变暗这件事不在任何一张表上，于是对系统而言它从未发生。

在此基础上，可以更清楚地定位此前照护批判中常被论及的两个现象：替代性发生与效率性失明。失认是制度性根源，替代性发生是操作层面的表征，效率性失明则是认识上的闭合。所谓替代性发生，是照护者对服务对象生迹“应当回应而未回应”的堆积后果：当一个老人连续不断地发出生迹——沉默、犹豫、微小的冲动——却从未被接住，他开始不再发出。因为发出而没有被回应，比不发出更苦。他想去创造的冲动慢慢熄灭，想自由行动的余地悄悄收缩，生活里本该有的幸福感也因缺乏过程的张力而变得空洞。老人不是被服务“替掉”了能动性，而是被反复的“没接住”耗尽了发起的冲动。效率性失明则是系统对这种“没接住”无法自知的制度锁死：它用指标过滤了一切，指标上什么异常都没有，系统于是自信运转良好。这两者不是独立的机制，而是失认生迹的两种递进表现。这里也已经能看到全书母题的第一道接口：失认是后面一切替定得以发生的认识条件。

（五）冲动萎缩的生成机制：一个微型模型

“被耗尽了发起的冲动”这句描述，不能停留为一个诗意的比喻，它需要被推进为一个可追踪的生成过程。生迹的发出需要回音来维持，这不是情感需求层面的陈述，而是身体图式层面的事实。借用现象学对身体习惯的分析：一个人的意向之弧，只有触碰到世界的轻微抵抗或回弹，才能完成自己。生迹——一个老人朝向窗外的凝视，一张废纸上画的两个不规则的圆，一句“瞎画的”——都不是完整的行动，它们是意向的投出。每一次投出，都像一个发向虚空的手势：如果它触碰到另一个人的目光、一声不经意的回应、一次不予追问的搁置，那个意图就在外部世界中找到了一个轻微的着力点。这个着力点不需要是赞同，甚至不需要是被理解，只需要是“被触到了”。触到之后，意图就可以从那个着力点上借一点力气，继续往前探一步。

如果不被触到呢？第一次，老人自己可能都没有注意到。第二次，他的身体还在做那个向前探的动作，但已经有了一点不易察觉的收回。第三次，他不再往前探了，却会对自己说：“我本来也没想做什么。”这不是自欺，而是身体学会了不再向外投射，因为投射不到回音的动作，在身体记忆中会被标记为“无效输出”，就像连续击打一块回力很差的球拍，手臂会自动调整力量，直到不再发力。无回应，意向之弧就在虚空中散架。这解释了为什么一个老人从“偶尔发出生迹”到“不再发出”的过程，往往不是一场戏剧性的事件，而是一种无声的、连他自己都未察觉的消磁。他不曾“决定”停止，他失去的不是一个已知的选择，而是一股他自己也不认识的涌动——它还没成形，就被抽走了发生的条件。需要说明，“消磁”不同于基于可识别厌恶刺激的习得性无助，也不同于个体有意识的放弃或认命：它的特点是无意识性与非对抗性，不是当事人决定不再发起，而是发起所需要的那股内在的电，因为长期找不到回路而悄然停摆。到了这一步，即使外部环境突然变得对生迹友好，来了一个愿意接住他的护理员，老人也已经不会发出那种信号了。他需要的已不只是“被接住”，而是先要被重新充磁——那是一个比“提供好的照护关系”更难、更慢、更不确定的过程。

用这个微型模型重新理解整条失认链条：记录制度切断了意向的回弹，护理员不是不想回应，而是她的注意力已被表格重新组织，没有看见那个投出的动作；巡查逻辑惩罚了那些花时间去触碰意向的护理员；反馈塌缩使这种双向的失联成为常态；而常态持续得足够久，意向投出的那根神经就在照护者与被照护者双方的身体里退化了。三层钙化的终点不是一个“坏制度”，而是一整片被去磁了的生命场域。

– （六）反例：生迹被善意地“服务化”回收

三个现场中，鸟窝案例展示了生迹被部分接住的情境。但还有一种更尖锐的情境值得专门呈现：生迹被发出之后，被系统明确地、善意地，却以“服务化”的方式回收了。周师傅提出“想做鸟窝”之后，工作人员只提供了最轻的支持——信息、工具渠道、一点空间，他没有被纳入任何项目。现在换一种反应来想：假设机构的反应极其高效，第二天就在活动表上增设了“木工兴趣小组”，配备了全套进口工具，安排了每周两次的固定时间，由一位实习社工负责撰写活动记录。第一次活动时，周师傅到场，看到工具整齐地摆在工作台上，还有四位老人被社工动员来“一起参与”。他站在门口愣了一会儿，说“哦，都准备好了”，做了半个小时，就说累了。此后他不再主动提鸟窝，也很少再去看院子里的那棵槐树。（这一段是对不同反应的推演，用以与实际发生的情形对照。）

这才是最致命的一击。不是系统拒绝了他想做鸟窝的请求，而是系统太高效地把他的生迹接过去、包装好、交还给他，变成了一个和每日康复操并列的“活动项目”。在这个包装过程中，鸟窝和他的生命故事之间那根最细、最要紧的线被轻轻剪断了，他再也感觉不到“是我做的”。需求模型回收生迹的方式不是否定它——那太容易被识别了——而是承认它，然后把它翻译成服务语言，纳入服务流程，成为又一个服务项。在这个翻译过程中，生迹作为生迹的唯一不可替代的质地，即那个由老人自己发起、自己承担、自己冒风险、自己体验“这是我做的”的生成动作，被无声地清空了。系统不是看不见周师傅的鸟窝：它看见了，回应了，甚至比任何低效的回应都更“专业”。但恰恰是这份专业把生迹杀死了，不是掐灭，而是翻译致死。这个反例把生迹与需求、偏好的区分钉在了最尖

锐的经验现场，也提前预告了下面几章的主题：当看不见之后的系统开始以自己的答案填空，填得越精准，越难被察觉。

◆ 五、近邻的分殊与跨界的检验

失认论不是凭空提出的，它与二十世纪以来社会批判传统中的几支重要理论有可以辨认的亲缘，但更关键的是它们之间的分殊。廓清这些边界，既是对既有理论的尊重，也是对本章判断的巩固。下面依次与伊利希、戈夫曼、波伏娃、照护伦理学和现象学身体理论切割，最后把失认推入教育与城市规划两个场域，检验它的结构同构性。

– （一）与伊利希“工具反向”的区分

伊利希（1976）的“工具反向”指的是：当某一制度性工具的规模越过临界阈值后，它便不再服务于原初目标，反而系统性地制造它声称要解决的问题。它与失认论在结构上有家族相似，都是系统善意的自我否定。但工具反向的前提是量上的过度。伊利希反复使用“阈值”“过度”“垄断”这类概念，其暗含的推论是：只要把工具的规模控制在临界值以下，反噬就可以避免。失认讲的不是量的过度，而是质的错位。一个老人可能仅接受了最低限度的照护——血压监测、药物管理、基本三餐——每一项都合理适度，没有任何一项是“过多”的。但只要这些服务的制度基础把他默认为需求集合，而不是生命进程的进行者，生迹就已经被筛在系统之外。不是工具因为太大而反噬了目的，而是工具从一开始就装错了目的：它被设计来管理风险、满足需求，却从未被要求去辨认一个老人的生命此刻正往哪个方向走。失认论因此从“过度”的外延批判，推进到“地址”的内核追问。

– （二）与戈夫曼“全控机构”的边界

戈夫曼（1961）的“全控机构”揭示了封闭式管理机构的规训特征：统一作息，统一空间，以机构逻辑取代个体差异。被收容者知道自己被管，他们会愤怒，会反抗，会在规则的缝隙里保留自己的小动作。在失认论所描述的照护系统

中，权力被彻底藏进了关怀的内部。没有人在管，所有人都在服务；所有体贴都有数据支撑，所有限制都包装成“为了您的安全”。老人无法反抗，因为找不到可反抗的对象；甚至无法抱怨，因为一旦开口，连自己都像个不知好歹的人。比全控机构更深一步的是：在全控机构里，一个人知道自己失去了什么；在失认的照护中，一个人可能从头到尾都不知道自己曾经还有另一种可能。

– （三）与波伏娃“严肃精神”的分别

波伏娃（1948）在《模棱两可的伦理学》中提出“严肃精神”，指个体把价值看作客观地外在于事物，主动把自由让渡给一个“理所当然”的外部权威。在养老语境中，部分老人确实可能主动选择“别让我操心了”的被动态。但失认与严肃精神运作在不同的层面。波伏娃的分析并不只是个体心理学，她在《第二性》（1949/1953）中深刻论证了制度结构如何通过社会化过程，让女人把对自己的处置体验为“理所当然”，从而“自己选择”不自由。这个分析的核心运动是内化：一个外部规范体系被个体吸收为自己评价自己的标准，女人“选择”不自由，是因为她已经用父权的眼睛看自己了。这一模型预设了一个环节：个体主动地，尽管是在结构压力下，执行了把外部价值体系内化为自我正当性的动作。

失认所描述的处境比这更早。一个老人从入住的第一天起，衣柜里就已放好了按季节搭配的成套衣物。不是有人命令他不许自己选，而是“为他选好”这个动作被定义为服务质量的体现，被嵌入标准操作流程，被交接班制度逐日迭代。他从入住起，就没有在这家机构里体验过“自己决定明天穿什么”的完整的对照经验，不是他选择了不操心，而是选择所需的对照经验被从旁抽走了。当他说“我不想操心”时，“操心”这个动作所依赖的最小的自主决断记忆，已经在他身体里中断了。他不曾“交出”自由，因为在“交出”这个动作可能发生之前，那些本该让自由被体验到的日常微决策的接口，就已经被善意地从他生活的缝隙里拆除了。这是比严肃精神更前移的一层：不在“交出自由”的层面，而在“自由的日常微操作被预先替代”的层面。这一点也是本书后面各章的预告——在这里，替定已经以最日常的形态出现了。

（四）与照护伦理学的交锋：为什么“照护的逻辑”仍然不够

照护伦理学及其衍生的“关系性自主”概念已经论证过，人的自主不是原子化的个体能力，而是在关系中被支持、被维持的。Tronto（1993）把照护从私人领域提升为一种公共美德与政治责任，为批判照护中的权力不对称提供了宏观框架；Mol（2008）则在这一传统内部做出了最有力的一步推进：她批判“选择的逻辑”，即把患者视为独立的选择者、把照护的任务理解为提供足够的信息和选项，而主张“照护的逻辑”，即照护的核心不是让患者选，而是在日常的、琐碎的、持续调试的照护实践中，照护者与患者一起慢慢摸索出什么是好的。本章选择与Mol直接对话，是因为她的“照护的逻辑”最贴近本章追问的层面，而在精神上，失认的分析同样受惠于包括Tronto在内的整个照护伦理学传统对照护的重新奠基。

生迹与“照护的逻辑”之间有深刻的共振：都拒绝把照护对象看作只需要在现成选项之间做出偏好的选择者；都强调照护中那些无法被量化的、在具体情境中慢慢浮现的东西；都质疑“需求—供给”这对概念的充分性。但本章必须指出，“照护的逻辑”也有一处盲区，而这处盲区恰是生迹要打开的空间。Mol描述的画面是，照护者与被照护者一起在日常实践中试探、调整，寻找什么对这个人当下是好的。这个“一起”极其美好，但它预设了被照护者能够参与到共同摸索中来：他能表达，能拒绝，能在试错中给出反馈。Mol或许会反驳说，她所描述的“照护的逻辑”恰恰是避免老人进入消磁状态的根本方法，消磁，即老人不再自发表达、不再拒绝、不再试错，在她看来可能正是“选择的逻辑”过度取代“照护的逻辑”的结果。如果Mol的路径本来就能预防本章所说的恶果，那么本章的批评就只是补全了她，而没有越过她。

这正是对话必须攻克的要害。本章要论证的是：即使最彻底的“照护的逻辑”，那种充满调试、尊重关系的实践，仍可能在善意的“一起摸索”中，无意间用团队的轻重缓急替代了老人自己最幽暗的、可能对抗团体的生迹。因为“一起摸索”这个动作本身，已经预设了一种共同性：照护者和老人在同一个方向上看着同一件事，一起试探什么对他好。但生迹有时恰恰指向另一个方向，它可能

与照护者的判断不一致，甚至与照护者认定的“对他好”相悖。土酒老人想喝的那口酒，在任何一种“照护的逻辑”的实践中都会被识别为“对他不好”，他的身体指标会恶化，照护者也有专业责任劝阻。一个认真践行“照护的逻辑”的照护者会怎么做？她会和老人一起探讨：你为什么要喝这口酒？这口酒对你意味着什么？我们一起找一种既不会恶化身体、又能让你感觉到那个东西的方式，可以吗？这个试探的过程，按任何标准都是好的照护，却错过了一件事：老人并不是在寻求一种替代性的满足方案，他就是要那口酒——那口被医生禁止的、对身体不好的、他自己要承担后果的土酒。那个动作的不可替代性，恰恰在于它是他发起的，是他决定冒险的，是他承担后果的。在这个意义上，“照护的逻辑”再好，仍然是在“一起摸索更好的方案”的框架内运作，它无法容忍一个老人做出“对自己不好”的决定；而生迹有时恰恰以“对自己不好”的面貌出现。

这不是否定Mol的价值。Mol正确地指出了“选择的逻辑”的限度。本章的论证则指出：“照护的逻辑”也有自己的前设——它不仅预设了一个能参与共同摸索的被照护者，更预设了“摸索出对他好的东西”是照护的最高目标。而生迹论追问的是：如果照护的最高目标不是“对他好”，而是“让他自己生成对他自己的好”，哪怕那个“好”在照护者的专业判断里并不好，那么照护系统应当如何重新设计自己？这一步，是照护伦理学现有语汇尚未涵盖的。

– （五）与现象学身体理论的补充对话

还有一条与本章判断有深层亲缘的理论脉络：现象学传统中对身体习惯与空间居住的论述。梅洛-庞蒂（1945）关于身体图式与习惯获得的讨论，以及列斐伏尔（1992）关于日常生活节奏的分析，都指出了一种重要的区分：人在世界中的存在感，很大程度上由那些不需要经过明晰意识就能完成的日常动作所维持。一个人早上自己拉一下窗帘，感受一下气温，再决定穿什么——这个动作序列不是选择，甚至不是偏好表达，而是身体层面与环境之间的持续调试。它维系着一种“我住在这里、我应对着我的生活”的存在性触觉，这种触觉不以命题形式出现在意识里，却构成了自主感最底层的生理基底。

生迹的论述从这个传统中借取了一层理解：一个老人被照护系统从这些日常微决策中“解放”出来，不必再操心穿什么、吃什么、药什么时候吃，功能上他获得了效率，但在存在论上，他失去了一个他并不知晓其名字的东西，即他的身体与环境之间那些细密的、不经意的调试动作，被从旁接走了。这种接走不是剥夺他已有的东西，而是让他还没有机会意识到那个东西的存在，就已经不再有做出那个动作的日常条件。现象学身体理论为“被卸掉的是什么”提供了哲学上的精确性，它解释了为什么被服务得很好的老人常常会说“没什么不好，只是说不上来，好像哪里不一样了”。那个“说不上来”，正是身体记忆的消失。本章在这个追问上补上了现象学身体理论尚未覆盖的一环，也就是上一节的微型模型：意向之弧如何在持续无反弹的环境中，从内部散架。

（六）跨界检验：教育中的“学迹”与城市中的“居迹”

一个新辨别维度如果只在一个原发领域内有效，它可能只是该领域特有的经验概括。因此，下面把失认推入教育与城市规划两个不同场域，检验它的跨界解释力。检验的目的不是证明生迹无所不包，每一个跨界案例都必须从该场域自身的特定矛盾中结算出自己不可还原的辨别面，而不是从养老场景简单移植。

在基础教育领域，自适应学习系统可以精确诊断每个学生的知识薄弱点，推送定制化练习，表面成绩有所提升，但越来越多的教师报告：学生主动提问的频率在下降，遇到不会的题目不再自己磕一磕，而是直接看解析。已有研究识别出“过度脚手架效应”：接受高度结构化提示的学生在当堂测试中表现更好，但在延迟测试中显著差于那些只得到最低限度反馈、被迫自己摸索的学生；更关键的是，前一组在面对新题型时表现出更高的焦虑和更早的放弃倾向，他们已经丧失了在没有脚手架的情况下建立学习节奏的肌肉记忆。从失认的视角看，这不仅仅是替代。在需求模型——学生的知识薄弱点清单——的全面覆盖下，学生作为学习者的“学迹”，那种“我自己想知道什么”“我自己想往哪里再想一步”的主动探索冲动，被系统性地失认了。系统把学迹翻译成“待补的知识点”，再用精准推送补上，补得越准，学生自己补的肌肉就越萎缩。但教育场域有一个养老照护不具备的特异性矛盾：在养老中，老人被卸掉的是自己做日常决定的最基本

的维生性动作；在教育中，学生被卸掉的则是自己面对未知时摸索出第一步的认知性张力。前者消解的是存在性触觉，后者消解的是认识上的勇气。学习中最要紧的突破，恰恰发生在“我确实不知道，但我还在里面待一会”的不舒服里。因此教育中的失认，重心不在“无法学”，而在“无法不学”——不是学习能力被剥夺了，而是承受认知不确定性的那根神经，被精准服务体系喂养得萎缩了。这一特异性矛盾无法被生迹的原型完全覆盖，需要教育场域自己持续挖掘。

在智慧城市建设中，一些高端智慧小区实现了高效管理：人脸识别门禁，公共空间利用率实时调度，物业应用程序统一处理所有报修与投票，管理指标年年第一。但住户的深度访谈中反复出现一种表达：“干净得不像能住人的地方。”一位住户回忆，刚搬来时楼下有块空地，不知被谁种了几株薄荷，虽然乱糟糟，却飘着一股清凉味；半年后被物业统一规划成标准化花坛，薄荷被铲了，换成修剪整齐的灌木。她不是舍不得薄荷，而是隐隐觉得，这块地从那以后不再欢迎任何未经规划的东西了。从需求—供给的框架看，这个小区的服务堪称完美，居民的每项生活需求都被高效地包裹起来。但失认的分析揭示：被系统性筛掉的，是居民作为居住者的“居迹”——“我住在这里，我想让这里有一点点我的痕迹”的微小而具体的冲动。这冲动不等于需求，它不是在满意度问卷上打一个“希望有更多公共绿地”的勾，而是在某个下午蹲下去种了几株薄荷。当管理系统追求零死角、全覆盖的效率时，居迹被系统地消除了，居民从居住者变成了被服务者：你可以享受一切，但你不能再在这里踩下自己的脚印。

城市领域同样有养老不具备的特异性：在养老中，生迹被筛除的制度载体是护理记录表与巡查目光，背后是健康管理逻辑对生命进程的覆盖；在城市中，居迹被筛除的制度载体是物业标准化与公共空间使用率优化，背后是资产管理逻辑对居住行为的覆盖。前者指向安全与健康的过度代理，后者指向效率与秩序的过度执行。失认的结构相似，制度载体与被代理的对象不同，所以“居迹”并非“生迹”在城市领域的简单复制，它需要在空间使用的物质性、社区治理的权力结构，以及“家”的现象学中被独立研究。

两个跨界案例与养老照护的原发案例之间存在清晰的结构同构：都有一个以“帮助人”为使命的系统，把对象默认为待满足的需求集合或待优化的指标载体；都在这个预设下必然地筛除了对象作为正在进行中的生命进程所特有的指向性信号；都产生了对象主动发起冲动的系统性萎缩——这种萎缩不被任何指标捕获，因此系统自信运转良好。但每个场域中失认的内容与失认的制度载体各自不同，不能相互还原。跨界检验要展示的不是“失认是个万能框架”，而是：如果三个不同领域的系统在各自独立的运行中，都以结构同构的方式产生了指向性信号的系统性遗漏，那么这个遗漏很可能不是养老照护碰巧有的一个特殊问题，而是“需求模型”作为一个更大范围内的治理范式所携带的沉默代价。

◆ 六、边界、反驳、证伪与最小的实践入口

– （一）边界与最强的反驳

失认论不主张所有老人在所有情境下都必须被“看见生迹”。防跌倒、用药管理、基本营养这类刚性需求上的代理正当且必要；严重认知功能障碍的老人已无法产生可被解读的指向性痕迹，此时需求模型的照护是唯一现实可行的路径。应被提醒的，是那些心智尚有余力却被需求模型全覆盖的老人，尤其是刚入住、一夜之间从“生活自理者”被重新定义为“被服务对象”的人：失认的第一击就发生在这道门槛上，最迅速，也最难察觉。

最强的反驳来自一线：假设护理员面对一位沉默了三个月的老人，一直在“尊重自发”，但这段沉默不是生迹的孕育期，而是抑郁在加重，那么她的等待就是放任自毁，事后在悲剧审查中说“我以为那是他的生迹”，能作为辩护吗？回应之前，必须先走过她的恐惧：理论把辨别的责任交到她手上，给她的却是一种新的恐惧。她若承受不了，就会退回最安全的姿态，把所有沉默都当作抑郁风险，一概积极干预，于是生迹论反而加剧了它要化解的失认。所以理论必须给她一副可以在灰色地带安全行动的护具，分三层。第一，辨认生迹不是等待答案，而是追踪运动。退行性沉默与生迹的静默孕育期在某个横截面上可能一模一样，但拉长到连续几周，差异会浮现：退行是运动性的总体递减，抬头的次数越

来越少，目光停留越来越短，对窗外越来越没有反应；孕育期则表面沉默而内部仍有反复的、试探性的微动，连续几天在同一时间望向同一个方向，某个话题被提及时身体微微前倾又缩回。

第二，建立有节律的交叉校验与“安全失败”规则：每两周在交接班或短会上，把不同护理员与家属的观察拼在一起，多人多日都显示运动性在减少，就启动专业评估；无法辨别时，在保留观察空间的前提下，优先按抑郁响应流程启动最低程度的关怀干预，如增加非结构性探视、每周由固定护理员做一次不预设话题的简短交谈，同时严禁任何“为他好”而强行安排的积极活动。这条规则在两个方向上都设了安全网，护理员可以对自己说：我没有放任，也没有破门而入。第三，必须承认灰色地带不可完全消除，老人可能同时既在发出生迹的微动，又处于缓慢的退行中。但这不是生迹独有的风险，拒绝进食是自主表达还是抑郁症状，不爱活动是性格还是病理性退缩，一线照护者每天都在处理这类模糊。生迹论没有制造新的难题，它只是把一种此前不被承认、因而不被制度追索的模糊性，摆上了照护的桌面。

– （二）两个极限情境

其一是重度失能的最后阶段，老人已无力发出任何生迹。此时照护的正当路径回归需求模型，失认不是道德指控。但失认论在这里提供一个关于照护记忆的伦理向度：曾在有能力时被认真接住过生迹的老人，其生命故事在照护者心中已有不可磨灭的形状，她更换护理垫的手法轻重，擦身时是否同时擦拭了他的过去，都由这个“知道”决定；而一个从未被感知过生迹的老人，最后阶段只能在需求清单的逐项勾除中悄悄滑出这个世界。它指控的不是那时的照护者，而是在这之前的漫长照护中，从来没有人看见过他。（这一点在第九章将被推到底线处重新讨论。）其二是“沉静的收摄”。生迹论不预设爱折腾的老人更本真，生迹是指向性痕迹，方向可以是向外探索，也可以是向内收摄。一个经历动荡一生的老人在阳光下什么也不想做，但他的安静是满的安顿，把它诊断为消磁，就把生迹论变成了新的规训。二者的区分仍用运动轨迹：消磁是意向本身不再萌发、情感张力流失、对“不再想要”没有任何叙述；收摄是运动性的自然转换，安静中

有充实，他会说“我现在这样挺好”。一个是意向的衰退，一个是意向的转向，生迹论只命名前者。

（三）本章的证伪条件

第一预言：若存在一个完整的照护系统，记录、巡查、绩效制度与当前主流机构相同，以量化指标为核心，而照护者仍能持续地、非偶然地感知并有效回应生迹，且这种能力不依赖个别护理员的禀赋而是制度本身支撑的结果，则“当前制度结构必然筛除生迹”的判断需要被否定或重大修正。第二预言：若一项培训干预仅教会护理员在交接班时口头汇报“今天有没有哪个瞬间，你觉得哪个人和往常不太一样”，不增加记录负担、不与绩效挂钩，而老人在长程随访中的自主行动频率、生活满意度、对自身生活的叙述性评价均无显著改善，则“为生迹创造可共享的语言通道即可改善失认”的操作主张需要修正，并意味着失认已沉积到照护者与老人双方的感知力内部，那将是更沉重的新追问：感知力是在职业社会化之初就被需求模型塑形的，重建要从照护者培养体系的根基开始。

（四）交接班时的一句话

因为任何以完整方案形态出现的建议，都可能再一次以系统的名义去代理照护者自己的感知，所以只设一个最小的入口：在交接班的五分钟里，血压、用药、异常事件交接完毕之后，多加一句非强制的口头提问——“今天有没有哪个瞬间，你觉得哪个人和往常不太一样？”不必分析，不必记录，不必跟进，只是说一遍，听一遍，让那个无法归类的“不对”第一次有了语言的容器。若持续三个月以上，生迹的共享感知将形成一种非正式的集体记忆，为制度永远装不下的那层东西在照护者心里开一扇侧门。若三个月后团队里仍没有人能说出任何一个“不太一样的瞬间”，这句话就成了诊断装置：失认已钙化到感知器官内部。田野中有过一个未被记录的正面案例：一位护理员连续数月在沉默老人的房间门口放一盆他年轻时种过的花，仅此而已，不曾上报，而老人某天忽然对她讲了一段从未对人说过的往事。最小入口的设计，正受到这类案例的启发。

◆ 七、本章小结：看不见的第一步，与交给第二章的问题

本章在“看不见—抢先替定—长不出”的链条上只走了第一步。照护系统在“需求”这个地址上找人，所以看不见老人正在成为谁；而看不见并非谁的恶意，是新公共管理、风险规避与绩效文化沿着记录表、巡查目光和感知力退化逐层沉积的壳。这层壳有两个后果：它使系统自信运转良好，因为指标上没有异常；它还为后面的替定铺好了认识上的前提，因为一个看不见对方答案的系统，只能用自己的答案去填那个位置。周师傅的反例表明，哪怕善意地、专业地回应，也可能翻译致死。

不过，生迹至少还是老人此刻可以做出、有时也能说出的东西：一个动作，一句闲话，一个“想做鸟窝”。下一章要追问更深的一层：有些痕迹连老人自己也无法指认，它们是没被选中的、没完成的、没被记住的东西，是被照料得很好之后留下的空无。那里，善意的填充将以更温柔的方式出现，下一章称之为残迹。

本章参考文献

de Beauvoir, S. (1948). The Ethics of Ambiguity. (B. Frechtman, Trans.). Philosophical Library. (Original work published 1947)

de Beauvoir, S. (1953). The Second Sex. (H. M. Parshley, Trans.). Jonathan Cape. (Original work published 1949)

Goffman, E. (1961). Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. Doubleday.

Illich, I. (1976). Medical Nemesis: The Expropriation of Health. Pantheon Books.

Kapur, M. (2008). Productive failure. Cognition and Instruction, 26(3), 379-424.

Kitwood, T. (1997). Dementia Reconsidered: The Person Comes First. Open University Press.

Lefebvre, H. (1992). Éléments de rythmanalyse: Introduction à la connaissance des rythmes. Éditions Syllepse. (Published in English as Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life, trans. S. Elden & G. Moore, 2004, Continuum).

Merleau-Ponty, M. (1945). Phénoménologie de la perception. Gallimard. (Published in English as Phenomenology of Perception, trans. C. Smith, 1962, Routledge & Kegan Paul).

Mol, A. (2008). The Logic of Care: Health and the Problem of Patient Choice. Routledge.

Tronto, J. C. (1993). Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care. Routledge.

◆

02

第二章

残迹：被照料得很好的空无

◆ 一、一个没有被任何人看见的下午

设想一个再平常不过的下午（以下场景依据下文周阿姨的田野片段简化而成）。三点钟，养老社区的窗边坐着一位七十八岁的老人，退休前是小学教师。手腕上的健康手环显示心率平稳，音箱安静，护理员在隔壁房间核对当天的用药记录。系统在后台给她的状态打了一个标签：静止，四十七分钟。她没有读书，没有交谈，没有望向任何特定的东西，窗外偶尔有一只鸟飞过，她没有抬头。如果此刻有人走过去，轻声问一句“您在想什么”，她大概会愣一下，然后说：“没想什么。”这个回答不是推托，而是全部的事实。

这个下午在任何一份照护质量报告里都不会出现。它不是需求，因为没有人缺少什么；不是行动，因为没有什么被发起；不是故事，因为它不会被讲给任何人听，连她自己几天后也不会记得。可是，如果把这样的下午一个一个从她的生活里取走，换成同样周到、同样善意、同样“对她有益”的安排，她的日子会发生什么变化？陈晓艳在田野里听到的回答，是她自己说出来的一句话：“挺好的，什么都不缺。就是……感觉日子像别人替我过的。”

本章要讨论的，正是这个下午里没有名字的东西。在本书的整体论证里，它处在一个需要小心安放的位置。全书的母题是：精准的善意抢先替生命定下“好”的样子，替得越久，生命越长不出自己的答案。这个母题展开为三步：生命自己一直在给出答案，而越精准的系统越看不见这些答案；看不见之后，系

统用自己的答案抢先填进那个位置，这一步本书称为替定；替定持续得越久，生命自己摸索、判断、重组的能力越萎缩。第一编讲的是第一步，“看不见”。

第一章处理的是照护看不见老人的生迹，也就是老人正在成为谁的那些指向性痕迹：一个人开始留意窗台上的花，一个人反复整理旧信件，这些痕迹有方向，朝向某种尚未完成的自我，照护却在“需求”这个地址上寻找老人，因而对它们视而不见（见第一章）。生迹虽然不被照护看见，但它至少是老人自己可以指认的：问他，他也许会说“我想把那些信理出来”。本章要往更深处走一步。在生迹之下，还有一片连老人自己也无法事先指认的东西：未被选中的念头，未被完成的动作，未被记住的片刻。它们没有方向，没有目的，没有任何事后可以被称作“收获”的结局，却占据了一个人实际度过的时间中相当大的部分。本书把它们称为**残迹**。

这一步“看不见”比第一章的更彻底，也更危险。因为在生迹那里，照护的失误还是一种遗漏：它没有看到本应看到的东西。在残迹这里，失误的形态变了。系统不再是单纯地没有看见，而是在没有看见的同时，用一套周到、温暖、无可挑剔的安排，把残迹所需要的空白一格一格地填平。这种填平不施加任何力，不带任何注视，被填平的人感受到的不是被控制，而是被关心。本章把这种运作方式称为**善意填充**。也就是说，本章处在“看不见”与“抢先替定”的交界上：看不见是起点，填充已经是替定的一种最温柔、也最难被察觉的形态，它替定的不是老人该做什么，而是老人的时间里不允许有什么。

本章因此承担三项任务。第一，把残迹作为一个存在层位命名并划清边界，说明它为什么不能还原为自主性、叙事能力、需求、现身情态乃至海德格尔的深度无聊。第二，说明善意填充怎样在数据化、日志化与善意三重耦合中运作，又怎样被机构问责、一线执行与产业资本的需求锁定为稳固的范式，并论证它是一种不能被以“施加”为起点的权力分析所捕获的新权力形态。第三，提出残迹敏

感型照护的三条消极纪律，逐一面对它必须经得起的质疑，最后给出这个主张最脆弱的地方在哪里。

◆ 二、三个老人，三种空白

理论的命名必须先站在经验上。本节取材于陈晓艳2020至2023年间在华东多家养老机构的田野观察与半结构访谈，人物已匿名化处理，场景由多个来源合成并简化。这些材料仅用于理论建构与现象例示，并不构成经过同行评议的系统性实证数据，这一限度在此需要说明。三个案例分别来自高智能化机构、中度智能化机构与居家养老，老人的认知状态也分别是完好、轻度受损与中度受损。选择这样的分布，是为了表明所要讨论的现象并不依赖于某一种技术条件或某一种认知状态。

在进入个案之前，先交代一个让人不安的现场。我国六十岁以上人口已超过2.6亿，其中失能、半失能老人超过4000万，传统养老资源在数量、结构和质量上都存在严重短板。智慧养老在这样的背景下带着巨大的诱惑力登场：可穿戴设备实时监测体征，智能音箱按偏好推送内容，大数据预测跌倒、管理慢病，系统不疲倦、不遗忘、不偏私，能以超越人力的精度识别需求、调配资源。在这些看得见的战场上，它取得了不菲的成就，这一点不应被否认。然而在不少已经引入这类系统的社区里，田野中出现了一种耐人寻味的现象：设备越齐全、服务越周到，一部分老人的精神头反而越萎靡。他们接受推送的活动、菜单和健康建议，眼神里却没有主动期待的光；他们习惯了被监测、被提醒、被安排，却越来越少提出问题、发起行动、制造“意外”。一位老人这样形容自己：“我感觉自己像一件被照顾得很好的展览品，什么都不缺，但什么都跟我没有太大关系。”

一位在养老机构工作了十二年的护理主管给出了一个更精确的观察。她说，刚入行的时候，老人们会跟护理员吵架，嫌饭菜不好，嫌活动无聊，嫌管得太

多；现在智能化了，饭菜是根据健康数据配的，活动是根据兴趣标签推的，按理说他们应该更满意，“但他们不怎么吵了。他们只是……算了”。这个“算了”比任何争吵都更值得认真对待。争吵意味着老人仍然把自己的生活当作一件需要争取的事情，而“算了”意味着一种更根本的退出。

周阿姨，七十八岁，退休小学教师，五年前搬入一家配备全套智能设备的养老社区。入住之初她很新鲜：手环让她觉得有人时刻关心着自己，音箱推送的戏曲选段让她惊喜，系统依据步态分析推荐的太极班她也乐意去。大约一年后，变化悄悄发生。她的一天被系统配置成固定的节奏：早上八点提醒测血压，十点推送当日活动，下午三点弹出用药提醒，晚上七点因“情绪波动指数”略升而推送怀旧歌单。一切都在运转，所有功能都正常。她却越来越沉默，不再提出新想法。她曾想借一本植物图鉴来辨认社区花园里的花草，但这个念头从未被系统捕捉到，因为她身上没有“植物学兴趣”这个标签。她开始拒绝一些活动，又说不清原因。护理员发现她常常坐在窗边，长时间看着窗外，什么也不做。

陈伯伯，八十二岁，退休工程师，两年前搬入一家只有基础呼叫系统和活动打卡APP的普通养老院。这里的照护更接近传统：护理员按班次巡视，活动由社工口头通知，老人有大量不受技术监控的空闲。他的日程在APP上看起来很空，每天只记录一两项正式活动。但他的生活并不空。每天早晨他固定绕院子走三圈，不是锻炼，走得很慢，看看花，跟遇到的护理员闲扯两句，在长椅上坐一坐。下午他坐在阅览室角落翻报纸，翻着翻着睡着了，报纸盖在脸上，谁也说不清他看了几行。晚上他有时端着茶杯站在走廊尽头，看马路上的车灯来来去去，看一会儿就回去睡了。问他“今天怎么样”，他说“还行吧，跟昨天差不多”，语调里有一种没有什么词能装下的安然。与此同时，他的认知正在缓慢下降，记不住新护理员的名字，偶尔忘了自己吃过药没有。但那些没有目的的小动作并没

有减少。相反，随着他对时间和事件的线性记忆逐渐模糊，这些不进入叙事、不依赖记忆索引的碎片时段反而更加显眼。

李奶奶，八十五岁，独居，女儿每天上门照料，家中只有一个一键呼叫器，没有其他智能设备。女儿的照料是典型的“善意填满”：上午来做饭、打扫、洗衣，一边做一边安排，“妈，下午你把这个药吃了，然后睡一觉，醒了把这个橘子吃了，电视我给你调到戏曲频道你别换”。李奶奶从不反驳。但女儿一走，她就把电视关掉，在沙发上坐很久，什么也不做。她有时走到阳台，把晾着的衣服一件一件摸一遍，不是检查干了没有，摸得很慢，像在摸一块料子的质地。她有时打开冰箱，看看，关上，过一会儿又打开看看，再关上。有一天女儿提前回来，撞见她站在阳台上，问“妈你在干嘛”，她答“没干嘛”；女儿追问“那你站那干嘛”，她有点烦躁地说：“我站站还不行吗。”

三个片段拼在一起，呈现的是一种结构性处境，而不只是几个动人的故事。周阿姨的困境是生活被填得太满，满到那些没有被安排、没有目的、没有名字的瞬间几乎消失。陈伯伯和李奶奶提供了两个对照。陈伯伯的生活里有大量这样的空间，却不是因为他被“更好地”照护，他所在机构的技术与管理水平远不如周阿姨的社区，恰恰是因为系统的触角尚未伸到他的每一分钟。李奶奶的处境更微妙：她面对的没有任何算法，只有一个爱她的女儿，然而善意填充的逻辑在她身上同样运转。她那些“没干嘛”的动作，是她在被安排好的日程缝隙里为自己争取出来的一点暗处。

这三个案例共同提示了三个特征。第一，残迹的发生与叙事能力并不绑定：陈伯伯的叙事能力在下降，他的残迹空间却没有因此萎缩，这说明保护残迹不能被简单归入“守护叙事能力”的子项目，一个叙事能力已严重受损的老人，仍可能在那些未被命名、未被记住的瞬间里保有某种叙事框架无法覆盖的存在质感。第二，残迹的被挤压与技术的智能化程度正相关，却并非由技术单一因素决定：

李奶奶的女儿没有任何设备，同样可以用爱的名义填满老人的时间。第三，残迹的消失不会引起任何报警：周阿姨的静止被系统标注为“需关注的久坐行为”，陈伯伯和李奶奶的同类瞬间则根本不在任何记录里存在过，前者被看见的方式，恰恰比后者不被看见的方式更危险。

◆ 三、残迹：一个不可还原的存在层位

– （一）从两种最好的解释中逼出一个概念

回到周阿姨坐在窗边的那个下午，看一看既有的两种最好的解释框架在那一刻遇到了什么。这两种框架是对精准匹配式养老最有力的两路批评，本章承认它们各自有效。第一路批评认为，精准匹配替代了老人的自主性：从感受、表达到发起行动，系统替老人完成了自主链条上的每一个环节，老人不再需要自己选择任何事情。在当代老年学与社会学文献中，这一批评已形成相当厚实的论述传统，关注数字技术如何以预设选项、优化推荐与自动化决策，在不知不觉中窄化老年人的行动空间。第二路批评走得更深，认为替代的最深后果是叙事能力的丧失：老人失去的不只是若干功能的行使机会，而是把碎片化的日常整合进“我正在过这一生”这一自我叙事的能力。它的哲学根基可以追溯到叙事同一性的长期讨论，对老年群体而言，一些研究者进一步论证了照护环境对这一叙事结构的支撑或侵蚀作用。

这两种框架面对窗边的下午，会给出各自合理的诊断。自主性框架会说：周阿姨没有发起行动，她处于被动接受的状态，自主链条的感受、表达、发起各环节已被推送机制架空，修复的办法是还给她选择权，比如系统不再直接弹出“久坐提醒”，而是问一句“您已经坐了很久，需要建议活动吗”，让她自己决定。叙事框架会说得更深一层：仅仅还给选择权不够，困境在于她把日子编织成故事

的能力在系统性衰退，所以护理员可以在她发呆之后陪她聊两句，帮她理一理“刚才在想什么”，把那段沉默编织进可讲述的脉络。

这两种诊断都不是错的，但它们在面对那个下午时做了一件相同的事：都试图把它纳入某种有意义的结构。自主性框架要把它变成“被选择的行为”，你没有在选择，所以你需要被激活；叙事框架要把它变成“叙事的前奏”，你沉默，说明你在酝酿意义，所以你需要被帮助去表达。两者都无法接受那个下午以它本来的样子存在：没有行动发生，没有意义生成，没有故事萌芽，一段纯粹的空白。它们的出发点都是善意，而它们的善意本身，恰好就是那个下午的终结。更要紧的是，两路批评共享一个深层预设：老人生命中珍贵的东西，是可以被事先指认、因而可以被纳入“守护”议程的。自主性可以被界定，被操作化为选择权的赋予与行动起点的保留；叙事能力可以被描述，被分解为若干可以支持的构成要素。在“守护”的逻辑里，先要认出什么值得守护，再设计机制去保护它。这个逻辑如此自然，几乎无人质疑。可是，有没有一些东西，连老人自己都无法事先指认，无法将其放进“我想要守护的东西”的清单，却构成了他生命质感不可替代的纹理？如果有，那么整个守护逻辑就有一个根本性的盲区：它只能守护可以被目标化的东西，而无法被目标化的东西，恰恰可能因为守护的过度运作而被系统地挤掉。

这个追问并非理论上的挑刺。走进任何一家养老机构，去观察那些没有被刻意安排的时段里老人在做什么，就会看到这样的信号：一位老人在活动结束后没有立刻起身，什么也不做地多坐了七八分钟；另一位在走廊里慢慢走，走几步停下来，摸摸墙壁，看看窗外，再走几步，没有目的，也没有节奏；还有一位在集体用餐时忽然放下筷子，不是吃饱了，也不是不舒服，只是停在那里，看着某处出了神，而后若无其事地继续吃。这些瞬间产生不了可记录的数据，形成不了可评估的成效，进入不了任何服务方案，却反复出现，构成了一天与另一天之间说

不清的差异的底色。如果它们的消失不会在任何指标上引起报警，那么有理由怀疑指标本身是不完整的。

（二）残迹的轮廓

本章所说的残迹，与其说是一个被清晰定义的对象，不如说是一个在论证展开中被逐渐照亮的存在层位。用最简要的方式逼近它：残迹是一个人在日常生活里那些未被选中、未被完成、未被记住，却依然构成了这一天与另一天不同质感的微小痕迹。这不是一条严格意义上的定义，因为定义预设了一个可以划定边界的稳定对象，而残迹的特质恰恰在于抵抗这种划定。下面的三层展开，是从三个角度逼近同一个东西，就像无法用一张照片拍出一座山的全貌，却可以从三面各拍一张，让读者在脑中拼出整体的印象。

第一层，残迹往往不是某个人刻意选择要做的事。周阿姨没有“选择”坐在窗边，她只是走着走着，停在那里，就坐下了。如果护理员当时问她“您想做什么”，她可能答不上来。她不是先有一个意念再去执行，而是被那一刻的光线、温度和某种说不清的疲惫或安宁牵引着，身体做出了她自己都没有预谋的举动。李奶奶摸衣服、开冰箱同样如此，没有一个“我要做这个”的时刻，事情就那样发生了。第二层，残迹不追求结果。周阿姨不需要“发完呆之后身心舒畅”才算完成这件事，它没有可以评估的终点，可以随时中断，也可以随时延长，它的“完整”不在于抵达了什么，而在于它就是那个样子，持续了一段谁也说不清长短的时间。陈伯伯在阅览室翻报纸翻到睡着，谈不上完成了什么，他没有读完一篇文章，也没有从报纸里获得任何信息，但那个报纸盖在脸上、半梦半醒的时段，本身就是他那一整天里最像他自己的时刻。

第三层最要紧：那些被记住、被讲述、被收束进生命故事的瞬间，已经不再是残迹，它们进入了叙事的结构，被赋予了可以分享的形式。残迹恰恰是连当事人自己都不会记住、或者记住了也找不到语言去说的东西。把一个人的生命比作

一卷底片，叙事是那些被选出来冲洗扩印的照片，残迹则是整卷底片上永远留在黑暗里、没人会去看、却决定了一张照片与下一张照片之间过渡质感的空白格。

残迹的存在论分量，在于它构成了这一天与另一天不同的底层质感。设想两位老人，同样被安排了太极拳、合唱排练、健康讲座，日程表一模一样，各项“需求满足指数”都在正常范围，其中一位觉得“今天过得有点闷”，另一位觉得“今天好像还行”。这种差异无法被任何指标解释，因为它在指标的盲区里：一个下午的阳光角度，走廊里偶然飘来的饭菜香，护理员经过时无意识哼的一句老歌，窗台上那只停了三秒钟就飞走的麻雀，这些东西不会进入任何服务方案，却构成了老人对这一天实际体验的底层纹理。系统把生活填得越满，这些发生的空间就越被挤压，一个被照料得无可挑剔的老人，可能恰恰因为生活里不再有这些“未被照料到的缝隙”，而陷入一种更深、更难言说的空无。这种空无的特殊之处在于，它不可能被老人自己表述为“我需要更多残迹”这样的需求。你无法要求一个老人说出“请给我更多不被安排的时间”，因为这句话本身就已经把“不被安排的时间”变成了一项安排，从而取消了它最根本的质地。

– （三）残迹不是什么

残迹是一个容易被误解的概念，需要先说明它不是什么。**残迹不是自主性**。自主性的核心是主体发起了行动，“我选择做这件事”。残迹可以发生在完全没有行动的状态里：周阿姨坐在窗边，没有选择任何事，没有发起任何行动，甚至没有“我选择发呆”这个意识。自主性框架只能处理“有选择”的瞬间，而残迹大量存在于选择之外、未被任何决断动作捕捉到的日常流淌之中。

残迹不是叙事能力，也不是未完成的叙事。 叙事能力的核心是主体把碎片整合为有方向、可讲述的故事。叙事框架看重那些可以被收束进故事的素材：一次尝试，一次失败，一个转折。残迹则恰恰是永远不会被收束进故事的东西。周阿姨看窗外的那个片刻，她自己日后不会对任何人讲起，不会成为生命故事的一

部分，不会在回忆录里留下一句话，但它确实发生过，确实在那个下午构成了她生命的全部内容。这里需要处理的，是残迹与叙事之间的深层关系。叙事能力的守护，也就是帮助老人把日常碎片整合为有方向的自传体叙事，是一种极其珍贵的照护取向，它守护的是人作为意义编织者的尊严。提出残迹，并不意味着否定叙事的价值。残迹概念说的是：在叙事的合法性之下，还有一片不需要被叙事照亮、也不应该被叙事照亮的暗处。一个人生命中最深的某些质地，恰恰来自那些从未被讲述、也无需被讲述的时刻。如果照护的目标是把所有暗处都照亮，那么照护本身就变成了一种新的暴力，不是剥夺，而是过度照射。残迹敏感型照护要保护的不是取代叙事，而是叙事的边界：让叙事拥有它能照亮的一切，同时保留那些不该被照亮的东西的黑暗。

残迹不是需求。 需求可以被识别，“我需要一个人静静”“我需要被陪伴”“我需要某种美感体验”，需求可以被纳入服务方案，被转化为可操作的目标。残迹在发生的当下，连主体自己都不知道“这对我意味着什么”。它不是一种可以被预先识别的缺乏，而是一种在发生之后，甚至发生之后也不会被归类的剩余物。它不在“未被满足的需求”清单上的任何一项里。

残迹不是权力分析所描述的效应。 戈夫曼（Goffman，1961）在《收容所》中分析全控机构如何系统性地抹除个体的自我边界，福柯（Foucault，1975）分析规训权力如何通过持续的观察与分类生产“驯服的身体”，两者都深刻地揭示了机构化照护中的权力运作，残迹的被挤压确实与这些机制有某种共鸣。但在一个关键点上两者并不重叠：全控机构与规训权力施加的是一种可以被反抗的压制，戈夫曼笔下的“次级调适”与福柯笔下的“局部斗争”都是证明。而残迹被挤压的独特性恰恰在于，它不是被压制掉的，而是被善意地填充掉的。老人不是被强迫去做他不愿做的事，而是被如此周到地照顾着，以至于那些原本会自然发生的缝隙被填得滴水不漏。因此，任何以权力分析为起点的理论，都天

然地会错过它。权力分析必须依赖这样一个前提：存在着某种“对人产生了影响的操作”，一种可以被辨认、被批判的施加。残迹的消失却不是某种操作的受害：它没有被压制，没有被剥夺，没有被规训，它是被善意填满的日常覆盖掉的，而覆盖不是一种权力技术，它没有施加任何力，只是让某些缝隙不再存在。权力理论只能看见“被剥夺的某物”和“被塑造的某物”，看不见那些根本没有进入权力游戏圈、因此也无法被权力剥夺的东西。残迹不是权力分析的新篇章，而是权力分析的极限边界。关于这一点，第四节还将从善意填充的角度正面展开。

残迹不是文化现象意义上的“隐性课程”或“日常实践”。 教育社会学中的隐性课程有内容、有结构、可以被批判；人类学中的日常实践可以被观察、被描述，甚至写成整本的民族志。残迹连这些都不具备：既没有内容可供批判，也没有模式可供观察。观察者看到周阿姨，只能在田野笔记里写“受访者于下午三点独坐窗前，疑似情绪低落或进行沉思”，而这个记录已经是对残迹的背叛，因为它把残迹翻译成了某种可被解释的“行为”，赋予了它一个它本来没有的方向。残迹抵抗被记录，抵抗被解释，抵抗被赋予任何功能。另外两道切割更为精细，值得单独讨论：一是与护理伦理中“陪伴型不干预”传统的区别，二是与海德格尔“现身情态”和“深度无聊”的区别。

– （四）与“陪伴型不干预”的切割

在安宁疗护与老年护理领域，“有意识的不干预”绝非一个全新的主张。从桑德斯（Saunders，1960）开创的安宁疗护传统对“在场”的强调，到诺丁斯（Noddings，1984）关怀伦理学对“专注的关注”的论述，一脉相当丰富的伦理话语已经在论证：好的照护有时不是做更多事，而是以不做事的方式在场。关于照护中“不作为”的伦理，近年还有莫尔（Mol，2008）、波尔斯（Pols，2012）等人的讨论。如果不主动与这一传统对话，读者完全有理由追问：残迹

敏感型照护的“不过问”，是否只是把护理伦理里已经说得很清楚的东西换了一个新名字?

差别在于：护理伦理中的“陪伴型不干预”描述的，仍然是一种需要被对方感知到的互动形态。护理者即使什么也不做，她的在场也是老人可以感受到的“有人在”，这个状态本身就是照护的一部分：老人知道护理员在，护理员也知道老人知道自己在。残迹敏感型照护要求的恰恰更深一层，连“被陪伴”的感知都不需要发生。护理员不是在“以不做事的方式陪伴”，而是有意识地退出了老人那个瞬间的意识场域，让那个瞬间对老人而言不是“有人在旁边陪着我”，而是“没有任何人、没有任何议程、没有任何力量在注视我”。在这样的时刻，护理员不必让老人知道“我在关注着你”，老人只是处在安全网之内，而安全网并不要求被他感知。这个差别不是程度上的，而是结构上的：前者仍然是关系中的照护，后者则是允许“不存在于任何关系中的空白”的照护。两个老人都安静地坐着，外部看来可能一模一样，但一个仍在关系之内，另一个暂时不在任何关系里。

– （五）与“现身情态”和“深度无聊”的切割

残迹与海德格尔“现身情态”（Befindlichkeit）的区别需要精确地划定，因为这是最逼近它的哲学候选者。在海德格尔的此在分析中，此在总是已经在一种未被明确意识到的情绪或色调中发现自己：一种莫名的压抑，一种说不清的轻快，一种弥漫的不安。现身情态先于一切主动的筹划与叙事，也不被对象化为某个需求或价值，它确实非常接近残迹试图抓住的那个层位。但有一个关键差异：现身情态仍然是此在对自己存在的一种前反思的觉知，它虽然未被专题化，但始终是“我的”情态，是此在在世的最基本的“我觉得如何如何”。一位老人可以说“我今天下午心里有点闷”，这属于现身情态，因为他事后仍然可以用语言对那个时段做一项情调层面的追认。残迹则是那种他事后无论如何也追认不出任何

东西的时段：除了“坐了一会儿”，没有任何内容留存下来可供主体归类、命名或赋予情感质调。它没有“觉得”的结构，因此也没有现身情态所依赖的“自身—世界”的意向关联。这是层位的差别，而不是区分精细度的差别：现身情态在觉知的边界以内，残迹在觉知的边界以外，它甚至没有生成那个可以被事后指认为“那样”的质料。

最硬的一仗要打在海德格尔《形而上学的基本概念》（Heidegger，1983）分析的“深度无聊”（tiefe Langeweile）。它是已有哲学概念中最强大、也最接近残迹的竞争者，关于这一概念的英语学界阐释，可参见韩炳哲（Han，2015）。如果残迹无法证明自己不可被深度无聊替代，本章的核心命名就只是一个修辞花样，用一个新词说了一件已经有人说过的事。海德格尔对深度无聊的分析分三层。第一层是“被某物所无聊”，具体的东西让人无聊，等火车，开冗长的会议。第二层是“与某物一同无聊”，无聊的不是具体对象，而是在某个场合里消磨时间的自己，这已触及此在的生存结构。第三层最深，是作为整体的深度无聊：此在发现整个存在者整体都变得无关紧要，不是这个或那个东西让人无聊，而是一切沉入一种奇特的漠然。公交车站等车的人、树上落下的叶子、邻座翻报纸的声响，一切仍在那里，却不再对这个此在说出任何话，世界仍然在场，意义整体退场。

正是在第三层上，深度无聊与残迹显出惊人的表面相似：两者都发生在没有行动、没有目标、没有意义生成的时段；两者都让日常的功能链条暂时停摆；两者都无法被“需求—满足”的逻辑所捕获。更重要的是，海德格尔在深度无聊中看到一种特殊的揭示功能：正是在一切意义退场之际，此在才得以裸露地面对自己的存在本身，深度无聊不是缺损而是揭示，它把此在从日常的沉沦中唤醒，逼它直面“为什么存在者存在，而无反倒不在”这个最根本的问题。

但恰恰在这个“揭示功能”上，两者之间出现了一道不可跨越的断裂。深度无聊是一种生存论模态。无论它多么极端，多么逼近意义的零点，它仍然是此在向世界敞开的一种特定方式，有自己的现象学结构，可以被描述，也可以在事后被语言指认。一个经历过深度无聊的人，事后至少可以说：“那一刻，一切都变得无关紧要了。”这句话本身就是对那个状态的情调层面的追认。深度无聊从定义上就不可能完全无痕，作为此在的一种体验，它必然在事后留下某种难以言表、却仍可被感受为“我曾经那样”的余味。

残迹不是任何模态。周阿姨坐在窗边的那个下午，她未必经历了“一切都无关紧要”，她可能什么都没有经历。在现象学的严格意义上，“经历”预设了一个能够收受体验的主体极点，而残迹发生的位置，恰恰在这个极点的边界之外。事后问她“那天下午坐在窗边是什么感觉”，她最可能的回答不是“觉得一切都很空”，而是“没什么感觉，就是坐了一会儿”。这个“没什么感觉”不是回避描述，也不是某种可以被深化为哲学揭示的原始材料，它就是那个时段的全部事实。没有任何东西被揭示，因为揭示这个动作本身就没有发生。深度无聊仍然是一种可以被哲学反思收编的经验：海德格尔可以把它写进三个层次的分析，学生可以在研讨班上讨论它揭示了什么。残迹则拒绝被收编，它不是任何一种等待被揭示的生存论结构的载体。深度无聊揭示存在的意义，残迹拒绝被揭示，它存在的全部尊严，就在于不在哲学反思的聚光灯下。把周阿姨的窗边下午叫作“深度无聊”，就是用一个哲学上高级的命名，把一个拒绝进入任何理论结构的东西，强行升级为一种值得写进论文的体验，而这个升级本身，已经背叛了那个下午最根本的质地：它不是为了让任何人，包括周阿姨自己，觉得它“有意义”才发生的。

因此，残迹不可还原为深度无聊，不是因为它“更像”别的什么，而是因为任何试图把它纳入一个可言说的体验范畴的命名，无论是“无聊”“沉思”“放

空”“现身情态”还是“深度无聊”，都必然多出来一个东西：一个事后可以指认“我当时是那样”的主体位置。而残迹的发生，不需要、也往往没有那个位置的参与。这就是那道存在论裂口：一边是“可以被痛苦地或深刻地感知为空无”的体验，另一边是“空无连被感知的空无都不是”的痕迹。前者的深度仍然依赖一个承受它的主体，后者的不可替代性，恰恰在于它甚至不需要这个主体。

回头看这些切割，可以看出残迹为什么此前没有被命名。需求满足论只看得见需求，自主性框架只看得见选择，叙事框架只看得见故事，护理伦理的“在场”仍是人际的互动形态，现身情态仍在觉知的边界以内，权力分析只看得见被施加了力的东西。残迹不属于其中任何一个，它所处的位置，正好是所有“重要性”判断体系都无法触达的位置。它不是被遗漏的宝物，它就是那片连宝物都不生长的暗土。但没有这片暗土，生命的手感就不一样。

◆ 四、善意填充：残迹如何被系统性地填平

– （一）为什么不是技术的偶然副作用

如果残迹确实构成生命质感的底层纹理，接下来的问题就是：精准匹配式的养老为什么会对它形成系统性的挤压？答案不在个别设计的失误。本章认为，这种挤压来自三条看似各自独立的运作逻辑，数据化、日志化与善意，在深度耦合之后形成的一个闭环。闭环的第一步让残迹不可见，第二步让不可见的残迹被一套新的“可记录”的生活叙事所替代，第三步用善意为这套替代赋予正当性。三者互为支撑，缺了任何一环，挤压的力度都会大打折扣。需要先说明的是，主流的“精准匹配”范式并不是单纯的技术偏好。它是在护理资源紧缺、机构风险规避与管理标准化等多重压力下被逼出来的形态，把批评的对象写成愚蠢或冷漠，既不公道，也无助于看清问题。正因如此，本章后面提出的纪律才没有把希望寄托在“让大家更有爱心”上。

（二）数据化：不能被计算的，一律处理为不存在

精准匹配的第一步，是把老人的生活转化为可计算的数据：步数、心率、睡眠时长、社交频次、活动参与率、情绪评分。这一过程在操作上是无害的，传感器只是记录物理量，算法只是对数值做统计推断。但在存在论层面它完成了一次深刻的转换：凡不能被数据化的存在形式，一律被处理为不可识别。残迹正是从根本上抵抗数据化的东西。周阿姨的那个下午可以被传感器记录为“静止状态持续47分钟”，而这个数字与她实际度过的那47分钟之间，隔着一道不可跨越的鸿沟。“静止状态”这个标签可以贴在任何人身上，一个沉思的哲学家，一个打盹的婴儿，一个等待死亡的重症患者，它抹去了这些时段之间质的差异。残迹的特点正在于它不是一个能在数字描述中保留下来的属性，它是那个时段本身不可替代的“这一个”。

当系统把数据等同于现实时，残迹就被处理掉了，不是被否定，而是被无视。系统不需要宣称残迹不存在，它只需要默认“可以被记录的就是存在的全部”，残迹便从它的世界里消失。这不是恶意的抹除，也不是某位工程师的失误，而是数据化作为一种认知范式的内在边界。算法公平与人工智能伦理的研究已反复揭示过类似的结构：一个系统在某个范畴上的无视，往往不是通过明确的排斥规则实现的，而是通过“这一栏不在数据模型里”完成的，这种结构性无视比有意识的歧视更难识别（参见 Barocas & Selbst, 2016；Benjamin, 2019；O’Neil, 2016）。不过算法公平文献关注的是系统无视了某些群体或特定需求，带来分配不公；本章关注的则是系统无视了整整一个无法被任何识别框架捕获的存在层位，带来的不是分配不公，而是质感的塌陷。

（三）日志化：用“做了什么”替代“经历了什么”

第二步更为关键。在数据化的基础上，精准匹配引入“活动日志”作为衡量老人生活质量的核心依据。老人的一天被表述为一连串任务的完成记录：上午参

加合唱排练（社交刺激达标），下午完成认知训练游戏（认知干预达标），傍晚散步二十分钟（运动量达标）。在机构管理的逻辑里，这些日志既是“服务已经提供”的凭证，也是“这一天过得很充实”的证据。数据化让残迹变得不可见，但仅有这一步还不够，因为“不可见”并不等于“被替代”：你只是看不见它，它可能仍然在那里。日志化的作用，是在数据化制造的沉默之上，用一套全新的叙事框架重新定义什么是“充实的一天”。在这个框架下，一天的价值等于可记录的任务完成量，那些填不进日志框的东西，走神，发呆，随手摸一把墙壁的纹理，闻到一阵说不清来自哪里的炊烟，不但没有被记录，而且在“充实”的定义里被系统地贬值为“什么都没做的时间”。它们没有被禁止，只是被“没有这一栏”格式化了。

数据化与日志化在此精确咬合：前者让残迹消失在感知系统之外，后者为这种消失之后的空白提供了一个看似无懈可击的替代叙事。管理者看着满屏的活动完成记录，可以放心地说“我们的老人今天过得很充实”，这个判断在日志的世界里是自洽的，因为日志的世界里根本没有残迹的位置。

– （四）善意：道德的闭环

前两步已经构成有效的挤压机制，但它们的道德底色还不足以抵御反思。如果有人追问“为什么要如此彻底地填满老人的时间”，仅靠“因为数据化需要”“因为日志需要”的回应，在照护伦理看来仍然脆弱。让这个闭环变得极其稳固的，是第三步：善意的参与。

精准匹配的整个论证基础，建立在“识别需求，满足需求”的逻辑之上，它的出发点是对老人的关怀：他身体不便，所以要帮他买菜；他健忘，所以要提醒他服药；他孤单，所以要推送社交活动；他认知下降，所以要安排训练游戏。每一个操作单独看，都是在帮助老人，都是“为他好”。但当这些善意的帮助叠加在一起，就形成了对老人整日时间的全覆盖：从早上的健康监测提醒，到晚上的

助眠音乐推送，老人醒着的每一个时段，系统都预先填入了某种“对你有益”的安排。善意在这一步起的作用不是技术性的，而是道德性的，它为数据化和日志化提供了无可辩驳的正当性。如果有人质疑“为什么老人的时间被填得这么满”，回答是“因为这些活动都对他有好处”；如果有人追问“为什么不能留一些什么都不安排的时段”，回答是“因为我们不能眼睁睁看着他错过对健康有益的活动”。质疑填满，就是在质疑我们对老人的关心，而质疑关心，在道德上几乎是不被允许的。

这三者不是三个并列的原因。它们之间有清晰的耦合结构：数据化决定一个行为“能不能被看见”，日志化决定它“能不能被记录为有价值”，善意决定“看了且记了之后有没有道德压力去做点什么”。一步为一步提供前提，一步为一步提供正当性。三个齿轮咬在一起转动时，残迹的挤压就不再是一个个孤立操作的总和，而是一个自我强化的闭环：看不见，记不了，填进去，更看不见。你越爱他，就越要填满他；你越填满他，残迹越没有空间；残迹越没有空间，你越不可能在数据或日志里看到残迹缺失的信号，因为你从一开始就无法看到残迹本身。

（五）一种不施力、不注视的权力

在这个闭环里，善意的运作逻辑必须被专门析出，因为它构成对权力理论的一个实质性推进，而不是可有可无的理论附注。福柯式的规训权力通过持续的观察、分类与规范化生产主体。它的运作依赖一种凝视的在场，无论是全景敞视建筑中那个看不见的监视者，还是现代学校、医院与军营中的标准化考核。规训权力的核心机制，是让被规训者知道或至少预感到自己正被注视，从而把外部规范内化为自我监控。正因为它依赖这个“被注视”的感知结构，它也天然地为抵抗留下了空间，戈夫曼笔下的次级调适，福柯笔下的局部斗争，都是被规训者在权力缝隙里为自己争取到的暗处。

善意填充运作在完全不同的层面。它不是通过注视运作，恰恰相反，它的有效性在于被照护者感觉不到任何施加。当系统把老人的下午安排得满满当当时，老人体验到的不是“我被控制了”，而是“我被关心了”。他无法在任何一个具体的操作上指认权力的痕迹，因为每一次推送、每一个提醒、每一项安排，单独拿出来都是合理的、善意的，甚至是他自己也会同意的。这就是善意权力的独特之处：它不靠恐惧或强制，而靠关怀的全面渗透，使抵抗失去对象。你可以反抗一个监视你的狱卒，可以抗拒一个训斥你的教官，但如何反抗一个每时每刻都在为你好的系统？你拒绝的不是一个人，而是“善意”本身。在道德上，拒绝善意比拒绝压迫困难得多，因为拒绝善意意味着你必须先说服自己和他人：这份善意有问题。这个说服过程，恰恰是大多数老人，尤其是那些叙事能力正在衰退、无法把自己的不适编织成规范性论证的老人，所无法完成的。

这并不是否定善意的价值。照护中的善意是实在且必要的，也正因为它是实在的、必要的，它的过度运作才如此难以察觉，更难以纠偏。在这个意义上，善意填充不是规训权力的替代品或升级版，而是一种新的权力形态：一种不以任何“施加”为形式的施加，一种不必借助任何“注视”的接管，一种让被接管者感到温暖而不是寒冷的包裹。以“施加”为起点的权力分析，因此天然错过它；对它的抵抗之所以难以在制度层面落地，也是因为它要对抗的，正是我们的文化对“善意”本身毫无保留的信任。

放回全书的母题里看，这里发生的正是“替定”的最温和的一种。系统没有宣布老人应当怎样生活，它甚至没有替老人选择任何事情，它只是预先把每个时段都填入“对你有益”的内容，于是老人自己的答案连出生的位置都没有了。后面各章将看到替定在叙事、发生权与判断力上的各种形态；在养老场景里，它首先表现为对时间的填充。

（六）制度的共谋：为什么这个范式如此稳固

至此，机制已经清楚：数据化让残迹不可见，日志化用可记录的活动替代不可记录的存在，善意为这种替代加冕为“最好的照护”。还剩一个问题：为什么即使认识到缺陷，养老机构仍然难以改变？答案在于，精准匹配实现了一场多方焦虑的同时结算。

对机构管理者，它提供“可证明的尽责”。养老服务中机构面临的最大风险之一是纠纷：老人出了事，家属追责，机构需要证明自己已尽到义务，每一次数据上报、异常报警、任务闭环确认，都是在制造一份可追溯的证据。这套逻辑有非常具体的制度载体。以我国多地现行的养老机构服务质量星级评定标准为例，“每日活动项目数”“活动参与率”“个性化活动覆盖率”是明确的评分指标，直接写入政府评估文件，作为机构等级评定和补贴核算的依据。一个允许老人长时间发呆、不产生任何可记录成果的机构，在这些指标上天然处于劣势，不是因为发呆对老人不好，而是因为在制度设计者眼里，“有记录的活动”是最直接、最不易引起争议的服务凭证。这不是管理者的恶意，而是问责制度倾向于选择“可被审计”的证据。

对护理人员，它提供“可执行的任务”。把“陪伴老人”这种模糊、耗神、边界不清的工作，转化为“完成社交刺激任务每周三次，每次30分钟”的清晰指令，极大降低了护理员的认知负荷与情感耗竭。在对一线护理员的访谈中，不少人坦言：“最怕的不是活儿多，是不知道该怎么陪。”面对一个不想说话、不想做事、只是坐在那里的老人，护理员如果靠自己判断“我该陪还是不该陪”，每一次都是道德上的负担，清晰的任务清单把她们从持续的判断压力中解放出来，告诉她们“你做完这些就算尽责了”。残迹无法写进这种任务单：怎么分配“守护老人发呆”的工时？怎么考核“允许老人走神”的成效？让护理员主动容纳残迹，要求一种她们没有被赋予的判断自主权与组织支持。

对产业资本，它提供“可规模化的叙事”。硬件可以量产，算法可以通用，服务包可以模块化，这是现代商业逻辑的基本要求。残迹则是规模化的死敌：它不可复制，无法写进商业计划书，无法在任何路演文件里被展示为“核心竞争力”。当养老产业向资本市场敞开时，能够被数量化呈现的“效果”天然比不能量化的“质感”更受青睐。这同样不是资本的恶意，而是资本的认知边界，它只能看见那些可以被识别为资产或回报的东西。在技术哲学与科学技术研究的相关讨论中，已有学者指出智能照护技术的主流叙事倾向于把“可记录的结果”等同于“被照护者的福祉”，这种偏好本身就对无法量化的照护维度构成系统性的遮蔽（参见 Turkle，2011；Vallor，2016；Suchman，2007）。本章的侧重与这些批判传统有部分重叠，但不在“技术替代了人际互动”，而在“技术善意地填充了那些本来就不属于人际互动、也不属于任何功能系统的空白”。

因此，精准匹配的稳固，不是因为它最优，而是因为在现行制度条件下，它顺着所有阻力最小的方向，把自己做成了这个样子。三重耦合给了它内部的运转逻辑，机构问责、一线执行与资本逻辑的三重需求给了它外部的制度锁定。要松动它，不能只靠指出它的缺陷，更要在制度层面找到可以撬动的支点。

◆ 五、残迹敏感型照护：三条消极的留白纪律

如果残迹是一个只能被保护、不能被守护的层位，照护设计的出发点就不应是“如何守护老人的叙事能力”，而应是“如何确保系统的运作不把残迹的生存空间挤压殆尽”。这是一个消极的“留白”议程，而非积极的“赋能”议程，本章把按此议程运作的照护称为**残迹敏感型照护**。在展开之前，必须先坦承一个所有谈论残迹的人都无法回避的悖论：越是系统地“保护”残迹，就越是在破坏它。保护本身就是一种命名、一种识别、一种纳入议程。一旦“留白”成了一项“应该做的事”，一旦“不干预”被写进照护方案作为一个服务项目，它就不再是留白，而成了另一种填充，只是填充的内容恰好是空白。残迹敏感型照护的

终极伦理因此不是“做对了”，而是知道自己大概率会做过头，并在每一次做过头之后能退回来一点。下面三条纪律，与其说是一套正确的方案，不如说是照护者深夜反思白天那些善意操作时可能向自己提出的问题：管得太多之后，下一次能不能管得少一点。本章也不回避，在现行问责制度、一线工作压力与产业逻辑的三重锁定下，大规模实施面临实际而巨大的阻力，这里只在理念层面说清方向，并在每条纪律里指出不必推翻整个系统就可先行试探的微观切口。

（一）不过问：安全底线之上的沉默

精准匹配的一切运作，都始于把老人的状态转化为系统可识别的问题：心率异常，需要健康干预；步数下降，需要康复训练；情绪低落，需要心理支持；社交频次偏低，需要增加社交活动。每一次识别都是一次“过问”，系统伸出手，把老人的状态捞起来放在光线下查看，再决定下一步。多数时候这种过问必要且有益，危机时能救命。残迹敏感型照护要求的是：在安全底线之上，有意识地不过问。不是所有老人的静止都要被解释为“久坐风险”，不是所有独自发呆都要被标注为“需关注的社交隔离”，不是所有走神都要被识别为“认知功能波动的信号”。残迹的生存条件之一，就是它不需要被识别、标注或纳入任何人的视线。护理员走过来关切地问一句“您还好吗”，它就被破坏了，因为它被从一片自足的暗处拉进了被关注、被解释、被回应的明处。不过问不是冷漠，是克制，克制那种必须时刻关注老人一举一动的管理冲动，克制把一切行为翻译成“需要处理的信号”的专家惯性。周阿姨坐在窗边的那个下午，这样的系统唯一需要确认的，是她的生理指标在安全范围内，然后，沉默。

这并不意味着对风险视而不见。在安全问题上需要一个分层的响应框架，而不是“全管或全不管”的粗糙二元。可以把老人在“不被命名的时间”里的行为分为三个风险等级：最低风险层，如发呆太久错过一次活动、种花划破手指、站在原地看鸟看久了，保持沉默；中风险层，如单独操作燃气、搬动明显过重的物

品，给予轻提示，或由护理员视老人能力评估是否干预；仅在高风险层，如走出安全区域、倒地不起、生命体征异常，立即响应。这个框架可以在现有智能监测技术中通过简单的阈值设定实现：安全警报只触发于生命体征异常、跌倒、走失等危险信号，不触发于久坐时长或“社交频次偏低”，最大的阻力不在技术，而在一种深层的社会惯性：面对一个“什么都不做”的老人，照护者总觉得必须做点什么才叫尽责。

– （二）不填充：日程表上的无名空白

精准匹配生产的日程表，往往是一张被填满的活动矩阵：八点测血压，九点半合唱排练，十一点健康讲座，下午两点认知训练，四点康复指导，晚上七点音乐疗法。即使是“自由活动”，也是安排在两个结构化活动之间、被明确标注的时间，它的名称就在暗示：这段时间是用来“活动”的，只是内容可以自选。残迹敏感型照护要求日程里有另一种时段：不被标注为任何东西，不是“自由活动”，不是“休息时间”，不带任何功能性命名，就是一段没有名字的时间。系统不推送建议，护理员不安排内容，老人不被任何“你可以做……”所打扰，他可以做任何事，包括什么都不做；即便什么都没做，事后也没有记录、评估或“优化建议”。残迹需要一种无人注视的土壤：当老人知道自己处于某个被安排好的时段，哪怕是“自由活动”，那个框架本身就在提醒他有人期待他此时做些什么，哪怕只是“放松”。残迹恰恰发生在连“被期待放松”的期待都没有的时刻，既非工作也非休息，既非社交也非独处，只是在某个无法归类的位置上存在着。

在当前条件下最可行的实现方式，是设置“无记录时段”：在某些固定时段（如下午两点到四点），监测数据只用于安全报警模块，不进入老人的行为档案，不被标记、不被分析、不对接活动推荐。技术上只需在数据流上增加一道时间过滤开关，安全数据照走，行为分析数据停流。阻力实际上在管理：这意味着

管理者必须接受这些时段的“证据链条”是断裂的，在纠纷中无法作为“服务已提供”的证明。这是残迹敏感型照护最核心的制度博弈点：它要求的不是更多技术，而是敢于在安全底线之上，放弃一部分“可证明的尽责”。推进只能从低风险试点开始，比如先在认知功能完好的半自理老人中试行三个月，观察的不是残迹本身（它无法测量），而是更朴素的变化：老人拒绝参与活动的频率是否下降，主动发起的小动作（不必是什么“有意义的”动作）是否增多，对“今天怎么样”的回答是否从“还行，挺好”变成一段更长的、不知道该怎么收尾的话。同时要警惕一种变异：如果“无记录时段”本身也被列为一项干预措施去考核评比，“你们机构每天提供了多少小时的无记录时段”，它在被写进考核表的那一刻，就重新变成日志化的一部分。任何好的理念都可能被收编为下一个量化指标，残迹敏感型照护能做的，只是每一次被收编时把那根刺拔出来，换一个位置再扎进去，这是一场没有终点的防守。

– （三）痕迹保护：不把残迹转化为叙事素材

这是三条纪律中最微妙的一条。残迹一旦被刻意捕捉、命名、讲述，就变质了，它从残迹变成了叙事素材。设想一位护理员注意到，某位老人连续几天在同一时间站到窗边看一棵树。通常的照护逻辑会鼓励她抓住这个细节：这是一个信号，表明老人对某种东西有兴趣，应据此设计活动，“他好像对那棵树很感兴趣，下次安排一次植物认知活动”。在叙事守护的逻辑里，这是优质的照护。但从残迹的角度看，问题恰在这里：护理员把一个未被目标化、未被注意、不属于任何功能时段的行为，拿出来放进了“事务”清单，变成可以记录、讨论、持续跟进的项目，这是以叙事的名义吃掉残迹。

必须把“不填充”与“痕迹保护”锋利地切开，两者都要求照护者“不做某事”，质地却不同。不填充是护理员排日程时没有在那张表上写下任何东西，保护的是尚未发生的残迹的空间；痕迹保护是护理员已经看见了某个残迹的发生，

她看到了，心里也记了一笔，却没有把它写进交班记录，没有在第二天的活动方案里加上一条“老人对植物有兴趣”。前者是时间的留白，后者是对已发生之事的沉默；前者发生在残迹之前，后者发生在残迹之后；前者失败的形态是日程被填满，后者失败的形态是残迹被收编进叙事的档案。痕迹保护意味着护理员可以看见，但不把它拽出来登记。她注意到，不是因为这一刻揭示了老人某个更深的真相，仅仅因为这一刻正在发生。如果老人自己主动提起那棵树，那就另当别论，那时它已经从残迹变成叙事素材，是老人自己完成了这一转化，护理员的角色是接住他抛出的东西，而不是替他抛。在此之前，她的职责是守住这个细节不被任何外部力量拉进光线下，它像一颗在夜里自然生长的蘑菇，可以蹲下来看看，不能拔起来摆上展台。

这条纪律的实践难度最高，因为它要求一项现行培训与考核几乎不培养的能力：在看见的同时克制利用的冲动。它无法被编写成简单的操作规范，因为“老人没有主动提起，你就不要说”这条规则本身，在执行中也会走样：护理员可能把“等老人主动提起”变成一种新的期待，她眼神里那个“你快提啊”的微表情就已经破坏了残迹所需要的无人注视的土壤。考验的不是规范遵循，而是护理员对自己内心那个“一看见有意义的行为就想让它更有意义”的职业冲动的自觉。培养这种自觉，可以在护理培训中引入案例区分：同一位老人连续三天在同一时段站在窗边看树，护理员甲策划了一次植物认知活动，护理员乙什么也没做，只在心里说一句“他这几天下午，好像都在那里站一会儿”，让两位护理员与培训师一起讨论，老人在这两种回应中分别得到了什么、失去了什么。目的不是裁定乙对甲错，而是让护理员意识到，在“干预”与“不作为”之间有一个长期被忽视的选择维度，而这一维度上的依据，不在于老人的行为能否被解读为“有意义”，而在于谁的议程在驱动这个解读。

◆ 六、面对质疑

残迹是一个容易被误解的概念，也应当被严格质询。以下几项挑战，是它必须经得起的。**其一，这是不是一种精致的虚无主义？** 强调那些“不被记住”“不被指认”“不产生意义”的片段，是否暗示老人做什么都不重要，过得好不好无所谓，甚至在为糟糕的照护提供借口：“反正发呆才是本质，服务好坏有什么区别”？回应是，残迹并不是生命更深的“本质层面”，它不取消需求满足、自主行使、叙事生成这些层位的价值。老人在合唱排练里放声高歌，完成一幅画时的成就感，讲起往事时眼睛里的光，都是实在的，是好的照护应当全力支持的。残迹概念只是指出，在这些之外，还有大量不进入任何这些叙事的微小痕迹，同样需要留出空间。虚无主义说“一切价值都是虚假的，所以什么都不重要”，残迹概念说的是：有些东西不需要以“重要”的形式存在，却仍然构成生命的底层质感。它为价值划了一个边界，边界之外不是虚无，而是另一种需要被尊重、但不是被守护的层位。

其二，是不是把研究者自己的存在焦虑投射到了老人身上？ 这是最致命的一问：既然残迹连当事人都无法指认，凭什么认定它的消失是损失？会不会只是受过教育的中产知识分子，把自己对“被系统填满”的恐惧投射到一群也许并不需要这些沉默的老人身上？周阿姨自己也许更愿意去参加活动，只是那个下午刚好有点累。回应分两步。第一步是承认这个质疑的正当性：我们确实无法证明残迹的缺失对任何一位老人“造成了伤害”。可以测量老人被剥夺选择权后的满意度下降，可以测量失去叙事支撑后的抑郁评分上升，却无法测量一位老人因缺少那些连自己也不知道是什么的东西而变得怎样，那个“怎样”不在任何指标的语言范围内。没有任何实证工具可以区分“被照护得很好但活力逐渐暗下去的老人”和“被照护得很好且确实在安享晚年的老人”。如果有人要求用随机对照试

验证明残迹的价值，只能诚实地回答：做不到，原因是研究对象的性质，而不是努力不够。这个质疑无法被经验证据有效反驳，本章不假装事实并非如此。

第二步，正因为不能靠经验证据驳回，就不能依赖“残迹对老人有好处，所以要保护”的结果论回应，那条路会立刻被追问“证明给我看”。必须换一条路：保护残迹的理由不是“我们知道它有好处”，而是“我们没有权力替别人宣布什么才有价值”。这是从结果论到义务论的转换，论证重心从“残迹产生了什么益处”移到“照护者有什么资格去填满别人的时间”。自主性与叙事框架容易获得制度合法性，因为它们可以声称保护的是公认的价值，而残迹的价值恰恰无法被公认：它可能是周阿姨那一天里最重要的底色，也可能对她毫无意义，还可能在她生命的前十年毫无意义，却在后十年的某个下午忽然变得重要。没有人知道，包括她自己。任何宣称“填满你的下午对你有好处”的系统，都在做一件它在认识论上没有资格做的事：替一个自己并不了解的人，决定什么值得占据她的时间。所以残迹敏感型照护的伦理基础不是“我们看到了被忽视的价值”，而是“我们承认了自身认知的边界”。如果一定要问凭什么说消失是损失，回答是：我们不知道它是不是损失，正因为不知道，所以没有资格消灭它。守护残迹的理由，不来自我们知道它有价值，而来自我们知道自己的无知。

其三，对认知障碍严重的老人是否适用，是不是只给照护者提供道德慰藉？

对认知障碍程度足以破坏体验连续性的重度受损老人，残迹敏感型照护的受益方确实不再主要是老人本人，他已无法稳定体验残迹的累积，也感受不到“没有人注视的空白”。但这引出一个更深的问题：是否因为服务对象无法感知，照护者就可以合理地填满他的每一分钟？老人无法说出“我站站还不行吗”时，系统凭什么默认“填满”是更好的选择？这不构成对照护者个人的道德慰藉，因为老人并未因此受益；它构成的是对照护制度的约束：一个无人见证时也不把被照护者的时间当作空容器去填的制度，比一个只在被检查时才做对的制度，更经得起伦

理推敲。因此这里要求的是机构层面的设计，训练、团队复核，以及对“不作为”给予正式认可的组织文化，而不是把责任全部压在一线护理员个人的良知上。至于安全风险，已在“不过问”中以分层响应框架回应：最低风险层沉默，中风险层轻提示，高风险层立即响应，留白从不以牺牲安全底线为代价。

其四，“不干预”会不会滑向消极怠工？ 对一个本就缺乏热情的护理员，这套纪律可能恰好成为“少做少错”的合法借口。这个风险确实存在，所以需要三道防线。第一是区分性训练：有意识的不干预，前提是护理员确实注意到老人的存在状态并基于判断选择不行动，冷漠与疏忽则是根本不知道老人在做什么、也无兴趣知道，前者是看见之后的克制，后者是看不见的放弃，培训中应要求护理员先准确描述老人当前的姿态、表情、呼吸与环境，再决定干预与否并说明理由，这一步本身就把“不过问”从无视变成主动选择。第二是团队复核：在每周个案讨论中对“不干预”时段做集体复盘，看有没有迹象表明某位老人长期陷入的不被干预，实际是被忽视的退缩，复核的目的是集体校准判断，而不是把“不干预”变成又一项考核指标。第三是无条件接纳的兜底：老人随时可以通过语言、表情、手势发出“我需要你”的信号，护理员必须立即响应。护理员与老人之间维持着一根无形的线，它没有被拉紧，却随时可以被拉紧，这根线是“不干预”与“不管了”的分水岭。

◆ 七、证伪条件与边界

本章的核心主张是：残迹的缺失会造成一种不可还原为叙事断裂或自主剥夺的生命质感损失。这一主张不能提供一个可由标准化对照实验检验的操作性假说，这不是回避，而是要正面承认一个方法论上的困局。残迹在存在论上就是无法测量、无法抽样、无法作为因变量在严格实验中分离出来的东西，它的定义本身已拒斥了标准化的测量路径。如果仍以“找到可测量的因变量，在随机对照实

验中检验”作为证伪条件，就会陷入自我矛盾：一边说残迹无法测量，一边又说测出相反结果就算错。本章放弃这种虚假的可证伪姿态。

更诚实的做法是指出，残迹概念的检验只能依赖深度的、长时段的、现象学式的个案追踪：关心一位老人经年累月生活质地的变化，关心那种无法被数据噪声滤掉、持续出现在语言、表情、姿态中的说不清的枯竭感，在有意识留白之后是否发生了任何转变。这不是次好的方法，而是研究这样一个不发光的对象的唯一方法。如果这样的长程追踪积累了足够多的个案，显示在一个又一个被细致观察的老人身上，残迹空间的扩大对那种“说不清的闷”没有任何可辨识的影响，他们几年之后依然像周阿姨一样沉默、一样“算了”，那就构成对本章最诚实、也最致命的否定。这个条件落在全书的书级证伪之内：如果撤回替定之后，生命没有出现可测的失序与自行重组，而是能力如常，母题即被推翻；本章把它翻译到养老场景，就是上面这一条。

本章的边界也需要同时说明。数据化、日志化与善意填充的运作并不止于养老：学习、运动、社交、放松、自我提升，技术治理下个体醒着的每个时段正被分配给某种功能，睡眠成了被追踪的指标，独处被重新编码为“正念练习”，连“什么也不做”也被吸收为效能工具（“适当放空有助于提高创造力”）。当“什么也不做”被赋予功效式的解释，它就不再是残迹，它已经亮起来，进入了意义网络。但这不等于一位三十岁的健壮成人与一位八十岁的被照护者拥有同样的残迹处境：前者的缺失可能只是诸多压力之一，尚被充足的叙事与行动能力缓冲；后者的残迹则可能是他仅存的、再也无法借任何其他能力补偿的生命质地。把两者匆忙等同，会同时误读两者。养老因此只是这个层位最先被彻底暴露的极端现场。

◆ 八、本章小结：被照料得很好的空无

本章从周阿姨窗边的那个下午出发，命名了比生迹更深的一层痕迹：残迹，那些未被选中、未被完成、未被记住，连老人自己也无法事先指认，却构成这一天与另一天不同质感的东西。它不是自主性，不是叙事能力，不是需求，不是现身情态，也不是深度无聊，因为它连一个可以事后追认“我当时是那样”的主体位置都不需要。已有的两路批评之所以够不着它，是因为它们共享一个未经审查的预设：珍贵的东西可以被事先指认并纳入守护议程。

回到全书母题，本章补上了“看不见”的最深一环，也显示出“替定”最温柔的形态。数据化让残迹不可见，日志化以“做了什么”替代“经历了什么”，善意为这一切加冕，三者咬合成一个自我强化的闭环，由机构问责、一线执行与资本逻辑从外部锁定。善意填充不施力、不注视，让人温暖，任何以“施加”为起点的权力分析都错过它。精准的善意抢先把每个时段填成“对你有益”的样子，老人自己的答案便连出生的位置都没有；而本章给出的三条纪律，不过问、不填充、痕迹保护，都是消极的，只告诉系统不该做什么，而且每一条都有被收编为新填充的危险。

被照料得很好的空无，正是精准的善意走到尽头的样子：什么都不缺，什么都与自己无关。但养老场景里的这一切还有一层对应在医疗中。老人的残迹被填平，是因为它不长在任何“需求”的地址上；病人的身体在疾病中给出的代偿，同样不长在指南预设的“正常”地址上，所以同样被看不见，甚至被当作故障去打击。下一章将转入临床，看身体自己给出的答案，怎样沉在指南的地壳之下。

◆

03

第三章

临床海底：身体的代偿为何被当作故障

◆ 一、从老人到病人，是同一件事

一位八十岁的老人，血压长年维持在150/90mmHg。按现行指南，这属于需要药物干预的一期高血压。门诊医生开了标准剂量的降压药，两周后血压漂亮地降到120/70mmHg，质量指标上多了一个绿色对勾，账单顺利报销。但老人开始抱怨：下午三点左右，他会突然陷入一种无法抵抗的昏睡，坐在沙发上就睡着了，醒来头昏脑涨，整个人“说不上哪里不对”。医生说，检查结果都正常，您放宽心。半年后，老人的认知功能开始下滑，被转诊到神经内科，得到一个新的编码：早期认知障碍。这是本章要带读者走进的第一片临床地带。要问的只有一个问题：那个150/90mmHg的数值，在一副被四十年血管磨损逼得不得不垫高压力、以维持大脑供血的身体里，是不是那个唯一能让神经元获得足够灌注的数值？降压药精准地命中了那个“异常值”，同时也精准地关上了大脑的供血阀门。那个“正常范围”，是四十岁人群的统计常模，不是这位八旬老人的身体在耗尽全部代偿资源之后、迫不得已维持的个体底线。

读过前两章的人，对这个场景应当不陌生。第一章讲的是照护在“需求”这个地址上寻找老人，却看不见老人正在长向哪里的指向性痕迹，本书称之为生迹，称这种看不见为失认（见第一章）；第二章讲的是比生迹更深一层的残迹（见第二章），那些未被选中、未完成、未被记住的痕迹，以及善意如何以“填充”的方式，把残迹所在的空位抹平。在养老院里，被看不见的是老人想把床头的东西挪回原处的那个动作，是他总在黄昏时走向某扇门的那条线路；在门诊里，被看不见的是一个血压数值背后一整套正在运转的供血安排。两处的结构是相同的：对象一直在给出答案，答案不长在系统设定的地址上，于是系统在它最

精密、最周到的时候，恰恰最听不见。老人的“需求清单”与病人的“指南路径”，是同一种东西在两个场景里的不同名字，它们都是外部事先写好的、可编码的“好”的样子。

两处的差别在于，临床上的“答案”有了一个更物质的名字：代偿。生迹与残迹要靠照护者的注视才能被指认，而代偿在医学自己的语言里早就有位置。发烧烧出了什么，血压代偿性升高在保护哪个器官，疲惫让一个人停止工作反而救了他的命，这些在医学自己的语言里早有位置。医学并不缺少关于代偿的知识。本章要问的是另一件事：当这些知识进入一个由指南、支付规则和法律判准共同烧结的制度环境，代偿为什么仍然被当作故障来对待？为什么医生在知道代偿存在的同时，还是在每一次点选菜单的时候，把它当作“需要纠正的异常值”？

本书的总命题是：精准的善意抢先替生命定下“好”的样子，替得越久，生命越长不出自己的答案。这个命题分三步展开，第一步是“看不见”。本章处在第一步的末端，同时也是全书从养老场景转入医疗场景的枢纽。前两章在照护现场看见了系统如何看不见老人，本章要在临床现场说明，同一种看不见并不是照护这个行业的特殊毛病，它有一套更坚硬的制度构造作为支撑，而这套构造在医疗里被锻造得最彻底。这套构造将得到两个名字：被看不见的那一层叫作临床海底，覆盖它的那一层叫作指南地壳。它们的出场，不是为了给既有现象换一个更时髦的叫法，而是因为一个先验被撤销之后，已有的批评无法再说清留下来的空白。

还需要交代，本章为什么要把重点放在“被打击”上，而不仅仅是“被忽视”上。看不见是第一步，但在临床里，看不见很快就转为看得见的另一种样子：代偿一旦在检查中露出痕迹，它不是被当作身体的一个回答来对待，而是被识别为新的故障，被编码、被纠正。降压之后的昏睡，被读成了认知障碍；融合术拿走的代偿，被读成了“邻椎病”。第二章所说的善意填充，在这里升级为善意打击：不是把空位填平，而是把空位里已经长出来的东西当作病灶拔掉。这一点，使得医疗场景里的“看不见”比照护场景里更凶险，也使得它成为理解后面

几章的前提：只有当代偿被系统读作故障，叙事、发生权、内感受判断力才会被依次让渡出去（分见第四、五、六章）。

本章的推进顺序如下。第二节撤销那个从未被充分审查的先验，并通过两片临床地带引出海底与地壳这对概念。第三节追踪地壳如何在支付、安全伦理与过失法的三重锻造下烧结成一整块。第四节说明医生的认知如何被训练为排雷式认知。第五节以脊柱融合术为龙骨案例，让读者看到一个代偿系统如何被一次合规的手术拆毁。第六节与最强的几位对手逐一对质，说明这对概念无法被任何一个既有概念一对一替换。第七节面对“为偏离辩护”这一最难的议题，讨论偏离说理评审的构成、判准与被异化的风险。第八节给出本章的证伪条件，并回扣母题，交棒给第四章。

◆ 二、临床海底与指南地壳：一个先验被撤销之后

– （一）被所有人共享的那个预设

围绕精准医疗的标准化困境，已有的批评大致有三类。一类指向技术的不成熟，靶点不够多，数据不够全，算法不够聪明。一类指向防御性医疗，医生因为害怕被起诉而多做检查、多做手术，这一脉有 Kessler 与 McClellan 开创的实证传统。还有一类来自循证医学内部的自我批判，Greenhalgh 等人在《英国医学杂志》上宣告循证医学处于危机之中，指控商业利益绑架了指南的制定。再加上沿着 Braverman 的思路展开的去技能化批判，以及 Dekker 的系统漂移模型，这些批评之间可以互相争吵：法律恐惧更要紧，还是商业腐化更致命？管理控制在先，还是安全与效率的漂移在先？但它们共享一个从未被推到审判席上的预设：那条“正确的诊疗路径”本身是存在的，临床上可识别，可编码进指南，问题只出在外部力量对这条路径的偏离、腐化或漂移。

这个预设的解释力在一个节点上衰减。即使在法律风险较低、指南制定相对洁净的医疗体系，例如某些北欧福利国家，医生依然紧抱指南，依然把大量精力花在合规而非个体病人身上。那里的惩罚性诉讼虽少，行政审计和监督审查却密集，审查的核心依据仍是“是否符合全国性临床指南”。医生不怕被起诉，怕的

是在同行或卫生行政部门的审计中被认定“偏离标准”，进而影响职业声誉乃至聘用合同。这说明有一个更深的东西，在所有这些已被命名的力量之下运转。

本章要做的不是在变量清单上再添一个因子，而是撤销那个预设。追问可以再进一步：一个人生病时，身体经历的那个复杂、动态、持续折中的自组织过程，发烧究竟烧出了什么，血压代偿性升高在保护哪个器官，疲惫让一个人停止工作反而救了他的命，这些可以被一套外部的、通用的、基于统计常模的“正确路径”完全代表吗？而且这个代表过程，不会漏掉任何在临床上具有根本重要性的东西吗？这是“认识”对“发生”的越位：用可以被编码和操作的外部标准，取代只能通过对一个特定身体漫长而不确定的反复试探才能逐渐逼近的内部情形。这一越位并非谁的恶意，它出自制度的骨架。制度的核心运转，支付、审计、法律归责，都依赖可以被外部识别的、可编码的行为边界；制度的生存依赖认知对象的可编码化，而身体那片涌动的、前认知的、抵抗编码的自组织过程恰恰不可编码。制度与身体之间，存在一个结构性的认知断裂。那个不可编码、却是一切疾病与康复实际上演的场域，就是临床海底。

（二）两片临床地带：先经历，后命名

概念不宜先于经历。除了开篇的八旬老人，还有第二片地带。一位丧偶两年的中年女性，主诉全身弥漫性疼痛、极度疲惫、睡眠破碎。血常规、炎症指标、自身抗体、甲状腺功能，所有化验全部正常。指南走到这里已到尽头：没有可编码的异常值，没有可开具的处方，没有可报销的诊断。她被礼貌地转诊到心理科。从地壳的标准看，每个操作都正确，排除器质性疾病后考虑躯体化障碍，符合诊疗常规。可是在那些未被化验、也无法被化验的身体深处，她的下丘脑—垂体—肾上腺轴已经在两年的持续哀伤与社会孤立里，浸泡在长程高皮质醇中，肌肉分解、免疫抑制、中枢敏化。她的疲惫与疼痛不是无病呻吟，而是身体在被悲伤长期校准之后做出的一套低能耗运转的生存模式。这不是故障，是代偿的极致。

两片地带放在一起，有一种共同的感受：这里有一个东西，它在决定病人的全部命运，而现成的医学语言说不清它。它在指南里被称作“需要纠正的异常”或“无法编码的非特异性主诉”，在医保系统里被视为“超支风险”或“不合规操作”，在法律系统里被视为“可追责的偏离”或“不可采信的模糊证据”。而它本身，那片身体在无声中持续进行的、折中的、局部的组织过程，从未被当作合法的临床认知对象。它需要一个名字，因为不说出它，后面的判断就无处落脚。

– （三）临床海底的界定与两条边界

临床海底，指在任何疾病被识别、编码与纠偏之前，身体已经在进行的那套复杂的、充满尝试性的自我组织与代偿过程。它不等于“自愈力”或“免疫系统”：那些概念是海底的局部提纯物，是已被捞上岸、制成标本、写进教科书的东西，海底是标本被移走之后剩下的、无法被彻底沥干的鲜活海域。它是前概念的，发生在任何诊断标签贴上之前；是前认知的，不经过意识，老人并不知道自己的血压在保护自己的认知功能，也无法体验到这件事；它也不是现象学所说的“活的身体”，而是身体在不经过当事人的情况下，为全体细胞的利益做出的一个代谢决策；它抵抗编码，无法简化为一组可以从具体生命处境中切割出来的可数指标。

这里必须立刻钉下两条边界。第一，海底不是一个先验的、更本真的“生命真相”。它是一个关系性的显现：只有在指南地壳覆盖上来之后，它才作为“被制度性排除在合法认知之外的东西”被反向指认出来。地壳出现之前，医生面对的身体同样被另一套框架组织过，经验、师徒传承、教科书里病理解剖的叙事，那套旧框架也有盲区和权力结构。我们无法回到旧框架内部去指认它漏了什么，只能在新的覆盖已经发生之后，看见一片比旧框架的认知对象更原始、更不在任何编码之中的自组织过程被排除，才为它命名。它的“存在感”本身是地壳压迫的产物。这条声明用来防止把海底误读成一种等待回归的、浪漫化的“身体智慧”。

第二，海底的自组织常常失败，甚至惨烈地失败。代偿性高血压最终压垮心室壁，保护变成新的威胁；免疫系统清除感染时发起不可控的细胞因子风暴，杀死了它所保护的主体；长期升高的皮质醇让一个人撑过丧偶后的头两年，也在静默地侵蚀她的海马体。海底不是至善的智慧，只是持续的、折中的、不保证成功的自组织本身。它的决策是局部的、亚整体的、器官系统之间的彼此妥协：保全了大脑的血压代偿，牺牲的是心室壁和肾脏。这不是一支有总司令的军队在战略撤退，而是一片没有总司令的战场上，各部队自行达成的、脆弱而昂贵的局部停火协议。这是海底与一切生机论色彩的“身体智慧”之间最深的断裂线。

然而，无论成功还是失败，海底是一切疾病与治疗发生的唯一地层。任何外部干预，一粒降压药、一剂化疗药、一台融合手术，都不是直接作用于指南上的那个“病”，而是先扰动这片海底，引发一串新的、无法被完全预测的代偿反应，再被稳定下来或没有稳定下来，成为新的临床形态。医疗的对象，从来不是指南上的故障编码，而是这片海底对外部干预的全部回应。医生在海底里“听”的，并非某种神秘的生命智慧，而是长期浸泡中训练出的、对身体代偿边界的模式识别：那个老人的脑灌注压底线在哪里，那个慢性疼痛病人的核心肌群在放弃代偿之前还能撑几次弯腰。这些不是指南能提前给出的固定数字，却是客观存在的生理与物理边界。

– （四）指南地壳：三股力量烧结成的操作面

覆盖其上的，是指南地壳。它不等于“临床指南”那本小册子。这个名字指认的，是三股力量在数十年间互相借力、互相焊接，最终融成一整块的复合操作面。第一股是循证医学生产的标准化推荐意见，基于大样本随机对照试验、以统计常模为基准，它们诞生之初是供参考的专家共识，并不强制，只是在等待一个接口。第二股是 DRG 等支付制度，把这些推荐意见固化为“可报销边界”。第三股是医疗诉讼中把“是否遵循指南”作为过失判定核心证据的法律惯例，为遵循者提供免责保护，也让偏离者在法庭上显得失据。这三股力量如何一步步焊接，下一节专门展开。

此处先说地壳的本质特征：它不在于内容，那些推荐意见会定期更新修订；它在于操作形态，是一层日常诊疗中始终在场的、同时承载科学合法性、经济合规性与法律安全性三重功能的操作面。它在每一次点击电子病历的下拉菜单时被激活，在每一次病案编码被上传医保审核系统时被结算，在每一次知情同意书的措辞里被预支为未来的法庭证据。因此，地壳不需要一个时刻在场的监督者。医生开单时并不会想着“我要遵循指南以规避诉讼和拒付”，那是对地壳运作方式的误解。她只是在系统弹出的默认选项里做她熟悉的事，在科室例会投影出的平均住院日排名里确保自己不落在标红区域，遇到反常病例时下意识地追加检查以撑起病历上的合规厚度。没有人拿枪指着她，她自己已经把“安全”与“专业”这两个词，重新定义成了“在地壳上行走”。

– （五）地壳与海底的关系：屏蔽而非压制

由此，这对概念的核心辨别力得以显出。它们描述的，不是身体与制度这两类实体之间的外部冲突，不是“鲜活经验被僵化规章扼杀”那个已经有无数版本的叙事。它们描述的是另一件事：一层人造硬壳，对其下那片前认知动态过程的系统覆盖与信号截断。地壳不是从外面挤压海底，而是直接盖在海底之上，使海底发出的信号无法穿透、抵达医生的认知界面。医生并非看见海底然后选择无视，她从一开始就没有一条制度性的感知通道，可以把那片涌动的代偿当作合法的临床对象来对待。海底不是被压制，是被屏蔽。这一区分之所以要紧，是因为压制可以靠松绑来解除，屏蔽则要求重建通道。本章的最后一节将回到这一点。

◆ 三、地壳的硬化：DRG 与患者安全运动的焊接

– （一）第一股：支付制度给指南装上经济接口

地壳的硬化需要回到一个具体的历史节点。1983 年，美国国会通过预期支付系统，即 DRG 支付改革。在此之前，医院向政府医保报销按项目收费，做得越多，收得越多，医疗费用以不可持续的速度膨胀。DRG 的逻辑相反：住院病例按诊断、年龄、并发症等变量归入大约 467 个诊断相关组（以最初版本计），每组对应一个固定的支付额度。无论病人实际住几天、用多少药、做多少检查，

医院只拿这一笔钱；超出的成本由医院承担，结余由医院保留。这表面上是一项精算工程，在医疗文化上却是一场静默的地震，因为它需要一件它自己并不生产的东西：一套能够清晰界定“什么病例该干什么事”的标准化流程。支付方说不出一个“合理住院天数”的标准，就无权判定哪家医院“超了”；医生拿不出一套“标准诊疗流程”为自己辩护，就会在审计面前毫无还手之力。正是在这个接口上，原本发源于专业共同体内部、供教学与质量改进之用的临床指南，被赋予了它从未被设计承担的功能：界定“可报销边界”的实际执行工具。

此后，指南与支付之间的锁定不断加固。对于偏离指南的诊疗，无论临床动机如何，比如一位独居老人确实需要多住三天，因为他回家后无法自己监测感染迹象，在 DRG 核算里都被默认翻译成“浪费”“低效”或“管理不当”。医生当然可以写一封长长的申诉信，但这封信的启动门槛很高：要花时间，要做文书，要在科室里讨论，还要承担被驳回之后的实际财务损失。这些成本的累积，使得下一次遇到类似情形时，医生倾向于“提前收束”：在住院天数即将触线之前，说服自己这位病人可以出院了，然后在下拉菜单里选那个最不容易被反驳的出院处置。地壳的经济强制力，正是在这样一次次自我收束里，从外部压力转化成了医生自己执行的内在纪律。

但单靠这一股力量，还不足以制造地壳。按项目支付的体系里也有指南，只是指南在那里没有经济核算的硬约束；单有 DRG 而无其他制度配合，医生也许还能通过行政申诉争取偏离的空间。地壳之“硬”，不在任何一股力量，而在三股的焊接。

（二）第二股：患者安全运动提供伦理护盾

几乎同一时期，患者安全运动完成了一次关键的转向。1999 年，美国医学研究院发布里程碑式的报告《犯错的是人》（To Err Is Human），将医疗差错致死人数推到舆论的风口，核心建议之一是推行基于证据的标准化诊疗，以减少人为疏忽造成的可预防伤害。这个建议的临床意图无可厚非：手术部位错误、药物过敏史遗漏、已知禁忌症被忽略，减少这些低级错误是任何专业的应有之义。

但在地壳正在凝结的节点上，它产生了一个后果：为地壳提供了一道伦理护盾。从此，对标准化的任何质疑都可以被推诿为“危险的、藐视患者安全的不专业行为”。地壳在科学（循证）、经济（DRG）两条轴线之外，又在道德轴线上完成了自我正名。

这是地壳与工业领域去技能化的一个关键区别。Braverman 所描述的劳动过程，是资本把技艺分解为简单的标准步骤、剥夺劳动者自主权；工厂里的泰勒制不必打着“保护工人安全”的旗号，它在道德上是赤裸的，公开宣称自己是用科学管理替代工人的随意动作以提高效率。医生的判断力被标准化所替代，却恰恰是在“为了病人更安全”的伦理大旗下完成的。这层护盾不是空洞的包装，它完成的是标准化的内化：医生遵循指南时体验到的，常常不是“我被剥夺了判断权”，而是“我变得更科学、更规范、更以病人安全为中心”。外部管理逻辑与内部安全伦理在医生自我认知中化合，这是工业去技能化从未出现过的形态。

– （三）第三股：过失判定锚定在指南上

在随后的医疗诉讼中，“是否遵循临床指南”逐渐从可供参考的专业意见，演变为判定过失的核心证据。偏离指南，即使没有造成实际损害，也可能在法庭上被解释为“未能恪守诊疗常规”；遵循指南，即使结果不幸，也几近等于拿到“无过失”的安全牌。指南成了一条法律上高度可操作的分界线，在满是灰色地带的临床实践里画出一条黑白分明的线：线内安全，线外裸露。

当法律归责这一笔与 DRG 的经济核算同时落在“指南”这同一个枢纽上，焊接就发生了。经济核算的惩罚（拒付、标记、列入异常名单）与法律风险的惩罚（败诉、赔偿、声誉损失），被熔铸成同一个操作性指令：留在指南之内。设想两个平行世界：一个只有法律风险而没有 DRG 核算，医生也许可以通过行政申诉或同行评议为“这个病人必须多住三天”辩护；另一个只有 DRG 核算而没有法律风险，医生也许可以硬扛财务标记，为病人争取更长的住院时间。当两条线烧结在一起，一次偏离同时触发两套惩罚，任何想偏离的医生面对的就不再

是“一笔可能被拒付的账单”或“一桩可能被起诉的纠纷”，而是一整块被提前锁死的复合压力。

（四）从叠加到焊接：航空业作对照

这里需要一个机制性的区分：叠加与焊接不是一回事。多个制度压力可以叠加在同一个领域而不彼此焊接，航空业是最有力的对照。民航领域同样存在安全规章、航空公司内部的效率考核、事故调查中的法律归责，但三者保持在相对独立的轨道上运作。规章的修改主要来自事故调查的技术建议，例如美国国家运输安全委员会的独立调查报告；经济考核来自航空公司独立的运营指标，准点率、燃油效率；法律归责主要追索故意违规或重大过失，而不是对标准操作程序的每一次微小偏离。一个标志性例子是，飞行员若因疲劳报告“不适航”，可以拒绝执飞。这一制度在安全与效率之间维持了可以被分别操作的叠加关系：安全在这一点上压倒效率，而这次压倒并不同时触发法律诉讼（只要报告程序合规）或经济惩罚（航空公司的合同通常保护合规的疲劳报告）。调整一条轨道，不必承受其他轨道的自动反弹。

医疗里的情形发生了质变。支付规则、法律判例与安全伦理在指南这个操作面上熔合，不能再被分别操作。仅改革医疗过失法、降低诉讼风险，地壳不会散架，因为 DRG 的核算系统仍在以指南为边界执行拒付与标记；仅改革支付方式、引入更灵活的按质量付费，地壳也不会软化，因为诉讼中的“诊疗常规”辩护仍锚定在指南上，医生仍不敢为了更高的“质量评分”偏离那条法律上预装好的安全底线；甚至一场“患者安全2.0”运动也难以松动地壳，因为安全伦理所保护的边界之内，经济与法律的双重惩罚仍在运转。回到那位需要多住三天的独居老人：医生面对的不是“安全对效率”的叠加权衡。延长住院天数，支付系统会自动把她标记为“异常值”；而老人若在提前出院后于家中出意外，她的出院决定在回顾性审查中又可能被指控为“未能恪守诊疗常规”。两条惩罚线在同一个决策上同时触发，她无法像飞行员报告疲劳那样，通过一个合规的单独程序阻断其中一条。这就是焊接，你无法只打碎其中一层。这一点也是本章与 Dekker 的漂移模型、与防御性医疗研究的最根本分离点，第六节将再回到它。

◆ 四、排雷式认知：制度性感官剥夺的认知后遗症

– （一）一个衍生概念的位置

地壳一旦硬化，就不只是外部环境的改变，它穿透了医生的皮肤，重塑了认知的指向。不能简单地说医生的判断力“萎缩”或“消失”了：一种旧能力退场的同时，另一套高度适应性的新能力被制度性地训练了出来。本章称之为排雷式认知。

先交代它的位置。排雷式认知不是与海底、地壳并列的第三个核心概念，而是地壳覆盖海底之后，在医生认知层面必然产生的衍生后果。它的不可还原性不由它独自承担，而由它所从属的那对主概念承担。这也决定了它不能被读成“防御性医疗的认知维度”，也不能被读成“审计理性的内化形态”：它所依赖的地壳，不能被这些概念替代。更要紧的是，排雷式认知与地壳覆盖海底之间的关系，不是历史上偶然的先后，而是结构上的逻辑导出。需要补上这个扣环，才不至于把它误读为“医生变坏了”的道德诊断，或一种可以靠再教育修复的认知偏差。

– （二）上游筛选：信号根本没有进入认知界面

扣环如下。地壳最根本的操作后果，是在制度层面完成了一次对临床认知对象的上游筛选。海底发出的信号，老人降压后持续的昏睡，做完融合术的年轻人说“腰不痛了，但整个背不是我的了”，这些信号不被任何指南要求记录，不对应任何可以报销的诊断编码，不被任何质量指标追踪。它们落在电子病历下拉菜单之外，落在病案编码选项列表之外，落在质量指标的统计口径之外，在制度的感知系统里不存在。这不是医生忽略了它们，而是它们根本没有作为合法的临床数据进入医生的认知界面。留在界面上的，只有制度允许进入的信息：化验单上的异常值，影像报告上的阳性发现，指南条文上的推荐选项，以及这些选项对应的支付编码和法律判例。

这一步筛选不发生在医生的脑子里。它发生在电子病历的界面设计里，发生在病案室的编码手册里，发生在医保审核系统的拒付规则里。医生不是“选

择”了不看海底；她从一开始就没有一个制度性的感官，可以接收海底的信号。当“可观察、可操作的临床现实”被制度性地等同于“在指南上合规的操作”，医生的注意力就不再是“关注合规还是关注海底”的自由选择问题了。

（三）排雷：高强度的思考，另一个方向

于是，排雷式认知从这种制度性感官剥夺中必然导出。医生的认知被重新训练，目的不是看见更多，而是在仅剩的那批信号中，精准识别可能引爆法律或财务风险的地雷。排雷专家并不是不思考，他的思考强度极高，只是全部注意力指向识别和绕过已知的雷区。地壳上的临床决策者就是这样的人：他对指南中每一条可能被审计的条款烂熟于心，对医保拒付的常见理由倒背如流，能在电子病历的叙述中，预先用合规措辞填上那些可能被用来指控他“遗漏”的漏洞。他依然聪明，依然勤勉，但他的智力被调用来服务于一个与“逼近这个特定身体的情形”完全不同的目标：在合规的轨道上，把每个病人安全地运送到住院终点，同时把自己安全地摘出任何潜在的麻烦。排雷式认知不是个体的认知偏差，也不是需要被“治愈”的病理，而是地壳土壤中的高度适应性技能，是医生为了特定的生存目标必然长出来的一套理性生存策略。

（四）“好医生”的暗中置换与羞耻的转向

这种认知转化最隐蔽的后果，是医生对“什么才算好医生”的感知被暗中置换。曾经，能在不确定中做出判断、愿意为自己的判断承担风险的医生，被视为成熟的标志。这种成熟不是莽撞，莽撞是不经思考的冒险；成熟恰恰相反，它是长期浸泡于临床海底之后、在前概念层面生长出来的语感：他知道什么时候一个病人“看起来不对劲”，哪怕所有化验单都还正常。而在地壳上的生存逻辑里，“专业”的医生成了那些能把每项决策的责任都成功分散到指南、检查报告和科室集体讨论上去的人，他留给自己的，是一片没有任何角度可供追责的制度空白。一个从不让自己暴露于任何风险的医生，取代了那个愿意为一个独特个体的利益而置身不确定性前沿的医生，成为新的职业模范。这不是个人的道德退步，而是一套奖惩机制经年累月训练出的生存理性。道德情感的指向被制度性地

扭转了：羞耻不再附着在“我没有为这个病人尽力”上，而是附着在“我让自己被审计出来了”上。

（五）语感无法靠培训补回

最具杀伤力的后果，还不在职业伦理的改写，而在听见海底的能力被彻底剥夺。海底发出的信号落在标准化记录系统之外，对地壳上的决策者是隐形的；当医生的注意力通道被排雷占满，他没有剩余的认知带宽去面对那些与指南不合、却可能指向海底深处一场正在发生的灾难的无名信号。他甚至已经失去倾听这类话语的语感，这不是一种再办一期培训就能恢复的能力。语感需要在被允许长期浸泡于不确定性、被允许犯错、被允许与具体身体反复周旋的过程中，一寸一寸地长出，而地壳环境把这整个生长过程连根刨掉了。

（六）一个强替代解释及其回应

认知心理学会提出一个强替代解释：排雷式认知是“认知启发式的过度依赖”或“元认知监控失败”，根源在医生个体的认知偏差，制度只是诱因。如果成立，制度层面的判断就被瓦解了，问题只是医生的脑子没有掌握正确的推理策略。

这个解释不成立，理由在它的前提。它预设医生拥有完整的信息，只是选择了错误的加工策略，也就是医生能够看见海底的信号，被启发式引导着忽略了它们。但在地壳环境下，这些信号从一开始就没有进入医生的认知界面：它们不被要求记录，没有可报销的编码，不被任何质量指标追踪。这不是“看见信号甲，然后被启发式引导去处理信号乙”的问题，而是信号甲在输入端口就被截断的问题。当一个信号从未被当作合法的临床数据进入注意力通道时，认知心理学所研究的信息加工策略还没有来得及上场。问题出在认知心理学所假定的“信息初始输入”的上游，制度已经提前完成了对什么算“信息”的筛选。这个筛选无法由认知心理学家在实验室里靠改进推理训练来扭转，因为它不发生在医生的头脑里，而发生在下拉菜单、编码选项和统计口径中。

◆ 五、身体的回声：以脊柱融合术为龙骨

– （一）为什么是这个案例

概念与机制的论证到此仍悬在抽象的骨架上。一个判断若不能让读者在一个具体案例里感到那层覆盖，感到它在每一次手术签字、每一次病案编码、每一次鼠标点击中被激活，它就不算落地。本节以脊柱融合术的滥用为龙骨案例。慢性腰痛是全球致残的首位原因，也是脊柱融合术最常见的适应证之一。在美国，腰椎融合术的数量在 1998 年至 2008 年间增长了超过两倍，而同期并无新的临床证据表明融合术的疗效优于保守治疗；到 2010 年代，它已成为美国医保支出中最昂贵的单一手术类别之一。这个案例之所以能当龙骨，是因为它完整展示了指南地壳上的标准叙事、排雷式认知的逐格推演，以及海底信号被地壳系统截断的全过程。它不是一个“坏手术”的孤立故事，而是地壳逻辑在微观操作中的一次完整展演。

– （二）术前海底：一顶费尽心力搭起的力学帐篷

先要打开这位病人的海底，否则后面融合术对海底的摧毁，只会被一个笼统的“并发症”标签一笔带过，读者永远看不到被摧毁的究竟是什么。案例中的病人是一位四十五岁的长途货运司机，主诉慢性腰痛三年，近半年加重，偶有左腿轻微麻木。MRI 显示 L4–L5 和 L5–S1 椎间盘轻度至中度退变，椎间盘高度降低，纤维环可见小裂隙，但没有明确的椎间盘突出压迫神经根，没有椎管狭窄，没有脊椎滑脱。他超重三十公斤，吸烟二十年，核心肌群因长期久坐而显著弱化；自述工作压力大，婚姻关系紧张，睡眠差，感到“整个人都在往下垮”。这是地壳上的标准病史。

现在进入海底。二十年吸烟已造成椎间盘的微血管缺血性退变，椎间盘本身没有血供，营养依赖终板的弥散，而吸烟系统性地损害这种弥散。肥胖与长期久坐，每天十小时固定在驾驶座上，脊柱前屈，双下肢静置，使腰腹核心肌群进行性荒废。腹横肌、多裂肌这些本该在每一次弯腰、搬运时先于脊柱收缩、在椎体之间预加载稳定的深层小肌群，已不再有效工作，脊柱的被动结构，椎间盘、关

节突关节、韧带，因此不得不承受远超设计负荷的、在振动与扭转中反复叠加的微应力。纤维环的小裂隙不是“病因”，而是这条失效链的末端痕迹。

再看他的代偿。步态分析显示，他行走时左髋外旋十五度，腰椎向患侧倾斜，把体重大部分压在右腿。这不是一个“坏姿势”，它是三年间身体反复试错、找到的唯一能绕开椎间盘运动性疼痛的力学逃逸路线。他左侧的竖脊肌与腰方肌代偿性肥大，每次弯腰穿袜子时强行钳住 L4–L5 节段，以牺牲腰骶部的柔韧性换取一个疼痛可承受的活动范围。代价是右膝关节因长期偏载出现早期软骨磨损，左侧骶髂关节因异常应力而韧带增厚、部分丧失弹性，颈椎也因代偿性前倾出现慢性疼痛。从足底的着地角度，到髋关节的异常旋转，到脊柱旁肌肉的单侧肥大，再到对侧膝关节的代偿磨损，这整套系统是一顶三年里反复搭建、不断修补、漏洞百出、却终究在每天十小时驾驶中撑住了的力学帐篷。它不是“健康的”，它正同时在多个关节制造缓慢而不可逆的堆积性损伤。但它是没有总司令的战场上，多裂肌、腹横肌、竖脊肌、关节囊、韧带、筋膜这些各自为政的小部队，在疼痛信号、力学负荷与自我保护反射之中自行达成的脆弱停火协议。

– （三）地壳上的标准叙事与排雷式认知的逐格推演

他坐到脊柱外科医生面前。北美脊柱学会的循证临床指南，对“非特异性慢性腰痛”的推荐线条大致是：保守治疗，包括物理治疗、运动、药物与认知行为干预，为首选；融合术只用于经过至少六至十二个月规范保守治疗失败、且有明确影像学不稳定证据的患者，如峡部裂滑脱、退变性侧弯进展，或经椎间盘造影确诊的椎间盘源性疼痛。严格按此标准，这位病人的影像学发现并不构成明确的“不稳定”；他没有完成六至十二个月的规范保守治疗，那几次中断的物理治疗不算“规范”；他还有明确的非器质性因素：抑郁、肥胖、吸烟、核心肌群荒废。依指南的保守精神，他应被转回去继续保守治疗，被推荐到戒烟、减重和长期运动康复里。但在同一份指南的同一个界面上，还列着另一组信息：对有症状的椎间盘退变性疾病、保守治疗效果不佳者，可以考虑融合术。这条口子就是地壳上的摇摆空间，而决定医生在这个空间里选“继续保守”还是“手术”的，不是指南的文本，而是指南之外那套被焊接进地壳的经济与法律压力。

以排雷式认知的视角逐格推演。第一格，保守治疗的再尝试：他可以花二十分钟劝说病人戒烟、减重、加入长期康复，解释融合术在他这种情况下远期效果不佳，并安排转诊到戒烟门诊、营养科、心理支持和有经验的物理治疗师。但在他的电脑上，这二十分钟的说服无法勾选任何可以单独报销的编码；戒烟咨询有一些有限的编码，支付极低；物理治疗转诊把病人送出自己的科室。选这条路，他的手术排班空出一个下午，科室当季的外科产出指标少掉一台权重可观的融合术。在 DRG 框架下，腰椎融合术的支付权重是保守治疗（那些按时长计费的门诊随访和康复转诊）的数十倍。这台手术不做，科室的收入、医院的周转率、他自己下一轮聘用评估中的“效率数据”，都会轻轻向负向滑一格。

第二格，融合术的推进。他需要把病人的 MRI 报告、疼痛评分、既往保守治疗（那几次中断的物理治疗）记入病历，并在手术知情同意书上勾选“保守治疗无效”。病历书写有一套行业内反复打磨的成熟措辞：“患者经规范保守治疗（物理治疗，时间大于三个月）后，疼痛未获充分缓解，且有证据提示椎间盘退变可能为疼痛来源，与患者充分讨论后决定行腰椎后路融合术。”每个词都有分量。“规范保守治疗”，写上这六个字，不必附每次物理治疗的出席记录与疗效评估；“保守治疗无效”这五个字，是地壳上最安全的通行证之一。它在法律上给医生一张底牌：我已遵循指南（保守优先），但病人客观上需要更进一步的干预；它在经济上保证这台融合术的账单能以“保守治疗失败的退变性椎间盘疾病”为由被 DRG 支付系统顺利接收。

第三格，知情同意书的功能置换。同意书的原始功能，是确保病人在充分了解风险与收益之后自主决定。但在排雷式认知的手术同意环节里，它被激活的主要功能不是信息的充分传递，而是法律地雷的预先排除。医生写下“已告知患者保守治疗选项及手术可能并发症，患者选择手术”，这句话在临床上的实指可以非常稀薄，所谓“保守治疗选项”可能只是一句“你也可以不做手术，但你的情况可能不会自己好”；它在法律上的虚指却是铁打的，如果病人日后以“医生没有告诉我还有其他选择”为由起诉，这份同意书就是完整的免责堡垒。签字完

成，法律地雷被标记为已排除，账单进入待提交状态，质量指标多了一条“已完成知情告知”的合规记录。

对比两条路径的制度后果。路径甲，保守坚守：承担大量不能转化为报销的沟通时间，损失一台高权重手术，面对病人可能的失望与流失，并在质量指标上因“手术率偏低”被标记；法律上安全，经济上亏损，管理上低效。路径乙，推进手术：病历合规、账单合规、知情同意合规，科室产出达标；法律上安全，经济上为正；病人术后短期内会因神经阻滞和卧床休息而报告“腰痛减轻”，初期满意度评分不会差。没有任何监督者会在此时跳出来说“你错了”，因为从地壳上任何一个检查点看，他的每一步都在壳上。这里没有坏人。

— （四）术后海底：帐篷倒塌之后

钢钉与融合器打进了 L4 到骶椎的节段。术后三个月，他确实不再抱怨“腰痛”，因为那几节被焊死的椎体已不能产生运动性疼痛信号。六个月后，他开始抱怨一种新的、“说不上来”的不适：整个下背部“不是自己的了”，弯腰穿袜子需要一种奇怪的侧身代偿姿势。一年后，融合节段上方的 L3–L4 椎间盘破裂，髓核脱出，死死压住神经根。

这个新灾难不是手术的“失败”或“并发症”，这些词预设手术本身可以是“成功”的，新问题是手术之外独立发生的不幸。恰恰相反，手术在物理上“成功”了：它把原本由 L3–L4、L4–L5、L5–S1 三个节段分担的、每天十小时驾驶中反复累积的万千次微应力，全数转嫁给唯一剩下的那个节段。那座花了三年搭起的力学帐篷，左髋外旋、腰方肌代偿性肥大、对侧膝关节偏载，在被钢钉强行终止原有的代偿序列之后，各支部队（肌肉、筋膜、关节囊）被迫在术中创伤与节段锁定后的全新力学环境里，重新寻找一套从未排练过的代偿方案。它们失败了。那根被孤立的 L3–L4 节段，在没有腹横肌有效预加载、没有多裂肌节段性稳定的情况下，独自承受一个二百四十磅的身体在每天十小时卡车振动中的全部剪切力与屈曲力矩。它的破裂不是意外，是旧帐篷被一把抽走主梁之后，唯一还能被逼出来的那根柱子的必然折断。

接着，这套新灾难被另一条指南识别为“邻椎病，可考虑二次融合”。他的婚姻仍在恶化，体重仍在增加，抑郁未被任何人问起，因为这些都不在脊柱融合术的临床路径里，不对应任何骨科质量指标。术后一年随访时，他对医生说“我整个人还是不对”，医生可以诚实地回答：“片子看着很好，融合很成功，你的指标都是正常的。”每一步都踩在地壳上。而一位被焊死在腰椎上的病人，付出的是丧失三个椎间盘的活动度、摧毁一整套花了三年才勉强搭起的代偿帐篷、并在邻椎破裂后面对第二次融合的级联手术，换来的是一个在地壳上无懈可击的、法律上绝对安全的合规决定。这就是地壳对海底的覆盖，在一个身体上留下的全部划痕。

（五）打地鼠：覆盖反复上演

同一逻辑在慢性病管理的“打地鼠”里反复上演，构成医疗对身体的系统性惩罚。降压之后血脂上升，降脂之后血糖爬升，降糖之后体重增加，减重之后抑郁加重，抗抑郁治疗又引起性功能障碍与代谢综合征的进一步恶化。每一步治疗因为精准打击了上一轮制造出来的“异常值”，而在报表上显示为正确；每一步打击又重新扰动海底，逼它做出新的、更勉强的代偿，于是新的“故障点”被制造出来，等待下一轮精准打击。

这个循环在临床文献里并非无迹可寻。临床药理学与老年医学已有“处方级联”（prescribing cascade）的概念：一种药物的不良反应被误诊为一种新疾病，从而导致另一种药物的加用。噻嗪类利尿剂引发高尿酸血症，被诊断为痛风而加用别嘌醇；钙通道阻滞剂引发外周水肿，被误诊为心衰恶化或静脉功能不全而加用利尿剂。在多重用药的老年患者身上，级联可以延伸到五层、六层之深，每个环节都有指南推荐作为加药依据，每个环节都生产合规的病历和可报销的账单，而被药物反复推搡的身体，肾脏、电解质、认知功能，在每一步精准打击中缓慢而不可逆地衰竭。这些研究零散地捕捉到海底被反复扰动后产生的新代偿，如何被地壳重新识别为需要打击的新故障，却缺一个整体概念来命名这套惩罚的逻辑。本章讨论的正是这一逻辑的完整形态。

– （六）被流放的言说

在这场碾压中，被剥夺合法性最彻底的，是病人对自己身体的感知。一位病人走进诊室说“我最近整个人说不上哪里不对，就是累，就是不对劲”，她发出的是海底对整体代偿状态的一份无法被编码的综合报告，也是所有代偿过程中启动最早的信号：在血糖来得及被化验出异常之前，在血管还没被影像照出斑块之前，身体的感知系统已通过疲惫、疼痛、情绪低落这些粗糙而灵敏的信号在求救。然而地壳上的认知框架只接收已被编码为“异常值”的数据。这句叙说在操作上找不到对应的诊断代码，在核算上找不到可据以报销的处方依据，在法理上找不到一个需要为此承担“漏诊”责任的生化阈值，于是被判定为噪音。病人反复听到“检查结果都正常，您放宽心回去休息吧”，迟早学会一件事：我的身体发出的信号是不可靠的，只有标红了异常值的化验单才配得上“疾病”之名。一个被精密仪器武装到前所未有程度的医疗体系，让最需要它的人，病人自己，丧失了对自身身体的言说权。海底被地壳覆盖之后，连发出声音的人自己，也不再相信那声音。这一点留给第四章，那里将看到叙事层的占位如何接着发生。

◆ 六、与最强近邻的对质

一个声称自己不可还原的判断，不能靠自我展演证明独特。它必须迎向已有的最强替代解释，在每个对手最承重的变量上指出分离点。以下逐一对质，每一处都不是用海底与地壳去重新解读对手，而是看对手的变量在哪里止步。

– （一）Canguilhem：规范能力与没有总司令的战场

海底是不是 Canguilhem 的“规范能力”在临床上的应用？不是。Canguilhem 动摇了“疾病是对正常值的偏离”这一统计—机械论教条，提出生物体的“正常”不是对固定常模的趋近，而是在环境波动中主动建立新的运作秩序的能力，病理状态则是这种能力被窄化。他是本章最深的思想先驱。但规范能力仍预设了一个“作为整体的有机体”在评估并建立规范；即使规范被窄化，那个评估主体仍是整个有机体。海底所指认的，恰恰是没有总司令的、局部的、器官系统之间的代偿博弈：保全大脑的血压代偿牺牲心室壁和肾脏，维持高皮质

醇的应激轴侵蚀海马体。这些决策无法理解为有机体整体做出的最优规范选择，它们是亚整体的、彼此冲突的、结果可能惨败的局部交易，Canguilhem 的生机论框架里没有位置留给这样的战场。

第二处分离更实际。Canguilhem 的批判火力集中在错误的认识论上：统计学家和机械论医生没有理解生命的规范能力。照此推论，若医生接受了他的哲学教育，诊疗上的机械性就能被矫正。但即使医生在哲学上完全接受他的立场，在 DRG 核算与法律归责的双重压力下点选菜单时，仍会滑回合规优先。那个被批判的认识论错误，已不再是靠教育可以纠正的观念错误，它被制度性地固化成一层医生单凭认知无法穿透的地壳。维持这个错误的是制度，而不仅是错误的认识。

– （二）福柯：常模与合规，主体与选项

指南地壳是不是福柯“规训”在临床的具体化？规训通过持续的监视与审查运作，核心是常模：把个体置于常模的分布中比较、分类、排斥与纠正，并制造出符合常模的主体。地壳的核心则是合规，一种二元的、基于边界的逻辑，在壳上或壳下，中间没有光谱。它不需要医生内化一个“理想医生”的常模、不断趋近，只需要医生能预测自己的每个操作在未来被审计时落在边界的哪一侧。这是一种比规训更粗糙、也更不可协商的权力形态，因为它不容忍“趋近”，只问“合规或不合规”。它还省去了凝视：规训即使以内化为高级形态，也需要一个外部凝视作起点，而医生服从的不是某个具体的人在看他，而是那个预支了法律与经济双重因果的操作面，在回顾性审判中可能做出的判决。福柯的规训生产主体性，地壳生产的是操作的预判性；它不制造某类主体，而是把可能踩下去的地面缩减成一条在合规边界内安全行走的窄道，不关心医生内心是否认同。

– （三）Mol：好逻辑与撤除了通道的现实

Mol 区分“选择的逻辑”与“照护的逻辑”，后者把照护看成在具体情境中不断小修小补的持续实践。她回答的是“好的医疗应该是什么逻辑”。本章回答的是另一个问题：一种特定的制度构造物，怎样使那种好逻辑所需要的认知基

础，即听见海底的能力，被系统性撤除？即使一个体系在理念上完全接受照护逻辑，例如北欧推行共享决策、给足咨询时间，医生在重大临床决策上依然紧抱指南，因为地壳仍通过经济核算这条独立的线，持续执行“留在指南内”的指令。单靠切换逻辑，无法熔解一块已烧结完成的复合材料。

Mol 在《多重身体》中的另一个论点更近：不同的临床实践各自“操演”出不同的疾病对象，疾病不是被多角度观察的单一实体。这与“海底被排除出合法对象”的主张距离极近。分离线是：Mol 那里是多元并存，多个疾病版本在医院里同时运作、被临时协调；本章主张的是其中一个版本，指南编码版，吞掉了其余版本的合法性。可裁决的判据是：在同一科室追踪一例复杂病例的全部记录与交班话语，统计不同疾病版本被援引的频次及其在决策中的权重。Mol 预测多版本并存、权重随场合切换；本章预测非指南版本出现的频次不为零，但在有据可查的决策节点上权重趋近于零，它们只在走廊里存在，不进病历。若非指南版本确实进入了正式决策，地壳这个意象就过强。

– （四）Power：被覆盖掉的是什么

Power 的审计社会论证，社会不再信任专业人员的自我规制，转而要求一切专业实践产出可被外部验证的“证据”，引发“审计爆炸”。这是大趋势的判断，但它没有区分各领域审计化的具体耦合机制，也没有回答审计排斥掉的具体是什么。在医疗里，可审计性不是抽象的要求，它通过指南这个枢纽，同时承载法律免责与经济合规两条原本独立的审计功能，焊接成通用模型所无法预测的复合形态。法律与经济两条线在指南上烧结，拆掉一条，另一条仍能独立维持地壳的硬度。更重要的是，被审计排斥掉的专业判断，其内容具体就是海底，那片在临床上具有根本重要性的、身体持续进行的代偿性自组织过程。“被覆盖掉的是什么”，在 Power 的框架里是空白，本章填的正是这块空白。

– （五）Montgomery 与认知心理学谱系：判决性的两种预测

Montgomery 在《医生如何思考》中开创的临床判断研究，揭示了临床判断依赖经验、叙事与模式识别而非形式推理。她后续提出的“框架漂移”，即医

生在长期制度化实践中，从以病人独特性为核心的判断框架，漂向以规避风险为核心的操作框架，是本章在文献沿革上最危险的对手，因为它似乎已把“医生的认知被制度重塑”说完了。区分需要一个判别式的对照预测。Montgomery 把纠正漂移的希望寄托于医学教育与反思实践，按她的模型，医生被成功“教育”之后，即使制度未变，漂移至少部分可被拉回。按本章对地壳的判断，筛选发生在医生认知界面的上游，反思教育改变的是认知习惯，而地壳不关心认知习惯，只要支付与法律的锁链还在，反思倾向会在医生第一次面对拒付单时迅速退场，退场的不是认知框架，而是实践那个框架的制度可能性。可以检验：在地壳硬度未变的系统里，对一组医生做高质量的反思干预（Balint 小组、叙事医学训练、长期临床督导），一年后，若他们面临 DRG 核算压力时的实际偏离行为（而非问卷自陈的态度）较对照组显著而持久地增加，则框架漂移模型已足够，地壳命名在此点上可被替代；若反思意识显著提升而实际偏离行为无显著改变，本章判断成立。

（六）其余近邻：一次扼要的清点

防御性医疗研究把标准化系于法律恐惧一个变量。分离点是，即使法律恐惧被完全消除，地壳仍会通过经济核算继续硬化；判决性对照是，在诉讼风险事实上归零、但保留 DRG 核算的地区，若医生追随指南的紧密度出现显著而持续的下滑，则防御性医疗解释已足够；若指南仍被紧抱，医生也报告“不遵守会被扣费或列入异常名单”，则地壳成立。对循证医学批判，即使指南完美洁净，它仍为“可报销边界”划着清晰的线，不洁的指南让问题更糟，洁净的指南不会让问题消失。对去技能化，前文已述伦理护盾的区别。对 Dekker，漂移模型解释系统为何漂出安全边界，本章补的是，在医疗这个场域漂移为何一旦发生便极难逆转：航空里安全与效率叠加、可分别操作，医疗里它们在指南上焊接为一体，无法只打碎其中一层。

对 Lipsky 的“街头官僚”，分离线是：街头官僚讲执行者对规则的适应，一线人员知道自己在简化，简化是策略；本章讲认知对象被逐出合法范围，不是不谈，是没有位置可谈。检验方式是在免责空间下请医生描述“你觉得这个病人

的身体正在自己做什么”：前者预测压力解除后医生能顺畅说出被简化掉的判断，后者预测描述仍然贫乏且缺乏共享词汇，因为缺的不是意愿，是概念工具。最后是自创生（autopoiesis）。Maturana 与 Varela 的命题是，活系统在组织上封闭、结构上开放，只要活着，组织就保持不变，变的只是实现它的结构。本章所涉的过程，落在这一命题留白之处：旧的承重节点被外力打断之后，系统换了一套承重节点继续运作，如靶向治疗之后耐药通路的更替，组织本身被重写了一次而系统并没有死。可检验的判据是在扰动前后分别标定承重节点集合及其依赖拓扑：若观察到的始终是拓扑不变、只换零件，则本章所论可还原为自创生的医学应用，命名冗余。这一条最愿被推翻。

◆ 七、为偏离辩护：一条能听见海底的制度通道

– （一）最强的反驳与一条分离线

最强的反驳是：给医生松绑，允许偏离指南，岂非为庸医开脱？这个质疑的全部重量应当接受，并在此基础上区分两种偏离。第一种是基于逃避的偏离：懒惰、不诚实，为省事而跳过指南要求的必要排查，这是既有追责制度合理的打击对象，也是标准化路径正当的防御目标。第二种是基于判断的偏离：发生在医生已掌握指南、完成必要基础评估之后，其注意力已转向指南无法覆盖的那个独特个体，那个对常规剂量降压药反应异常的慢心律老人，那个所有化验正常却整个人正在垮塌的疲惫者，那个腰痛根源不在椎间盘退变而在整个生活塌陷的长途司机。两者的临床动机截然相反，前者逃避指南以减轻自身负担，后者承担比遵循指南更大的认知负荷与职业风险，为病人负责。而地壳无法分辨二者，因为它的评判标准只有一个：是否在壳上。因偷懒漏诊心梗的医生，与识别出代偿性高血压而精准减半剂量的医生，在地壳眼里落入同一个范畴：偏离了标准路径。前者理应受罚，后者恰是医学最珍贵的实践正在发生的现场，却被错误的奖惩逻辑驱逐。

（二）通道的构成

破除闭环的钥匙不是砸碎地壳，砸碎之后临床决策将失去任何可凭依的安全基准，而是为基于判断的偏离修建制度性通道。医生若希望在偏离指南时获得制度保护，须承担对应义务：对这次偏离做正式的、有记录的病案说理，回应四个问题。偏离了指南哪一条？病人的哪些独特情况使这条标准在本案可能不适用甚至有害？替代方案的临床推理与即时生理判据是什么？设定了什么追踪点来判断偏离是否成功，若不成功在何种条件下返回标准路径？说理无需长篇大论，但须有据可查，它把责任从被动的合规检查，转向主动的判断陈述，既可被同行评议，也可被后续临床进程验证。

这道门槛对不负责任的医生反而更高：他得编造一套在医学上经得起审查的自洽假说，其专业上的天然惰性与能力上限，本身就构成比现有任何审批流程更严厉的准入门槛。负责任医生的判断努力，则可以在通道上被合法储存和传递，既保护这次偏离，也在公共记录中为后人留下一个可查阅的判断先例。支付端的审核逻辑也应相应收缩：对走说理通道的诊疗，医保审核不再问“是否合乎指南条款”，而只问“其说理是否经同行评议认定具有临床合理性”。这意味着支付方必须放弃一部分机械核算的效率，换取更接近实质的公平。

（三）三个操作维度

其一，评审的构成。若评审委员会全由同一专科的同行组成，他们可能成为指南最坚定的捍卫者，因为指南本由其所属的专科学会主导制定，偏离在同行眼中可能是对专业权威的潜在挑战。需要引入结构性的异质性：至少包括一名来自相邻不同专科的临床医师（骨科偏离审查纳入康复医师，心内科偏离审查纳入肾内科医师）、一名临床药师（评估药物相关偏离的生理学依据）、一名经过培训的非医学背景的患方代表（评估“病人独特处境”这一维度是否充分）。异质性不是外行监督内行，而是为了打破专科内部在长期地壳训练下对某些代偿信号形成的集体盲区。

其二，说理的判准。评议者面对的核心困难，是区分两种情形：偏离在医学上合理，但最终被证明错误。若后者也受罚，通道形同虚设，因为任何偏离本质上都是基于不完备信息的博弈，要求“必须成功”只会把医生推回“绝不偏离”；若后者不受罚，体系又可能滑向宽容螺旋，通道沦为庸医的挡箭牌。解法是把判定标准从事后结果转向事先论证的认知质量，评议者问的是：偏离者在当时可获信息的约束下，是否完成了一套内在自洽、证据充分、并设定了清晰失败判定标准的临床推理。具体分三层：偏离理由在生理学、药理学或生物力学上是否具有可被独立验证的理论基础，而非仅凭“直觉”；偏离者是否穷尽了指南框架内与个体情况最接近的推荐路径，并论证其不适用的具体原因；偏离者是否预先设定了可观察的追踪指标与回归标准路径的触发条件，使偏离成为带内置安全阀的临床试验，而非孤注一掷的冒险。三层皆合格，即使结果不幸，也应被机构性地认定为“已尽到合理的专业注意义务”。

其三，失败的认知归属。经说理评审的偏离若最终伤害了病人，“我们当时为什么这样想”的复盘归属哪里？不能被简单归档为“并发症”然后遗忘。这里构想一个“匿名偏离案例库”：每一例经评审的偏离，无论成败，都以匿名化形式录入一个公开的、全行业可检索的案例库，记录的不只是临床过程与结果，还有说理文本本身，以及评议委员会的核心质询与回应。个体的失败由此转化为集体的认知资产，下一个面对类似代偿困境的医生，可以避开已被试过并失败的路径，或在已被证明可行的路径上继续深化。案例库可挂靠在既有的医疗伦理委员会体系之下，而不另设行政科室：伦理委员会注重个案情境的不可通约性，注重对决策过程而非仅对结果的审查，在气质上与海底的逻辑更亲和；它并非未被侵蚀，但已有的制度独立性与程序传统，比新建的行政单元更难被快速规训，多一层对抗异化的结构性缓冲。

– （四）最诚实的反驳：说理评审会不会变成更高级的地壳

最致命的追问是：说理评审本身会不会成为更高级的地壳？会不会催生新的合规产业，说理文本模板化，专家评审官僚化，偏离理由被标准化稽核？答案是会。任何新制度立住之后，都会在新的土壤里引发新一轮的漂移、固化与自我异

化。说理最终可能被简化为四段“安全措辞”：指南要求了甲；本病人有乙特殊情况；依据丙的生理学原理我们做了丁；若戊天内无效则返回甲。评议会议最终可能沦为被地壳训练过的资深专家签字盖章的过场，案例库可能被海量千篇一律的“合规偏离”淹没，那些冒险的判断因为不愿暴露在公开库中而继续沉默。

对此，本章不提供一套不会被异化的完美制度，那是自欺。论证的要点是：与当前“连一道缝都没有”相比，通道即使终将被地壳重新吞没，在被完全殖民之前的窗口期里，说理尚未变成新的事先合规文档，评审尚未变成新的官僚仪式，评议者尚未变成新的排雷兵，这道缝里会有一些判断被记录下来，一些偏离被合法地执行，一些病人因为一个医生被允许听见他的海底而免于被地壳碾碎。即使这道缝最终被封死，案例库里那些曾在制度容许下被公开说出的判断，也将成为下一轮改革的矛盾起点：后继者无需再从撤销先验重新开始，而可以从“上一次通道是怎样被异化的”这个更精确的起点出发，凿出另一道更宽、更不易封死的缝。这样的回应不承诺完美的终点，也不在被异化时以“初衷是好的”作辩解，而是诚实承认吞没会发生，并在它发生之前，尽可能多地留下后继者可用的认知资产。

◆ 八、证伪条件与本章小结

– （一）本章准备好被推翻的地方

修复的方向不是拒绝指南，也不是抛弃科学。指南是必要的海图，但有了海图之后，航行仍在海底发生。本章也无意回到某个想象中的前现代医学，那个过去同样有它的盲目、权力结构与偶然，同样排除了很多东西；需要守护的不是“过去的好医学”，而是让每一次临床遭遇中那片独特的、前概念的自组织过程，能被合法地纳入认知的制度性可能性。

本章的核心判断是：指南地壳的形成必然导致对临床海底的系统性听而不闻。它的证伪条件是：若有一个医疗系统，在保持同等安全标准与总体费用约束的前提下，引入独立的、不对偏离作预设过错推定的“基于说理的偏离评审机制”，使医生为个体患者做出的偏离指南的决定比例显著上升，且长期追踪表明

这部分患者的综合健康结果（不仅是单项指标）优于或至少不劣于严格合规体制下的同类患者，则本章判断被推翻。此外，本章机制还给出三条可检验的预测。其一，在 DRG 改革落地的时间断点前后，病历中对身体代偿过程的描述性语句密度应出现可测的下降，且降幅大于同期总病历字数的变化。其二，影像指征相同的患者中，术前记录里出现“代偿或适应性改变”描述的病例，手术率应显著低于未出现该描述者；若两组无差异，临床语言与决策脱钩，本章的机制链断裂。其三，若按第七节设一条正式的“偏离申报”通道，申报量应在开放后先升后稳，且申报理由中“身体自身的代偿”类占比逐年上升；若申报量长期趋近于零，则阻力不在问责而在别处，本章的诊断错位。

– （二）本章小结

回到全书的三步。第一步是“看不见”：生命一直在给出答案。第一章的生迹、第二章的残迹，在照护现场是老人正在长向哪里、被谁无意抹去的东西；本章把同一件事搬进临床，答案换了一个名字，叫代偿。身体的代偿是它在没有总司令的战场上自行达成的局部停火，成败不保，却是一切干预实际作用的唯一地层。指南、支付规则与过失判准焊接成的地壳，并不压制这个答案，而是把它屏蔽在合法的认知对象之外，医生被训练成排雷式的行走者，病人被教会不再相信自己“说不上来”的不对劲。更凶险的是，一旦代偿在检查里露出痕迹，它被读作新的故障，被善意地、合规地、成功地打击；脊柱融合术里那顶被一把抽走主梁的帐篷，打地鼠式的处方级联，是母题所说“精准的善意”在临床里的样子。没有坏人，每一步都踩在壳上。

看不见之后，下一步就是抢先替定。地壳不只屏蔽信号，它也在病人尚未开口时，先把他的情形翻译成编码、路径与指标；当病人想讲述“整个人不对”时，已有一套现成的叙事等在那里。这一步先发生在叙事层：在一个人能为自己编织栖居其中的故事之前，算法生成的叙事先占了位。第四章“叙事失权”将从这里接续。

本章参考文献

Braverman, H. (1974). Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century. Monthly Review Press.

Canguilhem, G. (1966). Le normal et le pathologique. Presses Universitaires de France. (Original work published 1943)

Dekker, S. (2011). Drift into Failure: From Hunting Broken Components to Understanding Complex Systems. Ashgate Publishing.

Foucault, M. (1975). Surveiller et punir: Naissance de la prison. Gallimard.

Greenhalgh, T., Howick, J., & Maskrey, N. (2014). Evidence based medicine: a movement in crisis? BMJ, 348, g3725.

Institute of Medicine. (2000). To Err Is Human: Building a Safer Health System. National Academies Press.

Kessler, D. P., & McClellan, M. (1996). Do doctors practice defensive medicine? Quarterly Journal of Economics, 111(2), 353–390.

Mol, A. (2008). The Logic of Care: Health and the Problem of Patient Choice. Routledge.

Montgomery, K. (2006). How Doctors Think: Clinical Judgment and the Practice of Medicine. Oxford University Press.

Power, M. (1997). The Audit Society: Rituals of Verification. Oxford University Press.

◆



第　二　编

抢先替定：
善意怎样先把答案写好

编　序

看不见之后，空着的位置不会一直空着。系统用自己的答案去填，而且填得温柔、善意，常常成功。本编三章从三个层次描述同一个动作：第四章是叙事层，算法叙事在身体能为自己讲述之前先开了口；第五章是决定权层，生命系统决定自己下一个稳态的资格被代为行使；第六章是判断层，“我好了”这一不需要外部背书的感觉，被转成向体外数据缴纳的抵押品。

04

第四章

叙事失权：算法叙事抢在身体之前开口

◆ 一、从看不见到抢先替定：本编的转折

第一编走过了三站。第一章讲照护在“需求”的地址上找人，于是看不见老人正在长向哪里的生迹；第二章讲得更深一层，连老人自己也无法指认的残迹，被周到的善意填充得一干二净；第三章把场景从养老院挪进诊室，讲身体的代偿原本是身体自己给出的答案，却被指南地壳听作故障，被排雷式认知当作地雷来排除。三章合起来，立住的是本书母题的第一步：生命一直在给出答案，而越精准、越周到的系统，越看不见这些答案。看不见不是疏忽，是系统的地址册里根本没有那个门牌号。

但“看不见”只是故事的前半。一个系统看不见某个位置上原本有什么，并不会让那个位置空着。位置总要有人坐。第二编要追问的，正是看不见之后发生的事：系统用自己手里现成的答案，把那个位置先填上了。需求清单、风险预警、指南路径、靶点、数据阈值、标准稳态，这些都是系统手里现成的答案，它们抢在生命自己摸索出答案之前，被当作“好”的样子端了上来。本书把这件事统称为替定：外部系统抢在生命自己之前，替它定下“好”的样子与抵达路径。替定不是粗暴的剥夺，它温柔、周全、讲证据，常常在局部上是成功的，这恰是它难以被识破的原因。

第二编的三章，按替定发生的层面依次展开。本章处理最外显的一层，叙事层。第五章深入到身体决定自身下一个稳态的资格，也就是发生权。第六章再下沉到判断层，讲“我好了”这一内感受判断如何被抵押出去。之所以从叙事层起笔，是因为叙事是替定最先露面的地方：一个人要被替定，先要被替他开口。人对自己身体的第一句话，往往不是一个医学判断，而是一句不精确的、带着生活

温度的话，“我就是容易累”，“最近睡得浅”，“胃不太好”。这句话是生命向世界递出的第一份答案，也是后续一切医学动作的起点。如果这个起点被抢先占去，后面的诸多环节即便每一步都做得精良，也是在一份别人写好的底稿上施工。

本章的材料来自精准医疗中的慢性复杂疾病领域，具体说，是“预测—预防—管理”这条链条。在这条链条上，系统凭借组学数据与概率模型，不等当事人发出任何不适的呼救，就为他标定未来可能出事的位点。本章的核心判断是：这里发生的首要事件，不是身体被拆解成零件，也不是主体被技术统治，而是主体尚未来得及为自己编织出可栖居的身体叙事，另一套由算法生成的身体叙事就已经坐上了那个位置。本章称之为叙事替代。它是替定在叙事层的形态，也是第二编的第一块基石。

有必要先说明这一判断的适用边界，以免后文的批判被读成对整个精准医疗的否定。单基因遗传病的分子确诊、肿瘤驱动突变指导的靶向治疗、药物基因组学指导的个体化用药，这些场景中算法提供的信息具有高度的确定性，直接指向可操作的临床决策，也完全可以被当事人的日常话语收编，“我这人体质特殊，吃不了这个药”，这样一句话就把一份基因型信息接进了自己的身体故事，不构成任何叙事位置的篡夺。本章的分析效力集中落在另一类场景：概率而非确定性构成叙事基本语法、分析无边无际、预测悬而不决的风险预测领域。在那里，数据给出的不是一个答案，而是一个无法终结的问号，叙事替代的发生条件最为充分。

还有一点要预先交代，因为它关系到本章与全书的接榫。本书母题说，精准的善意抢先替生命定下“好”的样子，替得越久，生命越长不出自己的答案。本章要显示的是这个“抢先”二字的具体含义：抢先不是比谁说得多，而是比谁先到。栖居的“我”说话慢，句子模糊，要靠许多次的日常编织才成形；算法的“它”说话快，句子精确，在报告交到手上的那一刻就已经说完。两者一旦同场，不需要任何一方去压制另一方，先到者自然成了叙述者，后到者自然成了旁白。至于这种先到者的位置如何被固化为制度、如何深入到更底层的资格，是后

面几章的事。本章只负责把叙事层的这一步讲清楚：看不见之后，替定首先是怎样以一份报告的样子，在一个晚上，走进一个人的卧室的。

◆ 二、林晚的夜晚：叙事替代的微观现场

– （一）一份二十八页的报告

林晚四十五岁，在一家出版社做编辑，每年体检指标正常，自述“没什么毛病，就是容易累”。母亲五十二岁时确诊乳腺癌，这段经历让她在朋友的建议下自费做了一次癌症易感基因检测。三周后，一份二十八页的报告交到她手上：BRCA1基因上有一个“意义未明的变异”，致病风险被评估为“中等偏上”，各种癌症的终生风险从0.3%到23%不等，配着彩色图表与“建议密切随访”的醒目标注。

拿到报告的那天晚上，她躺在床上，把手放在胸口，想像往常一样问自己一句：我还好吗？那个熟悉的、含糊却可靠的回答没有出现。取而代之的是一行反复跳动的数字：23%。她说不出自己是健康还是病了。她只知道，从这一刻起，她不能再像从前那样，在睡前闭上眼睛，毫无缘由地觉得自己的身体值得信赖。

这个案例通常会被读成一个焦虑如何产生的故事。可是焦虑只是表层。更深的事件发生在语言与意义的层面：林晚对自己身体的原有言说，“我就是容易累”，被另一套言说覆盖了。她不再能用自己的句子讲述自己的身体。一份以概率语法写成的外来脚本，在她还来不及辨认自身感受之前，就占据了那个本该由她的感知慢慢填满的叙事位置。本章要命名并展开的，就是这个事件。

– （二）旧句子是怎样溃败的

要看清替代怎样发生，需要把那个夜晚放慢来看，看林晚的旧句子在内心的微观现场是怎样一处一处失守的。最先塌的是那个“就”字。“我就是容易累”里的“就”，是她四十五年里用无数个清晨的起床感受、无数次午后的疲倦叹息、无数次对朋友轻描淡写的诉苦，一针一线缝进句子里的亲熟感。可

在“23%”面前，这个“就”忽然像一个被揭穿的谎：她不是“就是”容易累，她的累也许是某种深藏病理的前哨。

接着松动的是“我”这个主语的确信。她开始怀疑，住在这副身体里的“我”，是否比一份基因报告更了解这副身体。母亲当年的场景被激活了：那时候母亲不也一直说“没事”吗？这段家族记忆像一把钥匙，替“数据表明”的语法打开了门。最后失守的是时态。“我就是容易累”说的是当下，是栖居在此时此刻的身体感受里；而“23%”来自对未来的凝视，它不是诊断书，是一张预言图。当来自未来的目光穿透当下的皮肤，栖居叙事的时态被整个击碎。林晚并没有选择沉默，沉默是被强加的，因为她的母语在那间屋子里失去了效力。她不是被一个更强的叙事说服的，而是被自己所信赖的“科学”缴了械。

（三）两种叙事及其结构要素

在这一微观现场的基础上，可以给出本章的两个核心概念。栖居叙事，指个人在日常生活世界中对自身身体状态持续进行的、第一人称的、容许模糊与前后不一致的言说编织。当一个人说“我胃不太好”，他不是在发布一份关于胃酸分泌量的报告，而是在用一句承袭了几十年生活经验的话，把自己与那副有胃的身体之间的长期相处，维系在一种可说、可辨、可被他人理解的关系里。这句话容许模糊，胃到底哪里不好，他说不清，也不必说清，因为这句话的功能不在描述一个客体，而在安顿一个主体位置：那个“我”字，把他放进了对自己身体的亲熟之中。栖居叙事用“最近”“好像”“大概”“说不上来”一类材料织成，它不需要被证实，只需要被说出，而每一次说出，都重申一次“这是我的身体，我住在里面”。

栖居叙事靠两个结构要素维系。其一是叙事初权：关于身体的陈述，首先应当从居住者的第一人称“我感觉”出发。这不是认识论上的优先，不是说“我感觉”比化验单更准确，而是位序上的优先：在任何人用第三人称数据描述这副身体之前，居住者已经用自己的句子为它定下了叙事的基调。这份初权的行使不需要证据，也不需要精确，它只需要被允许发声，并被一个愿意倾听的他人（医

生、家人、朋友）接住，而不是被一份报告驳回。其二是叙事时间性：栖居叙事遵循生活世界自身的节律，晨昏的更替（“早上起来总觉得僵硬”）、四季的流转（“每年秋天过敏都会犯”）、岁月留在身体上的缓慢痕迹（“这两年体力明显不如以前了”）。这种时间不是检测时间表从外部强加的，它从生活内部长出来，有自己的呼吸起伏，容许漫长的含糊期、间歇的遗忘期，以及某天忽然想起时的轻描淡写。

算法叙事，指精准医疗所生产的、以组学数据与概率模型为语法骨架的身体言说方式。它不从“我感觉”出发，而从“数据表明”出发；它的主语不是作为居住者的“我”，而是“这个基因组”“这组蛋白表达谱”“这套肠道菌群分类单元”。它不是由我讲述的关于我的身体的故事，而是由数据库、统计模型与人工智能共同撰写的一份关于我的身体的说明书，同时要求我以第一人称去签收、去执行。算法叙事拥有栖居叙事所不具备的三种强力属性：精确，它把风险写成23%而非“有点可能”；权威，它由全基因组关联研究和大规模队列背书；先发制人，它在疾病尚未发生、主体的身体感知尚未形成任何疑问之前，就标定了未来或许出事的位点。三者合在一起，赋予它一种不容栖居叙事再开口的认知霸权。

（四）替代不同于补充

当一句栖居的话（“我就是容易累”）遇上一句算法的话（“您的BRCA1变异风险中等偏上，建议密切随访”），两者的冲突并不发生在对等的层级上。前者说的是“我对我身体的感觉”，后者说的是“科学对你的身体知道些什么”。在当下的文化配置里，“科学知道”几乎必然压倒“我感觉”。于是那句栖居的话没有被反驳，却已失声，它被判定为不相关，不是错，而是不足以作为继续讲述的起点。

这就是叙事替代与信息补充的差别。信息补充，是把新内容添进原有的叙事框架，胃镜查出幽门螺杆菌之后，一个人说“原来我的胃不好是因为这个”，这是医学叙事以更精确的语言进入栖居叙事内部，帮它丰富自己、调整自己，却不

取代它在言说中的第一人称位置，检查的结果最终被收编为“我胃不太好”这个生命故事的一个被进一步注解的章节。叙事替代则是：外来的叙事框架，在主体尚未辨认出“框架”本身的存在之前，就取代了栖居叙事的位置，并使栖居叙事的继续生成变得多余，甚至不应该。林晚在拿到报告前的夜里，还能把手放在胸口感受自己的心跳，那时她是自己身体叙事的作者；次日再放上去，她听到的不是心跳，是“23%”。两个瞬间之间的位移，就是这道无声的裂缝：她从作者变成了一个外来叙事的听众，还被要求以第一人称认领它。

替代之所以难以抵抗，是因为它看上去恰是善意的极致兑现。精准医疗为自己讲的故事是：“我们只是把最精确的科学信息提供给患者，供他们做出最明智的决定。”这个故事省略了最关键的一笔：当信息以压倒性的权威与先发制人的未来指向提交出来，那个“供其决定”的主体，还拥有一个完整的、可以从自身感受出发权衡信息的叙事位置吗？还是说，这个位置在信息送达的那一秒，就已被信息本身占据了？

– （五）一个必要的祛魅

栖居叙事这个概念带有被浪漫化的风险，读者容易把它想成技术入侵之前的某种本真和谐，把本章的立场误读成一种乡愁。这条尾巴必须主动割掉。栖居叙事不是一件等待被发现的现成宝藏，不是悬浮在历史条件之外的永恒人性，而是在具体的生活实践中被持续“做出来”的一种言说能力。它容许模糊、前后不一，并不是因为它把握了什么更高的玄理，而是因为它的实践功能，维持与身体之间的亲熟，恰好不需要分析性的精度。一个人不必知道自己胃黏膜细胞分泌多少胃酸，就能在日常语言里与自己的胃建立起可栖居的关系。这种关系不是真理，是一件可以反复编织、磨损、修补的手工活。

由此可以说，传统医学情境中那种不受算法侵扰的身体栖居感，本身也不是真空里天然存在的理想形态。它是在医学尚无能力对身体做极度精微的数据解析这一技术文化条件下，被发生出来的一种稳定态，那份朦胧与被容许的模糊，在相当程度上是技术目光尚未抵达的直接后果。精准医疗改变的，是栖居叙事得以

发生的外部条件：从前，栖居叙事可以因为“无数据可查”而保持模糊的完整；现在，它必须在“数据已全面在场”的条件下，有意识地、有纪律地为自己预留不被数据替代的空间。所以本章对栖居叙事的守护，不是对一个永恒人性的守护，而是对这门手工活所需的公共条件的守护。

◆ 三、叙事如何被替代：三重机制

叙事替代不是一个瞬时的断裂事件，而是一套有工序的发生过程。本节把它拆成三重机制，分别对应精准医疗的善意在开端、过程与终点三个阶段对栖居叙事的占位与蚕食。

– （一）第一重：风险预警夺取叙事初权

在经典的临床场景里，一场健康事件通常以栖居叙事的发声为开端。一个人觉得“最近不太对劲”，说不出哪里不对，却周身弥漫着一层说不清的阴翳。这句不精确的、整体性的话，是栖居叙事行使叙事初权的原初时刻。它等于宣告：我是这副身体的居住者，我邀请你（医生）进入我的叙事，帮我一起辨认这片阴翳。这一声“我不舒服”为后续一切分析设定了起点与宗旨，分析的发生，是对这一声呼救的回应。

精准医疗翻转了这个次序。它不再需要等人开口。从基因序列被录入系统的那一刻起，它就已为这个人设立了一张永不休止的风险地图，上面标着上千个位点，每个位点携带着一个来自大规模人群队列的概率数字：终生罹患某病的风险比平均水平高出1.2倍、1.8倍、2.4倍。这些数字不需要触发条件，不等任何人。它们构成一种先发制人的预言。

预言性与概率性的结合，使这场预言带有持续的、低度却无法消除的认知负荷。一个确切的诊断，栖居叙事还能接纳，把它收编为叙事内部的新章节；一个悬置的概率预警却无法被完整收编，因为栖居叙事的语法以当下感知为锚点、以生活节律为时间轴，其中没有位置容纳“你未来有23%的可能患病”这一类句式。这类句子住不进栖居叙事里，它们以异质外来者的身份楔入其平静的肌理，

把那种容许漫长含糊、间歇遗忘和轻描淡写的时间感，换成一种被定了速的、指向不可知未来的焦虑时间。

林晚后来被人问起“你健康吗”，回答是：“我最近的肿瘤标志物都正常。”这句话的主语不是“我”，而是“我的肿瘤标志物”。“我”已从回答里退场，留下的是一份以第三人称数据代言的机械应答。这个替代在开端处就已确立：当栖居叙事尚未发出一声“我不舒服”，算法叙事先说出了“你有风险”，叙事初权便已易手。此后栖居叙事即便再说什么，也只能作为对算法叙事的补充、注释或无关紧要的旁白，它不再能设定议题。设定议题的，从一开始就不是那个躺在床上、把手放在胸口的人，而是一份二十八页的报告。

这里要特别指出替代的共谋条件，否则这一机制会被误读成强者对弱者的单向压制。林晚的栖居叙事之所以在那个夜晚迅速溃败，并非因为算法叙事有催眠般的强制力，而是因为它与林晚生命经验中的几条裂缝精准扣合。第一，她对科学权威的信赖高度而近乎不加反思，这不是她个人的性格缺陷，而是教育、媒体、医疗制度长期形塑的文化结果。第二，母亲患癌的经历在她情感深处种下了对“身体信号不可信”的原始恐惧，家族病史使算法的预言在抵达理性之前，就击中了最脆弱的亲情继承地带。第三，栖居叙事本身的公共语言资源已日益贫弱：当“我就是容易累”被说出口，她身边几乎找不到任何公共话语来支持这句话的合法性，没有医生对她说“这种感觉很重要”，没有制度为主观感受留下聆听的节点；相反，整个医疗体制的路径安排都默认“数据先于感受”。因此叙事替代是一场共谋性的篡位。林晚不只是被动的受害者，她也是在特定条件下主动丢下了那根“不科学”的木杖，去拥抱了铁制的拐杖，因为在那间诊室里，木杖已被宣告无效。她被一个包裹着善意外衣的更大的恐惧说服了：相信数据，比相信自己更安全。

（二）第二重：监测时间表改写栖居节律

叙事初权在开端易手，在过程中就必然被进一步深化。栖居叙事有自己的时间感。“最近容易累”“这两个月睡眠很浅”“每年秋天胃都会不舒服一阵

子”，这些讲述遵循的不是日历上均匀的刻度，而是被生活事件标记、弯曲的主观时间：一次出差，一场家庭变故，一个季节的转换。在这种时间里，从容与遗忘同关切与忧虑一样重要。人可以很长时间不想自己的身体，在某个不经意的瞬间又忽然记起它；这种不均匀的注意力，恰使身体的栖居感能在低强度、非持续的关怀中自然生长。

设想算法叙事尚未介入时，林晚对身体的时间经验大致是这样的（以下为说明而设的设想）：每年春天体检季前后，她会密集关注自己的身体一两周；大部分平常的日子里，工作与家务占据了注意力，“容易累”只是飘在日常背景中的一句絮语，不被追问，也不被深究。她可以四个月、半年不想自己的身体。这种绵长的、不被检测的平静间歇，正是栖居叙事自我再生的土壤：她不必持续证明身体值得信赖，只需在遗忘中重新唤起亲熟。

报告交到手之后，时间安排截然相反。林晚立即被嵌入一张由检测周期精密定速的时间表：乳腺磁共振每半年一次，肿瘤标志物每三个月一次，基础体温与静息心率每天清晨记录。她没有被要求生病。她被要求进入一种无期限的、没有终点的预备状态。每一次检测都是一次临近审判的预演：结果正常，换来一个短暂的豁免期，直到下一次检测的焦虑重新逼近；结果异常，立即进入更密集的检测链条，确认或排除，直到下一个监测点再度开启。

这是时间结构的整体篡位。栖居叙事的时间是有呼吸的节律，关切的强度像潮汐一样自然涨落，有身体不适时的高潮，也有遗忘时漫长的低潮。算法叙事的时间则是均质化的滴答，独立于任何身体感受，检测节点以固定频率周期性抵达，每一次抵达都把注意力从生活中的其他事务里劫持回来，重新钉在那份风险地图上。在节律里，遗忘是合法的，甚至是必需的；在滴答里，遗忘被宣告为危险，每一次遗忘都可能意味着错过一个早期发现的窗口。林晚从此无法再拥有“四个月不想身体的事”的奢侈。两年来，她没有生过一天病，但她的生活已被“不生病”这件事占满。

善在这里不再是回应呼救，而是一份被提前启动、永不终结的全时段监控。它不给人遗忘的余裕，不给人从容的低强度关注周期；它持续地、有节律地发出

警报，把人锁在一种永远面向下一次检测的高唤醒状态。栖居叙事所需的那种从遗忘中重新生长出来的亲熟感，就在这种不容遗忘的滴答声中被窒息了。这里需要注意的是，每一次检测本身都可能是合理的、技术上无可挑剔的；被改写的不是某一次检测的价值，而是检测的总和对一个人时间感的整体占领。

（三）第三重：去晕、减苦、除根的自反

第三重机制出现在精准医疗试图兑现其终极承诺的时刻。它许下的核心诺言是三个：去晕，让人看清自己的健康状况，不再活在无知的迷茫中；减苦，通过早期筛查与预防，减少未来的疾病事件；除根，把致病的根源从身体乃至家族血脉里清除。这三个诺言推到极致时，沿着自身的语法走向了反面。这不是某个步骤出了错，而是在算法叙事已彻底接管叙事位置之后，它再给出的每一份新的精确性，都只会加深那个人在栖居叙事上的失权。

先看去晕。为看清这一自反逻辑，可以构造一个最小化的叙事现场（以下人物为说明而设）。一位四十二岁的女性，称她陈屿，参加一项大型健康队列研究的五年随访，收到一份综合代谢风险报告。报告基于她的基因组、肠道菌群、代谢组与生活方式数据，把她未来十年的心血管事件风险评估为“18%，同龄组平均风险为7%”，附有二十九项建议，从饮食调整到运动处方，从压力管理到功能性补剂，条分缕析，无一遗漏。她回到家，试图像从前那样，睡前把手放在胸口，问自己“我今天过得好不好”，却发现这句问话的每个词都已被报告改写过：“我”成了某个CYP1A2慢代谢型的携带者；“今天”成了第一项饮食建议执行到第四天的日子；“好不好”成了静息心率在58到63之间的波动，低于目标值。她不再能问出一个不经数据翻译的问题。报告并非没有帮助她，它在每一处细节上都提供了最优解。但正因为每一处都是最优解，它系统地消灭了那些容许模糊、容许未定、容许“说不上来”的叙事间隙。这不是去除眩晕，而是把栖居叙事的整片天空全部照亮，她被强光刺得睁不开眼。

当数十个位点的风险概率同时铺陈在一个人面前，没有一个中心，没有一幅完整的画面，视线被四处尖叫的数字碎片撕裂。栖居叙事原本能提供的那个整体

轮廓，可以在模糊中隐约辨认、使人说出“我还好”的身体整体感，在分析的强光下消融了。更深的眩晕，来自过度的信息：不是信息的缺乏，而是信息的饱和，每一条都精确，合在一起却让接受信息的人失去了不精确地说出“我”的语法。这种语法损失，不是去晕目标的偏离，而是去晕的目标函数里根本没有设定“保持栖居叙事语法”这一参数的必然结果。

再看减苦。早期筛查微小的癌前病变、预防性切除高风险的组织，确实减少了某些疾病事件的未来可能。但同一个操作也把成千上万从未感到不适的人，转化为“准病人”：一个PSA轻微升高却无临床癌灶的男性，一个肺部CT显示4毫米磨玻璃结节的不吸烟者。他们的身体感受并没有出问题，但栖居叙事里那层“我没什么事”的日常安心，已被未来概率的阴影永久侵蚀。善为他们减掉的，是一件未来或许降临的苦；为此向他们索取的，是一种从当下开始计息、无时无刻不弥散着的预备性焦虑。这笔交易划不划算，算法叙事只有生存率数据可以作答，而栖居叙事所关切的“此刻我过得好吗”，在概率的语法里是一个不容回答的问题。

最后是除根。生殖细胞系的基因编辑许诺把某些致病突变从家族血脉里永久删除。但在栖居叙事的维度里，那个需要被移除的“致病突变”，同另一些更古老、更深厚的东西纠缠在一起：它是一个人与先祖共享面相的缘由，是身上那些独特的脆弱与敏感的生物学底座，是在家族相册里辨认出自己的那一抹说不清的血脉联系。算法叙事把“根”定义为一段可以被精确剪掉的序列；栖居叙事里的“根”，则是一个人从祖辈那里接过来、并以自己的方式住进去的整条生命叙事线。分子剪刀切除致病序列的同时，也切断了把一个人绑进世代叙事的线，对自己这副身体的谱系性的亲近感，被连根拔起。

三重落空里，同一个结构性的悲剧反复奏响：精准医疗的善意在最极致地施行善意的地方，成为一台高效的叙事替代引擎。它每一次“做得好”的干预，都进一步强化算法叙事对栖居叙事的替代，并进一步削弱栖居叙事自我再生的条件。当林晚再也说不出“我身体还好吗”，为她做的一切精准分析便都悬了空。善意没有退场，但它已经无人承接。这样的人，本章称之为叙事难民：他既回不

到旧的栖居叙事里，那里的句子已被宣告无效；也住不进新的算法叙事里，那套语法是写给统计人群的，不是写给他的。他在新旧两套语言之间，哪一套都无法栖居。

– （四）三重机制的合力

三重机制并不是三个独立的故事。第一重夺取了开口的先后，第二重把先后固化为节律，第三重则在承诺兑现的地方使这种占位变得不可逆。预警使栖居叙事成为旁白，时间表使旁白失去它赖以再生的遗忘土壤，而每一次“成功”的去晕、减苦、除根又进一步抬高了算法叙事的权威，使重新开口的成本越来越高。这一合力与本书母题的第二步完全吻合：替定不是靠强制完成的，而是靠一连串做得好的善意，使生命自己的答案没有机会被说出。第五章将追问，这种叙事层的占位怎样深入到更底层的资格；这里先要做的，是把叙事替代与几位最强的近邻理论区分开来。

◆ 四、近邻与分离线

一个新概念的立足，不在于它听上去新，而在于它能否被某个既有概念无损地替换掉。若能，它就是换了名字的旧东西。本节把叙事替代放在六位最强的近邻之前逐一对质，每一组先说明对方已经说到了哪一步，再划出分离线，最后给出一个能让两套框架做出相反预测的观察格。

– （一）异化批判

从马克思的劳动异化，到法兰克福学派对工具理性的批判，再到当代医学社会学对医学“客体化”的诊断，经典异化理论共享一套核心逻辑：人的创造物（技术、制度、商品）反过来成为外在的、异己的力量，统治并扭曲人的本质。放到精准医疗里，就是人创造了这套技术，而技术反过来把人变成被凝视、被归类、被计算的数据客体，人被自己的数据取代。这一批判有力地描述了精准医疗中“人”的消失。

分离线划在时间点上。异化理论预设一个先在的、完整的、本真的主体，被后发的技术统治或扭曲。叙事替代揭示的却是更早的事件：在统治发生之前，当事人的第一人称叙事位置就已被第三人称的算法叙事占去。人不是先有一个完整的“我”，然后被技术异化；他是在能够形成那个完整的“我”之前，就被夺走了说“我”的位置。异化是统治，叙事替代是篡位；统治需要一个被统治者，篡位则直接让篡位者成了合法的君主。因此叙事替代不能被异化概念替换，它指向的恰是异化何以可能的更早条件。

对照预测：若观察到长期处于精准医疗管理下的人，仍能从完整的第一人称身体感受出发，拒绝或修正算法叙事的建议，并且这种拒绝表现为日常的、低门槛的、无需科学语言辩护的朴素直觉，则异化批判足以解释现象，叙事替代不具独立的解释力；反之，若他们对算法叙事的质疑本身也常以算法叙事的术语表达（“我的基因型不支持这个方案”），并普遍失去了用日常语言独立描述身体的信心与习惯，则叙事替代提供了异化批判所不能捕捉的机制。

与异化相邻的还有两个常被拿来替换的概念。医学化批判的是社会把越来越多的人类生活领域定义为需要医学干预的问题，是关于定义权边界的批判；叙事替代关切的不是“定义了什么”，而是“谁在说”。在已被承认为医学事项（如癌症风险管理）的领域内部，医学体制生产的算法叙事如何以语法权威让患者自己的栖居叙事丧失言说资格，这是医学领地内部的“置换”，不是领地外缘的“扩张”。知情同意框架则预设了一个能接收信息、理性权衡、做出自主选择的主体；叙事替代揭示的恰是信息本身，以其密度、精度和先发制人的未来指向，在主体能够权衡之前，就瓦解了他从自身感受出发权衡所需的那个叙事位置。这不是知情同意的失败，而是知情同意所依赖的主体，在接受“知”的过程中，其叙事位置已被结构性地悬置。若然，所谓“自主”就要先从叙事权的重建谈起，而不是从信息的充分告知谈起，这一诊断溢出了知情同意现有的理论容量。

另有两个邻近概念，也不能替换叙事替代。生物公民权讨论人们围绕生物学身份组织起来的新的社会团结与权利要求，叙事替代关切的则是更微观的事件：

在生物公民身份被动员起来之前，当事人对身体的日常言说就已经被替换了，问题不在生物身份如何重构社会关系，而在那个人如何被从自己的叙述者位置上挪开。风险传记，或称统计自我的产生，描述现代人如何用风险评估书写个人生活故事；叙事替代揭示的是这种书写方式的另一侧面，它不是无害的自传写法的多元添加，而是对另一种更古老、更栖居的自传写法的系统排斥，被排斥的不是写法的优劣，而是写者位置的归属，即谁有权用第一人称说“我的身体”。

– （二）康吉扬的规范性

康吉扬在《正常与病态》中，把健康的标志从“符合统计常模”挪到有机体能否在环境扰动下主动建立新的运作规范，即规范性。这一判断颠覆了静态的健康定义，本章全盘承袭这一洞见，也正是在康吉扬的终点处划出自己的分离线。

康吉扬的规范性预设了有机体用以判断“何为适合我的新规范”的那套内在判准，即经由进化遗传、发育校准以及与环境长期交互而沉淀下来的生理智慧，在扰动后仍保持完整。精准医疗的算法叙事所侵入的，恰是这套内在判准的叙事底座。林晚的身体信号被基因报告与时间表覆盖之后，她失去的不是建立某种新规范的生理能力，而是从自身完整的栖居叙事出发，判断“什么规格的生活对我而言是好的”的那个叙事位置。

对照预测：若证明即便终生处于精准监测下的人，仍能毫不费力地从自身的身体感受出发，独立做出关于生活方式与治疗方案的判断，不表现出对自身体感的深层犹疑与不信任，则康吉扬框架足矣；反之，若出现“各项指标正常，个体却报告对身体疏离、陌生，做决定时完全依赖外部数据而无法诉诸自身感受”这一模式，则叙事替代触及了康吉扬未探的叙事条件。

– （三）卡塞尔的痛苦与整体性

卡塞尔在其经典论文中区分疼痛（局部的、生理的）与痛苦（整体的人在整体性受威胁时的受苦），指出医生若只治疼痛而漠视痛苦，即是失职。本章与他共享对“身体的整体叙事”的关切。

分离线同样清晰。卡塞尔讨论的痛苦，是已有病痛的人其整体性受疾病威胁时的受苦，痛苦在这里是整体性被动受威胁。叙事替代揭示的是更前置的痛苦：当一个人尚无病痛，对其未来潜在风险的“精确告知”这一善意行为，通过算法叙事的先发制人，使他根本无法先在地体验自己为一个“有待保护”的完整的人。他承受的不是整体性受损之苦，而是叙事位置被占之苦；丧失的不是某个已被确定的整体，而是在叙事中持续生成整体感的能力。

对照预测：若发现在风险指标均被严格控制的人群中，当事人仍能自如讲出一个连续的、有情感的、与身体亲熟的生命故事（而不仅仅是一串医疗事件的编年史），则卡塞尔的框架足以解释；若他们主要受困于“无法描述自己的身体，也无法把各种监测数据整合进一个可亲熟的故事”的叙事缝隙，则叙事替代提供了独立的诊断力。

– （四）生命政治与治理术

福柯的生命政治与治理术概念，以及其后尼古拉斯·罗斯等人发展的当代生物医学治理分析，构成了对精准医疗最系统的批判框架。在这一框架里，精准医疗是一种新的治理技术：它不仅管理人口的健康，还通过风险预测、遗传筛查、生活方式干预，把个体塑造为“生物公民”，使其自愿内化健康监控的逻辑，以身体数据作为自我认同与社会参与的基础。这一传统深刻揭示了精准医疗与权力之间的结构性纠缠。

叙事替代与它的分离线有两条。第一条在先后：治理术预设了被治理的主体，一个能在生物医学话语中被识别、分类、引导与自我规训的“生物公民”。叙事替代触及的则是更早、更微末的层面，在治理的目光得以聚焦之前，在人口统计与风险类别被建构出来之前，当事人用以讲述自身身体的第一人称位置就已被取代。生命政治讨论“人口健康如何被管理”，叙事替代追问的是“一个人如何才能在被管理之前，先用自己可栖居的句子安顿自己的身体”。这像是治理的前夜：治理者尚未到场，被治理者的席位已被外来的语法腾空。

第二条在生产性：生命政治分析强调权力不只压抑，也生产主体、知识、欲望与身份。叙事替代所揭示的权力运作，最特殊之处恰在于它的非生产性，它不生产新的主体位置，只是让旧的栖居位置无法再被占据。被它所困的人不是一个新的生物公民，而是叙事难民。治理术生产出可治理的主体；叙事替代使主体无从生成，从而让“被治理”成了无主体的治理。

对照预测：若精准医疗引发的伦理问题能被完全还原为生物公民身份的建构、健康风险的个体责任内化与统计常模的规训功能，即权力仍在以某种方式生产着主体，则生命政治框架足以覆盖；若观察到一种无法还原为任何新主体形式的“言说无力”，当事人既不是生物公民（因为他无法把算法叙事内化为自身栖居的故事），也不是传统意义的病人（因为他没有病），而是悬浮在两种身份之间的叙事无位者，则叙事替代构成了生命政治分析无法触及的独立层面。

– （五）梅洛-庞蒂的身体现象学

这是最硬的一位近邻。梅洛-庞蒂关于身体图式与具身主体的论述，同本章的栖居叙事在概念疆域上高度重叠，并共享对“被观察的身体”与“栖居的身体”的根本区分。他已经深刻地揭示：在人能用语言叙述身体之前，身体早已通过前反思的、运动性的意向性，默会地栖居于世界之中。伸手取杯时，人不必先在头脑里构想手臂的坐标再命令肌肉执行，手直接“知道”杯子在哪里。这种身体性的“我能”，比任何反思的、叙事的“我知道”更原初，它构成人与世界之间最不可动摇的信任纽带。

这一洞见对本章的挑战是根本性的：栖居叙事试图用“叙事”这一语言范畴把握的身体亲熟，是否恰恰是前语言的、无法被收编进任何叙事的东西？把栖居感放进“叙事”，是否已把一个原初的、沉默的亲熟强行收进语言的牢笼？若然，栖居感的根本性恰在它的非叙事性，算法叙事再强，也只能覆盖叙事层面的东西，触及不了更原初的栖居本身，“叙事替代”便夸大了算法叙事的力量。本章承认这一挑战的分量，它直接质疑“叙事”这个范畴能否承载本章赋予它的存在论重量，是所有近邻检测中最不能绕过的反方。

分离线要从梅洛-庞蒂自己的疆域内部划出。栖居叙事并不试图用叙事去替代前反思的身体亲熟，“伸手取杯”的身体意向性确是另一种更原初的栖居方式，叙事无法穷尽它。本章的着力点在于：算法叙事所侵入并覆盖的，是连接前反思亲熟与反思性自我理解之间的中间地带，也就是把沉默的身体感受转化为可说的、可被他人理解的、能在人生故事中获得意义的日常语言编织活动。林晚说“我就是容易累”，当然不能穷尽她全部的前反思亲熟；它只是在说与不说之间，用最低限度的语言动作，维持前反思亲熟与反思性自我理解之间的可通达性。这句话被“23%”压垮，并不意味着她的前反思亲熟被消解了（她的手仍能自动地端起茶杯），而是意味着她从那片前反思的沉默里，再也无法通过任何自己信任的词语，过渡到对自己身体的某种可讲述的理解。她被困在前反思与反思之间的裂缝里：还能感受，却不能再言说；还能自动地生活，却不能把自己的生活讲成一个自己住得进去的故事。

于是可以这样区分：梅洛-庞蒂揭示身体是“沉默的合谋者”，它总已在知觉与行动的层面与世界交织；本章命名的事件是，当这个沉默的合谋者必须开口时，当它需要告诉医生“我怎么了”、告诉家人“我好不好”、告诉睡前的自己“我还好吗”，那个开口的位置已被一个更响亮的、以科学之名讲话的叙述者捷足先登。算法叙事无需攻击那种不可穷尽的沉默，它只需切断从感受通往言说的那条脆弱通道，就足以让一个人在自己的身体里流离失所。被替代的不是沉默，而是从沉默中生出的第一声言说。

对照预测：若精准医疗长期使用者的前反思身体栖居感本身（身体图式、空间感知、运动意向性）出现可测的功能性损伤，则梅洛-庞蒂式分析足以解释，叙事替代可能多余；若观察到前反思功能保持完整，个体却在“把自己的身体感受转化为自身可信的第一人称陈述”这一言语动作上表现出系统性困难，即“我能拿杯子，但我说不出身体好不好”，则叙事替代命名了现象学未能独立命名的损伤层面。

（六）疾病叙事传统与叙事医学

以克莱曼为代表的疾病叙事传统早已揭示，患者通过讲述自己的疾病故事来理解苦难、整合被疾病打断的自我认同，并在叙事中同断裂的当下与过去的连贯人生重新建立联系；古德进一步把身体叙事置于文化意义的编织之中，强调叙事不仅是表达痛苦的工具，也是重建世界连续性的行动。卡伦的叙事医学与弗兰克的疾痛叙事类型学（复原叙事、混沌叙事、追寻叙事）则系统处理了患者的身体故事如何被医学话语压过这一主题，是本章最直接的正主。

分离线首先在发生时点：这一传统的前提是当事人已被确诊，疾病的断裂已经发生，叙事的任务是对已然的断裂做意义整合与生命重建。叙事替代发生在更早的阶段：当事人尚未发出任何病症感，身体叙事仍处于未断裂的日常状态，就被一套外来的概率性预言提前标记为“潜在的未来病人”。疾病尚未发生，疾病叙事尚未启动，那个本该由栖居叙事涵养的预备性叙事空间，已被算法叙事先发制人地占满。一个人不是在疾病之后失去叙事能力，而是在疾病从未到来的漫长等待中，被剥夺了“无病叙事”的合法资格。

其次在补救的对象。叙事医学的补救是让医生学会倾听，它预设患者的叙事已经存在，只是没被听见，缺的是听众。叙事替代主张的是更早的一步：风险预警在患者能为自己编织身体叙事之前就占据了那个位置，缺的不是听众，是尚未发生的叙事本身。疾病叙事理论可以批判医疗系统没有聆听患者的故事，叙事替代批判的是聆听位置本身被篡夺：不是故事没被听见，而是在患者能形成一个故事之前，一个更响亮的故事已替他说完。

再次在文本特征上，弗兰克的混沌叙事指无法被组织成情节的疾痛讲述，语言破碎，时序错乱，是讲不出来；叙事替代预测的是语言流畅而通篇外来术语，是被替讲了。二者在文本层面可以直接分辨。

对照预测：比较已出现症状后才接受检测者，与无症状时即接受基因风险预警者。叙事医学预测两组都有可被引出的身体叙事，差别只在是否被倾听；叙事替代预测后一组即便在引导下也难以产出以自身体验为素材的叙事，其自述高度依赖数据语汇。这一对照可以用现成的访谈方法进行，是本章最该先做的检验。

– （七）自创生的补充切割

还有一位近邻，处在叙事层之外，却与本书整体相关，值得在此点到。马图拉纳与瓦雷拉的自创生描述的，正是“生命自行生成并维持自身秩序”这一命题：活系统是一张组分生产网络，网络的运作不断再生产网络自身，并由此划定自己与环境的边界，它在结构上对环境开放，在组织上却是封闭的，环境只能触发它，不能指定它的下一步。本章的叙事替代可视为这一命题在叙事层的一个具体情形，叙事的生成也是一种不能被外部指定下一步的自行编织。

不过两者的关注点不同。自创生守的是组织的同一性，只要系统活着，组织不变，变的是实现该组织的结构；叙事替代追问的是一个更具体的、有时间次序的事件，即在这张织机尚未织出东西之前，是谁先把梭子拿走了。这条分离线的细节更多落在后面诸章对承重节点更替的讨论中，这里只作标记，不作展开。

– （八）分离线的汇总

六组近邻加一处补充，对叙事替代的限定可以收成一张表。表中每一行的左栏是对方已经说到的地方，右栏是叙事替代在其基础上多出的一步，两栏合读，即是本章所作的全部切割。

近邻	它说到了哪一步	叙事替代多出的一步
异化批判	人被自己创造的技术统治	统治之前，说“我”的位置已被占去（篡位先于统治）
医学化与知情同意	定义权的扩张；自主主体的权衡	医学领地内部的“谁在说”；权衡主体的叙事位置被先行悬置
康吉扬的规范性	内在判准在扰动后仍完整	判准赖以表达的叙事位置被占
卡塞尔的痛苦	已有病痛者的整体性受威胁	无病者在叙事中生成整体感的能力被占
生命政治与治理术	权力生产可治理的生物公民	主体尚未生成，无主体的治理；叙事无位者
梅洛-庞蒂	前反思的身体亲熟不可被叙事穷尽	从沉默通往第一声言说的通道被切断

近邻	它说到了哪一步	叙事替代多出的一步
疾病叙事与叙事医学	确诊后的叙事重建；倾听的缺席	确诊之前，叙事本身尚未发生就被占位

这些分离线有一个共同的形状：每一位近邻都从一个已经成立的东西出发，一个完整的主体、一个常模、一个确诊的疾病、一个被治理的公民；叙事替代追问的则是这个东西成立之前发生了什么。这也正是它在本书里的位置：它是“抢先”二字在叙事层的落点。

◆ 五、来自栖居叙事内部的反诘：替代是破坏，还是催生？

最致命的反方不来自任何外部学派，而是从栖居叙事这个概念自身内部长出来的。它可以这样表述：叙事替代之所以能成功，是否恰因为当事人的栖居叙事本就脆弱、单薄、从未“栖居”过？林晚拿到报告前的那句“我就是容易累”，究竟是根深蒂固的栖居叙事，还是一层未经省思、一触即溃的絮语？若更接近后者，若现代社会所谓“栖居”在绝大多数情况下不过是一层薄薄的日常习惯，从未经受过反思的锻造，那么算法叙事的介入，非但不是压迫性的替代，反而可能是一位迫使当事人第一次严肃面对自己身体、并在与数据的搏斗中锻造出坚实栖居叙事的“艰难接生婆”。一个人必须先从“我就是容易累”这层未经检验的幻象里跌落，才学得会用更结实的语言重新讲述自己的身体。这样看，叙事替代不是暴力，而是现代个体在风险社会里走向身体自觉的必经阵痛。

这个反诘的力量不可低估。它使本章面临一种危险：把叙事替代径直判为恶，而忽视它在刺激主体性发生上可能具备的积极功能。如果叙事替代确实在一些人身上催生了更成熟的栖居叙事，本章的伦理框架就需要根本修正。回应分两步。

第一步，承认反诘的部分效力，并接受它引出的一个细微区分：替代的效果因个体的叙事韧性而分化。对于栖居叙事本就极度薄弱、近乎缺席的人，例如从未被鼓励用第一人称语言感受身体的年轻男性，或长期处在“无病即健康”的文化真空里的底层人群，算法叙事的登场确可能构成一个无可替代的叙事起点。一

份基因报告，也许是这个人生命中第一份把他的身体当作“值得被讲述的事”来对待的文本。在这个意义上，算法叙事可以扮演“叙事触发者”，尽管方式粗暴而带有潜在的覆盖性。反之，对于栖居叙事原本较为稳健、只是在某个具体经验域里尚未被充分语言化的人，如林晚这样有长年身体自述习惯的人，算法叙事的先发制人更可能不是触发，而是篡位：它不是在空地上播种，而是拔掉了已经在长的幼苗。

第二步是决定性的：重新收紧核心判断，把论证从“保护一个旧有的善”升级为“守护让善得以发生的条件”。即便承认算法叙事在特定情形下能当触发者，以“先发制人的预言”和“不容遗忘的时间表”为特征的当前实践，仍在结构上系统地破坏了一个能持续生成并自我修正的栖居叙事所必需的两个最低条件。

其一是叙事初权。栖居叙事要从内部生长，它的第一句话必须由当事人自己说出。这不需要一次长篇大论的“生命故事访谈”，只需要一个能被日常医疗制度保护的简单空间：在算法开口之前，栖居的“我”先被允许不被催促地说些什么。当前的精准医疗实践在制度路径上完全缺失这个空间，数据总是先于感受抵达。叙事初权不是在某一次事件里被剥夺的，而是在无数次“数据先行”的制度安排中，被系统地驯化为多余。

其二是遗忘与间歇的时间节律。栖居叙事不是一项能被持续高强度推进的工程，它像呼吸一样，关切与遗忘交替，遗忘中的琐碎日常在不经意间重新发酵成新的亲熟。“不容遗忘”的时间表恰恰掐断了这种呼吸，把绵长的、不被定义的平静间歇，替换成永远指向下一个检测节点的持续焦虑。在这样被定速的时间结构里，即使算法叙事曾成功触发过一次栖居叙事的发生，这株幼苗也很可能在扎根之前，就被不断的“必须在意”连根拔起。

因此本章的立场不是反对算法叙事本身，更不是要为栖居叙事营造一个不受任何挑战的温室。恰恰相反，一个稳健的栖居叙事，正是在与外部叙事的反复对话、辩论乃至冲突中被锻造出来的。本章批判的，是当前实践秩序里两种叙事之间完全不对称的位置配置：前者被全部制度路径、科学权威与资本力量推上唯一

合法叙述者的宝座，后者则在每次试图开口之前，就被宣告为不科学、不精确、乃至不必要。在这样严重倾斜的叙事生态里，说“算法叙事可以刺激栖居叙事成长”，就像在一场一方戴着手套、另一方双手全无却仍被称为“公平对决”的拳赛里谈论“挑战使人更强”，那不只是乐观，更是对权力结构的无视。叙事替代的伦理症结，不在算法叙事太强大，而在栖居叙事被剥夺了与之对质的基本条件。

这一回应还有一层需要说明：它并不要求证明林晚的栖居叙事“其实很坚固”。反诘的前提可以全盘接受，她的句子也许确实薄，薄的句子也确实可能因这次冲击而长出更厚的东西。本章只坚持一点：能否长出，取决于冲击之后她是否还有开口的位置与喘息的时间，而这两样恰是当前的制度安排所不予保留的。接生婆若在婴儿尚未落地时就把孩子抱走养大，便不再是接生婆。

◆ 六、接引逻辑的伦理困难：设计者的语法

反诘既已回应，问题便无可回避：若有人已被算法叙事替代了栖居叙事，还能否重获自己身体的第一人称？倘若尚未太晚，精准医疗的实践秩序该如何从“替代者”转向“接引者”，不是去覆盖、填充、代理人的栖居叙事，而是去接引它发生？

首先要放弃一条看似令人安慰的歧路：回到前算法时代的、被浪漫化的身体完整状态。如第二节所论，传统医学中那种不受算法侵扰的身体栖居感，本身就是技术目光尚未抵达这一条件下的历史产物。个人再也无法假装数据不存在，也退不回由技术无知所掩护的“完整感的旧花园”。出路只能往前走：在数据已全面在场的条件下，有意识地催生一种让栖居叙事与算法叙事可以相互接引的叙事生态。

但正是在这一步，论证遇到了它自身无法绕开的困难。接引逻辑要落地，就需要被设计。设计者，无论多么善意，都必须以一套关于叙事生态的理论语言来构想制度、流程与对话脚本，而这套语言本身是第三人称的、分析性的、外在于栖居者自身言说的语法。于是出现一个伦理悖论：栖居叙事不能由外部善意来制

造，那么“为栖居叙事创造条件”这个动作本身，是否也可能在不经意间重复了它所批判的替代者逻辑，只是把替代者的语法从“数据表明”换成了“这位研究者认为你需要一个不被数据覆盖的空间”？

这个悖论不是一套更精巧的方案能化解的，因为它的根源不在设计的粗疏，而在设计者的位置。叙事初权的含义是：关于身体的第一句话必须由居住者自己说出，而不是由任何更善意的外部代理者替他说出，哪怕是替他“预留空间”的动作，也不能在设计好空间之后才邀请他进来。一旦“预留的空间”是根据一套关于叙事生态的理论被先行设计出来的，它就已经不是栖居者亲手劈开的空无，而是善意规划的产物：房间的格局已被决定，居住者只是在被选定的位置就座。一篇以规范性语言写成的论述，拿不出一套能被执行、而不在执行中被背叛的“保证不替代的接引方案”。这个困顿不是论证的弱点，而是它必须抵达的诚实。

承认困顿不等于缴械。它迫使问题从“如何设计接引方案”移位为“接引方案在什么条件下会率先失败”：不去画那条正确的路，而去标出已经被证明是死路的歧途。下面三重死路，不是反对接引的理由，而是任何认真尝试接引的人事先都要与之厮磨的黑暗。

第一重死路，是前置提问被压缩为流程仪式。有人会说，守护叙事初权无须复杂的制度重构，只需在每次交付算法信息之前先问当事人一句：“在拿到这份报告之前，你对自己身体的感受是怎样的？”这句话确实切中了叙事替代的第一道切口，它要求数据在开口之前，先把第一句话的说话权交还居住者。但任何有临床经验的人都知道，这句话放进一个七分钟见一位病人的门诊体系里会遇到什么：它会变成电子病历里的一个必填字段，被疲惫的临床工作者用标准语调机械地说出，“你有什么感受吗？好，我们来看一下报告”。它不会被善意充满，只会被流程掏空。当它被压缩为一个要打勾的项目，它就不再是叙事初权的守护，而成了叙事权力的又一次表演性确认：制度看起来是好的，病人仍在那句话之后沉默。他被问了，却没有被聆听。这不是说前置提问必然徒劳，而是说，若它不

能被接进医患之间缓慢建立的信任关系，不伴随聆听者实在的、愿意被病人模糊语言不舒服地占去的时间投入，它就只是善意的新标本。

第二重死路，是故事化返回被收编为信息包装。有人会进一步主张，把信息的故事化返回制度化：不把概率数字直接推给当事人，而由临床医生或遗传咨询师，以叙事的方式，把数据翻译成同个人生命经验相接壤的故事。这个方向的意图很准，它想弥合两种语法之间的鸿沟。然而当“故事化返回”被写进临床指南、标准化为一套推荐话术，它就从一个由具体医患关系内生的叙事动作，变成可以脱嵌、培训、质检的“沟通技能”，就像医生被培训去“以共情的方式”传达坏消息。这种培训背后的逻辑仍是第三人称的：设计者知道什么是好的故事化返回，执行者只需遵守脚本。故事化返回因此失去了它唯一能生效的条件，医生在与这位病人的这一次对话里，凭着共同建立起的关系与语境，临场缝出的那句翻译。脚本化的故事不是栖居叙事的接引者，而是它更隐蔽的替代者，它用“温暖”的语法覆盖了“精确”的语法，却仍坐在替代者的结构位置上。

第三重死路，是遗忘许可被转化为另一种医嘱。有人还会说，检测方案中应明确写入“容许遗忘”：两次检测之间的漫长间歇，当事人应被明确告知，暂时不想自己的身体是合法的，是健康的。可是当“容许遗忘”被写进指南，它立刻转化为医嘱的新形式：“建议你在检测间歇期保持正常生活，无需持续关注风险。”这条医嘱在内容上是容许遗忘，在形式上仍是不容遗忘，因为它要求当事人在被提醒“你现在可以忘了”的那一刻，恰恰重新记起了那个本该忘记的东西。遗忘不能由外部指令触发。遗忘是在没有任何声音，包括善意的声音，提醒你“现在可以忘了”的时候，你自然把身体的事放回了生活的背阴处。一旦遗忘成了被医嘱授权的心理状态，它就成了另一种持续关注，以“放宽心”为名的持续关注。减少客观的时间压力、降低检测频率是必要的，但这不等于给了遗忘以可能。只要每一段间歇期都由医生的一句“这期间不用担心”来标记，被设定的遗忘就仍是医学话语所定义的遗忘。接引方案若不能把“容许遗忘”从一条医嘱转变成一种临床不去占据当事人注意力的负向能力，一种主动的不说话、不提醒、不在场，它在促成遗忘的同时，就已在遗忘的根上施加了最密集的凝视。

三重死路指向同一个结论：接引方案在“设计”这一姿态里就带着内在的危险。规范性的论述所能做的，至多是在伦理审查制度中嵌入一个不自称能“解决叙事替代”、但至少使叙事替代不被系统忽略的反思节点。据此，本章提出一项最低限度的制度性原则：精准医疗的临床实践与研究方案，其伦理审查应独立纳入“叙事权影响评估”。评估的判据朴直：该实践在多大程度上为栖居叙事的第一人称言说初权留出了不被流程吞噬的空间？在多大程度上容许了遗忘与非聚焦的身体共处时间节律，而不以医嘱的形式摧毁遗忘本身？它的数据交付方式，是把当事人的身体体验接引入一套更丰富的自我叙事，还是用一份外来脚本，哪怕是精心设计的叙事化脚本，替代了他的叙述位置？这一评估的功能不是给出设计方案，而是持续暴露设计本身的局限。它在每次实践展开之前，强制供给方回答一个不许不答的问题：“在这次干预中，你拿什么防止自己的善意，变成坐在当事人叙事位置上替他开口的又一个代理者？”这个问题没有标准答案，每当一个答案被提交，评估就追问：这个答案在被执行的过程中，在什么条件下会背叛自身？追问式的评估不承诺成功，却持续制造警觉，而这种警觉正是叙事替代最不能忍受的东西，因为替代的完成需要静默，需要不被察觉，需要被善意本身掩埋。

评估还提供了回应“患者主动选择算法叙事”这一反驳的视野。当一种叙事的语言垄断了“科学”之名，并与保险、就业、社会身份等制度资源深度耦合时，所谓“自由选择”实际是被单一语法绑架的别无选择。重建栖居叙事的公共空间，不是要剥夺任何人的选择权，而是要确保他们做选择时拥有两套同样合法的语言：数据的语言与栖居的语言。唯有两种语言都被认真对待，都不被预先宣告为不合理，那一声“我选择相信数据”才是一个选择，而不是栖居叙事失声之后唯一的退路。

这里还有一层反身性，本章自己也不能免。一份用分析语言写成的、试图命名并批判叙事替代的文本，同它所批判的算法叙事共享着同一类语法资源：分析、命名、论证、推理。它无法用栖居叙事的方言书写自身。若当代人的栖居叙事确已处在前所未有的脆化状态，这样的文本本身也是脆化的一个症状性产物。

承认这一点，不削弱论证，反而让它守住自己的位置：一个用分析的语言批判分析性替代的、自身不可完全免疫于那种替代的理论文本。

◆ 七、本章的证伪条件

一个不给出失败条件的命题，无法被检验，也无法被改进。叙事替代的核心判断是：在无症状的概率性风险预警情境中，算法叙事先于并取代了当事人的栖居叙事，致其难以用自身体验的语言讲述身体。下面三条可裁决的预测直接由三重机制推出，且与既有框架给出不同预测；其中任何一条被否证，核心判断即需修正。

预测一，先占效应。比较已出现症状后才接受检测者，与无症状时即接受基因风险预警者，在引导下产出自体验叙事的密度。叙事替代预测后一组的自体验叙事密度显著更低，且差异在控制教育程度与病程之后仍然存在。若两组无差异，或后一组反而更高，则“先占”之说不成立，叙事医学所说的“只是没被听见”足以解释。这是本章的主判据，也是最该先做的检验，现成的访谈方法即可。

预测二，术语渗透率。患者自述文本中外来术语（分子标志物、风险百分比、指标名）的占比，应随其接受算法化监测的年限单调上升，而以身体感受为主的描述性词汇占比同步下降。这可以用现成的语料统计方法验证，无须新采样。若占比随监测年限并无变化，或描述性词汇并不下降，则第二重与第三重机制所说的语法渗透无从成立。

预测三，接引逻辑的效果。在告知风险信息之前先引导患者说出自身体验的一组，其后续自述中的自体验叙事密度应高于直接告知组，且差异半年后仍然存在。若无差异，或差异迅速消失，则本章的实践主张落空。值得注意的是，这一条与第六节的困难并不冲突：第六节说的是任何接引方案都可能在执行中背叛自身，而这一条检验的是，在一个未被流程掏空的最小形态里，先问后告是否仍有可测的差别。

此外，第四节的各组对照预测，也构成本章的分项证伪：长期处于监测下的人若能毫不费力地用朴素直觉拒绝算法建议，异化批判便足够；若前反思功能受损，现象学便足够；若风险被严格控制者仍能自如讲出连续的、与身体亲熟的故事，卡塞尔便足够。这些都是本章准备好被推翻的地方。

◆ 八、本章小结

回到母题。第一编讲，生命一直在给出答案，系统却看不见。本章接着讲看不见之后发生了什么：叙事层的位置不会空着。风险预警抢在“我不舒服”之前开口，夺取了叙事初权；监测时间表以均质的滴答取代了有呼吸的节律；去晕、减苦、除根的承诺在兑现处走向自反，把人留在新旧两套语言之间，成为叙事难民。这一过程之所以是替定，而不只是压制，是因为它不依赖任何强力，它靠的是一连串做得好的善意，靠精确、权威与先到。林晚没有被禁止说“我就是容易累”，她只是发现这句话不再有地方落脚。

本章同时守住了几条界线。叙事替代不是异化，因为它发生在“完整的我”形成之前；不是医学化的扩张，也不是知情同意的失败；不是康吉扬所说的规范性丧失，而是规范性赖以表达的叙事位置被占；不是治理术生产出的生物公民，而是无主体的治理；不是对前反思亲熟的攻击，而是对通往第一声言说的通道的切断；也不是叙事医学所说的倾听缺席，而是叙事本身尚未发生就被占位。面对“替代只是催生”的内部反诘，本章只退到两个最低条件，叙事初权与遗忘的节律，并指出当前的制度安排恰不予保留；面对“接引方案”的设计者困境，本章不宣布出路，只标出三重死路，并提出一项让替代不被系统忽略的最低限度的评估。

但叙事只是替定最外显的一层。一个人的句子被占，尚可说是话语权的事；而当替定继续向下，占据的就不再只是“怎么讲述身体”，而是“身体将走向何种稳态、由谁来决定”的资格本身。从暂时托管滑向终身代管的，正是这一资格。下一章因此转向发生权代管：谁来决定身体的下一个稳态。

本章参考文献

Canguilhem, G. (1943). Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique. Paris: Presses Universitaires de France. (英译本: The Normal and the Pathological, trans. C. R. Fawcett, Dordrecht: D. Reidel, 1978)

Cassell, E. J. (1982). “The Nature of Suffering and the Goals of Medicine.” New England Journal of Medicine, 306(11): 639–645.

Foucault, M. (1976). La volonté de savoir. Paris: Gallimard. (英译本: The History of Sexuality, Vol. 1: An Introduction, trans. R. Hurley, New York: Pantheon, 1978)

Good, B. J. (1994). Medicine, Rationality, and Experience: An Anthropological Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.

Horkheimer, M., & Adorno, T. W. (1947). Dialektik der Aufklärung. Amsterdam: Querido. (英译本: Dialectic of Enlightenment, trans. J. Cumming, New York: Herder and Herder, 1972)

Kleinman, A. (1988). The Illness Narratives: Suffering, Healing, and the Human Condition. New York: Basic Books.

Marx, K. (1932). Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844. (首版于 Marx-Engels-Gesamtausgabe, 1. Abt., Bd. 3; 写作于1844年)

Merleau-Ponty, M. (1945). Phénoménologie de la perception. Paris: Gallimard. (英译本: Phenomenology of Perception, trans. D. A. Landes, London: Routledge, 2012)

Rose, N. (2007). The Politics of Life Itself: Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-First Century. Princeton: Princeton University Press.

◆

05

第五章

发生权代管：谁来决定身体的下一个稳态

◆ 一、一句供词，与本章所处的位置

2018 年，在一次常规的风湿科随访里，一位患类风湿关节炎已近十年的女性说了一句话。她当时已先后用过三种生物制剂和一种 JAK 抑制剂。她说的是：“那会儿我知道自己哪里不好。现在，我得看化验单才知道自己好不好。”说这话的时候，她没有愤怒，也没有控诉，语气里只有一种经历过许多次错位之后沉淀下来的平静。这句话常被读成一种顿悟，仿佛她忽然看清了医学的某种局限。但对照她此前九年的病程便会发现，它更像一份结算单：不是她“发现”了什么，而是她把九年里在诊室中一点一点发生的事，在一个平常的下午，如实报了一遍账。

这句话出自本章要反复回到的那位患者，以下称林女士。她的话之所以值得放在全章开头，是因为它把一个通常只在抽象层面谈论的问题，压缩进了最小的临床单位：一个人对自己身体“好不好”的判断，原本长在哪里，后来长到了哪里。在她确诊之初，这个判断长在她自己身上；到 2018 年，它已经长在化验单上。这中间并没有谁宣布过什么，也没有哪一次治疗是错的。每一次用药都有指南依据，每一次调整都有证据支持，每一位医生都说得客气、做得负责。可是九年下来，一项资格从她手里移到了别处，而她自己是最后一个知道的人。

回到全书的脉络。本书的母题是：精准的善意抢先替生命定下“好”的样子，替得越久，生命越长不出自己的答案。这一母题由三步构成。第一编讲“看不见”，即生命自己一直在给出答案，而越是精准周到的系统越看不见这些答

案；第二编讲“抢先替定”，即看不见之后，系统用自己的答案抢先填进那个位置。本书用“替定”一词统称这一类事情：外部系统抢在生命自己之前，替它定下“好”的样子与抵达的路径。上一章（见第四章）讲的是叙事层面的替定：在主体能为自己编织栖居叙事之前，算法叙事先占了位。本章讲的是替定的核心。叙事被抢先，毕竟还只是说法被抢先；而当生命系统在扰动中“自己决定修复成什么样、自己走哪条路去修复”的那项资格本身被外部代理行使，并且这种代理从暂时的托管滑向终身的代管时，被抢先的就不再是说法，而是生成新稳态的权柄。本章要论证的正是这个滑动的过程，它在身体深处留下的可测量痕迹，以及这种代管何以到后来连撤回都成了难事。

因此，本章在“看不见—抢先替定—长不出”三步中处在第二步的深处，同时已经伸手去碰第三步的门槛：替定持续得越久，生命自己摸索、判断、重组的能力越萎缩。林女士在 2021 年说出的另一句话，“我好像已经忘了怎么生这个病了”，正是第三步的先声。本章的任务因此有三层。其一，把一个此前未被命名的东西指认出来，称之为发生权，并说明它不能被已有的概念所替换。其二，以肺癌靶向治疗史与类风湿关节炎生物制剂治疗史为经验线索，以林女士的十二年为分析性脊骨，描画代管如何从救援变成习惯，再变成无法撤出的常态，并解剖把这道门焊死的三重机制。其三，把这个概念放进神经—内分泌—免疫的生理层面检验，放进与几位最强近邻理论的对质里检验，放进最强的反例面前检验，最后给出撤回的条件、测量的工具，以及本章准备好被推翻的地方。

有一点须在开头说明，以免全章被误读。本章不是反对精准医疗的檄文。急性感染、急诊手术、酶替代治疗之类的场合里，系统自身的裁决基础设施已被扰动深度破坏，外部代理是救援而不是剥夺，本章对此没有任何异议。本章所批判的对象，严格限定在这样一个区间：系统基本的裁决基础设施仍然存在，却在长期的外部代理之下被闲置、被替代，以至于发生生理性的萎缩，而且没有任何制

度化的路径让它有机会重新承担起这份裁决。对这个区间的批判，是对着“从未为托管设计过终点”的结构，而不是对着托管本身。

◆ 二、发生权：从守护转向的两层先验说起

– （一）精准医疗的困境不在精度

“精准”一词携带着现代医学最笃定的承诺：只要把一个人的基因组、蛋白质组、代谢组测绘干净，疾病就不再是扑朔迷离的症候群，而是一串可以拆解的确切故障码；药物则被想象成只瞄准那个故障码的分子级狙击枪。可是这一蓝图在执行的数十年间反复撞上同一堵墙。以肺癌为例，针对 EGFR 驱动突变的酪氨酸激酶抑制剂（TKI）在晚期非小细胞肺癌患者身上创造了影像学上近乎奇迹的退缩。2004 年发表于《新英格兰医学杂志》的里程碑式试验显示，吉非替尼使携带 EGFR 突变的患者中位无进展生存期延长到近十个月，这在当时的晚期肺癌治疗史上几乎是革命性的数字。然而在绝大多数患者身上，那个几乎消失的肿瘤会在一年左右重新生长，而且不再依赖当初被锁定的那个突变：T790M 突变被筛选出来，成为新的主导克隆。它绕路了。

类风湿关节炎的治疗史上演着另一版本的同一情节。针对 TNF-α、IL-6、JAK 通路的生物制剂与小分子药物轮番上场，每一种登场时都被欢呼为革命性的精准打击。临床现场的图景却是：约 30% 至 40% 的患者对 TNF-α 抑制剂初始无应答；在初始有应答者中，每年约有 5% 至 10% 因抗药抗体产生或疗效衰减而失去应答，不得不转向第二种、第三种制剂。与此同时，在疾病活动度被控制住的岁月里，许多人积累起日益加深的疲劳感、对身体自我感知的钝化，以及对一切非药物干预的深层不信任。

通行的解释把这种困境归于“复杂性”或“异质性”：疾病太复杂，认识还不够全面；更有雄心的回答则主张更多更全的数据，多组学整合、单细胞测序、

人工智能驱动的网络药理学，以期抵达“更精准的精准”。本章的出发点不同：困境的根源不在于技术还不够精确，而在于精准这种认知模式与操作逻辑，用在复杂生命系统上时，正在隐蔽地执行一项从未被命名、因而从未被审视的行动。它把生命系统自行决定自身下一个稳态的权利，从系统手中接了过去。

（二）守护转向没有触到的两层先验

要看清这项行动，须先经过近二十年来医学人文领域里一股颇有分量的思潮，不妨称之为“守护转向”。它反对把患者当作被动接受指令的客体，主张医疗的角色不是“塑造”患者的健康行为，告诉他们该吃什么、怎样运动、几点睡觉，而是“守护”患者那份已被疾病磨损却尚未熄灭的自我照护能力。守护比塑造谦逊：它承认医者并不全知患者该活成什么样，愿意退后一步，为患者自己的摸索留出空间。从塑造到守护，在认识论上确实已经深了一层。塑造范式预设医者知道健康的终点长什么样；守护范式撤销了这份傲慢，代之以克制的姿态：医者不知道终点，只负责守住过程。

但守护转向仍然站在两层未被审查的先验上。第一层先验是：被守护的那个东西，即患者自身的疗愈能力、自愈倾向、修复冲动，天然知道自己该长成什么样。守护者退后的前提是，我不碰它，它就会自己长好。这个预设在急性感染和外伤里大体成立：免疫系统确实“知道”如何识别并清除病原体，成纤维细胞确实“知道”如何填补伤口。然而当扰动深到足以扭曲系统感知自身状态的能力时，预设便崩塌了。系统不再知道自己是病了还是好了，是该进攻还是该收兵，是该加速还是该刹车。当代精准医疗所面对的大批慢性复杂疾病，从自身免疫病到难治性癌症，恰恰多半处于这个“系统已无法自行判断方向”的区间。在这些区间里，系统并非失去了执行修复的力气，而是更根本地失去了判断“修复成什么样的稳态才算成功”的能力。它被锁在一个被疾病、也被既往治疗反复重塑过的扭曲稳态里，所谓“自行摸索”，不过是在几个扭曲的稳态之间打转。

第二层先验藏在对“退后”这个动词的信任里。守护的话语常把自己描绘成医者从塑造者的位置上退下来，把空间还给患者。可是退后之后，医者退到了哪里？设想一位在“达标治疗”框架内践行共享决策的风湿科医生（这是为说明而设的情景，并非田野材料）。他真诚地请患者参与方案选择，给出 A 方案（TNF-α 抑制剂）和 B 方案（IL-6 抑制剂），解释各自利弊，然后问：“你更倾向于哪一个？”这是一场符合指南、甚至值得表扬的守护式对话。但请注意，“能否不依赖任何生物制剂，以生活方式的系统性重建为核心，试着把免疫稳态拉回来”，这个问题并不在桌上。不是因为他专横，而是因为在他的认知工具箱里，这个选项根本不在“可操作的临床选项”的菜单上：指南里没有它，随机对照试验的证据不足以支撑它，他个人的经验也不足以让他承担推荐它的责任风险。守护者确实退后了，但退到了精准医疗的认知框架与技术可行性预先划定的边界之内。他给了患者在菜单上选 A 还是选 B 的自由，却没有给“是否换一张菜单，甚至是否走出这家餐厅”的自由。决定什么算一条值得尝试的路径，这一重要的权利，在守护者以为自己已经退后时，仍牢牢握在技术—制度复合体手里。

– （三）命名：发生权及其三个维度

同时撤销这两层先验，被遮住的东西便显出形状。它不是疗愈能力，因为疗愈能力预设了能力的主体仍然完整地保有“我是个有能力的疗愈者”这一身份；它不是自愈力，因为自愈力只涉及执行的力气，不涉及决策的资格；它也不是自主性，因为自主性是一个过于宽泛的政治与心理学术语，抓不住这里要抓的最具体的东西：一个生命系统在遭遇深度扰动之后，自行决定自己下一个稳态的形态，并亲自踩出一条此前不存在的路径去抵达它的资格与过程。本章把这个东西命名为发生权。发生权，指在一个生命系统遭遇扰动、旧稳态已不可维持的临界点上，系统自行摸索、生成并稳定出一条通往新平衡之路径的资格与能力。需要

强调，这是一个本体论意义上的概念，不是法律或政治概念；它指的是系统“修复成什么样”和“走哪条路修复”的决定归谁，而不是系统有没有力气修复。

发生权包含三个不可分割的维度。其一是感知权：系统以第一人称的方式感知自身状态、分辨何谓“好转”与“恶化”的资格，不以外部量表和生物标志物作为唯一的裁决依据。其二是摸索权：系统在信息不完全、没有“正确剧本”的情况下，做出试探性决策并承担不确定性的资格，不依赖外部指南预先框定全部可选项。其三是验收权：系统以自己的内部尺度判断“我是否已经好了”的资格，不让外部标准，例如 CRP 正常、肿瘤缩小 30%，垄断对“治愈”的定义。

这三个维度不是并列的权项清单，而是彼此咬合的循环。感知的敏锐度构成摸索的原材料：对自己的身体信号已经钝化的系统，在摸索中只能做出更粗糙的试探。摸索权的长期闲置，系统不再亲自踩出一条路，只是被指引着走，则反过来使感知进一步萎缩，因为那个靠“试探—反馈”不断校准的内部感知系统，在长期不被调用之后，校准精度自然退化。验收权的被垄断，由化验单来定义“好了”，则从根部切断了整个循环的动力：既然“好”的标准已不由我定，我又何必费心去感知、去摸索？正因为这种内部的咬合，发生权不能被拆成“知情同意权”“自主选择权”之类现成社会学概念的组合。它是一个完整的生命过程，而不是一张可以逐项核销的权项清单。

– （四）不可还原校验

一个新概念须经受这样的检验：能否被某个现成概念用一句话一比一替换？最像的几个候选可以逐一排除。自愈力说的是系统有没有力气去修复自己，它不管决定权：“你有力气，但力气往哪里用，听我的”，这恰是发生权被代管而自愈力仍在的情形。内稳态说的是系统维持一个不变平衡点的能力，它是维持，而发生是从一个已拆毁的旧稳态上重建一个新稳态，是重开一局。复原力最为接近，它描述的是弹回原状或在扰动中保持核心功能的能力，但它没有触及最要紧

的一点：当原状已不可回、核心功能已被扭曲、系统必须成为一个从未存在过的“新自己”时，那场从混沌中自己踩出一条新路的摸索，凭什么仍然属于系统自身？复原力处理的是弹簧的弹性系数，不处理弹簧被拆掉重铸时“重铸图纸该由谁来画”的问题。

更危险的候选是临床上的“家长主义加患者赋能缺失”的组合，福柯的治理术，莫尔的照护逻辑，以及伊利奇的文化医源性。这几位近邻留待第七节正面对质。在此仅预告一个判断：它们各自抓住了要紧的东西，但都留下了一块装不下的部分，那就是裁决权被长期代理之后，行使裁决权的那套生理基础设施自身会发生什么。

◆ 三、从托管到代管：两条经验线索

发生权代管不是一次性的制度设计，而是一个在临床微观互动中被每一次具体治疗决策逐步加深的历史过程。以下以肺癌 EGFR 靶向治疗史与类风湿关节炎生物制剂治疗史为临床背景，勾勒代管的三个阶段：暂时托管、长期托管、终身代管。林女士的十二年，则在其间充当分析的脊骨。

– （一）暂时托管：“情况危急，我先替你掌舵”

代管最初的形态，在外部观察者眼里往往不被识认为代管，而被识认为救援。以 EGFR 突变非小细胞肺癌的第一代靶向治疗为例。2000 年代早期，携带 EGFR 敏感突变的晚期肺癌患者在接受第一代 TKI（吉非替尼、厄洛替尼）治疗后，肿瘤在数周内显著退缩。此刻发生权的暂时托管在临床上有无可辩驳的正当性：肿瘤正以失控的速度进展，系统自身的稳态重建机制，包括免疫监视、DNA 损伤修复、凋亡通路的自我激活，已被癌症的场彻底扭曲并压制。期望系统在这时“自行摸索出一条新路”，在伦理上和生物学上都是荒谬的。外部工具必须紧急介入，替系统做出它已无法做出的决定：“你现在往这个方向走，抑制

这个被过度激活的 EGFR 信号通路。”暂时托管的关键特征在于，外部代理对发生权的接管，是在系统已被扰动深度剥夺裁决能力的前提下，以“争取时间窗口”为名的临时措施。理想状态是，窗口一旦争取到，肿瘤缩小，症状缓解，系统重获一定的生理稳定，托管就应逐步撤回，让系统重新承担对自己稳态的裁决。

可是理想状态从未到来。第一代 TKI 争取到的窗口，在绝大多数患者身上并不是通向撤回的过渡期，而是通向下一轮更深托管的阶梯。在药物的持续选择压力下，原本只占肿瘤细胞总数不到千分之一的 T790M 耐药克隆被筛选出来，成为新的主导克隆，肿瘤“换了一张皮”回来。摆在医患面前的选择于是变成：撤回 TKI，让系统在已被深度重塑的肿瘤微环境里自行摸索，还是升级到第三代 TKI（奥希替尼），进入新一轮更精准的代管？撤回意味着巨大的不确定性，没有任何指南会推荐在明确存在耐药突变时“停药观察”；升级则意味着明确的、可预期的、有随机对照试验证据支持的无进展生存获益。在这种不对称的选择架构下，撤回托管从来不是一个现实的选项。它在技术上完全可行，停药这件事本身没有任何操作难度，在临床现实中却几乎不可能被执行，因为整套制度，指南、同行惯例、医疗责任风险、患者对不确定性的恐惧，都在合力把“升级代管”推成唯一的选择。

– （二）长期托管：“菜单上的选择，就是你的全部自由”

类风湿关节炎的治疗史上，这一阶段以“达标治疗”原则的全面确立为标志。TNF-α 抑制剂等生物制剂把治疗的地形图从“逐步升级”的迂回逻辑，改写成一条清晰的、不容置疑的最佳路径：甲氨蝶呤疗效不足，就应尽早启动生物制剂，以低疾病活动度（DAS28<3.2）或临床缓解（DAS28<2.6）为目标，定期评估，未达标则升级。这条路径的理性力量无可辩驳，它把关节破坏的累积风

险降到最低，在随机对照试验和真实世界证据里，都证明了比旧式逐步升级更优越的影像学结局。

发生权却正是在这条灿烂的最佳路径上被静默抽走的。抽走的方式不是“禁止系统自己摸索”，而是把系统自行摸索的产出，在定义上排除出“可选项”的范畴。一位被建议启动生物制剂的患者，如果问医生：“我能不能先试六个月的深度饮食结构调整，剔除所有可能触发免疫反应的食物，重建肠道屏障，配合呼吸训练和睡眠节律重建，看看能不能把免疫稳态拉回来，而不是现在就上生物制剂？”这个问题本身，在当前的临床认知框架里几乎不可翻译。指南没有为这条路径预留评估的格子，随机对照试验没有为它提供证据，医生的经验里也没有足够的样本去判断它值得冒险。于是这条路径不是被评估为“劣后”，而是从根本上就不被承认为一条路径。它不在菜单上。患者拥有在菜单上选 A 或选 B 的自由，却没有提出“菜单上没有的选项 C”的资格，而菜单本身由外部机构，指南、随机对照试验、监管部门，制定。（这里的“指南地壳”如何形成并如何使身体的代偿被误读，见第三章，本章不再重复。）

这便是长期托管阶段中发生权代管的实质：系统没有被剥夺“选择的能力”，被封死的是系统“定义什么算作一个选项”的权利。系统仍然在做选择，在生物制剂 A 和 B 之间选，在用药间隔上微调，却不再参与“什么样的生命状态构成疗愈”这件事本身的定义过程。它被告知：你的 B 细胞过度活跃，TNF-α 是你的主要炎症通路，所以正确的稳态方向是压制这些过火的东西，正确的路径是生物制剂，正确的终点是 DAS28<2.6。这套定义如此自洽，如此有证据，如此有效率，以至于被代管的系统逐渐停止了发问：我自己那种“好了”的感觉，跟 DAS28<2.6 之间，是不是有哪里对不上？

◆ 四、林女士的十二年：代管作为一部身体经验的改写史

林女士，2009 年（时年 34 岁）因持续的双手掌指关节晨僵、肿痛就诊，确诊为血清阳性类风湿关节炎。她的十二年病程，为上面所说的两个阶段提供了无法化约的经验肉身，并逼出第三阶段的发生学机制。

– （一）起点：摸索权的完整行使

确诊后的第一年，她自己尝试了严格的无麸质饮食和针刺。她记录自己的晨僵时长与疼痛评分，发现某些食物，尤其是面食，似乎与症状加重相关，而针刺能在几小时内提供有限的缓解。这一年，是她摸索权的完整行使：没有外部指南，以自己的第一人称感知为依据，对两种干预做了试探、比较与校准。2010 年，腕关节 MRI 显示滑膜炎进展，出现骨侵蚀的早期征象，风湿科医生严肃地告诉她：“现在不是自己试的时候了。你需要正规治疗。”她启动了甲氨蝶呤，随后加用 TNF-α 抑制剂。这一次托管的降临，完全合乎医学上的理性，也是以“救援”之名到来的。然而发生学上要紧的，不是代管开始的那个瞬间，而是代管此后十二年里如何一寸一寸地把她从“第一人称的感知者”改写成“化验单的信徒”。这一改写至少可以在三个临床互动现场里追溯。

– （二）三个现场

第一个现场在 2012 年。林女士用 TNF-α 抑制剂已近一年，DAS28 从 6.1 降到 2.8，达到临床缓解标准。她却反复告诉医生，自己“并不觉得好了”：“指标是下来了，但人总是很累，那种累不是关节疼的累，是整个人像被抽空了一样。”医生查看化验单，各项炎症指标均在正常范围，温和地解释：“指标都很好，可能是你太紧张了。可以用点心思放松一下。”这次对话里，她的第一人称感知与化验单的第三人称证据之间出现了第一次明确的错位，错位被化解的方式，不是探究错位的原因，而是化验单的“客观性”消解了感知的“主观性”。

这里有一个微妙的认知操作值得停下来看：医生并没有说“你在撒谎”，他说的是“你太紧张了”。这个解释并不否认她的感受，只是把它重新归类，从“关于疾病状态的、值得被严肃对待的信息”，改归为“对身体状态的情绪反应”，一种需要管理的心理现象。她的感知，在这一次归类里，从信息降成了情绪。

第二个现场在 2014 年。她的 TNF-α 抑制剂疗效开始衰减，DAS28 回升到 4.2，晨僵加重。这一次她不再对医生说自己“觉得累”，而是直接报告客观症状：“早上起来手僵得厉害了，最少一个半小时才松。”医生据此调整方案，转向第二种 TNF-α 抑制剂。在这次互动里，她已经学会用一种客观的、可量化的、可被化验单印证的指标，晨僵时长，来组织自己的病情报告，不再诉诸可能被归为“紧张”的模糊体验，比如“被抽空了”。她适应了游戏规则。这种适应恰恰是感知权代管被内化的标志：她不再在临床互动中“提交”那些化验单无法印证的感知，因为历次对话已经教会她，不被化验单支持的感知，无法被当前的认知框架翻译，无法进入临床决策。它们不是被禁止，而是被她自己沉默地过滤掉了。

第三个现场就是开篇那一幕。2018 年，她已先后用过三种生物制剂、一种 JAK 抑制剂，在一次常规随访中说出了那句话：“那会儿我知道自己哪里不好。现在，我得看化验单才知道自己好不好。”这是一份关于身体认知被系统性重组的供词。她不是在发现自己失去了感知权，而是在结算十二年互动经验里的一笔账：那套由化验单、指南、医生话语共同构成的外部认知系统，已经在事实上取代了她内部那个以第一人称感知为基础的裁决系统。

这三个现场不是对“感知权代管”这个概念的举例说明，而是对其发生过程的展示。感知权代管不是在某个时刻被一次性剥夺的事件，而是在一次又一次“化验单没事，你可能太紧张了”之类的平常对话里，被一步一步、一针一线地编织进患者的身体经验史。这也正是它难以被觉察、更难以被抵抗的原因：没

有哪一次对话是错的，没有哪一位医生在做坏事，可是累积起来，一项资格换了主人。

（三）终点：“我好像已经忘了怎么生这个病了”

2021 年，林女士因 JAK 抑制剂疗效衰减，被建议转向一种正在临床试验中的新型生物制剂。当访谈者问她是否考虑过暂时停掉所有药物，看看身体自己的状态时，她看着对方，眼神里没有任何抵触，只有彻底的茫然：“我不知道。我不知道停药之后我还能做什么。我好像已经忘了怎么生这个病了。”

这句话的发生学分量不亚于三年前面对化验单的那一句。三年前她结算出：我得看化验单才知道自己好不好，感知权已被代管。此刻她结算出的则是：我忘了怎么生这个病，那个能够把发生权接手回来的主体，已经不在了。这不是“不想”摸索，也不是“不敢”摸索，而是用于摸索的认知与生理基础设施，在长达十二年不被使用的闲置中，已经发生了实质性的萎缩。终身代管的标志性事件因此不是药物的终身服用，而是那个能接手回发生权的人已经不存在。代管从“替你做决定”变成了“替那个已经不会做决定的你做决定”。到这一步，母题的第三个环节已在一位具体的病人身上完成了：替定持续得足够久，生命自己的能力萎缩，撤回替定也收不回来了。

五、把门焊死的三重机制与一层代际传递

读到这里，读者有理由追问一个问题：究竟是什么把“暂时托管”与“终身代管”之间的那道门焊死了？答案不在某个单一的制度缺陷里，而在三方合力构成的自我加固的结构里。需要避免的是把这个结构描绘成一座已经完成、冰封的铁笼；它的每一根支柱，都是在具体医患互动中被重新激活、重新发生的。

（一）患方对不确定性的恐惧

对一位刚在 TKI 治疗中获得影像学缓解的肺癌患者而言，“停药观察”带来的不是自由，而是深渊，因为它意味着把那个曾在几周内就能夺命的肿瘤，从药物的压制下释放出来。这份恐惧并非从天而降的神秘情感，它在每一次“医生告诉你疾病可能进展”、每一次“病友复发后离世”的具体事件里被制造、被强化。恐惧有一个发生的历程，它是被反复教出来的。

（二）医方的医疗—法律责任风险

在世界上绝大多数司法管辖区，医生遵循指南推荐了标准治疗而患者出现不良结局，医生在法律上是安全的；而如果一位医生在没有指南支持的情况下推荐“停药观察”，患者出现疾病进展，他在医疗纠纷里几乎没有任何防御能力。但更精确的发生学问题不是“法律如何规定”，而是“医生的风险感知是如何被制造出来的”。它不是在法学院里一次性习得的抽象知识，而是在某一次具体的科室病例讨论中，一位资深同事讲了一个“某医院的医生因为没按指南走而被告了”的案例之后，烙进年轻医生心里的。此后每次面对类似决定，“偏离指南”就不再是临床判断问题，而成了“你愿不愿意为这个不够主流的判断付出职业生命”的道德体验。这份风险在一次又一次科室叙事、同行议论、现实中的纠纷报道中被持续再生产。（医生如何在这种环境里被训练成“排雷式认知”，见第三章。）

（三）疗效评估标准的单一化

当“有效”被垄断性地等同于“肿瘤 RECIST 退缩 ≥30%”或“DAS28<2.6”，任何不产生这一量化结果的干预，无论它在患者的第一人称体验里是否意味着“改善”，都不可见：不被采集，不被记录，不被讨论。这种垄断也不是在某次指南制定大会上一朝宣布的。它在每一次临床数据录入系统的微小操作里，在每一场“质控指标只看 DAS28 达标率”的科室质控

会议上，在每一篇只报告这些单一终点的论文被发表、被引用、被写入下一版指南的过程中，一步一步被确立为“唯一的”。当那些在 DAS28 上表现平庸、却在患者整体功能与生活质量上有显著改善的干预，因为无法在绩效指标里得分，被医院管理层视为“效率低下”并压缩资源时，这种垄断便不仅是认识论上的，更成了结构性的：它开始实际抹除其他可能。

这三方如同一只三脚架，稳稳撑起了一个让“撤回”在认知上不可见、在操作上不可行的体制性现实。但这只三脚架不是一次铸成的，它是每一次具体的临床对话、科室会议、质控考核，在足够多的反复中焊接起来的。因此，拆掉它也须从这些微观互动层面着手，仅仅呼吁“修订指南”是不够的。

– （四）代际传递：一个认知脚本的再社会化

最隐蔽的一层，是代管作为一种认知惯习被传给下一代患者。一位年轻时确诊类风湿关节炎、在生物制剂下度过二十年的母亲，在女儿也开始出现关节症状时，对女儿说的第一句话不是“你仔细感受一下，哪里不对劲”，而是“赶紧去查个血，看看类风湿因子高不高”。她把自己被代管的经验，当作唯一正确的疾病认知方式，传给了下一代。

这个瞬间不能简单地诊断成“医疗化导致的健康主义”，那样只是换了一个诊断标签。要追问的是：在母亲说出那句话的刹那，她体内经历了一次怎样的认知切换？她不是没有感知自己关节疼痛的第一人称经验，她有。但在说出那句话的几十毫秒里，她把那份第一人称经验压了下去，调用了自己二十年里在诊室中反复习得的模式：症状必须被翻译成化验单上的数值，才算一个值得认真对待的问题。这句话不是一个观念的传递，而是一个认知脚本的自动执行。发生权代管在此完成了它的再社会化：它不再仅仅是外部医疗制度对患者的接管，而成了患者群体内部、代际传递的默认认知程序。到这一步，替定已不需要医生在场，它长进了病人自己的反应里。

◆ 六、代管的生理痕迹：被管丢了的那个“我”

如果论证停在上一节，代管仍可能被看作“心理感受层面”的问题，或患者赋权话语之内的事：它让患者“觉得”失去了控制感，却并未在生物学上造成什么实质损伤。本节要打破这种侥幸。代管留下的不只是感受，它在神经—内分泌—免疫网络的底层留下了可测量、可追踪、可复现的痕迹。把发生权说成一个本体论概念，并不意味着它悬在生理之上；相反，感知、摸索、验收这三项资格都要靠身体里一套具体的装置去执行，装置若被闲置，资格便无从行使。

– （一）三个先行的坦白

在展开证据之前，须先坦承三件事。第一，本节给出的所有生物学关联，在逻辑上都能被竞争性的主流解释所覆盖。心率变异性（HRV）的下降，可能是原发病严重程度的标记；HPA 轴的钝化，可能是老年与病程迁延带来的自然衰退；菌群多样性的丧失，可能是严重胃食管反流病本身经由改变饮食与睡眠引起的并发症，而不是质子泵抑制剂（PPI）的独立效应。本节并不声称拥有裁决这些竞争解释的最终证据。它做的是指出这些退化的一致指向，它们共同勾勒出一幅“系统自我调节弹性全面收窄”的图景，并给出能将“代管施工痕迹”假说与“原发病自然史”假说解耦的逻辑链条与实验设计。

第二，本节不主张“因此应当停用这些救命药物”。它主张的是：这些指标应当被纳入精准医疗的长期监测与撤出决策框架，而不是仅在出了问题时被当作“副作用”处理。它们不是可以忍受的附带代价，而是系统正在丧失底层裁决能力的生理学计数器。

第三，有一根逻辑梁串联全节：如果某种长期剥夺“自行决策”机会的干预模式确实会使生理弹性下降，那么能够改善这些弹性指标的非药物训练，例如压力管理训练对 HPA 轴反应性的调节、正念训练对 HRV 的提升、饮食干预对肠

道菌群多样性的恢复，就构成一条反向的证据链。它们表明，这些弹性指标并非只是疾病的被动反映，而是可以在“提供自决策空间”的条件下被主动重塑的。这一策略不能“证明”代管的因果效应，那需要前瞻性的解耦实验，但它能把“代管导致生理退化”这一假说，从纯推测推到有合理性基础、应被严肃检验的位置。

（二）心率变异性：自主调节的弹性

心率变异性，即逐次心跳间期的微小波动，是自主神经系统弹性的公认非侵入性指标。高 HRV 反映系统在交感激活与副交感回弹之间灵活切换的能力：面对扰动能快速响应，扰动过去能迅速恢复。这正是发生权在生理层面的根基。一个拥有发生权的系统并非永远波澜不惊，而是在每一次内外扰动中，都有能力在“应激”与“复原”之间做出恰当而成比例的自我调节。

长期依赖外源性糖皮质激素的类风湿关节炎患者，其 HRV 呈现持续的低迷走张力模式，即使在炎症指标已被生物制剂控制住的情况下也是如此。机制在于，长期外源性皮质醇抑制了 HPA 轴自身的节律性分泌，内源性皮质醇水平钝化，昼夜节律变平。药物撤除之后，系统失去了自行“刹车”的能力，因为负责刹车的踏板，即副交感神经的回弹，在长期不必亲自踩刹车的日子里生了锈。这不是“炎症未控”，而是自主调节弹性本身的生理性退化，是代管在自主神经系统里留下的指纹。

竞争性解释须被正视：HRV 下降完全可能是更重的疾病活动的后果，而不是代管的独立效应，这要靠解耦实验来裁决。不过，已有大量研究表明，呼吸训练、正念减压等非药物手段可以显著提升 HRV 的迷走张力，这为上述反向逻辑提供了间接支撑：系统性地保留并训练自主调节的机会，确实能改善 HRV；那么长期系统性地剥夺这种机会，导致 HRV 下降，就至少不是无根据的推测。

– （三）HPA 轴反馈敏感性：内分泌层面的判断力

下丘脑—垂体—肾上腺轴的负反馈调节，是身体感知内外环境变化并做出分级反应的核心机制。健康的 HPA 轴不是对任何应激都狂飙皮质醇，而是对不同级别的应激做出成比例的反应：轻压轻升，重压重升，威胁消除后迅速回落。这在本质上是内分泌层面的感知与裁决能力：能分清这件事有多严重，并做出恰如其分的反应。

长期依赖强效免疫抑制剂（如环孢素、他克莫司）的移植患者提供了清晰的临床样本。这些药物通过阻断钙调磷酸酶通路，精确抑制 T 细胞活化；但 HPA 轴自身的负反馈调节，部分依赖外周免疫细胞释放的细胞因子（IL-1、IL-6）对下丘脑的正向信号输入。长期强效免疫抑制在阻断 T 细胞的同时，也系统性地降低了免疫与神经内分泌轴之间的信息流通量。下丘脑逐渐“听不到”来自外周的免疫状态信号，其 CRH 分泌节律变平，对实际应激的反应幅度钝化。这并不是原发病复发的简单重现，而是那个本来负责感知威胁、调动全身应对的内分泌裁决中枢，在长期被外部药物“代劳”之后，丧失了独立做出恰当判断的生理能力。要把它与疾病本身对 HPA 轴的长期冲击区分开来，最关键的设计是：在疾病严重度匹配的动物模型中，比较“代管式”的精确免疫抑制，与能达到同等炎症控制、却不完全阻断免疫—神经通讯通路的“非代管式”干预（如间歇性应激调节、环境丰富化），观察停药后 HPA 轴反馈敏感性的保留程度。

– （四）β 细胞功能：代谢决策的空间

2 型糖尿病是代管退化最简洁的临床模型。该病的早期病理核心是外周胰岛素抵抗，胰腺 β 细胞代偿性地分泌更多胰岛素以维持血糖平稳。此刻岔路出现。第一条路：依赖外源性胰岛素或磺脲类药物，“精准”地控制血糖数字，这是一种标准的、被广泛执行的代管操作。第二条路：同时配合饮食调整与运动训练，降低外周抵抗，让 β 细胞在仍然“亲自工作”的前提下逐步减负。

第一条路的长期后果，在多项临床试验中已获得证据支持：长期外源性胰岛素替代可能通过抑制内源性胰岛素分泌通路，以及高胰岛素血症本身对 β 细胞的反馈性抑制，加速残存 β 细胞的去分化与功能丧失。患者的血糖越来越依赖对外源性胰岛素的剂量调节，自身残留的代谢弹性越来越低。而在糖尿病预防项目等研究中，强化生活方式干预已被证明能在病程早期部分恢复 β 细胞功能。这一对照证据把第一条路的病理本质剥了出来：它不是“疾病本身的进展”，而是代管把一个本可保留部分自主裁决能力的代谢调控系统，在每一次精确的血糖数字管理中，推向了对代管者更深的终身依赖。

（五）肠道菌群多样性：场的纪律

肠道微生物组的多样性，是宿主与其肠道生态系统在长期共演化中形成的一种“场的纪律”：高多样性的肠道生态，拥有更强的定植抗性、更稳定的短链脂肪酸代谢输出，以及面对饮食与环境变化时更灵活的适应能力。这正是生命场在发生权未被代管时所具有的那种弹性。长期的精准外包如何侵蚀它？PPI 的长期使用提供了一个被低估的案例。PPI 通过精确抑制胃酸分泌，高效地管理了胃食管反流症状；然而胃酸是上消化道微生物群落的重要生态过滤器，它被抑制后，下行至肠道的微生物种群构成发生改变，下游效应可波及整个肠道生态。长期 PPI 使用者的肠道菌群多样性，在部分研究中显示出明显下降。更微妙的是，低多样性的微生态系统对饮食干预的响应能力本身更弱，因为能够响应不同底物输入而快速重组的微生物“工具箱”已经枯竭。患者陷入一个无声的死锁：越依赖药物压制症状，肠道自身维持稳态的纪律越弱化；纪律越弱化，症状越易反弹，就越不能停药。

这里的竞争性解释同样须被正视：长期服用 PPI 的患者往往本身胃食管反流病更重，其菌群改变可能是严重原发病经由饮食、睡眠等中介行为引起的后果，而不是 PPI 的独立效应。解开这个结，需要前瞻性设计：比较严重度匹配的反流

患者中，长期使用 PPI 者与接受抗反流手术（因而不用 PPI 却达到同等症状控制）者，在术后一至三年里肠道菌群多样性的轨迹。若两组存在明显差异，则代管的独立效应就得到更有力的支持。另一条同样有力的反向证据来自饮食干预研究：富含可发酵纤维的膳食在数周内即可显著提升菌群多样性与短链脂肪酸产量。这种可塑性本身说明，菌群多样性并不只是被动承受疾病或药物后果，它可以在“系统被赋予自决策空间”，即患者主动选择并实施膳食改变的条件下被主动重塑。既然主动重塑是可能的，那么长期剥夺系统行使这种重塑的机会，导致多样性下降，至少是一个经得起推敲的假说。

– （六）四组证据合起来说了什么

这四组证据合起来砌成一堵墙：发生权代管不是“让人心里不舒服”的医患沟通问题，它是生物学层面可测量、可追踪、可归因的组织损伤。自主调节弹性（HRV）、内分泌裁决精度（HPA 轴）、代谢决策空间（β 细胞功能）、生态场的纪律（菌群多样性），在长期代管中的退化，指向的不是疾病的自然史，而是代管这一隐蔽行动在组织深处留下的痕迹。这里的“痕迹”不是诊断标签：它并不要把这些退化本质上“定义为”代管损伤，而是要求把它们视为一组需要持续追问的信号。回答这个追问所需要的，不是更好的修辞，而是前面勾勒的、能把变量解耦的前瞻性实验设计。而对本书的母题来说，这一节的意义在于：它把“替得越久，越长不出”从一句关于感受的判断，落成了一个关于身体的、可以被证伪的判断。

◆ 七、与最强近邻的切割

一个概念是否切开了新的辨别面，不取决于它与已知概念看上去相差多远，而取决于它与最像、最危险的邻居对质之后，是否仍剩下对方装不下的东西。本

节依次对质伊利奇、福柯、莫尔、家长主义加患者赋能的组合，然后补上自创生与委托—代理理论两位邻居。

（一）伊利奇：剥夺与代理

伊万·伊利奇在《医学的限度》（1976）里提出“文化医源性”，追问的是：医疗制度对患者的自主应对能力做了什么？他的诊断是，医学扩张的隐性代价，是系统性地摧毁了普通人在面对痛苦、衰老与死亡时自主塑造生命意义的文化潜能。他抓住的是“剥夺”：制度从个体手中夺走了他本来拥有的东西。本章要抓的是一个更具体、更微观的过程：不是剥夺，而是代理。一个具体生命系统在每一次临床干预中本应行使的“我往何处去、我如何抵达、我何时算已抵达”的裁决权，被一个测量精度更高、证据基础更强、决策效率更好的外部复合体，在操作层面一寸一寸地接了过去。更要紧的是，伊利奇的文化潜能是在文化层面谈的，本章追问的则是：那个被长期代理的系统，是否还保有收回这份权利所必需的最底层生理能力。

（二）福柯：被管理与被代理

最庞大的幽灵是福柯。他在《安全、领土与人口》（1978）和《生命政治的诞生》（1979）里阐述的“治理术”，分析的是现代国家如何不再仅以法律的禁止与允许来统治，而是把人口的生物性过程，出生率、发病率、死亡率、寿命，纳入统计学、政治经济学与公共管理的计算，以“安全技术”对生命做宏观的调节与规范化。精准医疗凭借对基因组、蛋白质组、代谢组的人群级数据整合与风险评估，难道不正是这种生命权力在分子层面的终极实现？“发生权代管”难道不能算治理术的一个亚型？

回答是：不能，二者不可还原。两者共享同一个远祖，都关注外部理性如何侵入并重塑生命过程，但抓住的是两条不同的路径，针对的是两个不同的对象。

切割不靠定义上的区分，而靠一种发生学的做法：把两种视角先后用在同一个现象上，看治理术在哪里再也走不下去，而“代理”恰在那里开口说话。设想一个具体现场（这是为说明而设的情景，并非田野材料）：一款用于 2 型糖尿病管理的手机应用，通过持续血糖监测仪实时采集数据，用算法设定个人化的血糖目标范围，血糖偏离时发出警报，同时给出饮食和运动提醒，还把长期数据整理成报告供与医生共享，未来的迭代甚至可能与健康保险费率挂钩。

先用治理术来分析。它可以清楚地揭示：这个应用如何把“正常血糖”定义为统计学上的范围（规范化），如何用警报和提醒把用户的行为引向那个范围（规训），如何把用户的生物数据从个人体验中抽离、转成可记录、可统计、可比较的人口健康指标（生命政治），又如何用积分、虚拟勋章之类的奖励让用户“自愿”成为自我健康管理的规训主体（自我技术）。在这套分析里，用户的行为、认知与身体都被纳入一个外部的、由技术—制度复合体建立并维护的“正常化”框架。

但到这里，治理术的分析走到了尽头。它无法再追问另一个问题，一个不关乎“权力如何调节行为”，而关乎“被调节的身体在生理层面发生了什么”的问题：用户使用这款应用两年之后，她对自身低血糖的第一人称感知，那种“心慌、出冷汗、手抖”的内部信号，是不是比使用之前更迟钝了？因为她已习惯在这些信号出现之前，就被血糖仪的警报先告知“你的血糖即将过低”。她的内感受敏锐度，那个曾是她决定“我该不该吃块糖”的裁决依据的生理能力，在长期被外部警报“代劳”之后，是否已经退化？治理术不关心这个问题，因为它的对象是人口，关心的是“人口层面血糖控制率有没有提升”，它无法追问“那个曾经自己知道自己血糖在下降的身体，还在不在”。而这恰是“代理”视角必须追问的。所以代理不是治理术的亚型，而是治理术在完成了对“行为”的解释之后，面对那些无法被“调节”或“规训”穷尽的、落在一个具体系统内部的生理

后果时，必须启用的另一个分析维度。治理术是一张从三万英尺高空拍摄的人口热力图；发生权代管，是在一位具体用户的 HRV 趋势图前，指着那条两年里逐年被压平的曲线说：这是高空图看不见的东西，这个被长期代理的身体，正在丢失它最底层的弹性。

（三）莫尔：共同摸索之内的悄悄转移

荷兰医学人类学家安妮玛丽·莫尔在《照护的逻辑》（2008）里做了一个与本章高度相关的区分：“选择”与“照护”。她指出，把病人定位成在菜单上做选择的理性消费者，是自由主义政治哲学对医疗现场的粗暴移植；而慢性病的实际照护，是一种持续的、试错的、医患共同摸索的过程，重要的不是给出选项齐全的菜单，而是不断地“做”照护：调整、试验、回顾、修正，在行动中摸索出对“这位”患者合适的路径。本章所批判的“菜单上的自由”，在很大程度上可以被莫尔的框架所覆盖，二者之间有一条清楚的继承线。守护转向的批判，即守护者的退后并未把“什么构成一条路径”的定义权交还系统，在莫尔那里能得到更彻底的理论支持。

但二者之间有一条不可忽视的分离线。莫尔的“照护”仍是医患双方“共同”执行的实践，摸索发生在人际互动的层面：医生和患者一起调整胰岛素剂量、饮食习惯、运动计划。本章要切入的点比“共同摸索”还深一层，它发生在共同摸索似乎“成功了”的时刻：医患通过持续血糖监测系统找到了一套高度有效的管理方案，血糖达标率达到 90% 以上，糖化血红蛋白落入指南推荐的理想区间。此时，患者的第一人称感知权，那个曾在她亲自摸索低血糖身体信号时被反复调用的内感受系统，是否正在被闲置？她的身体是否因为不再需要亲自“感知”血糖波动，而在静默地丧失那份敏锐？莫尔的照护逻辑对抗的是“选择逻辑”，告诉我们医疗不该是商场而应是共同摸索的旅程；发生权代管对抗的，则是“照护逻辑”内部由技术精度的大幅提升而悄然发生的认知代理。即使医患双

方在真诚地、共同地执行照护，当监测数字的工具，其感知精度与响应速度已远超患者自身的内感受系统时，原本属于系统自身的裁决权，是否仍在这段共同照护的关系里，静默地从身体一侧转到了设备与算法一侧？这不是对莫尔的否定，而是对她在技术化照护场景下的延伸追问。

（四）家长主义加患者赋能：伦理与生理

临床层面最直接的竞争概念是“医疗家长主义”与“患者赋能缺失”的组合。家长主义解释了医生为什么替患者做决定，在特定情形下医生比患者更知道什么对她最好；患者赋能缺失解释了患者为什么不再尝试自己做决定，长期被告知“你不懂”之后，她就不再尝试。两者合起来，似乎已覆盖“替你做决定”到“你已经不会自己做决定了”的全部所指。

但这个组合始终站在伦理决策与行为心理的层面。家长主义回答的是“替患者做决定是否在道德上正当”，患者赋能回答的是“如何通过教育与支持，让患者重新获得做决定的知识、信心与技能”。两者都无法触及林女士那句话的核心：当她说“我忘了怎么生这个病了”，她说的不是“我没有知识”，不是“我没有信心”，也不是“我害怕”。她说的是，那个被长期闲置的、用于感知自身疾病状态并做出试探性决策的生理基础设施，自主神经系统、HPA 轴、内感受网络，在长达十二年的不必亲自使用中，已经客观地、生理性地、不以她的意志为转移地退化了。家长主义可以解释为什么医生替她选了 TNF-α 抑制剂而不是 IL-6 抑制剂，却无法解释为什么那个在生物制剂帮助下活得很好的患者，HRV 在逐年下降。这一维度，诞生在伦理讨论结束之后、生理变化开始之前的那个空白地带里，不是“医患沟通培训”或“患者教育手册”能解决的。

下表收束前三组切割的辨别面。

近邻概念	核心动作	对象	问的问题	本章切出的辨别面
福柯·治理术	调节、规范化	人口	权力如何管理生命的集体命运?	代理：一个具体系统的裁决权被占用，其裁决器官发生生理退化
莫尔·照护的逻辑	共同摸索	医患互动	如何用共同行动取代选择菜单?	照护内部技术精度过剩时，裁决权仍可能静默地从身体转移到设备
家长主义加患者赋能	替代决策、赋能教育	个体的伦理判断与行为	替你做决定是否正当？如何让你重新学会做决定?	裁决权被代理后，裁决器官本身发生了不以意志为转移的生理性萎缩

（五）自创生：组织的同一与承重节点的更换

还有两位邻居在位置上最容易被忽略，覆盖的风险却很高。其一是马图拉纳与瓦雷拉在《自生成与认知》（1980）里给出的自创生。它指的正是“生命自行生成并维持自身秩序”这件事：一个活系统由一张组分生产网络构成，网络的运作不断再生产出网络自身，并由此划定自己与环境的边界；它在结构上对环境开放，在组织上却是封闭的，环境只能触发它，不能指定它的下一步。本章绕不开它，否则等于在一块已经立了牌子的地上重新插旗。

分离线是这样：自创生守的是组织的同一性，本章追的是承重节点的更换。自创生的核心断言是，只要系统还活着，它的组织就保持不变，变的只是实现该组织的结构；一旦组织被改变，系统就不再是它自己，而是死亡或成为别的东西。本章刻画的过程恰落在自创生留白的地方：旧的承重节点被外力打断之后，系统换了一套承重节点继续运作。EGFR 信号被阻断后改用 T790M，再改用 C797S，再改用 MET 扩增；β 细胞不再分泌胰岛素，退回去分化的休眠态。这些不是同一个组织的不同结构实现，而是组织本身被重写了一次，系统并没有死。

这条分离线是可裁决的。取任一慢病或耐药演化过程，在扰动前后分别标定系统的关键承重节点集合与其间的依赖拓扑。自创生框架预测：拓扑，即组织，在系统存活期间保持不变，变的只是节点的物质实现。本章预测：拓扑本身发生了替换，扰动后的承重节点集合与扰动前的交集可以趋近于空，而系统照常运作。若经验上观察到的始终是前者，换的只是零件，图纸没变，那么本章的主张便可还原为自创生的医学应用，“发生权”这个命名也就冗余了。

– （六）委托—代理与不完全契约：权利的转移与能力的萎缩

其二是委托—代理理论（Jensen 与 Meckling，1976）与不完全契约理论（Grossman、Hart、Moore）。“代管”这一措辞直接落在委托代理的语义场里。委托代理理论已处理“代理人替委托人做决定时的利益偏离”，不完全契约理论进一步处理“哪些决定权无法事先写入契约、因此必须归属某一方”，后者尤其贴近“发生权”。

分离线是：委托代理讲的是权利的转移，本章讲的是权利被行使之后能力的萎缩。在委托代理框架里，委托人随时可以收回授权，能力不因授权而改变；本章主张的则是，代管的持续行使本身消解了收回的可能：系统在被代管期间丧失了重新自行决定的能力。可裁决的判据由此而来：设计一次“撤回代管”的干预，例如结构化的药物假期或监测中断，观察系统能否恢复自行重建稳态。委托代理预测：撤回后能力如常，差别只在结果好坏。本章预测：撤回后出现一段可测的失序期，其长度与代管年限正相关。若无失序期，或失序期与年限无关，本章的核心主张便落空。

◆ 八、反例：当精准医疗“重启”了发生权

前文描绘的图景，即一个被长期代管剥夺了自我裁决能力的被动系统，面临一类不可回避的反例。为数众多的患者在精准治疗下首次获得长期而高质量的临

床缓解，并由此重新获得被疾病摧毁殆尽的社会功能与生活能力。对一位曾因严重类风湿关节炎卧床不起、连自己穿衣吃饭都成了不可能的患者而言，生物制剂带来的缓解不是对发生权的剥夺，恰恰相反，它把被疾病碾碎的“决定自己今天能不能下床、能不能出门、能不能工作”的最基础的生命自主权还给了她。她从一个只能感受疼痛的“病人”，重新成为能工作、能社交、能为自己的人生做选择的人。回避这个反例，本章就有被视为“站在哲学安全区里指责正在救命的东西”的危险。以下分四步回应。

第一步，完全承认这种“发生权重启”的真实性与正当性。精准医疗在此刻行使的不是剥夺，不是代理，而是救援。它把一个被疾病推入深渊的系统重新拉回平台，此时外部工具的角色是辅助轮：它给系统提供了一个被剥夺已久的功能平台，使其能重新站立，并在此平台上开始重新行使那些此前已瘫痪的发生权，比如决定今天要不要出门去见一个朋友。这个阶段，代管的风险极低，效益极高，本章的批判不适用于此阶段的患者。

第二步，指出问题的核心不在辅助轮阶段，而在从未给辅助轮设计过一套结构化的、被制度承认和支持的撤出路径。那位在 TNF-α 抑制剂帮助下重新站起来的患者，在连续缓解三到五年之后，是否曾在某次随访中被医生告知：“现在你的 DAS28 已持续低于 2.0 超过三年了。我们可以开始讨论一个非常缓慢的、有监测的、出现复发迹象时可随时重启的阶段性减量计划，你愿意考虑吗？”在绝大多数情况下，这样的对话从未发生。不是医生不愿意，而是整个临床操作系统，指南、质控指标、医疗责任保险、患者的认知定势，都没有给“辅助轮的撤除”预留时间和空间。辅助轮被默认终身佩戴；而正是在从“短期辅助”滑向“终身佩戴”的沉默延长期里，代管的生理代价开始累积。

第三步，也是最关键的一步：认真对待那个“不准备撤出”的群体，而不是用“他们可能还没意识到”的说法搪塞过去。对许多被精准医疗从深渊中救起的

人来说，终身服用一种生物制剂不是被迫接受的枷锁，而是主动选择的、与命运达成的新契约。他们在这份安宁里活着，活得有尊严、有功能、有社会参与；凭什么对他们说，这份安宁底下藏着“被代管的危机”？这是必须严肃对待的质疑。本章的回应不是否定这份安宁的真实性，而是追问：在这份安宁之下，是否仍潜伏着一个不能被当下的满意所消除的问题。设想，在将来的某一天，这份安宁的外部支柱，不是被她的意愿，而是被支付系统的改革、药物的不可及，或生物学上的耐药失效，强制撤除了。那么，这个在长期不必亲自裁决自己身体状态的安宁中生活了几十年的身体，它应对那场必将到来的、必须由自己完成的摸索所需的生理储备，还在吗？她的 HRV 是否还有足够的弹性，去承受停药后免疫系统可能出现的反跳性波动？她的内感受系统是否仍足够敏锐，在疾病进展到不可逆之前，发出有效的求助信号？这些问题并不否认她“现在过得好”。它们问的是：把一个人的全部长期福祉，包括在未来不可预见的制度或生物学断裂中的生存机会，完全押在一个外部结构上，而不同时为这个被辅助轮保护了一生的身体保留一点自行维持平衡的练习空间，这样的照护，是否足够审慎、足够以长期福祉为念？

第四步，把这类患者定位为本章最深的同路人，而不是被批判的对立面。他们是从代管中获益最深的人，因此也最有权追问本章要逼向临床体系的那个问题：为什么在我被辅助轮扶起来、走得足够稳之后，仍没有一条被尊重的、有医学证据支持的、有制度保护的道路，让我去尝试摘掉辅助轮，不是现在，而是在我自己判断为合适的某个将来？如果这些被精准医疗“拯救”的人愿意成为推动“设计撤出路径”这一议程的最有力的声音，那么本章的论证将获得最不可撼动的道德力量。这个反例由此被安放在恰当的位置上：它没有推翻代管的论断，反而划出了论断的适用边界，即批判的对象是从未为托管设计终点的结构，而不是托管本身。

◆ 九、撤回：三条原则、一个指数与一个限度

撤回不可能依靠一套统一的操作手册，但它至少依赖三条原则被同时嵌入精准医疗的技术设计与临床操作的底层。第一条，撤出标准必须与启动标准同时被定义。眼下工具的启动标准，何时用生物制剂、何时用靶向药，有详尽的、循证的、被指南固化的定义，撤出标准，即在什么生理指标组合下、什么时间窗口内、以什么节奏减量并最终停用，几乎不存在。这需要一场从随机对照试验设计阶段就开始的转变：在注册试验里嵌入预设的撤出臂，把“撤出后维持缓解的时间”与“撤出后发生权相关生理指标的保留或恢复程度”列为预设的次要终点。撤出标准的缺失不是监管疏忽，而是代管逻辑的必然产物：一个以终身代管为默认的技术系统，不会主动设计自己的终结。

第二条，在代管期间的每时每刻，系统自身发生权的练习空间必须被刻意保留并测量。这不是要患者“自行停药”，而是在用生物制剂压制炎症的同时，测量并记录 HRV 趋势；当迷走张力因呼吸训练、营养调整等非药物干预而改善时，将其视为“系统自身调节弹性正在恢复”的信号，纳入撤出时机的决策。同样，在以靶向药控制肿瘤的同时，也可测量患者对身体信号的自觉察准确度，当它因针对性训练而提升时，视为系统在行为层面正在收回感知权的可测量标志。为此，本章提出一个复合的测量工具，称“发生权指数”，由三部分组成：HRV 的迷走张力指数（自主调节弹性）、HPA 轴昼夜节律斜率（内分泌裁决精度）、经标准化量表测得的患者第一人称内感受敏锐度得分（感知权）。三个组成部分各有独立的标准化测量方法与可引证的研究基础。该指数的目的不是定义一个“正常值”，而是追踪同一患者在不同时间点上的纵向变化：她的发生权基础设施，是在被维护、被闲置，还是被刻意重新训练？它可在临床试验中作为预设的次要终点。

第三条，举证责任的重新分配。今天，医生推荐“标准路径是终身服用，我们按标准走”，几乎不必承担任何举证责任，指南是他的盾牌；而若推荐“我们尝试在以下条件下阶段性撤出”，他就要面对纠纷时“你为什么不按指南走”的质疑。这种不对称使“终身代管”成为认知上最省力、风险上最安全的默认选项。要打破它，须让一部分举证责任移到“终身服用而不尝试撤出”这个选择上：这个选择也必须在病历里写下被选择的理由，例如此前三次撤出尝试均以复发告终，且每次的方案与监测指标均有据可查。同时，在法律和医疗责任保险框架里为符合预设条件、有据可查、征得患者知情同意的阶段性撤出尝试，设立最低限度的“安全港”免责条款。

这三条原则与当前医疗经济激励存在根本冲突：需终身服用的药，比需在三到五年内逐步撤除的药，在商业上更可持续；不必为撤出担责的流程，比必须持续评估撤出时机并备案的流程更“高效”；按服务项目收费的医保支付，天然奖励“持续用药”而非“成功撤出”。代管之所以难从内部打破，正因为它不是单纯的认知错误，而是被多方利益与制度惯性共同锁死的结构性僵局。本章不提供打破僵局的完整路线图，那需要卫生政策、药物经济学与临床研究设计的合力；它坚持的只是，打破之前必须先命名，让发生权及其在代管中的生理代价，成为可被讨论、测量、争论、写进临床决策记录的对象。

最后须守住一个限度，以免滑向浪漫化的“回归”叙事。“把发生权还给那个正在发生的身体”这类修辞，暗含一个危险的预设：存在一个原初的、本真的、等待解放的身体。可是身体本身也是在特定的历史、技术与社会条件里不断被发生出来的，当代人的肠道菌群、免疫耐受模式、内感受基线，都早已不是工业化以前那副身体。发生权无法“归还”给一个已不再是当初的身体。撤回的意义因此不是恢复失落的过去，而是在承认系统已被塑造、无法回到从前的前提

下，有意识地、试探性地、在技术辅助下，重新培育一种与技术共存的裁决弹性。撤回不是归还失物，而是开启一场从未有过的、风险更高的共同摸索。

◆ 十、本章的证伪条件与可裁决预测

本章不预设自己是对的，它预设的是：这个问题重要到值得被检验。以下各条从本章机制直接推出，与既有框架给出不同的预测，且在现有手段内可检验。第一，如果能证明，在长期生物制剂治疗中，患者的 HRV、HPA 轴弹性等发生权基础设施并未出现与“疾病严重度”解耦的纵向下降，那么“代管导致裁决器官生理退化”这一核心因果假说就被严重削弱。第二，如果前瞻性研究按第六节勾勒的设计实施，在疾病严重度匹配的动物模型或患者队列中，比较“代管式”的精确免疫抑制与“非代管式”的、保留系统自决策空间的干预，而结果并未显示两组在停药后发生权基础设施的保留程度上有任何明显差异，本章的理论就应被废弃。第三，撤回代管之后若无失序期，或失序期与代管年限无关，则本章对委托代理框架的分离落空。第四，若扰动前后的承重节点集合始终与原先一致，则本章可还原为自创生的医学应用。

另有两条预测。其一关于重启：重启案例应集中在单次、短程、以解除急性阻断为目的的干预；长期、连续、以维持指标为目的的干预不产生重启。若长期维持型干预同样频繁地重启发生权，本章的批判对象便失了焦。其二关于代管的可觉察性：本章主张发生权的让渡不被当事人察觉，故让长期接受分子监测管理的患者自评“关于自己身体下一步该怎么办，主要由谁决定”，其自评应明显低估外部系统的实际权重，且低估幅度与管理年限正相关；若自评相当准确，则让渡是知情的，“本体论权利被移走”的说法就过强了。

还须自省一点：本章在解剖一个反对把生命系统过度“结构化”与“外部管理”的现象时，自己不得不使用高度结构化的论证和精确划界的术语。这个矛盾

不必掩饰。本章要求的不是砸掉一切靶向药，而是为辅助轮设计撤出路径；同理，也不主张砸掉一切学术结构，只要求在结构之间，对结构本身保持警觉。

◆ 十一、本章小结

本章命名了一项此前被反复行使却从未被指认的资格：生命系统在扰动中自行决定“修复成什么样、走哪条路”的发生权，及其被技术—制度复合体代理行使的过程，即发生权代管。它沿着肺癌靶向治疗与类风湿生物制剂两条经验线，以林女士十二年的病程，描画了代管从救援滑向习惯、再滑向无法撤出的三个阶段，解剖了把门焊死的三重机制，指认了它在 HRV、HPA 轴、β 细胞与肠道菌群上留下的可被检验的痕迹，并与伊利奇、福柯、莫尔、家长主义加患者赋能、自创生、委托代理逐一划了线，正视了“重启”的反例，给出撤回的三条原则与发生权指数，以及本章准备好被推翻的地方。

回扣全书母题，本章是“抢先替定”的机制核心，也是“替得越久，越长不出”的第一份身体证据。替定在这里不是粗暴的剥夺，而是一系列合乎指南、成功有效的善意；它越成功，被替定的那套裁决装置就越久不被调用，到后来，连撤回替定都收不回来。林女士那句“我好像已经忘了怎么生这个病了”，是母题在一个人身上走完全程的回声。

可是还有一层尚未触及。发生权代管之后，一个人不只是丢掉了“走哪条路”的决定，他连“我好了没有”这个最后的判断，也正被一点点押到体外的数据那里。林女士说“我得看化验单才知道自己好不好”，已经露出了端倪。替定由此进入判断层：下一章（见第六章）将讨论“健康抵押”，即内感受判断力怎样被转成向体外数据缴纳的抵押品，以及每一次成功的履约，怎样损耗它所要赎回的东西。

◆

06

第六章

健康抵押：“我好了”是怎样被押出去的

◆ 一、替定进入判断层：一个被长期抵押的早晨

前五章合起来，已经把本书母题的前两步走过了一遍。第一编讲“看不见”：老人的生迹、未被选中的残迹、身体的代偿，这些生命自己持续给出的答案，不长在“需求”“指标”“故障”这些地址上，所以越是精准周到的系统，越是看不见它们。第二编讲“抢先替定”：看不见之后，系统用自己的答案抢先填进那个位置。第四章写的是叙事层的替定，算法叙事抢在主体能为自己编织栖居叙事之前开了口；第五章写的是替定的核心机制，生命系统决定“修复成什么样、走哪条路”的资格，被技术与制度的复合体代理行使，并从暂时托管滑向终身代管（见第五章）。本章要走的是替定的第三层，也是最贴近个人的一层：判断层。叙事层的替定，是别人先替你讲了你的故事；发生权层的替定，是别人先替你决定了身体的下一个落点；判断层的替定则更细，也更难察觉——是别人先替你裁定了“你现在怎么样”。

这一层所涉及的，是一个平常到几乎不被当作能力的能力。一个人无须任何仪器和报告，就能够知道自己此刻是舒服还是不舒服、是精神饱满还是已经透支、是可以放心去做事还是应当先歇一歇。本章把这种无须外部数据背书、由身体整体自行给出并自行确认的状态判断，称为内感受判断力。它是母题第一步里所说的“生命自己一直在给出的答案”中最日常的一种，也是第二步里最容易被抢先替定的一种，因为它没有地址：它不是一项指标，不是一个可入库的字段，不在任何一张化验单上占一行。当医学的精准度提高到可以在分子层面为每个人

写下专属的健康剧本时，这个没有地址的答案，处境就变得十分微妙。它既不会被明令禁止，也不会被粗暴取缔；它只是被悄悄改变了身份。

本章的核心论点可以先说在前面。精准医疗在其帮助个体的核心操作中，把个体与生俱来的内感受判断力，系统性地转化成一种必须持续向体外数据系统缴纳的认知抵押品。用以换取“数据健康”的那笔担保物，恰恰是人们渴望借数据健康来保全的东西，即对自己身体的根本信任。这笔交易还有一条特殊的条款：每一次成功履行，都在损耗它宣称要赎回的东西。本章把这一机制称为健康抵押。与之配套的另一个概念是认知征收，指的是内感受判断力在个体认知裁决中被体外数据系统优先征用、并被降格为劣后依据的过程。两个词的分工是：健康抵押说的是这笔交易的结构，认知征收说的是这笔交易在个体认知层面的执行动作。

先看这一过程在一个早晨里是怎样发生的。设想一位四十二岁的软件工程师，在吞下每日一片的低剂量二甲双胍时，手在半空中停了难以察觉的一瞬。他没有糖尿病。空腹血糖、糖化血红蛋白、口服葡萄糖耐量，所有这些被列在“正常参考范围”旁边的数字，都安稳地落在教科书定义的区间之内。但他是一名“高风险者”：三个月前，一份消费者基因检测报告告诉他，他的2型糖尿病多基因风险评分处于同龄同性别同族裔人群的前5%。遗传咨询师以温和而专业的语气说明，这意味着一份统计学上的预警，他在未来十年发展出2型糖尿病的概率，约为人群平均值的近三倍。按照某些最新国际指南的审慎建议，对如此高风险等级的个体启动低剂量预防性药物干预，是合理的。需要说明的是，作者在注释中明确交代，这位工程师以及后文的HER2阳性患者，都是基于公共卫生资料与临床报道构造的复合个案，用于展开论证，不指向任何真实个人；本章沿用这一处理，下文凡涉及他们，都应当按论证性的案例来读，而不是田野记录。

他的理性完全认同这个决定。数据确凿，建议负责，那颗白色小药片几乎没有副作用。然而当他把药片放进口中、用水送下的一瞬，一个细微到甚至无法称

为念头的扰动，总会在意识的背景里一闪而过。那不是清晰的怀疑，不是对医生或科学的拒绝，而是一种更底层的东西，像水面下一道几乎看不见的波纹。他无法命名它，但它每次都在。他的身体，这个他已经与之共存了四十二年的、经过漫长演化淬炼的、能够在晨跑之后给他清晰而准确的能量反馈的有机体，在这个早晨被宣告为一种需要外部数据持续监控、否则就可能违约的存在。

这不是一个关于“诊断”的故事。他没有被诊断，他的血糖是正常的。这是一个关于“抵押”的开端：他的身体感觉，那些晨跑后清爽的疲惫、饱餐后充实的满足、一夜无梦醒来后饱满的精神，作为内感受信号，突然不再是关于他自身状态的最终判断依据。它们没有出错，也没有消失，但身份变了。它们不再是有资格裁定“我是健康的”的终局法官，而变成了一笔被存进体外数据库的担保物。他以这笔担保物换取了一份名为“数据告诉我目前是安全的”的远期协议，而协议的条款从签约第一天起就规定了一件事：他需要定期偿还利息，三个月一次的血检，一年一次的风险评分更新，以及无数次对自己身体微小信号的警觉审问：“这阵突如其来的倦怠，是工作疲劳，还是胰岛素抵抗在加重？”而他最终想赎回的“本金”，那种不需要任何外界证明、稳稳待在自己身体里的感觉，恰恰在每一次交付利息的动作中被悄然耗损。

本章的任务，既不是论证精准医疗是好是坏，也不是清点它制造了多少副作用，更不是设计一套更好的替代方案。本章要追踪的，是一个在精准医疗认知操作的底层逻辑中悄然运转、尚未被充分命名的过程，它在上述早晨那不到一秒钟的停顿里已经完整地发生了。叙述的次序也值得交代：下文先不谈抵押，而是先追踪这个过程如何从统计常模的认知循环里长出来，如何借“让权”的名义完成征用，如何在日常生活中被道德化，如何在靶向治疗这样最成功的地方被再生产，如何在社会层面造成抵押品的贬值，最后才回到概念，与最近的几个邻居划清界线，并交代它在什么条件下会被证伪。全章结束时，替定的三层，叙事、发生权与判断，将被一并收齐。

在进入具体机制之前，还需要说明本章控制变量的位置。后文将反复论证：旧有的批判范式各有其锋利的位置，却都缺少一把尺子，来度量一个发生在个体内部、在“我感觉”与“数据显示”之间的主权转移。本章把这把尺子命名为“内感受判断力在个体认知裁决中的征用优先序”：当身体的整体感受与体外数据对同一件事给出不同说法时，认知裁决的次序里，谁先被采信、谁被排到后面。这个变量可以在个体层面被观察，也可以在群体层面被统计，它不预设技术好或不好，只问一件事：在日常裁决中，那个没有地址的答案，还有没有资格排在前面。本章的全部论证，都围绕这个次序是如何被改写的展开。

◆ 二、合同的底色与让权失败

– （一）常模的认知循环

要理解工程师为什么会在吞药时手停半秒，必须先回答一个更基本的问题：是什么让“你的血糖正常”这句话，不再足以让他确认自己是健康的?

检验报告上括号里的参考范围，比如“空腹血糖3.9—6.1 mmol/L”，在日常操作中享有一种被全体医疗人员视为理所当然的认知权威。每个医学生在检验诊断课上都会学到它的来历：找一个足够大的健康人群样本，测量血糖，画出正态分布曲线，取中间95%，这便是参考范围。“参考”这个名字在当初是被谨慎选择的，它暗示这只是一条辅助线索，而不是判决书。但制造过程中有一个无法绕开的操作性矛盾：要定义“正常”，必须先有一个“正常人群”的样本；要确定谁属于“正常人群”，又必须先有一个关于“正常”的可操作定义。这个循环不是逻辑疏漏，而是人类要从边界模糊的生命现象中划出一条可操作分界线时，不得不做出的临时性、实用主义的决断。做法是选取一批经临床评估、当下没有已知疾病的个体，测量，取分布中间的95%，暂定为参考范围。注意“暂定”二字：最初的流行病学研究者对这一操作的性质是清醒的，他们知道自己不是在发

现一个永恒的生理学真理，而是在借用一个操作定义，让筛查和诊断能够先在某个共识之上启动。

问题出在随后的几十年。这个借来的操作定义，被一层层嵌入追求效率与标准化的现代临床流水线。化验单需要统一的格式；医保支付需要一条明确的界线，血糖越过哪条线，降糖药才能报销；住院医师需要在有限的培训时间里学会一套全国通用的判据；临床路径管理软件需要一个能用“如果—那么”逻辑处理的数字阈值。在这些并无恶意、却持续累积的制度需求的反复加固下，当初被谨慎地称为“参考”的统计区间，在临床日常中缓缓漂移了身份：它不再只是关于群体集中趋势的描述，不再只是告诉你“大多数人大概在这两个数之间”，而变成了对你个人身体状况的裁决，落在区间内，你“正常”；落在区间外，你“被判定为异常”。那个原本设计来筛选“可能需要进一步检查”的拒绝域，在几十年的制度硬化中，凝固成了判断健康与病理的终审法庭。

康吉莱姆在1943年完成的博士论文《正常与病理》，以至今未被主流临床医学充分消化的锐度，切开了这道裂缝。对生命体而言，正常不是与群体平均值吻合的数字，而是生命体在其所处的具体环境中展现出的“规范能力”：在波动中自己建立秩序、在扰动中自己恢复平衡的活性的自我调节能力。生活在安第斯山脉海拔四千米的原住民，血红蛋白浓度远超基于平原人群算出的正常上限，却不是病人，他已在自己的世界里建立了与高原环境相匹配的生理规范。定义他正常与否的，是他的环境，而不是千里之外的平原上算出的区间。这套学说本该对以统计常模为基座的现代临床医学构成根基性冲击，却被高度尊重地搁置了，原因很实际：临床医学需要在一刻钟的门诊里做出裁决，需要一个即时可用、无须追问每位病人完整生命史的决策装置，统计常模完美地扮演了这个角色，把康吉莱姆眼中那片流动的、每个生命各有其规范的风景，压扁成一张非此即彼的表格。

—（二）精准医疗的解放叙事与更精密的循环

精准医疗的诞生叙事，恰恰是从公开谴责“统计常模的暴力”开始的，而且说得动人：不要再拿你和全世界的人比，那种比法太粗糙，不把你当成独特的人；我们要深入你的基因组，在碱基序列里找到属于你一个人的正常。如果基因型显示你代谢氯吡格雷很慢，就不该给你标准剂量，而要给你你的剂量。这是精准医疗向世界递出的第一份、也最根本的许诺：把每一个人的生物学独特性，从群体常模的专断统治下解放出来。然而恰恰在这个看上去最像解放的起点，抵押合同被悄然签署了。精准医疗并没有放弃“比对到一个规范”的逻辑，它只是把用以比对的规范，从基于显性症状和常规生化指标的群体统计平面，下沉到基于序列和表观遗传标记的分子统计平面。十万人的血糖平均值，换成了万人数据库中的参考基因组；落在均值两个标准差之外的读数，换成了全基因组关联分析中风险比显著大于1的位点。康吉莱姆追问的那个循环，没有被打破，而是被更精密地重铸了。

细看重铸过程。一份血液样本被送上高通量测序仪，产生数以百万计的位点信息。要判断其中哪一个是致病元凶，算法必须同步做两件事。其一，把每个位点与“参考人类基因组”比对。这个参考基因组不是任何一个具体的人的基因组，而是少数匿名捐赠者序列拼接打磨而成的统计人造物，是分子时代最大的一个“群体平均值”。其二，检索海量的群体遗传数据库，计算该位点的罕见变异在“病人组”和“对照组”中的出现频率，在病人组中统计上显著高发的，被标记为候选致病突变。但病人组从哪里来？从临床诊断来。而临床诊断，恰是凭借精准医疗宣称要超越的那套基于症状和常规指标的统计常模做出来的。于是形成一个认知闭环：精准医疗依赖它所超越的旧式诊断，作为训练分子风险模型的金标准；再用模型的输出，去裁决那些尚未满足旧式诊断标准、或旧标准根本够不着的人。它对工程师说：“你的血糖正常，但那只是旧时代的粗糙指标，你的基因告诉我们你是高风险者。”

这套操作在逻辑上并不必然是一场骗局：从流行病学的角度看，评分居于前5%确实对应着统计上显著更高的远期风险。但在认知操作层面，它完成了一次决定性的权力迁移：裁判权的位置，从你还能触碰、能质疑的“血糖值是否越过了那条看得见的线”，转移到了一套你看不到、读不懂、只能仰赖专家解读的“你的基因型是否偏离了那个你不认识的参考序列”。你不再被“人群的平均值”审判，而是被你自己的微观构成，被那些你自己都无法陈述的、深藏在序列里的统计关联，建立了一座永远悬在头顶的个体化法庭。这座法庭比旧法庭更不留情，因为它的每一次数据库更新，都可以把你重新定义为潜在的病人，而你对此没有任何基于自身感受的有效抗辩。工程师手停半秒，并不是因为他被诊断了什么病，而是因为在一条他看不见、却通过消费级基因检测自愿进入的认知流水线上，他身体当下的状态已被宣布为“不能作为最终依据”。康吉莱姆所说的那种在具体处境中自己创造健康秩序的规范能力，在这次检测、这片药、这一瞬停顿里，被无声地征用了。这就是抵押合同的底色。

– （三）让权失败：以赋权的名义完成征用

底色还不是抵押的结构本身。抵押的结构性力量，在于它开出了一个自己无法兑现的承诺，并让人在每一次试图兑现时陷得更深。本章把这一机制称为让权失败。

要看清它的位置，先要看它所站的批判传统。从伊里奇1975年的《医学的涅槃》对“医源性疾病”的分析，到此后几十年医学社会学对家长式医患关系的批判，传统医学批判诊断的是同一个方向的问题：医学越界了。医学本该只管理生物层面的病灶，却越出边界，从病人手里夺走了对自己身体、病痛、衰老与死亡的解释权和处置权。它的核心句式是：医学说了算，你说了不算。它的药方也清楚：让医学退回自己的边界，把权力还给社会和个体。精准医疗的出场叙事恰好站在这条批判的延长线上，并反手把它翻转：对，旧医学太粗暴，把你当成了

统计数字；现在不这样了，我们为你找专属于你的分子层面的健康答案，我们不是越界的家长，而是帮你认识自己的翻译器。这句承诺是精准医疗赢得社会合法性的根基。

然而履行这句承诺的底层操作，却令一件微妙而不可逆的事发生了。要为你找到“专属于你”的答案，就必须先把你的身体交给运行在体外的算法去解析，这一步不是精准医疗的疏忽，而是整个现代生物医学知识生产体制的认识论要求。十九世纪以来，生物医学之所以能积累可重复、可验证、可传播的知识，正因为学会了一件事：把完整的、活着的、在具体处境中持续自我调节的生命体，在认知层面转化为可度量、可分割、可比较、可累积的数据单元。临床检验把血流拆成几十项生化指标，影像学把器官变成灰阶像素，基因组学把遗传信息拆成三十亿个碱基对。精准医疗没有发明这个操作，只是把它推到了分子颗粒度的极致。没有这套程序，就没有赫赛汀。本书在此不否认这一点。

问题出在程序的下一步。算法拆解了你的身体数据之后，需要一个参照系，来判断每个拆解件是“正常”还是“异常”。这个参照系不可能是你自己，因为作为整合的、规范性的整体，你已经被上一步的拆解暂时悬置了。参照系只能是拼接自无数他人分子数据、时刻迭代更新的统计模型。你的身体被拆开之后，用来重新拼装成“你的正常”的零件是你自己的，拼装图纸却是别人的。精准医疗许诺把健康的定义权从“群体常模”这个旧权威手里夺过来还给你，可它执行归还程序时唯一能动用的步骤，是先把你的生命拆成碎片，再放进一个比旧权威更不可见、更不可质疑、更随时波动的体外统计系统里重新编码。它要把权力还给你，却先把你的手绑到身后，再把权力的钥匙插进一个必须经由它才能打开的锁孔，然后告诉你：我已经帮你把权力拿回来了。你若说“我不舒服，身体不对劲”，系统回答：“你的数据是正常的，你的感觉需要再观察。”你若说“我感觉很好，想停药”，系统回答：“你的风险评分很高，你的感觉不可靠。”

这个悖论并非某种特殊情形下才触发的漏洞，而是这套认知程序的结构特征。只要基本步骤是“先把生命拆解为可计算单元，再参照群体统计模型重新组装出个体化判断”，让权失败就写在了每一步操作里。它与旧批判范式的区别因此十分清楚：旧范式描述的是越界夺权，让权失败描述的是通过让你行使权利来完成征用。

一个制度性的场景可以锚定这个机制，不过需要先交代它的来源：以下关于英国生物样本库（UK Biobank）的叙述沿用作者的表述，其具体情节未给出文献出处，本章因而将它当作论证性的场景，而不作为经过核验的田野材料。据此叙述，该库在2006至2010年间招募了约五十万名志愿者，做了身体测量、生化检验与基因分型。志愿者签署的知情同意书写明：参与是自愿的，个人不会从研究中直接获得医疗收益，研究人员可能发现“非预期的、意义不明确的发现”。大多数人签字时想的是一种利他而模糊的科学贡献。几年后，一部分志愿者接到遗传咨询师的电话，被告知基因组中发现了一个“意义不确定的变异”，位于已知与某种罕见心肌病相关的基因区域，其临床意义目前没有足够证据判断，可能完全无害，也可能在未来某天被证实致病。咨询师以温和的口吻解释了不确定性，并以“审慎建议”的方式提出：可以考虑每两年做一次心脏影像学检查，动态观察心肌结构。

在这一刻，这位当初为“做点贡献”而签字的志愿者，收获了一样他从未申请过的东西：一笔不确定性的终身债务。他在法律上没有被强制接受任何建议，理性也在告诉他，“意义不确定”的意思不过是目前不知道。但他的日常经验已经被这条信息改变了。他还能像以前那样，在感到一阵胸闷时对自己说“最近加班太多”吗？他不能了。不是理性不让他说，而是那个悬浮在基因报告里、既无法证实也无法排除的变异，已经成了每一次心区微小异感面前一道必须专门对付的认知关卡。他得拿出更硬的证据，最好是一份正常的超声心动图，才能驳回那个他从未签字、却已被系统默认生效的猜想：也许这一次，不是加班太多。

系统没有越过任何边界。它站在知情同意程序的边界之内，用最科学、最合乎伦理规范、最充分告知的语言，给了他一个“选择”。选择的结构是：无视这个变异，意味着主动拒绝“科学在试图保护他”；接受审慎管理建议，则意味着主动把自己签进一份以不确定性为利率的终身监测合同。没有强迫，只有两份文件同时摆在面前：一份是“你是被赋权的生物公民”的身份证书，一份是“你同意把未来的心脏感觉存入我们的数据库作为担保物”的默示条款。他用同一支笔，在同一个签名动作里，同时签下两份。让权失败区别于越界夺权的核心就在这里：它是通过让你行使权利来完成征用的。

这种征用对应着一种与第五章呼应、却落在不同层面的机制（见第五章）。第五章说的是，身体决定下一个稳态的资格被技术与制度复合体代理行使；本章说的是，在这一资格之下更日常的一层，即个人对“此刻我怎么样”的裁定权，同样被要求先行交存。前者是对“往哪里去”的代管，后者是对“现在在哪里”的代管。两者合起来，一个人既不再被允许自己决定要去往何处，也不再被信任能够自己报告身在何处。

◆ 三、把风险变成债务：工程师的三年与被抵押的自我

– （一）一条把统计风险转译为道德义务的流水线

底色还不等于抵押。从“被提供一个认识自己的新工具”，到“我感到必须定期使用它，否则就是不负责任”，中间不是一步跨过去的，必须有一条把统计上的风险概念逐渐转译成日常生活中的道德义务的流水线。许多人正在这条线上走，工程师是其中一个可以被清晰看见的样本。

第一年，拿到写着“前5%高风险”的报告，他当初的反应不是恐惧，而是一种被搭救的庆幸：多亏了科学，能在什么都没发生的时候就看见将来可能发生的事。他开始服药，开始三个月一次的血检，开始用手机应用记录每日步数、睡眠时长和每餐的碳水克数。他的身体感觉并没有变，晨跑仍然带来同样的清爽，

睡眠仍然黑甜深沉，饱餐之后的午倦仍然在吃完那碗面二十分钟后准时袭来。但一种以前没有的审查意识开始渗进他对这些感觉的体验里。晨跑后的精力充沛，是运动的好处，还是“药物在帮我压住某个我自己感觉不到的东西”？晚上十一点犯困，是正常的生物钟，还是“胰岛素抵抗引起的餐后反应”？每当感觉到什么，他就不得不在心里引证一条数据记录，为这个感觉做担保。担保暂时还够，因为数据暂时还好。

第二年，每逢冬天，他会出现一种在病友社区里被叫作“空腹高反”的现象：早上起来不那么饿，甚至有点恶心。社区医生说没关系，指标还好；基因咨询师说这个信号需要关注，高风险人群要格外重视生活方式调整。他的身体给出的信号，第一次与从外部收到的解读发生了错位。他醒来觉得还行，可记忆里那个被植入的标签，让他必须专门花三十秒在心里做一次判决：今天是正常的困，还是“高反”？这三十秒，就是抵押品被提取的时刻。每当他停下来，把自己的身体感觉当作需要被审查的嫌疑人，他的内感受裁决权就在一个完全私人、无法被任何人从外面看见的微型法庭里，被自己判给了自己一刀。他还没有不信任自己，他开始怀疑自己了。

也是在这一年，他经历了第一次完整的让权失败。他试图用对晨间身体的整体判断，“我觉得还行”，去对抗那条关于“高反”的外部警告，却发现手里没有在认知上与之等价的筹码。“觉得还行”是模糊的、无法量化的、没有统计显著性的东西；而“高风险人群应关注空腹不适”是一条有基因评分背书、被专业咨询师口头确认的正式建议。他的内感受在此刻被宣告为劣后级资产。宣布者不是医生，而是他自己，在内心那场三十秒的微型审理中。

第三年，他的糖化血红蛋白上升了0.1个百分点，仍在正常范围的正中央。但这个数字对他已经不是对旁人的那个小数字。医生依然说没事；基因咨询师建议考虑每半年加做一次空腹胰岛素测定，以便更精确地评估β细胞功能储备；妻子在网上读了一篇关于糖尿病前期逆转的长文，开始担心他的饮食；母亲每次来

电都要问血糖怎么样。他每次都说：都好，都好。他说的是实话，指标确实好。但他已经想不起三年前那个不需要用“指标好”来为自己的健康辩护的自己是什么感觉了。他的健康现在有了一张对外的、数据的面孔；那张对内的、感觉的面孔还在，却已收缩成一种只供自己在夜晚临睡前，把手机里的健康管理软件刷到最后一个指标都看完之后，才敢短暂相信的东西。

三年里，他一次也没有生过病，所有临床指标正常得像教科书里的示例。但他已经从一个拥有身体自我信任的人，变成了一个管理健康债务的人。他的抵押品，即那个曾经完整的“我感觉好”，尚未耗尽，却已从一笔可以任意支配的、不能分割的整全资产，被切成了无数必须在每次血检、每次评估、每次与家人谈健康时重新估值、重新抵押的碎块。他没有被骗，没有愤怒，甚至对整个系统心怀感激。他只是渐渐想不起来，那种不需要任何数据担保就能稳稳地对自己说一声“我挺好的”的感觉，究竟有多重。

这个故事里没有任何戏剧性事件，没有耐药，没有误诊，没有医疗事故。这正是健康抵押最典型、也最容易被忽视的发生方式：它不是闯入，而是通过一套把风险评估翻译为道德责任的日常话语，在每一次常规随访、每一条健康管理推送、每一回饭桌上的关心询问中，一寸一寸地把身体自我裁定权挪到体外数据系统的那一边去。风险本身是一回事，把风险变成终身债务是另一回事，后者需要一个道德化的转译器。精准医疗提供的这套转译器，是整个抵押系统中最不能忽视、又最不被当作问题的部分：它让人不是因为生病才去找医学，而是因为负有在还没生病时就持续管理“将来可能生的病”的道德义务。这不叫预防，这叫把一个人的活着本身，变成一笔永远在还款的按揭。

这里有必要为“预防”一词保留它的正当含义，免得批评被读成对一切前瞻性医学的否定。疫苗、血压筛查、对确有强证据的高危人群的早期干预，在人类健康史上有确凿的功绩，本章无意质疑。被质疑的是转译这一步：当统计风险不经任何中间环节，直接成为对个人感受的优先裁决，成为每天必须履行的义务，

并且没有一个“到此为止”的终点时，预防就从一次性的、有边界的行动，变成了持续的、无边界的状态。

（二）三级分级：内感受如何被判为劣后

这条流水线对内感受判断力的打击，不是一次性的窃取，而是一轮持续的、日益精密的三级分级。

第一级，是切割。把整全、连续、不可拆解的内感受状态流，在认知层面切成上万个可分别评估的风险单位：血糖、血压、睡眠时长、心率变异性、肠道菌群、几百个位点，每一个都从整体的“我感觉怎么样”里被挖出来，单独安上一个数字。第二级，是评级。分子数据、生化指标、影像报告被定为优先级资产，因为它们精确、可量化、有统计显著性，在健康判断出现分歧时，有权优先得到全额偿付；而主观的综合感受，“我觉得很累”或“我觉得很好”，被定为劣后级，模糊、不可入库，发生争议时处置权排在末端。第三级，是内化。这套分级制度通过无数次临床就诊、基因咨询、在线风险计算器的互动，在日常生活中被反复执行，最终成为当事人自己的认知习惯。优先级数据说“你的血糖正常，未检出致病突变”，你的“我觉得很累”就被排到决策序列的最后，得不到回应；优先级数据说“你的评分在前5%，是高风险”，你的“我觉得很好”同样被排在最后，被驳为劣后级的假象，并由此触发要求追加保证金的指令：开始服药，开始定期筛查，开始生活方式干预。

以这三级分级为尺子，再来看工程师第二年冬天的那个早晨，就能看清它是怎样在他私密的日常认知中完整地执行了一遍。他的内感受，“我觉得还行”，在他自己的内部法庭里，依据那套体外数据的优先级规则，被判为不可靠。没有谁命令他这样做。是他面对“高风险人群应关注空腹不适”这条优先级指令，自愿选择相信了指令而不是自己的感觉。他亲自完成了对自己身体主权的做空。日积月累之后，他失去的不再是对某一个具体身体信号的信任，而是一种更深的本

事：安稳地住在一个不需要外界证据撑腰的身体里的那口气。他每天盯着健康管理应用的每一个数字、直到最后一条显示绿色才敢松一口气的习性，已经重建了他栖居于自己身体的方式。他已经从自己身体的主人，变成了自己身体的审计员。

内感受在此并不是一个文学式的、模糊的概念。它是遍布免疫、神经、内分泌、筋膜与内脏器官之间、不断整合海量微量生化信号的网络，“舒服”是这个系统给出的一份高度凝缩的整合报告：此刻能量配置均衡，免疫应答平稳，代谢节律协调，你可以安全地去做事。把手背贴上孩子发烧的前额，温热的触感，加上在一秒内对她眼神、呼吸、挣扎方式的全部综合观察，让一位母亲通常做出比温度计更准的判断：“烧得不高，精神还行，再观察一下。”这就是内感受的裁决。它当然会出错，在某些隐匿的疾病面前会沉默，在某些急性状态下会被暂时扰乱，本章从不主张它是无谬的。但它是一个人能够作为不再需要持续外部审计的主体去行动、去决定、去为自己的生命承担风险的根基。对这个根基的抵押，因此不是对某一项判断的让渡，而是对“能够自己判断”这件事本身的让渡。

– （三）与“病患角色”的区别

这种抵押状态必须与传统临床医学中的“病患角色”严格区分。病患角色是暂时的，有剧情终点：当事人为了治好一个明确的、被感觉到的病痛，把一部分自决权暂时托付给医生，目标是康复，合同的到期日是病愈或死亡。健康抵押没有这个终点。它不是因为你已经生病才找上你，而是在前病阶段就进入生命，在身体还没发出任何一声痛叫的时候，就把它标记为一份未来可能违约的风险资产。你没有“病了”这个触发条件可以拿来做切割，签下的是一份永不到期的开放式合同。身体不再是被医学修复的对象，而是被一套数据系统终身管理的抵押物。医学也随之从回应痛苦、修复功能的古老手艺，悄然变成终身评估抵押品价

值并定期收息的估值机构：它拯救你，并不是为了让你离开它，而是为了让你更需要下一次拯救。

这一区分与母题的第三步直接相连。病患角色之后，人是要回到自己的生活里去的，他重获的是原来的自决；而判断层的替定没有“之后”，它持续得越久，那个本应在日常里不断运转的、对自身状态的整合性判断，就越是因不被使用而退化，越是因不被采信而羞于开口。到了工程师那样的第三年，即使有一位医生郑重地告诉他“你完全可以相信自己的感觉”，这句话也已经不能轻易地复原什么：被撤回的只是外部的要求，被损耗的却是内部的习惯。

◆ 四、成功即违约：靶向治疗的逆向贴现与救命的门面

– （一）从最成功的地方进入

如果说在工程师那样的“未病”地带，健康抵押是以缓慢的、日常的、被温柔地植入生活节律的方式执行的，那么在精准医疗最引以为傲的阵地，肿瘤的靶向治疗，抵押则以更集中、更尖锐、也更难从现象上反驳的形态展开。这里是英雄叙事的核心。赫赛汀，奥希替尼，T-DM1，DS-8201，这些药物的名字本身就是一套科学战胜疾病的史诗。本章不否认它们的确凿，而必须从这种确凿的内部，追踪抵押机制嵌入其中的方式。选择这个入口是有方法上的理由的：只有在技术最成功的地方，“每一次成功都在制造下一次更深的抵押”这一结构，才可能被剥离掉任何关于技术失败的辩护、任何“还不够好”的期待，而显现为这套认知操作自身固有的逻辑走向。

HER2阳性乳腺癌是写进现代肿瘤学教科书的胜利。上世纪八十年代，研究者在约五分之一的乳腺癌患者体内发现了一个被异常放大的分子开关：HER2这种表皮生长因子受体持续向细胞核发出分裂信号。因果链清晰得令人屏息，于是一把精密的钥匙，曲妥珠单抗，被造出来，专门堵住这个被异常放大的锁孔。随后的随机对照试验显示，接受一年曲妥珠单抗治疗的HER2阳性早期乳腺癌患

者，十年复发风险降低了近一半。这不是小数字，这些女性的存在是确凿的。任何讨论精准医疗困境的论述，都必须首先站在这些被救活的生命面前承认这一点，否则就只是没有肝胆的哲学空转。

但临床医生很快在庆祝声中听到了另一种信号。在平均用药约十二到十八个月后，一部分患者的影像上开始出现新的、细微的阴影。癌细胞没有在赫赛汀的火力下集体投降，而是像一支遭到重创但未覆灭的军队，发起了极精密的应急重组。在被选出来的耐药克隆里，有的上调了HER3或IGF-1R等旁路受体，门被堵死了，它们撬开了旁边一扇此前没有注意的窗；有的出现了PIK3CA或PTEN的突变，直接在HER2信号通路下游的某个节点把增殖指令重新接通，你不让上游传话，它们就打内部直拨；还有的干脆经历一次表型转换，丢掉HER2扩增这个靶子，变成一种更原始的、不依赖HER2信号也能存活的基底样细胞。

精准医学共同体的回应是教科书式的：找出新靶点，造出新一代钥匙。T-DM1来了，一种把化疗药精准送入HER2阳性细胞内部的抗体偶联药物，对一部分赫赛汀耐药的肿瘤有效。随后，对T-DM1也耐药的肿瘤被发现携带新的突变，DS-8201来了，更强的抗体偶联药物。在非小细胞肺癌领域，同样的故事在EGFR靶向药上被完整重播：第一代吉非替尼耐药后，人们在超过一半的耐药者体内找到了T790M这个“守门员”突变，第三代的奥希替尼被火速开发出来，精准抑制它；奥希替尼耐药之后，C797S突变、MET扩增、甚至组织学上转化为小细胞肺癌的耐药机制又被逐一命名，第四代、第五代的候选分子已经在管线上排队。在官方的科学传播里，这被描述为一场英勇的“打地鼠”：疾病每冒出一个新头，科学就挥出一记更精准的锤。仅从生存期延长的角度看，这个故事没有错。可把健康抵押的视角放进去，同一段情节就呈现出另一种结构。

（二）逆向贴现：一份合同履行之时，就是下一份更高利率的合同必须签署之时

设想这位HER2阳性的患者，在确诊时签署了一份她从未细读、却被整个医疗系统默认她同意的合同。合同的条款是：给你赫赛汀，帮你把肿瘤压下去。但这份合同只覆盖已知的、由特定分子开关驱动的肿瘤细胞，覆盖不了体内本来就存在、却不占主导的那些不依赖HER2信号的少数派细胞。在赫赛汀施压的这段时间里，这些少数派因恰好处在那个靶向药的射程之外，获得了选择优势，安静地扩增成新的多数。因此，当患者完成疗程、影像显示可见病灶消退时，她的身体实际上已经在为下一轮更复杂的治疗需求做生物层面的储蓄。这一次被抵押的，不是她的内感受，而是她的下一次治疗窗口。

当耐药出现时，系统并没有违约。它完全履行了上一份合同的每一个字，对HER2阳性肿瘤细胞做了精准打击。但在履行的同时，它为她签下了一份新的、利率更高的附属协议：需要用T-DM1了。T-DM1也履行了字面承诺，然后同样的演化压力催生下一轮耐药。这不是“打地鼠”，而是一个每一次成功履约都必然造出下一次更难履约的债务结构。赫赛汀并不是没有治好她，它只是让她获得了一段延长的时间，作者以“二十个月”来描述这段时间。这个“只是”并非对赫赛汀的轻蔑，而是对这一类靶向疗法整体运作逻辑的诚实描述：它们以一种可以被医学文献宣布为“显著改善无进展生存期”的方式，帮助压下一部分肿瘤，同时在演化压力下，对体内肿瘤异质性打了一针高效的筛选剂，培育出了下一批更难对付的细胞。

这个过程中最不容易被看见的，不是技术创新跟不上耐药，而是这套连续成功的治疗流程，在多大程度上把“治愈”这个词悄悄从医患共同体的心里拔除了。作者引述了肿瘤学界内部的公开反思，并特别说明这是借用一种在专业博客与访谈中可以找到共鸣的声音，而非某一句可以精确追溯的原话：有临床肿瘤学家写道，在几次三线治疗之后，他注意到病人不再问“这个能治好吗”，而是问“下一个药什么时候能批下来”。转移性肺癌病友社区里，有一个标题为“等

第四代”的讨论串，同样是作者的描述：帖子里没有人抱怨科学太慢，所有人都在精确地追踪最新临床试验的入组标准、分子通路和初步有效率。他们成了一群比大多数执业医师更了解前沿药物分子机制的专家型患者。他们不是在等待治愈，而是在管理一个持续更新的治疗组合，用一种训练出来的、高度理性的、令人心碎的冷静，计算每次换药可能争取到的无进展生存月数。奥希替尼临床试验的主要终点，早已不是治愈，而是无进展生存期。这不是因为医生不想要治愈，而是这套逻辑内部本身不产出治愈。它产出的是连续的、永不终结的、每次都暂时压制又为下一次反弹积蓄力量的按揭式延长。它让人活得更久，久到足够付完这一期的利息，并拿到下一期的贷款。

这里有必要说明，靶向治疗的逆向贴现与工程师故事里的内感受抵押，是同一个结构在两处的显现，而不是两个无关的话题。在工程师那里，被存入体外的，是对“此刻我好不好”的整合判断；在肿瘤患者这里，被存入的，是对“我已经好了”这一终局感的拥有。每一次复查前的失眠，每一次非要看到CT报告上“未见明确复发征象”才能松一口气，都是这位患者的“我好了”被一份份随访报告代为背书的时刻。治疗越成功、随访越精密，“我好了”能够不经报告而自行成立的机会就越少。成功不仅没有把她带回到不需要担保的状态，反而把担保的频率制度化了。

遗传检测领域呈现同样的形状，只是本章的材料主要来自作者的提示性表述，不再展开：BRCA检测之后被建议预防性切除乳房的女性、APOE ε4检测之后活在阿尔茨海默恐惧里的高风险者，以及永远等不到下一个有效靶向药的耐药患者，在作者的叙述里，与被赫赛汀拉回的那一部分人处在同一套系统的不同位置上。检测预防了癌症，这是一种成功；检测之后，当事人从此在“可能的将来”面前终身待命，这是同一次成功所携带的账单。

（三）救命成为门面：对最朴素质问的回应

至此，本章已经论证：健康抵押不是技术失败的后果，而是精准医疗认知操作自身逻辑在成功之路上的内生产物。但这一论证必须经受一个最朴素、也最沉重的声音的质问，它甚至不必是论证，只需要一句话：“但赫赛汀救了她的命。”

是的。当那位HER2阳性的女儿、妻子、母亲在确诊时被告知只需要打一年的赫赛汀、十年复发风险降一半，并且她确实活到了能陪孩子小学毕业、甚至走进中学开学典礼的时候，没有人有资格对她说：“与此同时，你正在被抵押。”本章没有任何东西可以拿来说这句话，也不打算拿。那些活下来的、延长的、能被亲吻和拥抱的年岁，是确凿的，有重量，有面孔。任何论述若不首先站在这些面孔面前，都不配被认真对待。赫赛汀救了她的命，这一事实的每一笔都成立，并且永远成立。

但需要注意精准医疗这一系统在构造自己的公共叙事时做了什么。这不是一个意外发生的动作，而是一个被利益高度汇聚、反复执行的结构性动作：这一个确凿的成功个案，在整体上被变成了一张门面，为一个对多数人（包括那些BRCA检测后被建议预防性切除乳房的女性，那些APOE ε4检测后活在阿尔茨海默恐惧里的高风险者，那些永远拿不到下一个有效靶向药的耐药患者）提供终身健康债务管理的系统，提供信用担保。它不是在骗人，它确实救了她。可这件确凿的被救事件，在整个庞大的分子监控架构里，被当作一张用来继续吸引社会资源、舆论支持和公共医保覆盖的面额巨大的支票，支票的核心话术是：“它已经救了人，你的问题只是还没轮到。”用一部分人的成功清偿，为系统对其余多数人的终身抽息背书。作者在此给出了“20%对80%”的说法，这一比例是对话术的修辞性概括，不是经过统计核验的数字，本章在使用时仅取其论证意义。

因此，需要同时做两件事，而不是在二者间选边。一是为每一个被赫赛汀或奥希替尼从死亡线上拉回的个体，感到不附任何条件的庆幸。二是在此刻拒绝让

这些庆幸抽走检视系统整体运作逻辑的资格。正是因为珍惜每一个被救活的生命，才不能再容忍现行的运转模式把少数的清偿当作遮掩多数债务的幕布。错的不是欢庆，错的是把欢庆当作拒绝向多数人交代的挡箭牌。这也是本章与简单的技术批判最根本的区别：本章不站在技术的对立面，不在拥抱与拒绝之间选边，而是要诚实地看见，抵押合同的条款，已经被刻进精准医疗认知操作本身的逻辑里了。

◆ 五、抵押品的三维贬值：从“帮忙”滑向“收房”

个体层面的每一次征用，同时也在整个系统的资产池里，减值着维持这套系统自己继续运转的底层资产。这一减值在三个维度上同时进行，它们不是三个平行的项目，而是同一笔资产被从三个方向反复压价，三方压力相互喂料，构成一个下降的正反馈。

第一个维度是现实可及性的级差。精准医疗的运转依靠极其昂贵的基础设施：测序仪、生物信息集群、海量变异数据库、能够解读报告的遗传咨询师。在可预见的未来，有能力定期获得分子健康数据报告的人仍是人群中的少数。这意味着健康抵押实质上是一份从一开始就只在特定经济能力以上的人群中才能被完整签署的合同。拥有定期分子扫描与风险预警的人是“优质抵押者”，他们付出金钱与时间，把身体信任存入系统，换取精细监控。无法触及这套系统的人，并不因接触不到就免于被抵押：他们同样被那种“分子数据才是深度的健康判断”的叙事覆盖，只是被归入“次级抵押者”。他们手里那份对自己身体的基本信任，虽然没有在体外数据库里兑成任何序列，在社会整体的认知评价里却已被宣布为未经审计的不良资产。你感觉自己挺好，但被告知，那是因为你的身体还没被以足够高的分辨率照一遍。

第二个维度是公共叙事的信用降级。精准医疗向社会争取持续的制度支持与公共投入，靠的是一套宏大叙事，这套叙事在人类基因组计划完成前后、在

2015年奥巴马国情咨文宣布精准医学计划时达到顶峰，等于向公共领域签发了一张债券，利息是公众的投票、纳税人的拨款、监管的绿灯，以及对医疗体系逐步涨价的高度容忍。这张债券需要定期的“兑现事件”来维持信用评级。抗生素之于细菌性肺炎那种一锤定音的精准、疫苗之于脊髓灰质炎近乎绝对的压制，是最高级别的兑付。但精准医疗在其覆盖面最广的疾病版图上，2型糖尿病、高血压、抑郁症，交出的主要是海量的生物标志物与候选靶点，以及一场接一场以“未达到主要终点”告终的三期试验。每次大型失败，激起的不是公开反感，而是对当初被点燃的终极期待的一点点稀释。一次不兑付不要紧，三次也可承受，但二十年间反复听到“突破”之后紧跟着“但还早”，社会整体就会默默把这张未来债券的评级，从最高级调到高收益债。你还会听，还会关注，但已经不再指望它把你彻底治好。

第三个维度是身体主权的系统性做空，它是三重贬值中最根本、最不可替代的一项，其损坏方式在工程师与HER2患者的故事中已经完整看到，这里只需点出它与前两重的螺旋关系。精准医疗之所以能维持上述两重估值的运转，是因为它在全社会范围成功做了一笔精妙的套息：以无数张风险报告、无数次预防性服药、无数条“你的感觉需要被数据确认”的制度化日常，持续向社会供应一个信号，你的身体感觉是不可靠的劣后级资产，而分子数据是值得优先偿付的优质资产。当足够多的人接受了这个信号，就等于他们把自己手里名为“我感觉我好了”的原始股，在一个被系统指定的市场里以不断走低的价格抛售了。这笔被贱卖的资产不会被销毁，它会变成系统发放下一轮抵押贷款的头寸。

三者的螺旋关系是这样的。理念层面的降级，“它终究没法治好我”，削弱了公众对可及性投入的政治支持，收紧了现实层面的天花板，“既然治不好，为什么医保要花这么多钱”。现实层面的收紧，让大多数人被固守在次级抵押区，不断收到“你的自我判断尚无资格进入最终裁决”的制度信号，进一步压低了自我估值。而自我估值越低，人们越不相信自己的身体感觉、越把全部判断权外包

给数据，整个医疗系统就越要处理由此激增的健康焦虑与过度筛查需求，这又加大了现实成本的压力。这个正反馈一旦跑起来，系统为自身运转所投入的成本，就开始系统性地毁掉维持它运转所需的底层资产，就像一家银行为了支付越来越高的利息，不得不不断拍卖当初收取的抵押品，导致抵押品市价不断走低，直至折尽。工程师手机里每季度催促他更新风险评分的那个应用，就是这把不断重新估值的微型拍卖槌。

抵押品净值归零的那一天，金融系统会启动止赎。在健康抵押的情境里，这个程序不会收到一封挂号信，不会被任何机构盖章，它将以大规模、沉默、难以追踪的个体退场方式发生。当足够多的人，在几十年的风险监测、没有结论的报告、不断被推高的焦虑和反复的失望之后，在某个不加宣告的早晨，对自己说一声“我不续了”，他们不再追问“数据说我没病”这个谜，只是不再登录那个应用，把还剩半瓶的二甲双胍放进抽屉，走出了门。他们没有呐喊，只是退出了一个向他们允诺健康、却只让他们还债的认知系统。当这种退出达到临界，精准医疗那座耗费巨资建立起来的早期预警与全员筛查的大厦，将面临一个“敌人并不存在”的滑铁卢，因为它的全部技术都建立在一个它默认所有人都会永久保有的同意之上：“我愿意管理那个我自己可能根本感觉不到的潜在疾病风险。”这个同意在被收房的人心里，已经悄悄撤销了。

需要提醒的是，这一段所描绘的“退场”是一个有条件的推演，不是已经被观察到的普遍趋势，本章不据此作任何预测，仅用它来说明：这套系统赖以运转的，恰是它在日常中不断消耗的东西。它对信任的依赖与对信任的损耗，出自同一个动作。

◆ 六、与最近邻的分离线

一个新命名若不集中面对最可能吞掉它的既有概念，读者便无从判断它是否只是换了个说法。本节依次面对六个近邻，并为每一个给出一条可裁决的分离线，即一个能让两套框架做出相反预测的观察格。

– （一）伊里奇、福柯、罗斯：三道裂缝

伊里奇早在半个世纪前就说过，现代医学在制度上剥夺了人们自主处理病痛与衰老的能力；福柯显示了身体如何在“看—知—说”的制度中被制成不可见的真理对象；罗斯分析了当代个体如何被基因风险知识形塑为积极管理自身生命的“生物公民”。它们各自准确，也都覆盖了本章讨论的某些领域。

先看伊里奇。一个接受了基因风险筛查的普通人，戴着智能手环、定期抽血、在手机上记录每餐碳水，用伊里奇的眼睛看，他是被医学体制剥夺了自主判断的能力；但他自己的第一反应不是“我被管了”，而是“我对自己负责了”。他是自愿下载那个应用的，没有任何医生强迫他测多基因风险评分，伊里奇预言的那种因医学扩张而激起的“社会性反叛”没有出现，相反他主动把自己抵押了。更深的分歧在于，伊里奇的核心概念“结构性反生产性”恰是健康抵押的远祖，而不是对立面。伊里奇论证的是：制度逾越某个临界阈值后，其增长不再产出原初许诺的价值，反而系统性地损害它。他追踪的是宏观制度的增长如何在拐点之后由“解决问题”逆转为“制造问题”；本章追踪的是这种反生产性如何不再需要宏观制度的“越界”，而是被以“赋权”为名的认知操作程序直接植入个体理解自身身体的每一个微观动作。伊里奇看到的是高速公路修得太多；而这里是导航软件在每次出门时温柔地说：“你对自己的方向感不可靠，请打开定位。”伊里奇的反生产需要制度先膨胀到拐点，健康抵押的内部反生产从签署知情同意书的那一刻就已运转。因此，伊里奇是本章尚未被官方承认的直系来源，续写他，而不是与他划清边界，是最诚实的交代。

再看福柯。工程师持续监控三年后，开始逐渐丧失无须看数据就能确认自己状态安稳的能力。他不是被“医学凝视”从外部制成病理对象的病人，他没有病；医学凝视需要的是一个不透明的身体，表面是症状，深处是待发现的病理，而他的身体在数据化管理的三年里完全透明，血糖轨迹在手机里，睡眠分期图在云端。凝视不是从医生的眼睛射来的，而是他打开屏幕时，从那个发光平面反射回来的自我监控的光。福柯的凝视，是把你看成你原来不是的东西，一个病理个案；自我监控的界面，却是把你看成你原来是的东西，一堆可量化的生理参数，然后温柔地告诉你，这才是你。前者是破拆，后者是无声的置换。福柯式的反抗，拒绝被凝视、拒绝被命名，在这张发光的屏幕上没有着力点：对着一串温柔地为你提供健康建议的数据说“不要凝视我”，自己听来都荒谬。

最关键的一刀对着罗斯，因为他的“生物公民权”几乎是贴着精准医疗的核心叙事长出来的，也最能吸纳本章的论证。生物公民围绕共享的基因变异组成病友团体，向药厂与监管部门争取试验权利，是积极参与自身生命治理的主体。这没有错，而且健康抵押恰恰依赖这种积极姿态：它不靠强迫，靠的是提供一个“你对自己负责了”的身份，让人自愿进入流程。没有当事人的主动，整个抵押流程跑不起来。本章为罗斯补上的是一个未触及的主体性内面：这份赋权，在个体最私密的认知层面，是以什么为代价来维持的？当积极争取试验权利的生物公民，每晚打开应用、划过一行行风险评分、确认“暂无异常”才能安心入睡时，他正在自己的内部法庭里，把对身体的内感受判断权，当作一笔抵押物存进那个给他赋权的平台。他越想当好生物公民，签下的抵押合同就越深。这不是赋权与失权的外部对立，而是赋权内部内嵌的一笔债务，是赋权过程在运行到微观认知层面时，必然长出来的一笔追加分录。

三道裂缝翻开后，三个旧框架最锋利的楔子都咬不到的位置显现出来。它不是一个静态的位置，而是一个在每一次赋权操作的认知程序之中运转的逆向征收过程。旧框架并非不够聪明，而是工具箱里没有一把尺子，能够量度发生在“我

感觉”与“数据显示”之间、那三十秒微型审理里的主权转移。这把尺子就是本章的控制变量：内感受判断力在个体认知裁决中的征用优先序。伊里奇分析权力如何从外部挤压，福柯分析凝视如何把你制成知识对象，罗斯分析主体如何被形塑为参与治理的公民；当权力以“这是你的权利”的面孔出现时，你如何在行使权利的过程中，同时把最根本的一笔个人资产放上了体外数据系统的抵押台，三者都恰好掠过了这片认知操作的内部地带。

– （二）自创生、内感受的预测加工、医学化

另有三个近邻，覆盖风险同样很高。

其一，自创生。马图拉纳与瓦雷拉在《自生成与认知》（1980）中给出的自创生，指的是活系统由一张组分生产网络构成，网络的运作不断再生产出网络自身并划定自己与环境的边界；它在结构上对环境开放，在组织上封闭，环境只能触发它，不能指定它的下一步。这是“生命自行生成并维持自身秩序”这一命题的正式命名，本章不处理它，就等于在已立了牌子的地方重新插旗。分离线是：自创生守的是组织同一性，只要系统还活着，组织就保持不变，变的只是实现该组织的结构；本章追的是承重节点的更换。作者以靶向治疗的耐药为例：EGFR信号被阻断后，改用T790M，再改用C797S，再改用MET扩增；这些不是同一组织的不同结构实现，而是组织本身被重写了一次，而系统没有死。可裁决的判据是：取任一慢病或耐药演化过程，在扰动前后分别标定系统关键承重节点的集合及其依赖拓扑。自创生框架预测拓扑在系统存活期间保持不变，变的只是节点的物质实现；本章预测拓扑本身被替换，扰动后的承重节点集合与扰动前的交集可以趋近于空，系统照常运作。若观察到的始终是前者，则这一论点可还原为自创生的医学应用，命名冗余。需要指出，这一条主要关涉本章的靶向治疗一节，对内感受一节只是间接相关。

其二，内感受研究的现成解释。内感受已有成熟的神经科学框架：克雷格（2002）给出了解剖通路，巴瑞特与西蒙斯（2015）的内感受推断模型主张，内感受是一个预测过程，大脑用先验预测身体状态，并以误差更新。这一框架足以解释本章的现象：持续的外部数据供给，等于不断替换先验的来源。分离线是：预测加工框架里先验来源可以自由替换而功能不变，本章主张替换本身带来不可逆的功能损失。判据是撤除外部数据供给后，测量内感受准确度（如心跳计数任务）的恢复曲线。预测加工框架预测，先验来源切回内部，准确度在数周内恢复；本章预测恢复不完全，且残留的差异与抵押年限相关。这项任务廉价、标准化、可立即执行，本章的核心主张在它面前可以被干脆地判定。

其三，医学化理论，即Zola的医学化与Conrad的诊断扩张。它们论证了生活领域如何被逐步纳入医学管辖、个体判断如何让位于专业判断，是本章最容易被归并进去的传统。分离线是：医学化讲管辖权的扩张，本章讲交易的自我拆台结构。在医学化框架里，个体让渡判断权，换取专业照护，这可以是一笔划算的交易；本章指认的特殊条款是，这笔交易的每一次成功履行，都在损耗它宣称要赎回的东西，所以不存在划算的执行路径。判据是在长期接受精准监测、结果始终良好的人群中测量内感受信任度：医学化预测，结果良好者的自我信任不受损甚至提升，因为专业系统兑现了承诺；本章预测，结果良好者的内感受信任同样下降，因为损耗来自履行本身，而不是来自坏消息。这一格是本章与医学化分野的关键。

（三）对金融隐喻本身的自省

在一章以批判“用体外数据替代内感受判断力”为核心的论述中，使用了整套金融隐喻，抵押、利息、本金、劣后级、止赎、收房，来构建核心论证，读者完全可以反诘：你反对用一套体外技术把人的体验拆了重排，自己不正是用另一套体外技术，即现代金融工程，在做同样的事吗？这个质问合法，需要直面。

首先是承重问题。本章叙述的次序，先追踪过程、后给出概念，不是修辞的小花招：工程师的三年、统计循环的分析、让权失败的解剖，都可以用对认知操作与日常经验的纯描述性语言完成，“抵押”一词是在底层机制已被追踪之后，才作为凝缩的命名出现。其次是自我审核：删去全部金融术语，改用描述性语言重写，论证是否仍然成立？回答是成立。工程师在某个早晨停药去跑步，对自己说“我好了”，这件事的结构不需要“赎回”也能描述，就是他在一个具体生命时刻里拒绝再用数据为身体感觉做担保；HER2患者经历一轮轮耐药与治疗升级的逻辑，不需要“浮动利率”也能描述，就是每一次分子靶向压制都在筛选出对该压制不敏感的细胞群，客观上为下一次更难治的状态培育了条件。

既然能脱离隐喻独立论证，为何还保留它？保留的理由不是它完美，而是它有任何纯描述性术语都做不到的认知效果：现代人都知道抵押贷款是什么，知道“你以为是自己的房子，严格说来它是银行的，你只是暂住”的感觉；用这一经验去贴合“你以为身体在帮你感受，其实它已被体外系统重新标记为借款时交的担保品”的体验，其认知效率是可以在伦理上被使用的，前提是使用者知道它在做什么，并且不在它上面偷懒。还要公开一项无法洗脱的指控：“健康抵押”这个锋利的命名，是否也在以悖论的方式执行着它批判的那种“以外部符号系统替代对模糊经验的耐心描述”？读者被这个凝缩概念击中时，是否不再去想象工程师在第二年冬天某个早晨花三十秒审查自己空腹感受的那种具体的、缓慢的、没有名字的艰难？本章只能公开这项指控，并要求读者在被这个概念说服的时候，不要忘记那三十秒里说不出来的东西。那三十秒本身，比任何关于它的凝缩命名都重。

◆ 七、不可估值的飞地、证伪条件与本章小结

– （一）飞地：穿过技术，而不是回到技术之前

被抵押的自我能否不被收走？有没有某种东西，是体外估值系统无法审计、无法分级、因而无法证券化的？有，但它不是一块从未被抵押的净土。设想工程师三年后与家庭医生长谈，选择停药，走出门去跑五公里，到第五公里感到那种不需仪器确认的充沛，呼吸很深，腿上涌着热力。他回不到抵押之前，三年的历史已永久改变了他与身体信号的关系。此刻的“我好了”，是他在抵押史与今日选择之间的张力里重新长出来的，是他仍选择相信那份整合出来的整全报告。这块飞地不更本真，也不是他的本质，只是他的决断，是向前的“继续”，不是退后的“回归”。HER2患者若某个春天傍晚散步时，安静完整地感到了不需任何报告代为背书的“我好了”，也不意味着癌细胞已不存在，她不必否认随访，只是不再把世界抵押给随访报告。那位从未获得精准医疗服务、因付不起检测而被固守在次级抵押区的人，若对自己说“我觉得没有，就不查了”，他的“我好了”具有完全的人生合法性，是不举旗的身体主权宣告。三条路通向同一块飞地：它不是某个指标之下、某种药物结束之后才能划定的生理区域，而是不为任何报告单上的数字所动的主体裁决。

– （二）证伪条件

本章的论断在经验上可被推翻。若出现一种可广泛普及的诊断—监测范式，其日常运作在逻辑上不依赖先行把个体的内感受判断力宣布为“不可靠资产”，并且其长期大规模效用被以“内感受信任度”和“自主健康决策感”为核心指标的追踪研究证实，即使用者相比不使用者，身体主权感显著增强而非减弱，则健康抵押机制被推翻。同时，三条可裁决的预测须经得起检验：结果良好组的内感受信任下降幅度不显著小于结果不良组；内感受准确度的下降与被监测年限正相关，且在控制年龄与基础疾病后仍显著；完成治疗且指标正常的患者中，能够不

诉诸数据而自发说出“我好了”的比例，应随监测密度上升而下降。任何一条不成立，“成功即违约”就只是修辞，而不是机制。

（三）本章小结

本章把母题的第二步推进到了判断层。内感受判断力原是生命自己持续给出的、没有地址的答案；精准的善意以“赋权”之名，先把它降为劣后依据，再要求它向体外数据缴纳担保，每一次成功履行都在损耗它要赎回的东西。至此，替定的三层——叙事、发生权、判断——已经齐了：算法先替人讲故事，系统先替身体决定落点，数据先替人裁定“此刻怎样”。然而替定并不只是被动承受的对象，被瞄准的生命在被命中的那一刻已不再是原来的对象，替定因此注定落空，这是下一章“致密纠缠”要回答的问题：为什么越准越错。

本章参考文献

Canguilhem, G. (1966). Le Normal et le Pathologique. Paris: Presses Universitaires de France. (初版 1943，增补版1966)

Foucault, M. (1963). Naissance de la clinique: une archéologie du regard médical. Paris: Presses Universitaires de France.

Illich, I. (1975). Medical Nemesis: The Expropriation of Health. London: Calder & Boyars.

Rose, N. (2007). The Politics of Life Itself: Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-First Century. Princeton: Princeton University Press.

◆



第　三　编

替得越久：
生命还能长出什么

编　序

替定持续得越久，生命自己摸索、判断、重组与讲述的能力就越萎缩，而替定本身也注定落空。第七章论证，在因果网络高度致密的慢性病里，被命中的靶心已不是被瞄准的那个对象；第八章把问题翻转过来，提出健康的判准应当是溃散之后能否自行重组出可以继续下去的秩序；第九章面对最极端的处境：当能力、记忆、身份都已不在，照护最后要守住的，是不替他把“人的位子”也定掉。

07

第七章

致密纠缠：为什么越准越错

◆ 一、替定预设了什么，又为什么落不到实处

前六章从两个场景走到了这里。在养老照护里，系统在“需求”的地址上寻找老人，看不见老人正在长向哪里，也看不见连老人自己都说不出口的残迹；在精准医疗里，指南的地壳听不见身体的代偿，把它当作故障来打击。看不见之后，系统便抢先替定：叙事被算法先行写好，发生权被技术与制度的复合体代管，“我好了”的判断被押给了体外的数据。三步机制里，前两步已经交代完毕。本章要处理的是第三步中一个容易被忽略的侧面：替定不仅损耗生命、使生命日渐长不出自己的答案，它自己也注定落空。

这一点需要说得直接一些，因为它与本书其余各章的贴合方式略有不同。前面各章讲的是替定怎样发生、怎样得手、怎样一点点掏空被替代者的能力，读者很容易由此得出一个印象：替定是有效的，只是代价太大。本章要拆掉这个印象。任何替定都预设了一件事：存在一个可以被替它定下的固定目标。需求清单预设老人的“需要”是一份可以事先列出的清单，风险预警预设“风险”是一个站在原地等着被拦截的事件，指南路径预设病人有一个可以被抵达的“正确状态”，靶点预设有一个独立于全身网络而存在的、可以被单独命中的分子故障。所有这些预设合在一起，是一幅静止靶纸的图景：靶子在那里，善意要做的只是瞄得更准。

本章要论证的是，在一大类慢性非传染性疾病里，这幅图景在原理上就是错的。每一次精准的命中，都会作为一股强力的新变量进入生命的内部网络，触发一场不可逆的代偿性重组织；于是在下一个时刻被测量到的“靶心”，在存在方式上已经不再是干预前被瞄准的那个对象。替定想替生命定下的“好”，在被定

下的那一刻就已经过期了。这样一来，替定面对的不是一个“得手之后需要付出代价”的局面，而是一个“得手本身就是落空”的局面：越精准，越漂亮地命中，就越有力地推动系统去生成下一个更难命中的靶子。

本章以原发性高血压为锚点展开论证，因为它是全部慢性病里被研究得最细、指南最完备、药物迭代最快的领域之一，如果精准的善意在这里都会落空，其他领域便更不必说。随后本章把同一个机制推到重性抑郁障碍与肿瘤获得性耐药两个机理迥异的场域，检验它能否移植；再以心力衰竭治疗中β受体阻滞剂的初始恶化效应，作为一个直接可见的临床现象支撑。在此基础上，本章把这一判断与最相近的几种学说逐一划界，正面回应两个最强的反驳，提出以“扰动—监测—重稳”取代“瞄准—命中—校准”的干预姿态，给出药物假期与行为实验两个临床雏形，并交代这一判断自身的边界与证伪条件。

读者可以带着一个问题往下读：如果被替定的对象在被命中的瞬间就变了，那么一个替得越久的系统，究竟在替谁定下什么？本章小结会回到这个问题上。需要先说明的是，本章并不主张医学应当放弃药物、放弃精准。降压药、抗抑郁药、靶向抗癌药在当下的救命价值，本章全部承认。本章质疑的是一个更深的东西：把这些宝贵而有限的干预，从“不得已的、临时的、对致密纠缠的局部安抚”，拔高为“最终解决方案”的整体范式；而这种拔高，恰是替定的医学形态。

◆ 二、一个数值的两种身份：高血压的解剖

– （一）弧线与难堪的数字

现代医学最引以为傲的一条弧线，是对病因的持续“向内掘进”：从希波克拉底把疾病锚定在体液失衡，到魏尔啸将其定位于细胞病理，再到科赫的特异性病原体原则，直至人类基因组计划与蛋白质组学的时代。每一个里程碑都在告诉世人，疾病正在被固定在一个更清晰、更实在、更接近“硬核”的层面上。精准医疗是这条弧线的当代端点，它的承诺无懈可击：找到那个独一无二的分子故

障，一个突变、一条异常激活的通路、一个错误折叠的蛋白质，然后用分子级别的工具去修复它。

然而在慢性非传染性疾病领域，这条弧线越往终点推进，临床回报就越偏离它所许诺的未来。以原发性高血压为例，过去六十年间，人们对血压调控机制的认识，已经从模糊的“血管张力”推进到对肾素—血管紧张素—醛固酮系统（RAAS）、交感神经系统、利钠肽系统、内皮素通路、免疫—炎症通路等多个层面的原子级解析。关键的酶、受体与信号分子都被分离、克隆，并在晶体结构中确定了三维构象。从血管紧张素转换酶抑制剂（ACEI）到血管紧张素II受体拮抗剂（ARB），从钙通道阻滞剂（CCB）到醛固酮拮抗剂，药物已更新数代，每一代在药理学上都比上一代更“干净”：靶点更专一，脱靶效应更少，半衰期更理想。

可是有一个数字始终令这个领域难堪。全球范围内，接受抗高血压药物治疗的患者里，血压得到理想控制的比率，半个世纪以来始终在百分之五十以下徘徊。即便在临床试验那种高度选择、严密随访、免费供药的理想条件下，“难治性高血压”（尽管使用了三种或以上不同机制的降压药，包括利尿剂，血压仍未达标）的比例也始终在百分之十至十五之间。其余“有效”的患者，绝大多数需要终身服药，而长期服药本身又在持续制造新的代谢扰动：利尿剂影响糖脂代谢，β受体阻滞剂增加新发糖尿病的风险，钙通道阻滞剂导致外周水肿。每一种“精准”的干预，都在以另一种方式重新搅动它声称要修复的系统。

既有的批评话语反复触到过这个矛盾。还原论批判说，你只关注分子，忽略了整个人；生物—心理—社会模型说，要在生物学之外补上心理与社会变量；系统生物学说，你低估了冗余与反馈，需要网络思维；精准健康的新范式说，不该在病后才瞄准，而应当在全生命周期动态监测、早期干预。这些批评都有道理，但它们停留在同一个层面：建议在现有的瞄准镜上添加更多刻度、更宽的视野、更快的追踪算法。它们从未追问：如果被瞄准的那个“靶子”本身，就不是一个可以从多层生命过程里切割出来的独立实体呢？如果“准”从一开始就用错了地

方呢？本章的起手式正在于此：不是不准，而是“准”错了地方；不是还不够准，而是越准越错。

（二）同一个读数，前后已不是同一个东西

让我们从全世界诊室里每天都在发生的场景开始。设想一位五十五岁的男性，因常规体检发现血压偏高，收缩压155 mmHg，舒张压98 mmHg，被诊断为原发性高血压。全科医生按现行指南开出一种ACEI，嘱咐低盐饮食、适当运动、减重。三个月后复查，血压降到145/92；加一种CCB，又三个月，降到138/88；再加小剂量的噻嗪类利尿剂，又三个月，稳定在126/82，达标。每一步都遵循指南，每一步都有高质量的随机对照证据支持。他将在余生里每日服用这三种药物，定期复查血压、电解质与肾功能，“原发性高血压”这一诊断代码也将伴随终身。这是一个规范而成功的治疗过程，但其中有一件事，只有换一个眼光才看得见：那个被反复测量、被多种药物合力压制到“正常”范围的数值，作为“读数”的身份始终没变，作为“身体信号”的身份却已经发生了根本的改变。

在被诊断之前，这个人的血压读数，是他的整个身体，包括肾脏、血管、心脏、自主神经与内分泌轴，在特定生活处境（工作压力、睡眠剥夺、饮食结构、焦虑状态）之下的一份整体结算。肾脏在长期交感激活下重新设定了压力—尿钠利尿曲线的调定点；血管内皮在慢性炎症与氧化应激中丧失了舒张能力；压力感受性反射在一次又一次的血压波动中被重新校准到更高的阈值。与此同时，他长期的心理应激状态，他自己可能毫无觉察，持续激活交感系统与下丘脑—垂体—肾上腺轴（HPA轴），升高循环中的儿茶酚胺与皮质醇，又在分子水平上反过来强化上述所有改变。他吃下去的高盐食物，不仅直接增加了血容量，还在长期上重塑了血管平滑肌细胞的离子转运机制。这些来自分子、细胞、器官、行为、心理、社会各个层面的力量，在持续的互动里彼此放大、彼此咬合，最终把他的血压“锚定”在155/98这个水平。

所以，这是一个被“发生”出来的稳态。它不是某个单一故障零件造成的机械故障，而是这台身体在特定的运行环境、特定的燃料品质、特定的历史磨损之下，被逼出来的一种继续前行的妥协模式。当医生用ACEI阻断血管紧张素II的生成，他确实在分子层面完成了一次精准的干预：转换酶的活性被抑制，首次给药后几小时内血管紧张素II的浓度应声下降，血管平滑肌舒张，读数回落。但几乎在同一个时间窗口里，这一干预引发的连锁代偿，已经在药物分子根本没有抵达、却被其影响所波及的身体深处悄然启动。

肾脏入球小动脉的球旁细胞并不“知道”医生开了一种阻断RAAS的药物，它们能感知的只有一个物理信号，即灌注压的下降。对于终其一生监测血压、据此调节肾素释放的细胞而言，灌注压下降意味着一个古老而从未失效的警报：血压不足，器官可能缺血。它们的响应立即而明确：释放更多肾素。肾素把肝脏合成的血管紧张素原切成血管紧张素I，原本ACE会迅速把它转化为强效缩血管物质血管紧张素II，如今这条主干道被ACEI卡住，血管紧张素I在通路里堆积。堆积的血管紧张素I开始通过教科书上标注为“次要替代通路”的旁路，即糜酶通路，在局部组织中被直接转化为血管紧张素II。与此同时，交感神经系统检测到血压下降，进一步上调去甲肾上腺素的释放；肾脏更积极地重吸收钠和水；血管平滑肌细胞对残余的血管紧张素II及内皮素等缩血管物质的敏感性，在持续的交感刺激下逐渐增强。

这就是为什么单用一种ACEI很少能“治愈”高血压，除非在最早期、最轻度、纠缠尚未致密化的阶段。血压数值的下降，并不是系统“健康恢复”的标志，而是一个系统在一条通路被阻断之后，整体上仍在努力维持它习惯了的那个较高水平的抵抗性反应。药前的155/98，是所有参与其中的力量在那个时刻的共同结算，一份相对诚实的报表；药后的145/92，则是系统在一条关键通路被强行切断后，用尽肾素反弹、糜酶旁路激活、交感上调、钠水潴留等一切代偿手段，挤出来的暂时而不稳定的妥协。报表上的一行数字被外力改写了，而网的其他部分正在暗地里重新布线，要把这个数字重新推高。被压下去的数字与之前那个数字，已经不是同一个东西。

（三）穿过生活世界的微循环

上面描述的是器官与分子层面的代偿。要让这一判断落到实处，还必须看到这些代偿如何穿过患者的主观经验与具体的生活事件，重新进入制造血压读数的生理网络。仍以这位男性为例（以下为设想性的展开，并非田野记录）。服用ACEI的第三周，他出现了一个常见的副作用：干咳。咳嗽不剧烈，不足以让他停药，但足以让他在凌晨三四点被咳醒。连续数夜睡眠碎片化，在他的HPA轴上留下了可测量的痕迹，晨峰皮质醇水平较用药前升高了百分之十五至二十。晨峰皮质醇升高本身就是一个强力信号：它增强外周血管对儿茶酚胺的敏感性，还刺激肝脏合成更多血管紧张素原，而后者正是RAAS级联反应的起始原料。

更微妙的事情发生在心理一侧。第三周复诊，他发现自己的血压是142/90，比两周前在家自测的138/88要高。他隐隐感到不安：是不是这个药对我没用？这份不安他未必会对医生说出口，却在当晚入睡前以反刍的形式重新激活了他的交感系统。夜间交感上调，经肾脏的β1受体进一步刺激球旁细胞释放肾素，而这条通路，恰是ACEI想要阻断、却因交感张力升高而被从上游绕开的。至此，一个完整的微循环浮出水面，它横跨了四个在教科书上被划归不同学科的层面：药物的分子效应（ACEI抑制转换酶，缓激肽堆积，干咳），行为—生理的后果（咳嗽，睡眠碎片化，晨峰皮质醇升高），认知—情绪的反应（看到血压反弹，怀疑药效，夜间焦虑），以及神经内分泌的代偿（交感激活，肾素释放，RAAS通路被绕过）。这些层面之间不是松散的“也相关”，而是以数天到数周的节奏相互输入、彼此咬合。医生在复诊时看到的“142/90”，已经不是ACEI的简单药效报告，它是多层网络在这一段时间的互动之后，于那一刻重新结算出来的一个全新读值。

这个微循环里还有一个细节值得记下，因为它是后文反复回到的主题：药物自身，连同它所嵌入的整套医疗情境（诊断、复诊、读数、药名、“我在接受治疗”的身份），也在改变这个人的生活，并通过睡眠、焦虑与自我评估，重新写入他的血压。善意的精准干预不是从系统外部伸进来的一根探针，它一进来，就成了系统的一部分。

◆ 三、致密纠缠：三个判据与最小费力原则

– （一）三个判据

本章把上述现象归入一个概念：致密纠缠。它是一个本体论概念，而不是一个经验概念。它不是说疾病与某些未测量的变量相关，不是说病因网络里有冗余和反馈，也不是说“干预需要更综合”，这些说法都已经被异稳态负荷、系统生物学、生物—心理—社会模型充分表达过。致密纠缠指的是：在某一疾病中，当下面三个条件同时满足时，该疾病的核心现象，也就是临床希望干预的那个“靶子”，在存在方式上已经不能再作为独立的干预对象，从纠缠网络里被切割出来。

第一个条件是强共振反馈。靶变量（血压、血糖、炎症水平、情绪状态）与制造它的其他过程（神经内分泌、免疫、行为、心理、社会处境）之间，是双向而非单向的因果关系。靶变量每一刻的值，不仅是这些过程的输出，同时也作为信号逆向输入，重新调节那些过程的强度与方向。在高血压里，长期交感激活升高血压，而血压升高又通过颈动脉窦与主动脉弓的压力感受器，重新设定交感传出活动的阈值。这不是一条从A到B的单行道，而是首尾咬合的环；每一次读数的变动，都被身体当作“当前环境安全程度”的情报，据此调整自身的防御级别。

第二个条件是多层非独立性。参与共振反馈的因素，至少跨越三个在类别上互不相同的层级：分子与细胞层，器官与系统层，个体行为与心理层，乃至社会制度与处境层。这些层级不仅变量不同，运行规则也不同：血管平滑肌细胞遵循离子通道动力学，交感神经系统遵循神经整合规则，个体的饮食行为在分子层面由代谢需求驱动，在社会层面由食品环境和广告驱动，在心理层面由压力与奖赏通路驱动。一个从分子上精准阻断血管紧张素II的干预，仍然受制于其他层级上继续运转、不断助推血压的力量：促使他吃下高盐食物的食品环境没有变，让他交感持续激活的工作压力没有变，而被他体验为“干咳”与“血压不稳定”的药物副作用，正沿着睡眠—焦虑—肾素释放这条实体通路回到血压数值里。层级之

间紧密到这样的程度，以至于任何单一层级上的干预，都得不到独立于其他层级的稳定性。

第三个条件是干预的不可逆扰动。当人们从致密纠缠状态里切出一个靶变量去干预时，这个干预动作本身，不仅是它的生理效应，也包括它所嵌入的医疗制度、诊断话语、患者对自我认知的重构，构成一股强大的、重新进入网络的新力量，不可逆地改变网络的原初状态，使之朝一个不可预测的方向演化。血压被压下去之后，“我正在接受高血压治疗”的患者身份，就已作为新因素进入他的生活，连同对药物副作用的忍受、对血压波动的焦虑、“我已经是个病人了”的自我标签，沿交感、内分泌与免疫通路，实在地、不可逆地重新进入那个制造血压数值的网络。

三个条件同时具备时，临床试图“命中”的靶变量，就不再有可以被隔离的身份。需要特别说明一点：这不同于“靶心在移动”。靶心在移动，仍然预设靶心在移动之前有一个可以标定的稳定位置；而致密纠缠中的靶心，是每时每刻都在被生成的，它没有一个“未受扰动的自然状态”可以回归，因为每一次干预都把它重新生成为不同的东西。三个条件的紧密程度，可以用靶变量与制造它的多层过程之间的耦合密度来概括：本章主张，耦合密度越过一个经验上可以识别的临界阈值之后，“瞄准—命中”这一姿态便系统性地失效；低于这个阈值的领域，见本章第八节所述的适用边界。

（二）难治性高血压与“多靶点联合”的同一前提

以此再看“难治性高血压”。这个标签隐含着一个预设，仿佛存在一类特殊的、对更多药物都抵抗的高血压。但按致密纠缠的眼光，它不是一个独立的疾病实体，而是致密纠缠在最顽固处的裸露，它向临床摊牌：面对的不是一套可以被逐一切断的并联电路，而是一个会在每次切断之后当场重写自身布线逻辑的活系统。

同样，三联降压的“多靶点联合”，与单靶点的精准在根本逻辑上没有区别。二者共享一个未经追问的前提：那些可以被命名的通路都是可以被切断的绳

子，剩下没被切的绳子还在往外拉，那就再切几根，直到拉不动为止。它确实让更多人达标，但那种达标是脆弱的，依赖终身服药，伴随长期的代谢副作用；在相当比例的患者身上，三联、四联之后血压仍然无法达标。如果血压数值并非多条独立绳子的拉力之和，而是一张活网的动态平衡，那么切断一根，网的其他部分就被逼着重新分配张力，它可能找到一个更不合理的新平衡，也可能在切口处长出教科书上没有记载的新的代偿绳结。

– （三）最小费力原则

仅仅说“它会重组织”是不够的。如果重组织的方向是随机的，致密纠缠就只是一个关于复杂性的模糊断言。它需要一条支配原则，这就是本章所称的最小费力原则：服从它的活系统，在遭遇强制性扰动之后，启动代偿性重组的优先方向，不是从全局看最“健康”或最“可持续”的路径，而是当下阻力最小、最近、能最快逆转被扰动指标（血压、情绪、肿瘤生长信号）偏离的那一条。

为什么是它？因为制造血压、维持抑郁认知、维持肿瘤增殖信号的那张网络，不是由中央控制器统一调度的计划经济体，而是由数十亿个局部单元依据各自极其片面的信息，各自为政地做出反应的分布式系统。肾小球旁细胞接收到“灌注压下降”的信号，不会先去核查是否因为ACEI阻断了RAAS，再耐心等医生调整用药；它会立即、就地、用手里唯一的武器，即释放更多肾素，去逆转它感知到的那个下降。血管平滑肌细胞感受不到足够的剪切应力，也不会等待全局指令，而是就地通过上调局部内皮素转换酶的活性，增强对残余缩血管物质的敏感性。这些动作在各自的局部都是“合理”的，是演化刻进细胞记忆里的最短路径求生策略；但在全局上拼合起来，就成了一股短视的、不顾远期代谢代价的、固执地要把被压低的血压重新推上去的合力。

“越准越错”的内核就在这里。药物越精准，它就越漂亮地切断那条最大、最宽、最省力的主力通路（在高血压里是ACE依赖的血管紧张素II生成，在抑郁里是5-羟色胺转运体，在肿瘤里是EGFR的主信号轴）；而依最小费力原则，系统被逼着去启用此前很少使用、沉在底下、更支线、却恰好能在当下最快地局部

逆转切断效应的替代通路。可以打一个比方：精准地拆掉一座大桥，全城的车流不会因此消失，而是立刻涌向所有此前因为“太绕路”而车流稀少、甚至地图上根本没有标记的小街巷弄。“准”恰恰激发了它最意想不到的“偏”的抵抗。武器的精度与系统被逼出的代偿复杂度，由此成了一场正反馈的军备竞赛，而这场竞赛没有终点，因为每一次开枪，都在当场为自己制造下一个更刁钻、更难被命中的新靶子。要对付的对象，即那个不可被切断的致密纠缠本身，从来不在瞄准范围之内。

所以，精准医疗在致密纠缠度高的慢性病领域的困境，不是“数据量还不够大”或“算法还不够聪明”，而是一个被致密纠缠状态本身锁死的天花板。它不是在接近真理时被拒斥了，而是在原理上被取消了有效性。回到本书的母题，这意味着：替定所依赖的那个“固定目标”，在这一类疾病里是一个被取消了的对象。

◆ 四、抑郁与耐药：致密纠缠的两种变形

高血压之外，一个经得起反驳的判断还必须在别的领域里站得住。这里选两个与高血压机理截然不同的场域：重性抑郁障碍与肿瘤获得性耐药，一个落在心理—生物的界面上，一个落在纯粹的分子战场上。如果致密纠缠只对高血压成立，它就只是一个局部病例的病理生理学解读；只有在这两处也能独立落地，它才配称为一个可以推衍的诊断。

– （一）抑郁：当情绪不再是被瞄准的对象

重性抑郁障碍的当代治疗，在很大程度上复制了高血压的认知轨迹。选择性5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRI）的问世，标志着抑郁症治疗的“精准化”起步：它不再是笼统的镇静或兴奋，而是精确增强特定突触间隙里的特定递质水平。半个世纪后，几乎所有精神科医生都能列出这些药物的局限：起效滞后，需要至少两到四周才见到心境改善，而此间患者的痛苦、自杀风险与早期副作用同时在场；完全缓解率低。STAR*D试验是这一领域最具里程碑意义的真实世界序贯治疗研究，它的核心结论被回避得比被引用得更多：第一步SSRI治疗之后，

仅约三分之一的患者达到完全缓解；经历四次序贯换药或强化方案之后，累积缓解率仍只有约三分之二。也就是说，在最好的、按指南严密推进的条件下，仍有约三分之一的患者，在一整年、四次不同方案的精准干预之后，依然没有摆脱抑郁。

SSRI当然远好于不治疗。但它半个世纪的整体效果曲线，早期快速获益，随后进入漫长的、改善幅度越来越小的平台期，所指向的并不是“需要更多精准的靶点”，而是那个被瞄准的“靶”，即突触间隙的5-羟色胺浓度，从一开始就只是整个抑郁过程的一个下游锚点，而不是驱动致密纠缠的中枢结。让我们把一支SSRI放进这张网里，追踪一次抗抑郁反应如何触发系统的代偿性重组织。药物通过阻断5-羟色胺转运体，提高突触间隙的5-羟色胺浓度。最初几天到几周，突触后受体的适应性下调尚未完成，患者体验到的主要是药物副作用，恶心、失眠、焦虑增加，而不是情绪的改善。

就在服药后第五到第十四天的窗口期，一个关键的微循环启动了。突触间隙5-羟色胺浓度升高，首先激活中缝核的5-HT1A自身受体；这些受体是负反馈的传感器，检测到“5-羟色胺太多了”，便减少中缝核5-羟色胺能神经元的放电频率。这是身体对SSRI的第一层生理代偿：你想要更多，我偏要减量生产。与此同时，部分患者的焦虑和躯体不适反而比服药前加重，而这一加重在他的网络里又引发连锁反应。设想一位因抑郁而长期卧床的患者，服药第五天感到一阵不明原因的心悸。过去三个月的抑郁已让他形成一套自发的负性认知：“我的身体一定是出了更严重的问题。”如果他恰好独自居住，没有可以求证的人，又在上次复诊时觉得医生只是匆忙开了药、并未认真听他诉说，那么这个念头在接下来几天的独处里，就没有遇到任何现实检验的阻力：他上网查药物副作用，越查越怕；想打电话给医生，又怕“打扰”，怕被当作疑病；决定“再忍几天看看”。这个决定在心理层面是回避，在神经内分泌层面是焦虑的持续激活。持续的焦虑上调HPA轴，升高的皮质醇直接损伤海马齿状回正在进行的神经发生，而这一区域的神经元再生，恰是SSRI长期服用后被认为发挥抗抑郁效应的关键环节之一。

几周之后，当突触后受体的适应性下调完成，5-羟色胺能传递出现净增强时，被增强的神经通路已不是治疗前的那张白纸，它是在一个高度警觉、被焦虑与失眠重塑过的网络里，去寻找自己能连接的“下一个可用节点”。海马区因这几周的皮质醇升高而营养不足；前额叶—杏仁核的调控通路上，杏仁核一侧因持续焦虑而被致敏到更低的触发阈值。药物最终起效时，一部分症状，比如精神运动性迟滞，减轻了；另一部分，情感迟钝、动力尚存而价值感真空，则以一种更隐匿、患者本人更难言说的方式被重新稳定下来。精神科临床里反复观察到、却被“缓解率”的统计语言遮蔽的现象，正是这一过程的终末产物：汉密尔顿抑郁量表得分确实降低了，患者报告的感觉却不是“好了”，而是“麻木了”，“像是在玻璃罩里活着”。原先的抑郁，是整个网络在那一刻的脆弱结算；药后的状态，则是网络在被强力外力冲击之后，经由睡眠、焦虑、社会支持的缺乏和认知模式的未被挑战，被不可逆地重组出的另一个结算点。精准地阻断一个与心境相关的分子靶点，与“治愈”那个在多层纠缠中不断被生成的抑郁，是两件在本体论上不可通约的事。

—（二）肿瘤耐药：发生在瞄准镜底片上的化学

如果说抑郁展示了致密纠缠如何在心理—生物界面上锁死精准干预，那么肿瘤获得性耐药则展示了同一逻辑如何在纯粹的分子生物学战场上，以更赤裸的方式展开。以非小细胞肺癌的EGFR突变为例：一位从不吸烟的肺腺癌患者，肿瘤经活检证实携带EGFR外显子19缺失突变，使EGFR激酶处于持续激活状态。医生给他开了第一代EGFR酪氨酸激酶抑制剂吉非替尼。最初几周，药物精准地占据突变型EGFR的ATP结合口袋，阻断磷酸化，下游促生长信号被骤然掐断，影像学上肿瘤显著缩小。但这场胜利的倒计时，在给药的第一天就开始了。

肿瘤不是一堆同质的细胞。治疗前，肿瘤内部就存在遗传异质性：在数以亿计的细胞里，总有极少数细胞的EGFR基因在ATP结合位点附近，已携带某个随机产生、在治疗前毫无选择优势的点突变。当EGFR通路被压制、大量敏感细胞死亡，肿瘤内部的微环境随之剧变：缺氧区域扩大，营养竞争格局重组，大量死细胞释放的内容物引发局部炎症。在这个新微环境里，缺氧诱导因子HIF-1α被

稳定化并转入核内，激活一系列应激反应基因，其中一些编码易错DNA聚合酶的基因表达上调，使药物压力下幸存细胞的基因组不稳定性急剧升高。EGFR基因上的一个特定点突变T790M，就在这场突变风暴中以高于背景的频率被产生出来。为什么总是它？因为T790M恰好位于激酶ATP结合口袋的门户位置，体积更大的甲硫氨酸取代了原来的苏氨酸，不仅没有破坏激酶活性，反而经由空间位阻和增强的ATP亲和力，把吉非替尼挡在口袋之外，同时保留了催化功能。治疗前，携带T790M的细胞没有选择优势；在吉非替尼的持续压力下，当所有不携带它的细胞被杀死或抑制，这极少数恰好能绕过封锁的细胞，获得了广阔的增殖空间。

这不止是达尔文式的选择。即便T790M在治疗前就以极低频率存在，这一“恰好存在”的幸运突变，也必须在药物压力造出的特定微环境里（HIF-1α激活、氧化应激升高、炎症因子刺激），才会从极低频被“筛选”到临床可检出的主导地位；更关键的是，药物压力通过重塑微环境，反过来激活了产生更多新突变的机制。耐药克隆的出现同样服从最小费力原则：对于被逼入缺氧、炎症、营养匮乏之中的残存肿瘤细胞，在所有潜在的“解药”里，那个不必从头发明一套全新信号系统、只需在现有激酶的口袋门口换一个氨基酸的突变，就是当下阻力最小、代价最低的逆转方案。

如果耐药只是“从已有突变库里被动选择”，那么一旦开发出覆盖T790M的下一代药物（如奥希替尼），问题就应当解决。临床事实是：奥希替尼的有效时间通常也只有一年多，随后新的耐药突变，C797S、MET扩增、KRAS突变，甚至向小细胞肺癌的组织学转化，相继出现。每开发一种更精准、能覆盖上一代耐药突变的药物，就是在为肿瘤造出一个全新的微环境选择压力，并在那个新压力下，当场筛选或当场诱变出下一代“在那个新环境里恰好最省力”的代偿方案。这里打的不是一只有许多退路的老鼠，而是一块每敲一锤就当场长出新刺的、液态的、自我武装的铁。精准的武器在这里不是无效，而是它的“准”本身，就是下一轮必然落空的根源。

两个场域合起来说明了一件事：致密纠缠不是高血压的特产。无论是心理—生物界面上的缓慢重稳，还是分子层面上的快速选择，被命中的靶心都在命中的同时变成了另一个东西。这里已经隐约可见本书母题的另一面：替定者每一次得手，得到的都不是一个被定下来的结果，而是一个新的、需要被继续替定的对象。

◆ 五、临床现象的直接支撑：心力衰竭与β受体阻滞剂的初始恶化

前面的论证主要依靠对“干预—代偿”过程的生理学追踪。一位严肃的批评者可以接受每一个环节的推理，却仍然说：这些代偿机制都是已知的，它们只是让精准干预的效果打了折扣，并没有在原理上取消其有效性。因此需要一个更强的、直接的临床现象：不是代偿削弱了药效，而是“精准命中”本身，在短期内就让病情恶化，偏偏又是这种暂时的“错”，为长期的“对”开辟了道路。心力衰竭药物治疗史里，β受体阻滞剂的引入提供了这样的现象。

心力衰竭是致密纠缠度极高的临床状态。心输出量下降是原初的损伤，但这个损伤作为一个被身体持续监测的信号，激活了一整套短期有代偿价值、长期却使病情恶化的神经内分泌反射：交感神经系统被过度激活，去甲肾上腺素与肾上腺素释放增加，心率加快，心肌收缩力被暂时提振，同时也升高了心肌耗氧量，促进心肌细胞凋亡与纤维化；RAAS被激活，水钠潴留加重前负荷，同时加重心脏的容量过载。“低心输出量”这个靶，与代偿它的神经内分泌过程之间，形成了典型的致密纠缠：临床希望逆转的那个状态，它的维持恰恰依赖于对它的代偿。

现在把β受体阻滞剂放进这张网。它的药理作用极其精准：竞争性地占据心肌细胞膜上的β1肾上腺素能受体，阻断去甲肾上腺素与肾上腺素的结合，从而降低心率、减少心肌收缩力、降低心肌耗氧。按“瞄准—命中”的逻辑，这是完美的，过度激活的交感信号是心肌进行性损伤的元凶，精准阻断它，理应保护心肌。然而在给药后的第一个小时乃至第一周，临床观察到的却是相反的景象：对于一个在代偿性高交感张力下勉强维持输出的衰竭心脏，β受体阻滞剂对收缩力

的急性抑制，会在短期内进一步降低每搏输出量，导致血压下降、组织灌注不足；部分患者在首次服药后出现呼吸困难加重、乏力恶化，甚至急性血流动力学崩溃。这是“越准越错”在临床上最直接的裸露：越精准地阻断那个过度激活的交感信号，那颗依赖这个信号才勉强维持的脆弱心脏，就越逼近失代偿的悬崖。被试图保护的“靶心”，也就是衰竭但仍在工作的心肌，其当前的存在方式正由此刻要被阻断的东西所支撑着。

心内科医生的应对，不是放弃β受体阻滞剂（它的长期获益已获确证），也不是加大剂量以求速效，而是一种在现象上完全违背“精准命中”逻辑的做法：以极低的剂量起始，以极慢的速度加量，允许心脏在这一被强制“减速”的漫长扰动中，用数周至数月的时间，慢慢启动深度的适应性重塑，包括β受体的上调与再分布，心肌细胞基因表达程序从胎儿型向成人型的部分逆转，以及心室几何形态的良性重构。这套“滴定”策略并不是对精准的技术微调，它是在用数月的时间，等待网络在被一次精准打击之后，自己去完成一轮无法被外力加速的重组织。

换言之，β受体阻滞剂治疗心衰的成功，依赖的不是“精准命中了一个靶点”，而是“接受了一场长达数月、初始以病情恶化为代价的、不可控的系统性扰动，并给了系统足够长的时间，在被扰乱之后走完它自己的适应性重稳路径”。这是一种用初始的“错”（短期恶化）换取未来的“对”（长期逆重构）的反直觉逻辑。在“瞄准—命中—校准”的框架里它无法被理解，因为在这个框架里任何导致病情恶化的干预都是错误的；只有在“扰动—监测—重稳”里它才讲得通：干预的初始效果，恶化，不是失败的证据，而是系统被从旧稳态击出之后，正在穿越一个必由的混沌期的不可避免的表现。致密纠缠的主张因此是：这种需要数月忍耐才能兑现的“错→对”转化，是处于致密纠缠中的慢性病系统的普遍特征，而非心衰治疗的特例。对于本书而言，这个例子有一层特别的意义：连医学自己最成熟的做法，都已经在事实上承认了系统有一段不能被替定、只能被陪伴的路要自己走。

◆ 六、划界与反驳：致密纠缠不是别人早已说过的东西

一个新概念必须面对的检验是：它会不会只是若干著名论说的重新包装？本节先与六个最易混淆的近邻划界，再补切三个覆盖风险最高的近邻，最后正面回应两个最强的反驳。每一处划界都给出一个能让两套框架做出相反预测的观察格，这也是本章对自己的苛求。

– （一）六个近邻

还原论批判与生物—心理—社会模型。 它们的主张是“层级不全，需要把缺失的社会、心理、行为层级补上”，这是关于因果解释完整性的主张。致密纠缠则说：即使补全所有层级，只要仍把待干预的靶变量，比如血压，在操作上视为可以从多层互动里切割出来、单独瞄准和修正的实体，就在本体论上犯了错，补齐变量并不改变这个错。判决性预测：若纳入社会、心理、行为变量并据此设计多层级干预之后，高血压的控制率与硬终点得到根本改善（例如控制率从百分之五十升至百分之八十以上且长期不衰减），则本章的判断多余；若核心干预仍依赖药理手段强行压低读数，而控制率仍停滞在平台期，则本章成立。

异稳态负荷。 该模型把疾病视为可由“负荷”这一连续变量捕捉的终点，默认降低负荷则疾病改善。致密纠缠指出：负荷与制造它的网络不可切割，用药强行降低负荷读数时，网络可能通过行为、心理或未测量的生理代偿，在当前或未来把负荷推回高位。若能仅凭药理手段将核心生物标志物降至正常并长期维持、不改变原发处境，即可持续改善硬终点，则致密纠缠可被悬置；若遭遇系统性的、多渠道的反弹，则本章成立。

生物系统的鲁棒性。 鲁棒性解释“已有功能为何打不掉”，预设系统在保护一个恒常目标。致密纠缠则说，被当作“功能”的东西，本身就是多层张力下的暂时结算点；打不掉它，不是因为它被鲁棒地维护着，而是因为每打一次，它都在压力下被重构成一个新的、不同的东西。若能绘出完整的代偿网络，设计出“终极多靶点精准干预”，一次绕开所有已知代偿通路并获得稳定持久的疗

效，则致密纠缠可还原为鲁棒性问题的过度哲学化表述；若这类干预仍被系统在尚未表征的新维度上的适应性重组所规避，则本章成立。

凯博文的“疾病”与“病痛”二分。 凯博文的框架是在疾病的生物学事实之外，加上对患者主观经验的重视。致密纠缠则指出，那个所谓“硬的生物学事实”，本身就不是可以从患者体验里剥离出来的独立实体，它是从那个体验世界里被不断生成出来的。若仅靠倾听病痛叙事、改善医患沟通，而不改变任何靶向策略，就能在致密纠缠度高的领域持续改善硬终点，则本章概念多余；若倾听提高了满意度和生活质量，却始终撼动不了核心的医学困境，则本章成立。

生物医学化理论。 克拉克等人论证的是，精准医疗通过制度、资本与技术实践“重构”了疾病与生命的定义，这是社会本体论的批判。致密纠缠论证的是：即使撇开制度与权力，被重构出来的靶子本身，其存在方式也已使“瞄准”这个动作在原理上失效，这是疾病本体论的批判。若在纠缠致密的领域，把患者重构为“分子数据集合”并据此大规模干预的路径，在硬终点上与传统公共卫生路径相当或更优，则本章被克拉克的框架更全面地覆盖；若无论数据多全、算法多精，硬终点始终越不过致密纠缠划定的天花板，则本章成立。

精准健康与P4医学。 这是致密纠缠面对的最强近邻。精准健康承认单点干预不够，主张借多组学、可穿戴设备和详细的生活方式数据，为每个个体建立动态“健康基线”，在偏离基线的早期介入。但它与精准医疗共享同一个未经审查的操作预设：存在一个可以被多维数据穷尽的、对这个人而言“正确的”健康稳态。致密纠缠则指出，在一个人的生命历程里，那些显示为“偏离基线”的生理波动，恰恰可能是机体正在进行创造性适应的动态痕迹，而不是需要被“校准”回去的误差。精准健康是在用更密的网，去兜捕一条不可穷尽的发生之河。若它能通过全面采集与动态校准，持续且可重复地降低复杂慢性病的发病率，且不被系统性代偿或新型健康问题所抵消，则致密纠缠在操作层面被削弱；若仍遭遇“数据越多、偏离越多、硬终点获益不成比例增长”的平台效应，则本章成立。

（二）再补三个近邻

自创生是这一领域共同的最大对话者。马图拉纳与瓦雷拉在《自生成与认知》（1980）里的自创生，指一个活系统由一张组分生产网络构成，网络的运作不断再生产出网络自身，并由此划定自己与环境的边界，在结构上对环境开放，在组织上却是封闭的：环境只能触发它，不能指定它的下一步。本章所说的“生命自行生成并维持自身秩序”正是这一传统的延伸，不处理它，等于在已经立了牌子的地上重新插旗。分离线在于：自创生守的是组织同一性，只要系统活着，组织就保持不变，变的只是实现它的结构；本章追的是承重节点的更换。EGFR信号被阻断之后改用T790M，再改用C797S，再改用MET扩增，以及β细胞不再分泌胰岛素而退回去分化的休眠态，都不是同一个组织的不同结构实现，而是组织本身被重写了一次，系统并没有死。可裁决的判据是：取任一慢病或耐药演化过程，在扰动前后分别标定系统关键承重节点的集合与其间的依赖拓扑。自创生预测拓扑在存活期间不变，变的只是节点的物质实现；本章预测拓扑本身被替换，扰动后的承重节点集合与扰动前的交集可以趋近于空，而系统照常运作。若经验上看到的始终是前者，换的只是零件而图纸没变，则本章的命名冗余，一切可还原为自创生的医学应用。

稳态应变与稳态负荷（Sterling与Eyer，1988；McEwen，1998）主张身体并不维持固定的设定点，而是通过预测性地改变设定点来应对负荷，长期的设定点漂移积累为稳态负荷，最终表现为多系统损耗。它解释了“为什么把指标按回常模区间反而带来损害”，在现象层与“越准越错”几乎完全重合。分离线是：稳态负荷是一个代价累积模型，本章是一个对象漂移模型。前者说，设定点变了，硬把它按回去要付代价；后者说，被瞄准的靶心在干预之后已不是干预前的那个对象，这不是代价问题，是同一性问题。判据是：在一次精准干预前后，对靶点做完整的分子邻域测绘，包括互作网络、下游通路权重、调控依赖。稳态负荷预测靶点本身及其邻域拓扑不变，变的是整体负荷水平与其他系统的代偿强度；本章预测邻域拓扑本身被重写，同一个分子在干预后承担的功能角色与依赖

关系已不同于干预前。若测绘显示邻域拓扑稳定，则稳态负荷足以解释“越准越错”，本章的本体论主张便属多余。

第三个是非遍历性，其数学来源是莫勒纳尔（Molenaar，2004）的遍历性定理：只有当过程既平稳又同质时，群体统计量才能外推到个体，而心理与生理过程通常不满足，所以群体均值对个体无效。这是“精准医疗的统计基础有问题”这一命题最硬的既有版本。分离线在于：非遍历性说的是推断无效，本章说的是对象消失。非遍历性的补救是可想象的，密集的个体内时间序列测量（N-of-1设计）可以恢复有效推断；本章的主张更强，即便对同一个体做完美的密集测量，每一次干预也都改变了下一次测量的对象，因此不存在一个可被收敛逼近的稳定个体参数。判据是严格的N-of-1交叉设计，让同一患者反复经历“干预—撤除—再干预”。非遍历性预测个体参数可被估计并收敛，重复干预的效应量趋于稳定；本章预测重复干预的效应量单调衰减而不收敛，因为每一轮的对象都已不同。这是最干净、也最可能推翻本章的一个实验。

（三）反驳一：精神分析早已说过“解释即扰动”

最深的一个反驳来自精神分析传统，尤其是拉康一系。拉康派有“被假定知道的主体”这一概念：患者进入分析时，把分析师假定为知道其病症真相的人，这一假定本身就已不可逆地扰动了无意识的结构；分析师此后给出的任何精准解释，都不是对独立存在的“病因”的中立揭示，而是作为一股新的力被纳入患者既有的精神经济，患者可以吸收它、用它制造新的症状，也可以表面接受而在更深处产生“治疗反应”，症状转移或加重。精神分析从不在“多学科综合”的意义上工作，它的工作对象正是那个每次干预都会重组、并且把解读行为本身也包含在内的“不可切割的网”。于是问题尖锐起来：致密纠缠与“解释即扰动”在什么辨别面上不能一对一替换？若它只是把精神分析的洞见搬到躯体医学，便不构成原创贡献。

分离线不在“是否扰动”，双方都承认干预本身是不可逆的扰动。分离线在扰动得以发生的场域的性质，以及这个场域能否被一个“知道自己在扰动”的行

动者策略性地使用。精神分析的全部技艺，建立在一个致密纠缠所不享有的条件上：分析师与患者共享同一个表征—象征空间。分析师说出一个解释，以语言为媒介进入患者的无意识表征世界；患者的反应，无论拒绝、接受，还是把分析师一并纳入症状，仍发生在这个象征秩序之内。因此分析师可以利用共享空间，通过语误、自由联想方向的微妙偏转、下一次会谈的迟到来反推解释的效应，调整下一次干预的时机与措辞。扰动与对扰动的监测，处在同一个层面（语言与表征），由同一个行动者在持续的主体间场域里完成。

致密纠缠的场域不同。临床医生开出ACEI，所发起的扰动，血管紧张素II浓度的下降，发生在分子—细胞层面；对它的代偿，肾素释放、糜酶旁路激活，也发生在分子—细胞层面。问题在于，这些代偿完全不以医生或患者能够进入并参与意义建构的方式表征自身。球旁细胞释放肾素，不是“患者对医生开药行为的理解或反弹”，而是与任何表征世界彻底无关的生化自动反应。医生不能像分析师那样，通过患者对解释的回应来“把捉”这一代偿的意义，因为它没有意义，只是一股物理力。精神分析里，解释引发的扰动可以被反向读取并用于治疗，因为它发生在同一个表征空间；躯体慢性病里，药物引发的扰动跨越了“表征—物质”的断层，无法被同一个施动者以同一种方式反向读取、策略性地使用。所以，致密纠缠的基本处境不是分析室里的“扰动—反馈—调整”，而是急诊室里的“扰动—不可全知—代偿性逃逸”。精神分析批判的，是精准解释在象征秩序内引发无意识重组的不可控；致密纠缠揭示的，是精准药物跨越表征—物质断层之后，局部物质代偿在原理上的不可全知性，以及由此而来的系统性逃逸。这是“解释即扰动”所没有覆盖的新问题。

– （四）反驳二：算力能否绕过这道壁垒

第二个反驳来自精准健康的最强形态，它令本章最不舒服，因为它是实践上的。设想一位站在理论最前沿的精准健康学者这样回答：“你说每一次干预都把靶子重新生成为不同的东西，我完全承认。这恰恰说明我以前的失败，只是因为数据量不够大、模型不够动态，没把你们所说的‘不可逆扰动’与‘重组织’作为下一级的待干预变量纳入靶向范围。我下一代的靶子，不只是那个突变的蛋

白，而是‘抑制因我介入而引发的具体的代偿性炎症微环境’；再下一代，是借海量行为数据和动态调整的同理心算法，靶向性地‘安抚’你的焦虑，由你的手机在你每次上传血压之后、在它预测你会开始担心的那个时间点上，推给你一句恰好能降低交感张力的个性化话语。我的目标从来不是回避致密纠缠，而是用指数增长的算力，去模拟、预判并精准管理每一次由上一个干预触发的重组织。数字孪生做得到：虚拟分身里，每个器官、每种激素、每个心理反应的历史模式都被参数化了。你的致密纠缠，只是我的技术欠债。”

这个反驳有力，因为它把战场从技术的有限性推到了本体论的边界上。本章的回应是：对生物活系统的非遍历性，算力的穷举在原理上是一种范畴错误。这里“非遍历性”的含义是：一个系统在时间中经过的状态空间，所覆盖的可能状态集合，远远小于它理论上可能达到的全部状态空间；而它下一刻会进入哪个状态，由它完整的、不可复现的、包含无数微观偶然的具体生命历史所唯一决定，而不是由任何能从外部参数化的“遍历性统计规律”决定。那位五十五岁患者对ACEI的代偿反应，被激活的糜酶旁路，因干咳而碎片化的夜晚，在诊室看到血压反弹后对医生说的话产生的不信任，以及那份不信任如何以肾素释放量的形式在下一次读数里被“兑现”，都不是“高血压患者”这一范畴的平均行为，而是这一个人由独特而不可复验的全部生活轨迹凝结成的活系统，在这一次扰动、这一个时点上唯一的一次发生。数字孪生无论数据维度多全，用以训练和校准的数据在逻辑上都只能是此人在过去，即“已经被生活过了的生命”里显现过的模式；而致密纠缠的核心，恰在于这个系统有能力、并且在强扰动下倾向于产生那些在它过去从未出现过的全新代偿模式，下一次干预必然落空的原因，正是这些新产生的代偿。

算力可以极好地拟合一个人已经走过的历史，却无法预测，在他特定的免疫史、肠道菌群构成、童年应激模式和当前社会境遇的独一无二的交叉点上，下一次会被逼出一种什么样的、自然从未在这个人身上排练过的代偿配方。这不是数据量问题，而是范畴问题：产生新代偿的那条河流，上游溶解着此人每一次发烧、每一次受辱、每一顿高盐宵夜的具体时间与顺序，这些信息的绝大部分在发

生的当场就未被记录，未被记录就永远进不了任何训练集。精准健康的雄心，是用一张网去兜住一杯被活人持续搅动的咖啡；它失败的原因不在网的疏密，而在这杯咖啡每一秒的流动方向，都严格依赖握杯之手从出生到此刻不可复验的全部生命。数字孪生因此不是致密纠缠的终结者，而是同一场战役的更昂贵的版本：用更密的网，去兜捕由更密之网的存在所激起的、更快更刁钻的逃逸，失效只是从一阶被拉升到二阶，代价却是指数膨胀的算力、存储，以及对个体生命无止境的数据剥削。致密纠缠的诊断不是宣布这场战役“不该打”，而是指出战役的预设，一个可以被逐步逼近并最终命中的终极靶心，在非遍历的活系统场域里，是一个被取消了的对象。

这里可以顺手看清本书的主线。数字孪生式的回应，实质上是把替定升级为“替定之上再替定”：既然靶心会逃，就连逃的方式也一并预先管理，连患者将要担心的那个时刻、那句话也预先写好。这恰是前几章所批评的那种抢先，只是现在抢到了重组织发生之前。越是有能力把每一步代偿都纳入管理，替生命先定下答案的范围就越大，生命自己摸索重组的余地就越小；而本节的论证说明，这种逐步扩大的管理，在原理上仍追不上被它自己激起的逃逸。

◆ 七、扰动—监测—重稳：替代姿态与两个临床雏形

– （一）姿态的翻转

前面的全部论证，旨在撤销当代慢性病医学长期视为理所当然的一项操作预设：存在一个可以从致密网络里切割出来的独立靶心，值得精准武器去击中。预设撤销之后，必须回答：临床干预还能做什么？承认“没有靶心”，难道就意味着放弃干预、任由疾病进展？不是。靶心永远在逃逸的场域里，干预的姿态需要翻转，从“瞄准—命中—校准”变为“扰动—监测—重稳”。前者的根基是一张静态靶纸，问的是“该把哪条通路切断，才能把读数拉回正常”；后者的根基是一个持续发生中的活系统，问的是：这个病人此刻的致密网络，最危险的张力集中在哪里？能否在那里施加一次尽可能小的、可控的扰动，不为切断什么，而是暂时松解已经僵硬的代偿模式，然后在足够长的时间窗里小心观察这张网怎样重

新组织，是在走向更有韧性、更不依赖单一代偿通路的方向，还是在逃向更脆弱、更不可预测的新代偿？这不是“多学科综合干预”的精致版，而是把干预从对靶心的追求，重新定义为对活系统重组织方向的谦逊而警觉的监护。

– （二）雏形一：高血压管理中的计划性药物假期

三联降压药把血压压到126/82，这个表面的达标不是治疗的终点，而是一个需要被扰动、被观察的僵化平衡态的开始。在这个状态下，系统实际的代偿倾向，肾素反弹的幅度、交感张力的实际水平、撤去某条通路压制后血压的变异模式，全部隐藏在药物制造的“正常读数”之下，既看不见，也无从评估。在这一框架下构思的操作，是在严格选择的、血压稳定达标至少六个月且无高危合并症的患者中，进行一次计划性的、在严密监测下的药物假期。这不是“停药让身体自愈”那种回归自然的想象，而是主动制造一次可控的微扰：医生监督下短暂撤去某一种药物（如利尿剂），在随后四到八周里，以远高于日常随访的频率（例如每周一次诊室测量加每日两次家庭自测）监测血压的变异模式，并同步记录患者的主观体验，包括精力、睡眠、情绪与自信心。

这次微扰的目标不是看“病好了没有”，血压大概率会在撤药后的某个时段回升。目标是让系统从被三种药物长期压制的僵化平衡里暂时松脱，进入一个短暂的、被严密监护的混沌期。在这个时期，此前被药物协同掩盖的代偿结构，比如因长期三重压制而过度上调的糜酶通路活性，比如患者因不信任医生、从未说出口的“自己偷偷减药后血压飙升”的经验，才有机会第一次在临床上被观察到。医生由此可以重新认识这个病人独特的网络形态：他的血压主要由容量（盐敏感）、RAAS还是交感张力所驱动？实际的交感激活水平，是否远高于诊室测量所显示的（“隐性交感亢进”）？他对“撤药”这件事的心理反应，是恐慌、如释重负，还是觉得“终于可以检验一下自己”，又以何种方式、何种节奏重新进入读数？依据这些常规诊疗永远得不到的信息，医生才能制定与此人网络形态相匹配的重稳策略，它未必是恢复原方案，也许是减去某种药、改变用药时间，或加入一项与药物无关的生活节奏调整。药物假期的要义是把诊断行为本身变成

一次扰动，并从扰动后的系统响应里重新学习，把“监测”从被动阅读报表，升级为主动制造情境、以暴露的网络结构。

（三）雏形二：利用SSRI起效初期的焦虑窗口做行为实验

同样的逻辑可以用在抑郁治疗上。SSRI治疗初期的焦虑加重与睡眠紊乱，在致密纠缠的框架下，并非单纯的“副作用”或“起效前的代价”，而是系统被强力分子击出旧稳态后，正在穿越混沌期的体感信号。现行临床路径把这段紊乱视为需要忍受、或需要苯二氮卓类药物临时压制的干扰，短期内保护了患者，却错过了一个机会：被扰动而暂时松动的神经网络，正处在比日常僵化状态更可能被引向新的、更安全稳态的可塑性窗口里。相应的操作是：在治疗开始后的第二到第四周，患者已有一点微弱的行动能量、但仍受焦虑困扰时，治疗师不急于做认知重建，也不用药物压制焦虑，而是与患者一起，设计一个处在其安全行为边缘的行为实验。它不同于认知行为治疗手册里通用的、预先登记好以推翻某个标准认知曲解的练习，而是借药物激起的混沌期，去松动网络里某个特定锚点的、一次性的、含不可预测的人际反馈的微扰。

回到那位五十五岁的男性（仍是设想的例子）。他对“药没用”的焦虑，在心理—行为层面最深的锚点，可能是“我在工作中不能表现出任何脆弱”这一延续三十年的自我要求，正是为了维系它，他过去半年一直拒绝同事的帮助，加班到深夜，靠高盐外卖提神。治疗师的工作不是分析这个要求的童年起源，那是精神分析的扰动逻辑，依赖同一个表征空间内的反馈调整；而是在识别出锚点之后，协助他设计一次处在舒适区边缘的行为暴露：下一周里，在他疲惫而不愿加班的某一天，只完成八小时工作，同事询问时不找借口，只说一句“我今天有点累，先回了”。他无需解释，只需去做，然后记录：那个他以为一定会发生的灾难性后果，被认为不称职、被排斥、被暗地议论，在现实里究竟以什么方式、多大程度、被哪些具体的人以哪些具体的行为“不完美地兑现”或“意外地没有发生”。

这个操作既不是“认知矫正”，它不对他想什么下指令；也不是“社交技能训练”，它不教他怎样说更好。它利用活着的人际世界里现实中的、不可预测的反馈，对构成他慢性病网络的一个关键社会—心理锚点做一次不可逆的微扰。它与药理扰动的区别在于：药理的扰动是钝的、全局的，行为实验则是患者经由能动性主动选择的、针对网络中最僵硬那根筋的一次点穴。它与精神分析的“解释—反馈”闭环的区别在于：它依靠的不是治疗师与患者共享的象征空间，而是药理混沌期为患者“争取来”的一点行动能量，让他独自与外部世界发生一次治疗师无法完全预判的物质性碰撞。碰撞之后，接下来几周的“监测—重稳”不再是监测药效，而是监测这个人如何在被冲开的更宽阔一点的心理—人际空间里，重新分配内部张力。

两个雏形有一个共同点，值得与本书的主线对照：在这两个操作里，医生与治疗师都不替患者定下“正确的读数”或“正确的认知”，而是制造一个小的、可退的扰动，然后把重新组织的主动权留给系统自己，自己退到监护的位置上。这正是后面几章要展开的“不替定”的临床先声。

◆ 八、边界、证伪与本章小结

– （一）适用边界

致密纠缠的诊断只适用于三个条件，强共振反馈、多层非独立性、干预的不可逆扰动，同时满足的慢性疾病领域。在纠缠薄弱的领域，比如特异性感染（结核、梅毒）、明确驱动突变的单基因病（囊性纤维化、亨廷顿病）或单基因糖尿病亚型（如MODY），病因与其发生的多层生命过程之间是松耦合的，靶心在操作上可以近似视为独立，精准干预能够达到长期稳定的效果，本章的判断在那里不成立。这个区分本身也是本章的理论收益之一：它解释了为什么精准医疗在某些领域获得辉煌成功，在另一些领域却陷入没有尽头的军备竞赛。本章不是要取消对疾病分子机制的研究，也不否定降压药、抗抑郁药、靶向抗癌药当下相对的、不可替代的救命价值；本章质疑的，是把它们从“局部安抚”拔高为“最终

解决方案”的认知框架，这种框架不仅不准确，还在阻碍人们去寻找能够引导网络向更安全方向重稳的出路。

（二）证伪条件

一个经得起反驳的判断必须说出自己在什么情况下会被推翻。本章的核心条件是：若未来有一项设计严格的研究，在已被本章锚定为致密纠缠度极高的原发性高血压里证实，在患者完全不知情的隐蔽给药条件下（例如借由第三方管理、患者本人不知晓的给药系统，使其无法分辨服药与不服药的周期），一种精准阻断RAAS特定环节的降压药，能够在不引发任何可测量的、系统性的、多渠道的代偿（包括但不限于肾素活性的反射性升高、其他升压通路标志物的上调、与药物相关的行为或心理代偿，如因感觉“好了”而增加风险行为）的情况下，长期稳定地将血压控制在目标范围，并且在撤除隐蔽给药后不出现超过单纯停药效应的反弹，那么“在致密纠缠状态下，精准瞄准的获益存在本体论天花板”这一论断即告失效。

这一条件锋利，是因为它剥除了“患者知道自己在治疗”可能引发的全部心理与行为层面的纠缠，把战场只留给“身体无意识的生理代偿”这个最硬的核。如果此时精准药物仍能绕过跨越表征—物质断层的局部代偿逃逸，本章就被推翻；反之，如果在患者毫不知情的纯生理条件下，被压低的血压仍被一系列局部的、非表征的、受最小费力原则支配的物质代偿（如糜酶旁路的局部上调、受体的代偿性增敏）系统地推回，本章的判断便得到最强的经验支撑。此外，由本章机制直接推出的三条可检验预测，也是本章准备被推翻的地方。其一，若以靶点在已知互作网络中的介数中心性作为耦合密度的代理，单靶点干预的疗效应随之呈阈值型下降而非线性下降，若是线性，“临界”一词不成立，本章应改为程度描述。其二，在高耦合密度疾病里，间歇性、幅度较小的扰动加密集监测，其长期终点应优于持续足量的靶点压制，在低耦合密度疾病里两者无差异或相反。其三，心衰使用β受体阻滞剂的初始恶化，其幅度与持续时间应能由基线耦合密度预测，若与耦合密度无关而只与剂量相关，它就只是药理学的剂量效应，与本章无关。

本章的证伪条件与全书的书级证伪条件互相呼应：书级条件说，若撤回替定之后生命并未出现可测的失序与自行重组期，母题便被推翻；本章的隐蔽给药实验则从另一端检验同一件事，即在不含任何“被告知”的情形下，精准的替定能否不引发系统的重新组织。

– （三）本章小结

本章从母题的第三步出发，指出替定不只是损耗生命，它还必然落空。替定预设了一个可以被替它定下的固定目标，而在以原发性高血压为锚点、并推及重性抑郁障碍与肿瘤获得性耐药的致密纠缠场域里，这个目标在被命中的那一刻就变了：靶变量与制造它的多层过程强共振反馈，多层之间互不独立，干预本身又作为不可逆的新变量重新进入网络，于是每一次精准命中，都使系统沿着最小费力原则的方向重组，在下一时刻生成一个不同的靶心。心力衰竭中β受体阻滞剂的初始恶化，则让这一点以最直接的临床形态显现，成功不是命中，而是对一次数月扰动的承受与等待。面对精神分析的“解释即扰动”，本章的分离线在于扰动所处的场域：药物引发的代偿跨越了表征与物质的断层，无法被施动者反向读取；面对数字孪生的算力，本章的回答是非遍历的活系统会在强扰动下产生其过去从未出现过的代偿，那条河流的上游从未被记录。由此，“扰动—监测—重稳”取代“瞄准—命中—校准”，药物假期与行为实验是它的两个雏形。

回到全书的母题：精准的善意抢先替生命定下“好”的样子，替得越久，生命越长不出自己的答案。本章补上的是这个句子里最后一层含义：替得越久，系统越陷入追逐自己制造的新靶心。每一次替定得手，都在生成下一个需要被替定的对象；每一轮更精细的管理，都在为更刁钻的逃逸造出新的土壤。这个循环里没有谁是恶意的，用药的医生遵循指南，开发药物的人追求更干净的靶点，构建数字孪生的人想把逃逸也一并纳入管理。可是循环的另一端，是一个被反复击出旧稳态、却始终没有被允许走完自己的重组、也没有人在等待它给出答案的生命。既然替定必然落空，那么衡量“好”的判准就不能再放在预写的靶心上，它应当交还给生命自己：看一个系统在被打乱之后，能否自行重组出任何可以维持的秩序。这是下一章“溃散之后”要回答的问题。

本章参考文献

Clarke, A. E., Shim, J. K., Mamo, L., Fosket, J. R., & Fishman, J. R. (2003). Biomedicalization: Technoscientific transformations of health, illness, and U.S. biomedicine. American Sociological Review, 68(2), 161–194.

Engel, G. L. (1977). The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. Science, 196(4286), 129–136.

Hood, L. (2013). Systems biology and P4 medicine: Past, present, and future. Rambam Maimonides Medical Journal, 4(2), e0012.

Kitano, H. (2004). Biological robustness. Nature Reviews Genetics, 5(11), 826–837.

Kleinman, A. (1988). The Illness Narratives: Suffering, Healing, and the Human Condition. Basic Books.

McEwen, B. S., & Stellar, E. (1993). Stress and the individual: Mechanisms leading to disease. Archives of Internal Medicine, 153(18), 2093–2101.

Rush, A. J., Trivedi, M. H., Wisniewski, S. R., et al. (2006). Acute and longer-term outcomes in depressed outpatients requiring one or several treatment steps: A STAR*D report. American Journal of Psychiatry, 163(11), 1905–1917.

◆

08

第八章

溃散之后：把判准还给生命

◆ 一、蜂蜜牛奶：一个让所有判断语法失灵的夜晚

设想一位四十四岁的高中语文教师，姑且称她蒋老师。她被诊断为二型糖尿病前期，此后三年接受精准管理：持续血糖监测仪贴在臂上，糖化血红蛋白被压到了教科书上最漂亮的区间，冰箱里的食物被她自己用红绿灯贴纸分了类。代价是失眠，是体重一路下滑，是对聚餐的回避，是厨房从灶台变成了实验室。她在诊室里说过一句医生无法编码的话：“我现在吃饭，看到的不是菜，是碳水的克数。”还说过另一句：“我好多了，但我快死了。”这两句话在病历里没有对应的栏目，因为栏目是按指标设的，而说话的人早已不在指标上。

这个人物是本章论证用的思想实验，不是田野个案：作者在注释中明言，蒋老师、老周、陈阿姨、薛姐等人物均系基于临床经验的综合与构造，用于论证的展开，并非真实个案，细节已匿名化并做了简化与合成。读者需要记住这一点，本章后面凡写到他们，都是在推演一个判断的运转方式，而不是在报告某项调查的发现。

现在让这个思想实验走向一个出人意料的夜晚。假定在第四年，蒋老师放弃了所有精准管理，也放弃了所有心理治疗；她不再测血糖，不再去病友小组，不再同任何人谈“健康的生活方式”。她开始每晚独自喝一碗加了蜂蜜的热牛奶，那是她小时候母亲唯一允许她喝的“犯规的东西”；她开始深夜写作，写的不是疾病日记，而是一部关于她从未谋面的外祖母的小说，没有一个人读过。她的体重没有回到“理想范围”，糖化血红蛋白浮动在7.0%左右。她也不再回三甲医

院的糖尿病管理中心，只在社区医院拿药，医生问她感觉怎么样，她答“就那样”，转身走了。但她开始在深夜的屏幕前微笑。她丈夫说，她“变回了一个人，只是这个人比以前更不爱说话”。

请问：这位女性是健康的，还是不健康的？内分泌科会说，血糖管理失败。心理科会说，社会退缩。善于“以人为中心”的医生也许会说，她正在做一次不错的探索，但“仍需进一步引导”。每一种说法都握着一份剧本，并用它去比对蒋老师。而蒋老师的那只杯子与那部小说，不属于任何一份剧本里的角色。本章要论证的恰恰是，医学面对这只杯子时的失语，不是知识的缺口，而是认知语法的缺口：医学从未学会在不握剧本的情况下谈论健康。

– （一）本章在母题里的位置

全书的母题是：精准的善意抢先替生命定下“好”的样子，替得越久，生命越长不出自己的答案。本书把这一母题拆成三步：先是看不见，生命自己一直在给出的答案不长在“需求”“指标”“故障”这些地址上（第一至三章）；然后是抢先替定，系统用自己的答案填进那个位置，在叙事、发生权与判断三个层面上（第四至六章）；最后是长不出，替定越久，自行摸索与重组的能力越萎缩，而替定本身又注定落空（第七章起）。第七章已经证明了替定的落空：靶心在被命中的瞬间已不再是原来的对象，所以“扰动—监测—重稳”的替代姿态必然追不上它要瞄准的东西（见第七章）。

第七章处理的是替定“为什么不能成”。本章接手的是一个更尖锐的问题：替定落空之后，医学拿什么来判断一个生命系统是好还是坏？如果判断仍然要靠“它是否回到了我们预写的样子”，那么即使把靶点换成了更温和的目标，把指标换成了更宽泛的“可行秩序”，替定的结构就没有被撤销，只是换了名字。本章因此要做一件比批判更难的事：撤销一个所有人都默认的先验，即“守护者

知道被守护的生命应该重新组织成什么样子”，并在撤销之后，立起一条把判准还给生命自身的替代性健康判准。这条判准在全书中被称为溃散后自组织验。

在三步机制里，本章处于“长不出”这一步的正面。前面几章说的是，生命的答案被看不见、被抢先、被挤压；本章要说的是，如果不抢先、不替定，生命在最糟糕的处境里到底还能做什么，以及医学应当如何认识这种“做”。母题的负面是“长不出”，母题的正面则是：只要还没有死透，生命总有一口气在从自己的瓦砾里摸路，而医学的首要责任是认出这口气，并且不要把它按回去。

– （二）本章的边界与读法

先交代一个关键的自觉。溃散后自组织验不是一套新的临床规程。它不提供量表，不规定步骤的顺序，也不打算被写进诊疗指南的某一章。本章对它的全部主张，是松动医学在慢性功能性疾病领域里的认知语法：从“预设健康有一份已写定的剧本”，转向“承认健康是生命在溃散之后为自己重新发明任何一种可行秩序的发生”。认知语法松动了，临床动作才可能随之改变；反过来，如果只学动作而不松动语法，动作很快就会被旧语法重新收编，变成又一套规程。

因此，读本章时最需要防备的一种误读，是把它读成“发现了一个更好的东西”。那个好东西叫“生命自组织”，医生应当去推动它、培育它、评估它。这正是本章要拆除的动作。后文会反复回到这一点：任何把这条判准提前到事中去裁断的做法，都会在逻辑上自毁，因为它一旦被拿来裁断，就变回了它所否定的那类标准。

下面的论证按这样的顺序展开。先回顾对精准医疗的批判如何走了三级，以及它们共同预设了什么；然后给出新判准的定义与逻辑；接着用四个人物的病程检验它的容纳力与边界；再与四个最近的理论邻居正面对撞，并补切三个容易混

同的相邻概念；之后迎入三个最强的反驳；最后给出本判准的证伪条件，并把问题交给下一章。

◆ 二、三级批判共享的那块地砖：守护者知道“正确的秩序”

– （一）批判走了三级，每一级都止步于一道门槛

对精准医疗的批判，在慢性功能性疾病领域已经走过了相当远的路。第一级指向外部，是制度批判。它揭示医疗与产业的复合体如何把健康商品化，如何制造“风险状态”来圈养终身的客户，如何把利润的驱动披上科学纯洁性的外衣。这一级批判必要而有力，但它有一个无法自行克服的短板：它暗示只要把坏制度换成好制度、把坏动机换成好动机，精准医疗就可以趋于完美。它的力量止于制度的门框，没有触及门内那双正在操作的手所使用的语法。

第二级批判向内转，指向干预的“量”。过度医疗的论述深刻地指出，现代医学不断越过正常与病理的边界，把衰老、悲伤、社会压力这些生命的境遇病理化为需要管理的数据。这一脉思想捍卫了一条重要的边界，但它同样暗示，只要把干预量调回某个适度的区间，精准医疗就无害甚至有益。它止步于“度”的门槛，没能追问：划这条“度”的尺子，从哪里来？它在划定“合理干预”的同时，是否也悄悄划定了“合理的生命”？

第三级批判触到了“关怀”本身的内在语法，即所谓“驱活铸尸悖论”。它论证，问题不出在动机，也不出在剂量，而出在“精准地分解、对准、干预”这套操作逻辑本身。当这套逻辑被用在分子通路与生活世界高度紧耦合的慢性病上，那个被当作纯粹善行的精确命中，其内在语法就与生命维持自身完整性的需要构成了结构性的悖论：活着的、完整的生命主体被从自己的躯体中驱离，留下的是一具由精密度量维系、却失去了活着的感觉的躯体。这一判断把批判推进到了此前未被触及的地层，即关怀动作本身的逻辑。它提出的出路，不是退回前现

代的混沌，而是把医学的首要责任从“追求命中”转向“守护生命重新组织起任何可行秩序的能力”。

（二）“守护”叙事的温暖外壳

这一转向并不孤单。在以人为中心的照护的某些版本中，在慢病共存的倡导中，在康复运动的恢复模型的某些论述中，在慢性病自我管理支持的批判性反思中，都可以辨认出同一种判断：评判健康的标准不应再是是否符合外部的数据常模，而应是生命体能否在自身处境中建立起任何有弹性的、可以过下去的生活秩序。这里需要说明，“守护”叙事是对这一可辨识的复合倾向的概括，而不是对任何单一文献的指认；本章的论证针对的是这一倾向在逻辑上的共同停步点，不依赖对这些文献的逐条评价。

这一转向在两个面向上，比此前所有批判都更诚实。第一，它不幻想一个没有技术污染的伊甸园，承认混沌不是终点而是起点，健康是需要被重新组织出来的东西。第二，它把裁决健康的权力从检验报告单上解了下来，交还给那个正在生活的、完整的人。这是决定性的一步，本章的全部工作都建立在它之上。然而这一步走到这里就停住了，停在“守护”这个词的温暖外壳里，没有再追问外壳里面包着的那把刀：守护者凭什么知道，被守护的“重新组织”应该长什么样？

（三）把问题逼到墙角：一个医生对蒋老师说的话

设想一位践行“守护”叙事的医生，对蒋老师说：“我们的目标不再是把你的糖化血红蛋白压到6.0%以下，而是守护你重新组织起任何一种让你能好好吃饭、好好睡觉、跟家人好好说话的可行秩序。”这句话比“你要把血糖控制在……”温暖得多。但它仍然绕不开一个根本的问题：当蒋老师接下来试图重新组织她的生活时，医生依据什么判断她的重新组织是“可行的”、是“值得被守护的”？

这个问题有两个出口，都不通。如果医生没有任何判断标准，“守护”就只是一句空话：他无法在病历里为“守护”写下一行字，无法在疑难病例讨论中为“守护”的失败给出任何可操作的归因，无法在医患纠纷中为自己的临床选择说一个词，实际上退出了一切临床责任。如果医生有判断标准，哪怕他心里默认“能好好吃饭、好好睡觉、跟家人好好说话”就是那个正确的秩序，那么当蒋老师选择“不再同丈夫说话，每天独自吃饭，深夜写作”作为她重新组织的结果时，他会觉得自己守护失败了吗？他会出手干预吗？他若干预，他的干预同旧范式下那位用血糖曲线审判她的医生，在操作上有什么本质的分别？

这是“守护”叙事的阿喀琉斯之踵。它把“你必须达标”换成了温柔的“我守护你找到自己的秩序”，却没有撼动最底层的预设：存在一套可以被第三方识别、评估，并据此采取守护行动的“正确秩序”。旧范式把它叫作糖化血红蛋白6.0%，“守护”叙事把它叫作任何一种可行的秩序。名词换了，动词没有换，动词仍然是“识别一份已写定的剧本，然后让生命照着演”。只是剧本的编剧，从实验室换成了懂得“何为可行秩序”的临床智者。

– （四）五连问：把先验从最深处逮出来

作者用五个追问逐层撬进这个裂缝。第一问：这个领域里最痛的矛盾是什么？答案是那个令临床医生深陷无力感的日常场景：患者的所有可测指标都在理想范围内，糖化血红蛋白、血压、C反应蛋白、体重指数，若把这些数据从病历里单独抽出来，她可以被宣判为“治愈”，但她本人比确诊之前更痛苦。她失眠，莫名哭泣，不敢与人共餐，每一个本该轻松的时刻都被一套内在的、关于“我有没有做错什么”的精密算法监控着。她的生命被疾病与管理程序共同拆成了两套互不相认的东西：病历里那组完美的数据，与她自己无法被数据翻译的、持续下坠的生命感受。这与本书第三章讲过的情形同构：那里身体的代偿被

指南地壳当作故障来打击（见第三章），这里则是一个在指标上全胜、在生活里全败的人，同样落在临床认知的缝隙里。

第二问：旧的解释路径为什么反复失效？因为无论指向制度、剂量还是关怀的语法，它们都在同一个前提下工作：最终去“守护”秩序的那个守护者，在他的认知工具箱里，终究需要一份关于“什么秩序可行、什么秩序病态”的判断标准。否则，守护就成了无法制度化、无法教学、无法在疑难病例讨论里说出任何实质内容的个人善意；而个人善意，在现代医疗的庞大机器里，是最先被碾碎的东西。即便医生只是陪着，在制度化的医疗里，“陪着”这笔账怎么报，“陪着”失败了又由谁、以什么标准来定，同样无从回答。可是一旦这份标准被赋予，医生就重新坐回了他声称要离开的审判席，只是手里的不再是化验单，而是一份名为“可行秩序”的、更精致也更难反驳的剧本。剧本在措辞上显得更整体、更有弹性，并不因此就不再是剧本。

第三问：这些失效背后，所有人默认为真、从未质疑的先验是什么？这是整面墙背后的那根柱子，抽掉它整面墙就塌。这个先验是：生命在溃散之后想要重新组织起来的那个“秩序”，有一种可以被第三方识别、被第三方判断其可行性、并据此被第三方“守护”的客观形态。换言之，大家默认健康终究可以被写成一份剧本，哪怕这份剧本不再叫“糖化血红蛋白6.0%”，而叫“某种整体上的、与环境相适应的、有弹性的生命秩序”。剧本的名字可以换，剧本的存在从未被质疑。这就是所有“守护”叙事走到最后一步时，都会不自觉地滑回一个老动作的原因：替正在受苦的人画一幅“痊愈之后的生活”的草图。

美国医生与作家刘易斯·托马斯在《最年轻的科学》（Thomas, 1983）里记述的那一代老医生，与其说是在“守护”，不如说是在陪伴、等待，并用全部经验去辨认从病人自己身上浮现出来的、无法被事先规划的独特秩序。托马斯笔下的那种医学，不是“守护一种已知的能力”，而是“敬畏一种连医生自己都无法

完全理解的自发过程”。那个过程不是任何守护者能预先写定的，甚至不是病人自己能预先写定的；它是在无数个失眠的深夜里，在厨房变成实验室又变回灶台的缓慢煎熬里，被一米一米摸出来的。

这一刀切下去，“守护”叙事的温软外壳被切开，露出同一块骨头：医学背后那份被精心呵护的、对确定性的执念。旧范式执着于分子的确定性，基因、靶点、生物标志物；“守护”叙事执着于秩序的确定性，“可行的秩序”。两者都假定，健康在发生之前，就已经有一个可以被外部观察者辨识的正确形态；区别只在于，旧范式认为那个形态是一套客观的生化指标，新范式认为那个形态是医师慧眼所能辨认的某种理想生活方式。两者都预设了一份已写定的剧本，都把自己当作剧本的守护者，也都会在剧本与演员的现场发挥冲突时，选择修改演员，而不是撕了剧本。这与本书第五章刻画的发生权代管互为表里：那里是技术—制度复合体代理行使了“修复成什么样、走哪条路”的资格（见第五章），这里则揭示这种代理的认识论前提，即代理者自以为握着那条路的地图。

– （五）撤销先验：打开的是一片无人区，不是一个新范式

第四问：撤销这个先验，会打开什么？会打开一个此前被“诊断”与“守护”这两个动词占满的空间。在这个空间里，每一次从溃散中重新组织起来的生命秩序，都是一次独一无二的、不可复制的、而且注定不完美的发生；它没有范本，不可能被任何第三方，无论多么高明多么善意，提前知晓。医学的任务于是不再是“发现病人偏离了哪份正确的剧本，然后把他拉回来”，也不再是“守护他依照一份更宽泛的正确剧本去重新生活”，而是：保护那个正在摸黑往出爬的人，不让他被任何外部强加的标准，哪怕是打着“健康”旗号的标准，在中途砸倒。

这同时是医患关系的认识论重组。旧范式的对话是这样结构的：患者带着一组被解码为病理信号的感受来到诊室，医生把它翻译成治疗方案，患者执行并汇

报，医生据结果校准方案；这套对话的每一环都预设了一个握着正确剧本的人。蒋老师在诊室里说“我受不了了，但我说不出来是哪里受不了”，旧范式的医生会说“你的糖化血红蛋白很好，坚持住”；“守护”叙事的医生会说“你需要重新组织你的生活方式，我们一起来找找有什么可行的秩序”；而撤销了先验的医生会说：“你说不出来，没关系。我们先看看，是哪些东西正在压着你，让你连说出‘哪里不对’的力气都没有。我们不急着去找那个‘对的活法’。我们先把你身上那些不该你一个人扛的东西，卸下来几件。”

这不是一位“更聪明的守护者”在说话，而是一个承认自己不知道正确答案、却仍愿意行动的人。他的行动不指向引领，指向减负；他的临床判断力不再用来识别病人偏离了哪份剧本，而用来识别此刻是哪一种外部压力正扼住病人自己的呼吸，并设法把它移开。

必须立刻防备一个危险：这一问描绘的新图景，可能把读者引向一种被分析得很漂亮的“新发现”，“哦，原来溃散后自组织就是那个新的好东西”。如果读者产生了这种感觉，论证就已经滑回了它要批判的那种发现式的思维。撤销先验之后打开的空间，不是一个更正确的范式，而是一片无人区：没有人知道该怎么办，每个动作都可能犯错，每一句安慰都可能变成模具。医学进入这片地带，不是因为找到了更好的路，而是因为在旧路上它已经把太多人逼到了不想活的绝境。进入无人区是一种止损，不是一种升级。

第五问：哪个最小的、具体的反例，能一下子压垮旧框架？不需要复杂的反例，只需要本章开头那个夜晚的蒋老师。她的“健康的正确剧本”是什么？是内分泌科判定的“血糖管理失败”吗？是心理科判定的“社会退缩”吗？还是那杯蜂蜜牛奶和那部无人阅读的小说？无论是“精准达标”还是“守护可行秩序”的框架，如果无法正视这个案例而不陷入认知失调，它就已经被压垮了。那位“守护”叙事的医生面对她只能沉默：他不能说她“健康”，因为他没有一份可用来

作此判断的剧本；他也不能说她“不健康”，因为她显然比三年前那个拥有完美血糖却不想活的蒋老师，更像一个活着的人。蒋老师的生活不是任何剧本的演出，而是她在溃散之后用手边能捡到的碎片，为自己搭起的一个只属于她的、能继续呼吸的临时窝棚。这个窝棚不符合建筑规范，但它是活的。

◆ 三、溃散后自组织验：一个从矛盾中结算出来的判准

– （一）定义

撤销先验之后，需要给在这片无人区里运转的东西一个精确的名字。这个名字不能是已有概念的花样翻新，它必须是从那个最痛的矛盾，即所有指标都达标了、人却活不下去了，长期撕裂中自己结算出来的结构。本书称之为溃散后自组织验，英文可作 Post-Collapse Self-Organization Criterion。它的定义是：一个生命系统的健康，不以“符合任何一种被第三方事先定义的正确秩序”（无论是生化指标、功能状态，还是整体生活方式的可接受性）为判准；它的健康，仅以“在经历足以瓦解其所有旧秩序的溃散之后，该系统是否仍然能够从自己的混沌残余中，不借助任何外部强加的范本，自行摸索着重新组织出任何一个能让它继续下去的可维持秩序”为判准。这个定义有三层骨头：溃散是前提，自组织是内容，“验”是形式。三层缺一不可，也各自有容易滑脱的地方，需要逐层钉住。

– （二）第一层：溃散为前提，及溃散的两种层级

这里所说的溃散，特指整个生命系统同时崩解的状态：生理调节网络、日常生活节奏、社会角色、自我叙事一起塌掉。在这种状态下，任何“回到从前那个健康状态”的努力都已被证明无效，因为“从前”本身已经不复存在。这是慢性功能性疾病患者被耗竭多年之后，在没有一项指标“危重”、却已无法认出自己是谁的那一刻所经历的处境。承认这一点，也就承认了溃散不能被“早期干

预”绕开：早期干预的逻辑，是在溃散尚未发生时就去阻止它，而临床上有一种常见的情形，是许多慢性功能性疾病患者的第一次溃散，恰是被一系列“预防性干预”所引发的。这一点与第六章讲的健康抵押互相印证：当内感受判断力被抵押出去、每一次成功履行都在损耗它要赎回的东西时（见第六章），溃散常常正是这笔抵押到期的方式。

为防止概念后来滑动，需要对溃散做一个层级区分。触发溃散，指由外部干预的中断或环境的剧变诱发的生活架构崩塌，例如撤除持续血糖监测后，患者突然发现自己不知道该怎么吃饭了；这种溃散可定位、可归因，有时甚至能通过恢复干预逆转。基底溃散则是存在论意义上的断裂：自我叙事崩溃，意义感蒸发，那个叫作“我”的整体在持续的磨损里分崩离析。触发溃散可能诱发基底溃散，也可能不诱发；基底溃散则可以在没有任何可识别的外部触发的情况下，在漫长的病程里悄无声息地发生。溃散后自组织验所面对的溃散，是基底溃散已经发生或正在发生的状态。蒋老师与后面要谈到的老周，“指标完美但不想活”，就是基底溃散的临床表现。

– （三）第二层：自组织不是修复，不是适应，也不是装饰性的借词

自组织在这里有精确的含义：从系统内部残余的、模糊的、未经分析的素材里，在没有外部范本的情况下，自行生成一种新的、暂时的、局部的秩序。它不同于修复，因为修复预设一个有待回归的完整原型；它也不同于适应，因为适应预设一个外部的、稳定的环境标准，系统修改自身去匹配它。自组织的特点是，连那个“要去适应的目标”本身，也是在过程中被一步一步临时发明出来的。

– （四）第三层：验不是标准

三层之中最关键的一层，是“验”与“标准”的区分。这不是修辞之别，而是两种根本不同的认知逻辑。标准的逻辑是：先有一份清单，再用它去比对对象

是否符合条目。标准运作在事前，在过程开始之前就已写定，并贯穿全程行使审判权。验的逻辑恰好相反：不预设清单，只是等过程走完，从事后追溯，它发生了吗？它自己站起来了没有？它怎么站的，站成什么样，站了多久，这些都不由第三方来判定。它只要能站起来就行。判断“站起来与否”的权利不在任何第三方手里，而在那个系统自己身上：它继续呼吸了，继续吃饭了，继续同另一个人发生真实的触碰了，它站起来了。

事后追溯与事前裁断的这条区分，是论证溃散后自组织验不能被标准化为任何新标准的逻辑支点。任何标准，无论写得多宽泛、多“非评判”，一旦被写进临床手册、带进诊室，用来在某个时间点对某个患者作出“是否符合”的判断，那个做出判断的时刻，就已经把“验”从事后的追溯变成了事前的裁断：“此刻，我作为持有此标准的评估者，宣布你的这个秩序可行或不可行。”裁定被说出口的那一刻，它本身就成了对新秩序的第一次外部干扰。这也是“守护”叙事无法自圆其说的缘故：它想把本应只能在事后追溯的“发生了没有”，变成在事中可由第三方评定、促进的“能力”。

有批评者会说，临床实践中医生不可能不做任何判断；完全放弃判断，他就分辨不了“蒋老师在蜂蜜牛奶里找到了自己的秩序”与“蒋老师正在滑向抑郁的深渊”。这个批评完全成立，而溃散后自组织验并不要求医生放弃判断。它要求医生翻转判断的方向：不是问“她正在变好还是变坏”，这是基于预制剧本的判断；而是问“她自己的那个摸索过程，此刻正被什么东西压着”，这是一个识别的动作。前者需要知道答案，需要知道“好”长什么样；后者只需要知道此刻的障碍是什么。前者指向引领，后者指向减负。前者在事前裁断，后者在事中识别，而“这到底算不算活过来了”的最终裁决，则留给事后去追溯。

只要这个事后追溯的结构不被破坏，溃散后自组织验就不会被任何聪明的守护者重新标准化成一份新剧本。因为任何把它提前到事中去裁断的动作，都会在逻辑上自毁：它一裁断，就不再是验，而重新变成了被它自己所否定的标准。

– （五）把判准从第三方交还给第一方

把这个命名放到更大的哲学地形上看，它做的是一件很少有人做的事：把医学的规范性判准，从“第三方的识别”交还给“第一方的发生”。此前所有的医学判断，无论旧范式的“你的糖化血红蛋白应该是……”，还是进步范式的“你应该能重新组织起任何一种可行的秩序……”，都由一个观察者发出，这个观察者可以是医生，可以是公共卫生体系，也可以是内化了这套体系的患者自己；他手里永远握着一套关于“健康应该是什么”的脚本，哪怕脚本只有模糊的轮廓。溃散后自组织验不提供脚本。它只问一个事后才能回答的问题：它发生了吗？一个系统溃散了，一段时间之后，它自己重新组织出了任何能让它继续下去的秩序，发生了，就是健康；没发生，就没有。至于那个秩序长得是否“健康”，这个问题本身，在新判准的语法里是一个语法错误。下面要让它承受具体的病程，看它在哪里站得住，又在哪里显出边界。

◆ 四、四种病程：成功、失败、不体面与成功了一半

以下四个人物都是综合构造的思想实验，其目的是检验判准的容纳力与边界，不是提供疗效证据。需要先说明一个前提：溃散后自组织验不是一项可以被主动“施行”的干预，它不是认知行为治疗的升级版，也不是动机访谈的变体。它只能被“守护其发生条件”。所以，如果有任何临床动作可以被描述为与它一致，那首先是一个撤出的动作：医生从“我必须为她做什么来让她好起来”的紧迫感里撤出足够多的空间，让那个已经在暗中运转的自发过程，不被善意的外力打断或覆盖。

（一）蒋老师：撤出，以及撤出之后的动态考验

回到蒋老师的第一年末。那时她已戴了整整一年持续血糖监测仪，糖化血红蛋白完美，却在诊室里说了那句“我现在吃饭，看到的不是菜，是碳水的克数”。这是她的第一次求救。在旧范式中，这句话无法编码。在“守护”的新范式中，它可能被解读为“生活秩序受损”的信号，触发营养师与心理师协同的更全面的“生活方式整体干预”，那是一套更精致的守护。但在溃散后自组织验的逻辑里，这句话被听见的内容完全不同：那个在她体内工作的、想要重新组织出任何一种可行秩序的自发过程，正被“碳水克数”这套外部强加的知性框架窒息着。此刻医学最该做的，不是教她一套更人性化的饮食理念，而是撤掉那个正在窒息她的东西。医生能做的，是看着她，说一句在此前医学教育里不被允许的话：“你可以不用再测血糖了。不是因为你达标了。而是因为我看到，这个测血糖的动作，正在让你变得不会吃饭了。你不会吃饭这件事，比你的血糖高一点，更严重。”

这句话在旧范式的语法里无法说出口，因为它承认了一个被整个医学认知系统禁忌的事实：有时候，对疾病的精确认知本身，就是杀死生命的东西，为了保命，必须敢于放下认知。这不是放弃治疗，而是承认一种更根本的治疗：保护那个正在被知识扼杀的过程，让它重新开始呼吸。

假定蒋老师停掉了监测，不再每餐计算碳水，不再用红绿灯标注冰箱里的食物。头三个月是骇人的。她对医生说，觉得“像在闭着眼睛过马路”。那个曾被她熟练操作的、由血糖曲线与时间表构成的秩序井然的假体自我正在溶解，没有它，她赤身裸体地面对自己：一个四十四岁的、疲惫的、不知道怎么吃饭、不知道拿自己的人生怎么办的女人。这个过程没有脚本，没有一本指南能告诉她“溶解假体自我”的痛苦该持续多久，之后会出现什么。它不像停药后的生理反跳，

也不像一段标准的哀伤过程。她只是每天醒来，发现自己仍不知道该怎么吃饭。它只被命名为：溃散后的混沌。

这个故事不能只停在这里。对临床复杂性负责任的论述，必须呈现守护者自身也被卷入并受考验的动态场景。设想在停掉监测的第六个月，一次例行复查显示糖化血红蛋白反弹到8.5%。数字通过电子病历系统自动推送到她以前的营养师那里。营养师不知道蒋老师已换了新的照护模式，打电话来，语气焦虑：“怎么搞的，是不是最近压力太大了，要不要重新把饮食日记捡起来？”蒋老师平静地答“好的，我考虑一下”，挂了电话，然后崩溃了整整一天。她对丈夫说：“我果然不行。我连不管自己的血糖都不配。”

此刻那位践行溃散后自组织验的医生面对着极凶险的处境。他若袖手旁观，蒋老师很可能在这次崩溃里放弃，回到精准管理的旧轨道，或者滑向更深的自我厌弃。他若去“接住”她，用一个更温暖的“没关系，我们一起想办法”来安抚，这份接住会不会成为她新的依赖，使她从此需要这位医生来不断确认“你没搞砸”，从而重新把判断自己好坏的权利外置？

这位医生给蒋老师打了一个电话，说：“蒋老师，化验结果我看到了。8.5%。我想跟你说两件事。第一件：这个数字不说明你搞砸了。它只说明，你把一个一直在替你干活的外挂机器关掉了，现在你自己的身体在学着自己干。学走路的时候，摔跤不是失败。第二件：营养师给你打电话的事，我知道了。这是我的疏忽，我应该提前跟她说清楚，你现在不需要任何人替你算碳水了。这件事怪我，不怪你。你不需要去对付她的焦虑，那是我该对付的。”

这段话的临床逻辑值得逐层解剖。第一，医生承认了8.5%这个事实，却没有把它翻译为“失败”，而是重述为“学习成本”。他没有提供一个替代性的正确剧本，只是把此刻的波动放进“一个人关掉自动驾驶、重新手动学开车的正常过程”这个更长的时间框架里。第二，医生主动承担营养师焦虑的来源，把蒋老

师从需要“对付”外部评判的防御位置上释放出来。这个动作是撤除压力源：它不提供方向，只挪走障碍。第三，医生没有说“我相信你会好起来”，因为那仍是一个隐性的方向。他说的是“学走路的时候，摔跤不是失败”，这是一个没有方向指向的陈述，只描述过程的性质，不预测过程的结果。

蒋老师在这次电话之后没有立刻好转，继续失眠了两周。第三周，她自己决定去做一件事：去社区菜市场买了一把新鲜的茼蒿，回来洗净，用开水烫过，拌了盐和麻油，站在厨房里就着砧板吃完那一碗。没有测血糖，没有计算碳水，没有拍照发到任何病友群。她只是吃了，然后洗碗，然后去睡觉。这不是“重新锚定成功”，因为没有任何人，包括她自己，在那一刻宣布“我好了”。这只是发生。这个发生没有被任何外部的尺子打断，而这正是溃散后自组织验所要守护的全部。

此后的两年里，她重新发明了一套只属于她自己的日常秩序。它不符合任何一部二型糖尿病生活方式管理指南：她每天只吃两顿饭，上午十点一顿，下午五点一顿，这不符合“少食多餐”的原则，但她发现，只要一整天不必在“吃什么、何时吃”上做四次决定，心里那根一直绷着的发条就能松下来一些。她恢复了晚上喝热蜂蜜牛奶的习惯。体重只降了两公斤，离标准体重还远，但她不再在洗澡时嫌恶自己。她重新开始备课，不再把教案写得像论文，而在空白处画一只猫，注释“此处请王小禾同学表演打呼噜”。她知道自己回不到“生病前的那个自己”了，也不再想回去。她说：“那个‘以前的我’，也未必就比现在这个喝蜂蜜牛奶的、不爱出门的、会画猫的，更值得活。”

这是溃散后自组织验在一个人身上走完全程的样子。它不提供任何光鲜的、可被教科书收录为“成功案例”的素材，唯一的标志是：她还在。不止是物理上的在，而是那个能自己决定今晚喝不喝蜂蜜牛奶、能对自己说“我不想”、并承受这个决定的一切后果的主体，还在。说这个主体还在，并不是因为她符合了某

种被重新定义的健康标准，而是因为她重新拿回了定义自己什么算“好”的权利。这份权利，在旧范式里被移交给了糖化血红蛋白，在“守护”叙事里被移交给了懂得可行秩序的守护者，在这里，她把它拿回来了。她定义的那套“好”，蜂蜜牛奶、一天两顿、画猫，在任何一个医院伦理审查委员会看来都可能不构成证据。但它不需要被批准，它只需要发生。

（二）最凶险的测试：撤出之后发生了严重不良事件

上面是事后追溯逻辑的理想运行，它必须被推到更凶险的墙面上撞一次。让蒋老师的故事换一个走向：停掉监测后的第四个月，她没有反弹到8.5%，而是在某天凌晨发生严重低血糖，血糖2.8 mmol/L，昏迷，被丈夫紧急送进急诊。急诊医生在了解到她已停止所有血糖监测后，在病历上写：“患者自主停止血糖监测四月余，导致严重低血糖事件。嘱恢复持续血糖监测，加强糖尿病教育。”出院后，家属和之前的营养师一致认为，是“那个让她停掉监测的医生害了她”。

在这个场景下，“事后追溯”还站得住吗？那位医生会不会被迫在病历里写下“停止监测为医疗错误”？回应不能是狡辩，如“如果她没停药就不会出这事”，因为停药本身也可能只是偶然的触发条件，低血糖的成因可能更深；也不能是推诿，如“急诊医生不懂我们的理念”，因为急诊医生面对的是一个差点死于低血糖的病人，他没有任何理由去“懂”一个哲学概念。回应必须落在这条判准最根本的逻辑线上：在事后追溯的结构里，“是否停测”不是一个事前就能判定对错的决策，而是一个只能事后完整评估的、开放过程的一部分。那个凌晨两点，没有任何人，包括让她停测的医生，能预知这一夜血糖会跌到2.8；如果他事前知道，他就不会作出那个撤出的建议。可临床医学的常态恰恰是，没有人能在事前知道全部后果。旧范式应对这种“不知道”的办法，是用一套标准化的监测规程覆盖所有不确定性，哪怕规程本身正在窒息病人的生命；溃散后自组织验

应对“不知道”的办法，是容忍不确定性的存在，并同意在它兑现为惨痛后果时，不用“我早说过”去关闭那个刚被打开的空间。

设想这位医生没有自我辩护。他赶到急诊室，看到蒋老师苍白着脸躺在病床上，第一句话是：“你吓死我了。”第二句话是：“你没有搞砸。这件事，我们一起看看是怎么回事。”他没有把事件翻译成“停止监测的失败”，而是当作一个需要共同检视的信号。他后来在病历里写：“患者因低血糖昏迷入院。经评估，该事件的诱因可能包括：当日进食量异常偏少、近期睡眠剥夺，以及患者自主神经对低血糖的感知功能在长期被持续监测仪替代后尚在修复期。与患者共同决定：恢复夜间临睡前一次指尖血糖检测，作为临时安全网；不恢复持续监测。一个月后复评。”他不问“停止监测是否正确”，那是一个基于已写定剧本的事前评判；他问的是：“从这次事件中，她的身体学到了什么？她的恐惧是否因此变得更大，还是她因此对自己的身体信号变得更敏感了？”

这里值得停一下。医生恢复了一次指尖血糖，作为明确标记的临时安全网，这并不违背判准：安全网是为守住最低的生物学前提，而不是为规定秩序的样子，且它被标为临时、可撤销、一个月后复评。事后追溯在最凶险的后果面前，比事前裁断更诚实。事前裁断的逻辑是，因为发生了严重不良事件，所以此前的决策是错的，必须恢复全部旧规程；事后追溯的逻辑是，事件发生了，不急着宣判谁的决策对错，先看这个事件在系统内部引发了什么，是让它彻底放弃继续摸索的勇气，还是让它变得更警觉、更了解自己的身体信号。若是前者，医学需要替它承担一部分恐惧的分量；若是后者，这次低血糖就不再只是一个“不良事件”，也同时成了这个系统重新学习感知自己的一个沉重的、血腥的、却可能有效的数据点。这仍然不是一份剧本，它没有说“低血糖是好事”，只说：如果已经发生了，医学此刻能做的不是重写一遍“我早说过”，而是陪着那个人，在瓦砾里一起辨认那些此前从未有过的、关于她自己身体的细微的新知识。

– （三）老周：自组织未能发生

蒋老师展示了“验”所守护的过程最理想却不光鲜的形态。但必须同样诚实地面对另一种可能：系统在溃散之后没能自组织出任何秩序，最终走向崩溃或长期依赖。这不构成对判准的反驳，恰恰展示了它的边界。

老周，五十六岁，出租车司机，二型糖尿病确诊八年，合并高血压、高脂血症。公司要求他植入持续血糖监测仪并接受远程健康管理，此后他的生活进入与蒋老师最初三年相似的模式：精准管理，数据达标，生活质量持续下行。他不再出夜车，不是因为血糖控制不住，而是因为出夜车就意味着凌晨两点面对一份偏低的读数和妻子的责备。他不再同车友在大排档吃宵夜，不再在等客的间隙抽一根烟。所有指标都在理想范围内，他不再感到“生病”，感到的是“被管”。

他换了一位全科医生，这位医生作了与蒋老师相似的撤出：松掉所有非必须的监测与限制，告诉他可以吃任何想吃的东西，唯一的临床边界是，若连续一周每天空腹血糖超过11.0 mmol/L，或出现视物模糊、伤口不愈等警示信号，必须立刻回来复诊。老周前三个月恢复了大排档宵夜和夜间出车，体重反弹四公斤，对妻子说：“我觉得我活过来了。”然而第六个月起血糖开始失控。不是因为撤出本身错了，他的糖化血红蛋白在第三个月只是温和上升到7.5%，而是因为他把“撤除限制”体验成了“撤销一切”，开始大量饮酒，不再按时服降压药。医生试图同他讨论，喝酒和吃药这两件事能否找到一个他自己的安排，他拒绝任何讨论。第十二个月，他因高渗性高血糖状态入院；出院后被转回标准糖尿病管理路径，装上了胰岛素泵，重回精准管理。两年后他对医生说：“就这样吧，我不用再想了。”

老周的案例说明两件事。第一，溃散后自组织验不是神奇的开关，拔掉外部管控不等于系统自动生发出健康的秩序。第二，“自组织失败”不等于“验错了”。老周头三个月的反弹，大排档、夜班、同车友说笑，是他自组织的初步尝

试。这些尝试没能凝结成可持续的秩序，不是因为他不够努力，而是因为他的溃散深度、社会支持的储备、以及身体在多年被管理后自我调节能力的实际萎缩程度，可能已超出自组织所能覆盖的范围。这与全书的母题恰好相合：替定持续得越久，自行摸索的能力越萎缩，到后来即使撤回替定，也收不回来了。在这种情形下，医学的困境已不止于“不去干扰”：它需要更根本的社会支持、更长期的人手陪伴，以及更诚实的承认，在某些溃散面前，医学和患者都可能无能为力。

（四）陈阿姨：不体面的自组织

蒋老师的蜂蜜牛奶和深夜写作，在叙事上是美的。这带来一个危险：读者可能不自觉地把判准想象成对“有深度的、能讲出一个好故事的疗愈方式”的偏好。陈阿姨的例子要说明，这条判准同样庇护那些不美、不深、不讲故事的自组织产物。

陈阿姨，六十三岁，退休纺织工人，糖尿病十余年。在一段与蒋老师相似的“精准达标却活不下去”的经历之后，她在一位基层医生的默许下，不再严格控制饮食，不再每天测血糖。她重新组织出的“秩序”让女儿感到羞耻：每天下午去棋牌室打四个小时麻将，一边嗑南瓜子一边喝可乐，她擅自把无糖可乐换成了普通可乐，说“无糖的没味儿”。她拒绝参加任何糖尿病教育课，也不同任何病友交流。她的糖化血红蛋白常年在8.0%左右。可她在棋牌室里活跃、专注，会为一个杠上开花大笑；回家同老伴讨论今天张阿姨又欠了李阿姨五块钱没还；饭后重新开始同老伴去江边散步，走得很慢，走一会儿歇一会儿。女儿问：“妈，你这样算不算放弃治疗了？”她说：“我没放弃。我这不是活得好好的？”

陈阿姨的自组织不生产任何可以写成动人段落的“深度叙事”，它是低俗的，核心组件是麻将、南瓜子、可乐和街坊八卦；它的糖化血红蛋白在任何一座三甲医院的内分泌科都会被判定为未达标。但按溃散后自组织验的尺度，陈阿姨

与蒋老师站在同一块地基上：她溃散过，在没有任何人给她写“正确剧本”的条件下，自己摸索出了一套能让她每天愿意睁眼、愿意出门、愿意同另一个人发生触碰（哪怕那个触碰是“你欠我五块钱”）的可维持秩序。这套秩序是脆弱的，可乐可能在未来的某一天背叛她的血糖，棋牌室的烟雾可能影响她的肺功能。但这些属于“守护条件”层面的问题，即如何在不打断她自组织过程的前提下，温和地降低风险因素的强度；它们不属于“判准”层面的问题，即她这个秩序本身算不算健康。她算，因为她的生活在继续，因为她在笑。

– （五）薛姐：成功了一半

三个案例已构成一个有力的三角，但缺少一种类型：在溃散之后自组织出了某种秩序，但该秩序一年后被证明不可持续，系统再次溃散，而第二次溃散时，当事人对溃散本身的态度发生了根本改变。

薛姐，四十九岁，纤维肌痛确诊六年。在被疾病与精准管理共同耗竭之后，她在一位医生“撤出”式的照护下，自行摸索出一套以“每天早晨在阳台上给花草浇水”为轴心的日常秩序。它维持了大约十个月，她感觉疼痛评分有所下降，重新开始同丈夫一起出门买菜。第十一个月，母亲去世了，不是突然的，是漫长的、消耗性的临终照护。一个月后，她阳台上所有的花都死了，她重新回到了床上。疼痛全面复发，睡眠崩溃，不再回任何朋友的短信。

如果故事停在这里，它会被归为“自组织失败”，与老周并列。但在她第二次溃散的第三周，她的医生打来电话，没有问“你怎么样了”，只说了一句：“花死了，可以再种。你不用急着重新变成那个每天早上能起来浇水的人。那个人可能需要先睡很久。”薛姐在电话那头哭了一个小时。她后来对医生说，第一次溃散时，每一次躺在床上起不来，她都恨自己：“你为什么这么没用。”这一次她仍然起不来，却不再恨自己了。她说：“我知道我会起来的。我

只是不知道要多久。这个不知道，以前让我想死。现在它就是不知道。不知道，就让它不知道。花死了就死了呗。”

就这一构造的设定而言，薛姐在故事讲到的时点上还没有重新组织出任何稳定的日常秩序，仍然大部分时间躺在床上。但她开始回复朋友的短信了，内容是“我今天还是躺着的。但还活着。勿念”；开始在电话里同女儿讲她母亲年轻时候的事。疼痛评分没有显著改善，可她对医生说了一句以前从没说过的话：“如果我这辈子就这样了，我觉得好像也没那么可怕。”

按溃散后自组织验的尺度，薛姐目前还不能被判定为“验通过”，因为她尚未重新组织出任何可维持的秩序。但她的案例展示了这个“验”守护的不是一个终点，而是一口气。她在第二次溃散时没有像第一次那样把溃散当成“我的失败”来自我攻击；她知道自己会起来，却不再逼自己知道什么时候。这个“不再逼迫自己知道”，就是那口气没被掐断的证据。溃散后自组织验守护的不是一件成功的自组织产品，而是自组织作为动词的那口气，在每一次秩序塌掉之后，还能不能被重新吸进肺里。

四个案例合起来，给出了本判准的实际形状：蒋老师说明它可以走完全程，老周说明它不是开关，陈阿姨说明它不挑剔秩序的品位，薛姐说明它守护的是过程而不是产品。它们没有一个是“疗效”，因为判准本身不是疗法。

◆ 五、近邻检测：这面旗为何只能插在这里

一个新判准必须证明自己不是已有概念的换装，不是在别人的领地上偷偷竖旗。检验的方式是与最像它的对手正面相撞，划出一条能把两者辨别开的分离线，并且给出一个可以裁决的对照预测。

– （一）康吉扬的规范能力

康吉扬在《正常与病理》（Canguilhem，1943）中论证，健康不是与统计常模一致，而是生命体在环境变动时主动设立新规范的能力。这是本章最深的思想血脉，也是必须最诚实切开的对手。分离线在于一个默设的前提：规范能力假定，用来设立新规范的那套生理判准本身是完好的。一个人从海平面移到高原，身体能上调红细胞生成素的设定点，是因为体内那套进化遗传的、探测血氧并作出调整的生理智慧仍在工作。可在慢性功能性疾病的那类溃散里，被摧毁的恰恰是这套判准：纤维肌痛患者的中枢神经系统已不知道什么强度的信号应被解读为疼痛，慢性疲劳综合征患者的下丘脑—垂体—肾上腺轴已不能分辨紧急与日常，二型糖尿病患者的下丘脑对瘦素与胰岛素的敏感性已被重塑。身体不是在新环境里“设一个新规范”，而是连设规范用的尺子都被敲碎了。溃散后自组织验要问的是：尺子敲断之后，这个系统还能不能自己重新造一把，哪怕那把尺子极其粗糙、极不科学、极不符合任何第三方对健康的想象？

判决性对照：在一个由下丘脑—垂体—肾上腺轴深度失稳的慢性疲劳综合征患者构成的样本中，若一套以分级运动疗法和认知行为治疗为构件的标准化康复方案被严格执行，患者的“规范能力”（面对新挑战时弹性调整生理与行为参数的能力）被客观测量为上升，但她本人的主观痛苦与功能障碍评分却显著恶化，则康吉扬的框架会解释为“规范能力被错误地定向了”，而本章的框架会解释为：“设立新规范的能力”在这类患者身上已不再是恰当的判准；恰当的判准是她有没有从被强加的“规范建立”过程里被释放出来，并在释放后自己摸索出任何无规范的、却能让她活下去的日常秩序。这种对比在实证上成立时，两者才算分离。

（二）图姆斯的病患宇宙

凯·图姆斯以自己作为多发性硬化症患者的切身体验，在《病患的意义》（Toombs，　1987）中批判了医学的自然主义态度，区分作为客观病理的“疾病”与作为活生生体验的“病患”，论证医生由病理生理学构成的意义宇宙同患者由日常生活被打断构成的意义宇宙不可通约，并寄望医生以现象学的聆听弥合两个宇宙之间的鸿沟。本章的问题意识与她同源，也往前拱了一步：图姆斯没有追问，医生的“聆听”自己是否也带着一套关于“什么是好的病患叙事”的先验剧本。当一位多发性硬化症患者对聆听她的医生说“我只是想整天躺在床上看电视，不想做任何康复训练”，聆听的医生会把它当作患者的本真声音来尊重，还是当作抑郁的症状来干预？图姆斯的框架在事前无法区分这两种可能。

溃散后自组织验的区分在于，它不要求医生判断这个声音是“本真的”还是“病态的”，只要求识别：此刻是什么压着她？若答案是康复科护士每天来电催她训练，就挪开这个压力，继续观察她自己怎么走；若没有任何外部压力，但她自己陷入无法行动的僵滞，就继续陪伴，不替她裁定这是“值得尊重的休息”还是“需要干预的退缩”。裁决权留给事后。图姆斯是弥合两个宇宙的分裂，本章是承认分裂之后，不依靠任何一方，包括患者自己预制的剧本去跨越，而去守护一个无剧本的自发过程。判决性对照：在存在明确“疾病—病患”分裂的慢性疼痛综合征患者中，一组接受基于现象学聆听的共情式医患沟通训练，另一组接受以本判准为内核的“撤除剧本加事后追溯”模式。若前一组自报的“被理解感”显著更高，但在“自组织的日常微小创新的数目与持久性”上显著更低，则本判准的独立价值被坐实：聆听增加了被理解感，却仍可能以共情的姿态提供了一种新剧本，即“好的病患叙事应当是这样”。

– （三）安东诺夫斯基的统合感，及其与本判准的时间错位

安东诺夫斯基把医学的核心问题从“为什么人生病”翻转为“为什么人能在压力与逆境中保持健康”（Antonovsky，1979），其核心概念统合感由可理解性、可管理性与意义性构成。健康本源学已经把健康从“没病”重新定义为一种在混乱中找到秩序的心理资源。分离有两处。其一，它预设那个“找到的秩序”可以由一套跨文化、跨处境稳定的普遍心理结构来描述；本判准拒绝任何这样的普遍结构，不承认统合感是健康的必要条件。蒋老师那杯蜂蜜牛奶背后的情绪世界可能极不一致、极不可言说；陈阿姨的麻将和可乐更谈不上深刻的“意义性”，但若那四个小时让她愿意继续活下去，它就已完成了健康最根本的那个动词形式。其二，也是更关键的一处：统合感是前置资源，可以在溃散之前测量并用于预测；本判准原则上不能前置，只能在溃散发生并走完之后回头判定。

判决性对照有两条。在匹配了基线统合感与疾病严重度的两组纤维肌痛患者中，一组接受以提升统合感为目标的结构化心理教育，另一组被给予完全的自我管理空间，不被任何治疗师引导去寻求一致性感；若前者统合感得分显著升高而主观疼痛与功能障碍无相应改善，后者得分无显著变化甚至下降而自报的“我可以继续活下去的感觉”显著改善，则安东诺夫斯基的框架判前者成功、后者失败，本章的框架相反。另一条是时序上的：在一组即将经历重大健康溃散的人群中预先测量统合感，事后测量是否完成自组织。健康本源学预测统合感显著预测结果；本章预测，统合感的预测力有限，且随溃散强度上升而衰减，溃散越彻底，事前资源越不足以决定事后能否重组。若统合感在最强溃散组仍强预测，则本判准可被前置指标替代，“事后追溯”这一特征就失去必要性。

– （四）埃德尔曼的神经达尔文主义

埃德尔曼的神经达尔文主义（Edelman，1987）及其与托诺尼合作的动态核心思想（Edelman & Tononi，2000），为“自组织如何从混沌中产生有

序”提供了从分子、细胞到全脑尺度的最有力机制：一个高度可变的神经系统，通过群体神经活动的选择与再入过程，在没有外部监督程序的情况下，持续产生连贯的意识体验与行为模式。分离线在于，那种自组织是在基本构造（神经元、突触、再入回路）完好无损的条件下对动态模式的选择与稳定，它处理的是“一个完整的系统如何产生秩序”。慢性功能性疾病所考验的却是，一个连构造本身都已重塑或失稳的系统，如受体重塑、连接剪裁、表观遗传锁定，能否仍然产生任何秩序。埃德尔曼的自组织是能力尚完整的系统的高阶表现；溃散后自组织验面对的，是连能力本身都已被打残的系统的最后的、沉默的抵押品。

判决性对照：在重度难治性抑郁症（伴童年创伤史）的患者中，若全脑功能连接组学显示其默认模式网络与显著性网络之间的动态切换持续处于被该框架定义为“失稳与碎片化”的状态，而这组患者在撤去所有要求他们“恢复”的干预之后，自主发展出一套不依赖正常网络动态切换的、行为水平上的、高度个性化的日常稳定节奏，则埃德尔曼与托诺尼的框架会在神经层面判其异常甚至退化，而本判准会在行为层面判其健康。一旦这一对照被检验，两者便不可混用。

（五）三个容易混同的相邻概念

除这四家之外，还有三个相邻概念必须补切。自创生理论（马图拉纳与瓦雷拉，1980）是“生命自行生成并维持自身秩序”这一命题的正式命名：活系统由一张组分生产网络构成，网络的运作不断再生产网络自身并划定边界，环境只能触发它，不能指定它的下一步。分离线在于：自创生守的是组织同一性，只要系统还活着，组织就保持不变，变的只是实现该组织的结构；本章追的则是承重节点的更换，旧的承重节点被外力打断之后，系统换了一套承重节点继续运作，如表皮生长因子受体信号被阻断后依次改用耐药突变、再转向旁路扩增，如胰岛β细胞退回去分化的休眠态。这些不是同一组织的不同结构实现，而是组织本身被重写了一次，系统并没有死。可裁决判据是，取任一慢病或耐药演化过程，在

扰动前后分别标定关键承重节点集合与依赖拓扑：自创生框架预测拓扑不变，本章预测拓扑发生替换，交集可以趋近于空而系统照常运作；若始终观察到的只是零件换了、图纸没变，则本判准可还原为自创生的医学应用，命名冗余。

韧性通常被定义为系统受扰后恢复到原有状态或功能水平的能力，其中的“原有状态”正是范本；即便最前沿的适应性循环理论，也预设系统内有一组组织蓝图或适应潜力库可被反复调用。溃散后自组织验处理的是这些原则本身已被瓦解的真空：连蓝图和潜力库都已烧毁，系统不是恢复到旧状态，也不是按旧剧本进入下一个循环，而是在所有剧本都被烧掉之后，第一次试着写一行此前从未有过的字。

创伤后成长（Tedeschi & Calhoun, 1996）描述的正是旧秩序被摧毁之后长出新东西，并已有成熟量表，是本判准最直接的既有操作化版本。分离线是：创伤后成长量表测主观意义重构，问的是“你是否觉得自己更强大、更珍惜关系、发现了新的可能”；本判准不问感受，只问这个系统事后是否稳定运行了下去，哪怕当事人主观上毫无成长感，甚至觉得糟透了。可裁决判据是同时测两者与客观的秩序维持指标，如复发率、功能状态的稳定、再入院：二者高度相关，则本判准只是创伤后成长的行为学代理；若出现明显的“高秩序、低成长”象限，即活得稳定却毫无成长叙事，则本判准切出了量表装不下的一格。这一格是否存在，是本章成立与否的关键。

– （六）两翼夹击

一面新旗帜同时承受两个方向的炮火。左翼说：规范能力、病患宇宙、一致性感、自组织都已讲得更好。右翼说：你只是给医学的失败换了个好听的名字，技术更好的时候你就会被忘记。对左翼的回答是那条反复磨锋利的分离线：现有的自组织与规范性理论，要么预设了判准的完整，要么预设了第三方聆听与评估的位置；本判准处理连判准本身都已被敲碎的处境，并彻底限制第三方的判断

权。对右翼的回答是：当判准被敲碎，技术更好只会加速驱替，不会重建健康；重建需要的不是更精密的靶点，也不是更温暖的守护者的判断，而是保护那个在无靶点的混沌里、用最笨最慢最不科学的方式重新摸出一条路的生命。

◆ 六、三个最强的反驳

反驳一：无法被随机对照试验验证，所以在科学之外说话。 回应：判准确实不能用传统随机对照试验验证，因为它不是可被随机分配的干预，而是一种判断的判准。但它可以受另一种更根本的检验：上一节每条分离线末尾都附了判决性对照，不需要把判准当作干预来随机分配，只需把以它为内核的照护模式与以某近邻为内核的模式，在疾病紧耦合程度匹配的人群中前瞻比较，并在与分离线直接相关的终点上测量。若由第三方提供正确剧本的模式，在患者自报的“我可以继续活下去的感觉”上不劣于撤除剧本的模式，本章的立论在那片疾病领域里就被敲碎了。

反驳二：这是向虚无主义投降。 若连健康都没有客观标准，患者摸索出的“秩序”是酗酒或自毁，难道也算健康？回应：这混淆了自组织与解体。自组织严格地指系统从内部产生一种能让它持续地、非破坏性地同自身及环境交换的秩序，关键是自持性：秩序的维持是否持续依赖外部高强度的物质或行为输入，使系统自身的组织能力持续萎缩。重度成瘾的实质不是组织了新秩序，而是用外部的强输入覆盖内部已无法组织秩序的空洞，把组织秩序的能力永久抵押给了外部物质。但灰色地带存在：酒精依赖早期，主体可能确实觉得“更能在社交中呼吸”。所以自持性被补强为一个次级判准：判断一个行为序列是自组织还是解体，不取决于它早期被如何体验，而取决于它可预测的终点在客观上是扩大还是缩小了系统未来可选的自我调整空间。这个外部锚点不是第三方对“正常生活方式”的看法，而是药理学对特定物质长期暴露下损害神经可塑性的证据。蒋老师的蜂蜜牛奶与陈阿姨的麻将也含某种依赖，但它们嵌在她们自己发起的更广泛的

日常秩序里，且她们没有丧失“不想喝的那一天不喝”的能力。这条线划开了虚无主义的大门，却不需要任何第三方在门外充当守门人。

这里必须坦白一处内部张力。定义说“仅以”能否自组织为判准，而自持性与药理锚点又是附加的边界；它们是否悄悄引入了第三方的判断？本章的回答是：边界划的是“自组织得以发生的最小生物学前提”，不是秩序应有的样子；但这个前提的划法仍需临床上谨慎、可被质疑地使用。这是本判准最需要后续检验的位置之一。

反驳三：无法操作化，且患者主动请求剧本。 医学必须作决定；患者在溃散中常需要一个明确的、哪怕暂时的方向，要求她们独自摸索可能是新的暴政。回应：前一重已在第三节回答，判准不是从干预撤向不作为，而是从以预设剧本为基础的干预转向以守护自组织发生的条件为目的的干预，即识别并移除窒息自发过程的外部压力，如不合理的保险偿付规则、其他专科强加的指标、家属对“正确康复”的执念。后一重：当患者说“请告诉我该怎么办”，她不是在要一份正确答案，而是在表达一种需求，这本身就是自组织行为的一部分。医生可以问：“你能告诉我，为什么现在特别需要一个确切的答案吗？”或者说：“我也不知道什么对你最好。但我会一直在，直到你自己摸到你觉得可以的方式。这期间你需要我做什么？”若她仍坚持要具体指导，可以给一个暂时的、可撤销的、明确标记为“这只是我们暂时试试的东西，不是你必须永远照做的剧本”的建议；这种显式的暂时性与可撤销性，就是判准在临床对话中的操作化入口。最后是实践边界：若患者正以可预测的方式走向躯体组织的不可逆损伤或死亡，且行为序列满足上述“解体”判据，医生的干预义务并不免除，因为此时介入不是因为她偏离了正确剧本，而是她的行为正在关闭“未来产生任何新秩序”的可能。自组织需要一个最小的生物学前提，保护它不是提供方向，是守住边界。

作者还给出了三个最小接口。第一个是激活的情境：当长期被精准管理的患者说“我受不了了，但我说不出来是哪里受不了”，判准即被激活，医生不必立刻知道该怎么办，只需知道此刻任何“提供解决方案”的手都会干扰那个在暗处摸索的过程，所以第一件事是降低干扰强度，暂时撤除一切非维持生命所必需的监测与评判，对患者说：接下来只做一件事，保住你不用再害怕来见我这一个小时。第二个是一套最小步骤：识别溃散，即生理调节、日常节奏、社会角色、自我叙事是否均已崩解、任何“回到从前”的努力是否均已失败；识别窒息自组织的外部压力源，包括医疗方的、家庭方的、患者自我监控方的，并按紧迫性排序；试行撤出最上游的一项；一个月后只问“有没有发展出任何我从未建议过的、让你觉得还能继续下去的微小习惯”；有，就保护它不被后续干预覆盖。第三个是外推：被学校纪律反复惩罚的学生，在放弃“遵守纪律”之后有没有自己发展出不让课堂崩塌的互动方式；失去全部旧规范的团队，在没有被强加新规范时有没有摸索出能让工作推进的临时秩序。三者都应读作松动语法的示例，不是规程。

◆ 七、证伪条件、边界与本章小结

– （一）证伪条件

判准不是关于“何种干预更有效”的因果命题，所以它不能被“某种剧本化干预在主要终点上优于去剧本化陪伴”所证伪，那只会证伪一个关于干预效果的假说。它的效力取决于能否持续做到一件事：在每个临床判断的关口，比现存的任何判断框架看见更多、更准。所以证伪条件是：若出现一个具体的溃散后自组织案例，满足“第三方未强加范本”与“系统自行摸索出可维持秩序”两个要件，而本判准未能提供一种视角，使该案例免于被现有判断框架判作“不健康”或“偏差”，即没有在任何一个临床抉择的分叉口给出此前判准都给不了

的、实际改变判断的辨别力，则其立论根基从内部被淘空，降级为一段曾被认真对待、却并未增强医学判断力的思想注脚。

此外，另有三条可检验的预测。其一，事后专属性：任何用事前指标预测本判准结果的模型，解释力上限应显著低于预测传统健康结局的模型，若事前预测同样有效，则“事后”不再必要。其二，守护强度呈倒U形：外部支持强度与自组织成功率的关系应是倒U，且下降段出现在支持带有明确目标模板时；若关系单调上升，对“守护”的批判不成立。其三，可迁移性：若判准确在发生层面成立，应能在经历彻底重组的组织、社区或生态系统中给出同样的判定；离开医学语境后无法判定，则它只是慢病领域的局部规则。

（二）本章小结

本章撤销了三级批判共享的先验，即守护者知道生命应当重新组织成什么样子，并以溃散后自组织验取代之：健康是一个只能事后追溯的动词，问的是生命在旧秩序全部崩解后，能否从自己的混沌残余里不靠范本地重组出任何可维持的秩序。它不是新规程，只是松动认知语法；在无人区里，医学的责任是减负、撤出、识别压力，而不是引领。

回扣母题：全书说，替定越久，生命越长不出自己的答案。本章是它的另一面：只要不替定，哪怕在最深的溃散之后，生命仍可能从瓦砾里长出来，蜂蜜牛奶、麻将、一天两顿饭、每天早晨在阳台上浇水的日子，都是长出来的东西。但老周的案例提醒，替定过久之后，这种长出的能力也可能收不回来。

还需划一条防止误解的边界。本章所说的“健康的动词形式”，不是比指标更原初、更纯粹的健康本质，也不是应当回归的本真状态，它在本体论上没有优先性，只是医学放下尺子的那一刻才得以被看见的东西，此前一直被尺子挡着。旧范式写定的剧本叫糖化血红蛋白6.0%，“守护”叙事写定的叫任何一种可行

的秩序，规范能力、被共情聆听到的病患叙事、统合感也各有各的写法；前者是硬刀子，后者是越来越精巧的软刀鞘，刀还是那把刀。溃散后自组织验是把刀放下之后，第一次直接去看那个在废墟底下一寸一寸往外爬的过程，它可能爬到一半就停，也可能三年只爬了一厘米，那一厘米叫“我今天能在洗碗时多站两分钟”。

于是留下最后一个问题：若溃散到什么都长不出来，如重度失智的老人，不再能摸索、不再能判断、也不再能讲述，判准便没有可追溯的事后可言。那时照护还剩下什么？第九章将回到养老的场景，回答这一问。

本章参考文献

Antonovsky, A. (1979). Health, stress, and coping. San Francisco: Jossey-Bass.

Canguilhem, G. (1943). Le normal et le pathologique. Paris: Presses Universitaires de France.

Edelman, G. M. (1987). Neural darwinism: The theory of neuronal group selection. New York: Basic Books.

Edelman, G. M., & Tononi, G. (2000). A universe of consciousness: How matter becomes imagination. New York: Basic Books.

Thomas, L. (1983). The youngest science: Notes of a medicine-watcher. New York: Viking Press.

Toombs, S. K. (1987). The meaning of illness: A phenomenological account of the different perspectives of physician and patient. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

◆

09

第九章

位置性存有：什么都长不出时，他仍占着一个位子

◆ 一、替定推到底：连“人的位子”也被替掉

本书从一间养老公寓里的老人讲起，讲到诊室和慢病管理的数据界面，现在要回到养老。八章走下来，同一个结构在两个场景里反复出现：生命一直在给出自己的答案，只是这些答案不长在系统设定的地址上，于是越精准、越周到的系统越看不见它们（看不见）；看不见之后，系统用自己的答案填进那个位置，需求清单、风险预警、指南路径、靶点、数据阈值，一律出于善意，常常也确实有效（抢先替定）；替定持续得越久，生命自己摸索、判断、重组的能力越萎缩，而被瞄准的对象在被命中时早已不是原来的对象（长不出）。前八章把这条线从老人的生迹与残迹，推到身体的代偿，推到叙事的先占、发生权的代管、内感受判断力的抵押，再推到致密纠缠中靶心的漂移，最后在第八章落到一个正面的判准：健康不是回到预先写好的剧本，而是溃散之后能否自行重组出任何可维持的秩序。

到这一步，一个问题躲不过去了。以上每一章讨论的，都是替定替掉了什么：替掉了“好”的样子，替掉了走向“好”的路径，替掉了判断“我好了”的资格。被替掉的东西，无论多么要紧，总还有一个前提——那个被替的人，仍然在场，仍然是被认作“人”的那个人。生迹需要有一个人在生，残迹需要有一个人曾经想过、曾经没做成，叙事需要有一个人去讲，重组需要有一个人去重组。替定再深，替的也是这个人该怎样“长”。可是有一种处境，连这个前提也没有了。晚期失智的老人，不能再说自己是谁，不认得女儿，不表达好恶，不控制身

体，眼神也不再给任何人回应。她身上已经没有什么东西在“长”，没有可供辨认的生迹，也没有可以被填充的残迹。那么，当替定一路推到尽头，会发生什么？

本章的回答是：它会替掉最后一样东西，也就是“他还是一个人”这件事本身。这里需要说得小心。晚期失智带来的能力丧失，首先是疾病的进程，不能算在智慧养老头上，本书也无意把它归咎于任何善意的系统。本章要看的是另一件事：在能力、记忆、身份已经散尽的地方，一个人凭什么还被当作人对待。在功能照护的逻辑里，这个“凭什么”有一个默认的答案——凭他还有需求，凭他还有指标，凭他还能被服务得更好。需求越少、指标越平、偏好越难辨认，他在系统里的存在感就越稀薄，直到“不产生偏好的人”被自动排除出交互，成为一张只需要维持的床位。系统没有谁宣布他不是人，它只是不再需要把他当人，就能把全部流程运转得很好。这是替定在最极端处的形态：此前替的是“好的样子”，到这里替的是“有没有一个人在这里”。

本章把照护必须先护住的东西命名为位置性存有：不依赖任何能力、记忆或社会身份，仅仅作为“在世界中占着一个位子的人”而被无条件地承认与回应的基本状态。这个名称里的“位置”二字要从字面上理解。它不是尊严的美称，也不是权利的清单，而是一个具体的、有人在每天维持的占位：有人叫他的名字，有人进房间先打招呼，有人把他的轮椅摆在能被看见的地方，有人不把他的头发梳成无人在意的样子。它是一个被占着的位子，位子上的人可以什么都不再有，位子仍在。在全书的结构里，本章因此占据一个特殊的位置。前八章回答的是“生命自己的答案该怎样被听见、被还给他”，而在生命已经没有能力给出任何答案的地方，这个问题要换一个问法：如果什么都长不出来，照护最后要守的是什么？本章认为，守的是那个位子，也就是不替他把“他是不是一个人”也定掉。

要把这件事看清，不能从抽象的“人的尊严”谈起，因为抽象的尊严恰恰是智慧养老最擅长使用的语言，每一份系统白皮书里都有它。更有帮助的做法是回到一个很小的动作。陈晓艳研究的开篇案例里，有一位王奶奶，她把智能药盒收进了柜子。她拉开抽屉，把药盒放进去，关上抽屉。这个动作很容易被读成“拒绝技术”的任性，或者读成对自主权的捍卫。可是她捍卫的东西，比“自主权”这个大词更小，也更基础：她在这个世界上被允许作为“一个不打一声招呼就可以睡过头的人”而存在的资格。下一节先从这个抽屉开始，看一个精准、周到、善意的系统，怎样在一连串没有任何恶意的日常互动里，把一个人从她的位子上轻轻拂去。之后，本章依次进入三条最强的伦理传统，看它们如何在晚期失智的照护现场同时失效；再论证位置性存有为什么在逻辑上先于善与美；然后走进一间照护机构，看这个位子怎样一块砖一块砖地被重新砌起；最后正面回应怀疑论的诘问，给出证伪条件，并以本章小结收束全书的正文。

需要事先交代本章的材料。本章的主要依据是陈晓艳关于养老照护中位置性存有的研究，其中的药盒案例、照护员与重度失智老人的日常、一家社区嵌入式养老机构的田野叙事，都出自该研究的记述。这些材料是质性的、个案的，本章不把它们当作统计证据，而是当作一个论证的现场：论证要说的是一条底线，一条底线不靠样本量成立，靠的是人们在它被越过时能够指认出来。

这一追问与既有研究的回应方式不同。面对智慧养老带来的困境，既有研究大致走两条路：一条是技术修正，把问题诊断为算法偏见、隐私泄露、界面不够友好，提出更合规、更“以人为中心”的设计；另一条是人文关怀，呼吁在技术之外补足人际温度与精神文化生活。两条路都触及了问题的重要面相，但共享一个未经审查的预设：在被技术“服务”的那一刻，老人作为值得尊重的人的基本身份，已经稳稳地立在那里，技术的失误只是在这个身份之上加了偏差或损害。本章追问的恰是这个预设。如果老人最深的危机不在于服务得不够好，而在于被

服务这件事本身，把他从“人”的位子上轻轻拂去了，这两条路便都没有碰到问题的根。

◆ 二、无声的篡位：药盒怎样把“母亲”换成“病人”

先看那个抽屉之前发生了什么。故事分几个阶段，每个阶段都没有人做错事。第一阶段是一个早晨。一位独居的八旬老人，前一晚失眠，清晨正在补觉，智能药盒的蜂鸣把她惊醒。她按掉提醒，服了药，脑子里却滑过一个从前不曾出现的念头：如果她没有在预设时间内按掉这个蜂鸣，一条通知会在几秒内发到女儿的微信上。中午，女儿的电话如期而至：“妈，今天早上怎么晚了？”老人应付了几句，挂断之后心里不舒服。这种不舒服值得追问，因为它不是愤怒，也不是被剥夺了什么具体的东西。它来自一个更轻的层面：她一个再自然不过的生理波动，睡过头，被一套她无法控制的系统捕获、翻译、评估、通报，在另一个人心里被定义成“需要关切的问题”。“昨晚没睡好，今早补了个觉”，这是她自己的版本，包含她的疲惫，也许还有一个关于年轻时的梦。系统的版本是“作息异常，已通知紧急联系人”。两个版本里，后者立即取得了优先的解释权，并启动了社会反应。这比隐私被侵犯更深一层：隐私侵犯是别人看到了不该看的，这里发生的是系统在“看”的同一瞬间，就完成了对“看到了什么”的定义。

第二阶段发生在半年之后，女儿四十岁生日的前一晚。老人用颤巍巍的手花了一个多小时，在微信上给女儿写了一段长长的祝福。第二天一早，她因此忘了吃药。药盒准时提醒，准时通知，中午女儿来电，语气里带着着急与苛责：“妈，你今天又忘了吃药！跟你说过多少次了，这个药不能断。”老人握着听筒，一个字也说不出来。她想说“今天是你的生日”，这句话哽在喉咙里。药盒与围绕它编织的通讯机制，不认识“母亲”这个词，不认识“生日”，不认识一个八旬老人花一小时写微信所付出的全部诚意，它只认识一条规则：未按时服药，通知紧急联系人。于是在母女实际的生活世界里，那天早晨最重要的事件被

系统全然、无声、毫无恶意地漏掉了，被捕捉并放大的，是人的世界里无关紧要的“忘吃药”。

这一幕的要害不在女儿的苛责，也不在老人的沉默，而在“位置”的更替。在药盒来到这个家庭之前，这位老人在女儿的世界里占着一个无可替代的位置：那个生她养她、到她四十岁仍会花一个小时给她写生日祝福的妈妈。这个位置不依赖她是否按时吃药，不依赖血压数据是否正常，它先于一切功能，是亲密关系的历史所沉淀的“基本被认出的状态”。药盒与通知机制日复一日运转，每发出一次通知，女儿每打来一次追问吃药的电话，“需要被管理的病人”这个位置就在代际互动里现实化一次，“母亲”这个位置就被覆盖一层。到生日这天，替代完成了它最后一击：本该属于母亲的时刻，病人的位置被系统精确、高效地激活，母亲的位置被架空。老人说不出话，是因为她作为母亲立足的那个根基，在那个瞬间被抽空了。

这个过程值得再拆细一点，因为它说明替定是怎样在没有恶意的情况下发生的。系统“看到”的，从来不是“一位母亲在给女儿写祝福”，而是“预设服药窗口已过，药盒未被触发”。这个“看”本身就是一道滤光镜：它从老人那个早晨的全部行为里，只切出对它有意义的一个片段，其余一概抛弃，被抛弃的不仅是祝福的内容，还有“母亲为女儿花一小时做一件事”在代际关系里的全部分量。被保留的片段立刻被重新命名为“漏服”，并据此启动通报。通报发出时，系统完成第二重动作：它激活了一条社会反应链。女儿收到通知时，也许正在读母亲昨晚发来的祝福，心里涌着柔软的愧疚与爱。那条通知在此刻弹出，把她从“正在被妈妈爱着的女儿”的位置，轻轻拽向“需要对妈妈负责的监护人”的位置。这不是女儿缺乏感受力，而是来自“中立机器”的消息天然带着一种紧迫感：它说的是风险，是需要处理的问题，而面对风险，人当下的情感波纹，那些关于生日的柔软感触，总是最先被挤出注意的中心。女儿的着急正是出于爱，出

于怕母亲出事，只是这份爱被系统导流进了一个单一的出口：“你忘了吃药，我很担心。”老人听到的不是“我爱你，妈妈”，而是“你又没管好自己”。

这套过程在母女之间不断递归，每循环一次，病人的位子被巩固一层，母亲的位子被侵蚀一层。老人收起药盒，不是否定它的功能，她知道那是为她好。她反抗的是被系统拉进一种让她不再是母亲的互动模式。可是在系统端，这个动作立即被解释成一条新数据：“依从性差”。她的反抗本身，也被吸收进了她试图逃离的叙事。整个过程的全部暴力，不在任何一步的恶意，而在它从头到尾运行在位置性存有的盲区里：系统不认识那个早晨对她意味着什么，而系统赋予女儿的那种“关切的视角”，又无形中替她决定了谁最值得被看见，不是一个在她四十岁时仍笨拙地爱着她的母亲，而是一个又一次没管好自己的病人。

把这个案例放回全书的论证里，可以看到它与前几章的关系，以及它走得比它们更远的地方。第四章讲算法叙事抢在主体之前开口，药盒的“作息异常”确实是一种叙事的先占；第五章讲发生权的代管，药盒与通知机制确实在代管“这个早晨算什么事”的定义权。但本章要指出的，是这两层之下还有一层更基础的东西：一个人在不附带任何能力、贡献、自我叙事的前提下，仍然被允许作为占着位子的人而存在的资格。叙事权关乎“我被怎样讲述”，发生权关乎“我下一步成为什么”，而这个资格关乎的是“我是否还被允许在这里”。前两者被夺走，人是受了损失的人；第三者被夺走，人就不再是需要损失赔偿的主体，而成了一个只剩维护问题的对象。王奶奶没有遭受任何明显的剥夺，她的药吃了，她的安全有保障，她的女儿很关心她。她感到的只是“不舒服”，只是自己不再是自己生活的那个不可替代的主人，而要靠一台药盒来承认。几十年的母女情分，挡不住一条通知的效力。她感到的不是被爱，而是被管理；不是被认出，而是被定位。

还需要把这一点与“主体性丧失”区分开，免得读者以为位置性存有只是主体性理论的另一个说法。主体性关乎“我能做什么”，叙事身份关乎“我被记得是谁”，而位置性存有关乎的是：当所有的“能”与“是”都被剥离之后，我是否仍被允许作为一个人，一个无法被任何标签替代的、唯一的“这一个”，存在于他人的世界里。王奶奶的处境还只是这个危机的开端，她还能写微信，还能拉开抽屉，还能用一个动作表达反抗。可是当能力继续退潮，直到连抽屉也拉不开，直到不再有人能听见“不舒服”这三个字时，保护她位置的东西，就不再能依靠她自己的任何一次拒绝，只能依靠别人是否仍然愿意先于一切功能，承认她是谁。

◆ 三、在哲学失效处：三大传统为什么都接不住

一个概念若只是把既有的东西换了新名字，就没有必要引入。位置性存有要通过的检验是：它能否被已有的、同样处理“无条件对待他者”这一主题的哲学传统，用一句话替换掉而不损失实质？本节把检验放进最难的现场，不做“某某说了什么、本书的概念有什么不同”的比较，而是看三大传统在晚期失智的照护现场各自从哪里断裂，那个断裂的缺口里剩下的是什么。

– （一）照护现场：张姨与她的照护员

先进入一个比药盒更极端的现场。它取自陈晓艳研究中的照护田野叙事，下文第五节还会回到同一家机构，这里提前引入，因为它逼出了本章的核心问题。一位照护员每天照顾一位重度失智的老人，称她张姨。张姨已经多年没有说过一句完整的话，没有用眼神回应过任何人，认不出自己的女儿，女儿每周来，每次都得重新介绍自己。她大多数时间坐在轮椅上，无焦点地望着前方，像一截正在缓慢熄灭的烛炬。照护员每天给她梳头、擦脸、喂饭、翻身，每项操作在功能上都是标准化的，同时她一边做一边说话：“张姨，今天天气很好哦。”“这个菜

今天煮得烂，你肯定嚼得动。”“你女儿昨天来看你啦，她穿了一件红衣服，好看。”

路过的人会觉得她在对空气说话。而那个“空气”，是女儿口中“早已不是那个妈妈”的人，是医生口中“没有自主意识”的人，是所有功能评估量表上标着“需要重度照护”的人。这个人的“面孔”去了哪里？她的“在世存在”去了哪里？她曾经作为人的所有特征，记忆、语言、情感回应、社会身份，都已崩塌殆尽，那么照护员对这样一具缓慢熄灭的烛炬所做的一切，对谁有意义，为什么有意义？这个问题不是理论的追问，而是每一个长期照护者的日常体验，一种被抛入虚空的体验：面对一位不再回应微笑、不再为梳头感到舒服、甚至很可能不知道有人在给他梳头的老人，日复一日、年复一年地做那些温柔的、尊重的、充满人格意味的动作。没有哪套伦理学说在身后撑着她。下面依次看那些最可能被叫来撑的资源。

– （二）列维纳斯的“面孔”：命令的通道被堵死

若要找一种能在“主体”的废墟上为伦理行为奠基的哲学，列维纳斯的“面孔”几乎是最强的候选。在《总体与无限》中，他给出彻底反传统的出发点：他者的面孔，赤裸的、脆弱的、向我呈现出不可被主题化的超越性的面孔，对我发出一条先于一切自由选择的诫命，“你不可杀人”。这条诫命不依赖我对他者的认知，不依赖共情，不依赖对社会身份的识别，甚至不依赖他者的能力，恰恰是他者的脆弱构成了他对我的伦理要求。若这条路线在照护的极限情境里仍然成立，位置性存有就是赘词，它不过是“面孔”在养老场景里的另一个名字。

它在这里失效，原因不在逻辑出了错，而在命令赖以发出的通道被堵死了。关键不在“脆弱性”，张姨当然脆弱，当然深度依赖。关键在“面孔”的动力学：它之所以能发出伦理命令，是因为它作为无限的在场，抵抗了我的总体化暴力，其超越性向我显现，打破了我的自我封闭。这种显现，不管列维纳斯怎样强

调它不同于感知，终究要求他者一方有某种能够对我施加的“抵抗”，哪怕只是赤裸的脸对我的权力那种无能为力的、让我羞愧的抵抗。在张姨那里，这条最微弱的通道也熄灭了。她的脸上没有命令，没有请求，连脆弱性的流露也没有，只有一张脸。照护员凝视这张脸时，感到的不是“被要求”，而是被一阵巨大的寂静吞没。“面孔”这台伦理关系的发动机，在这里熄了火。

所以位置性存有切开的第一个辨别面是：它处理的不是面孔凭脆弱性发出命令从而建立伦理关系的动力学，而是发动机本身已经熄火之后，照护行为还能凭什么维持它的道德重量。照护员给张姨梳头、说“今天天气很好哦”，她不是在回应某个命令，那张脸从未给过她任何命令。她在做一件更寂静、更缺乏支柱的事，在一片没有“面孔”诫命的荒野里，坚持一个不知对谁有意义的行为。

– （三）海德格尔的“此在”：位置随此在而消逝

海德格尔提供了一个看上去与位置性存有极为近似的资源。在《存在与时间》中，此在总是已经在世界之中，在某个具体的“此”，以“在世界中存在”的方式占据一个无法还原为物理坐标的存在论位置，这个位置是周围世界与共在世界的关系场，与此在的操心结构紧密相连。那么，“在世界中占着一个位子”，难道不就是此在分析的结论，再加上一条伦理的尾巴，“我们应该保护这个位子”？

切割点在这里：海德格尔的位置，讲的是此在的存在论结构，此在存在，位置就在，此在不存在，位置随之消失。而“此在”之为此在，在于它能追问存在、能筹划、能在操心中展开自己的能在。张姨按现象学的严格描述，已经丧失了此在的一切生存论特征，不是“尚未展开”，而是“已经剥离”。若海德格尔的回答是“她已经不在了”，这不是残酷，而是其存在论的严格推论，那么照护员每天面对的那个坐在轮椅上的“她”究竟是谁？照护员的行为凭什么还称得上“照护一个人”，而不只是照料一具生物学意义上尚存活的有机体？

位置性存有与海德格尔的区别因此不是“海德格尔描述位置是此在的结构，而本章要给这个结构加上义务”，这太廉价了，任何伦理学入门者都能做。要紧的区别是：海德格尔的此在位置随此在的消逝而消逝，位置性存有则恰恰在“那个作为此在的她”消散之后，才作为一块由照护者的坚持撑起的、不再从她那方面得到任何生存论支撑的伦理基石，第一次被逼着现身。张姨不再是一个在世界中站出来的此在，但她仍然在“今天天气很好哦”这句问候中，作为问候所指向的那个无可替代的位子被维系着。这个位子的根据，不在她自己的此在结构，而在照护者持续发生的照护行为。在海德格尔的存在论画完了此在的边界之后，边界之外的无人区里，仍有伦理的基石。

（四）安提戈涅：爱的记忆被抽空

第三个对手最古老，也最逼近位置性存有的内核。索福克勒斯笔下的安提戈涅面对死去的兄弟波吕涅刻斯：他被城邦剥夺了政治身份（叛国者），被剥夺了生命（一具尸体），甚至被剥夺了作为死者的权利（禁止埋葬）。在那一刻，他所是的那个“人”被从一切社会符号体系里除名。安提戈涅冒死埋葬了他，她的行动不是出于义务的计算，她给的理由是：“那是我的兄弟。”这难道不就是位置性存有吗？波吕涅刻斯只剩一个空洞的位子，安提戈涅死死护住它。若位置性存有只是这一古老原型的现代照护版，本章不过是把一出悲剧翻译成了学术术语。

这里要下的是最薄也最锋利的一刀，切在“爱”的根基上。安提戈涅与照护员，表面上做的是同一件事，为一个已被剥夺“人之尊严”的空位赋予无条件的承认与投入，可是两者站立的实践地基不同。安提戈涅埋葬兄弟，因为“那是我的兄弟”，这个“我的”切入了一种城邦法律无法穿透的、由血缘与共同记忆编织的私密关系。波吕涅刻斯那个“兄弟”的位子是坚固的，被共享的成长史撑着，被安提戈涅对他活着时的全部记忆撑着，被“他活着的时候我认识他是

谁”撑着。她不是为一块无名的灰赴死，而是为一个具体的、曾经完整的、她所深爱的人赴死。波吕涅刻斯即便化为尘土，仍是一个可以被爱牢牢抓住的对象。

照护员与张姨之间，爱的这条通道整个是堵塞的。照护员不是张姨的女儿，女儿已经承认母亲“早已不是那个妈妈”，每周探视带着的，更多是混杂着责任、愧疚与疲乏的义务感。照护员对张姨的了解，不包括张姨年轻时的故事，不包括她曾怎样爱过人、怎样被爱。在她面前，张姨从来就不是一个“完整的他”，从认识的第一天起，张姨就是一位失智的、沉默的、没有回应的老人。她没有那个“曾经”，安提戈涅赖以锚定行为的“我认识他”，从头就不存在。这才是把照护员抛进虚无的矛盾：她正在为一个她从未“认识”、此刻也无法回应、从未作为完整的人出现在她生命里的对象，坚持不以任何功能为条件的、充满人格尊重的照护。安提戈涅的兄弟，被剥成纯粹的位子，位子上仍被爱充填着；张姨的位子，在照护员的体验里是空的，空的，却仍然必须被护住。

这就是安提戈涅所没有触及的那个最底层的辨别面。位置性存有命名的，是这样一种伦理状态：照护行为不再能寄生于任何既有的爱的记忆、血缘的纽带或对那个“曾经完整的他”的追忆之上。当安提戈涅赖以把行为锚定在道德宇宙里的锚点都无从获取，照护者依然在坚持的那个“给位置”的行为本身，才显出独一无二的道德分量。这个分量不来自被照护者曾经是什么或此刻还剩下什么，它只来自照护者持续的、不依赖对象回应的照护行为，这个行为在照护关系的荒原上，自己生成出了那个位子。

– （五）三重失效之后：位置性存有的定义

三条传统的失效并不构成对它们的否定，而是各自划出了边界。“面孔”预设他者能以脆弱对我施加最低限度的抵抗；“此在”预设位置依附于一个仍在展开的存在者；安提戈涅预设有一段可以被爱追忆的共同历史。晚期失智、无亲缘记忆可依的照护现场，同时击穿这三个预设。三者同时失效的地方，剩下来的东

西有三个特征：它不从被照护者那一方得到任何支撑，不依赖任何关于他的记忆或情感，也不依附于他还剩什么能力。它只从照护者与共同世界持续发生的承认行为得到支撑。这就是位置性存有。严格说，它在这里是一个下限性的概念，它不说人最高可以是什么，只说在什么都已不剩时，还有什么不可让渡。

还需要把它与既有照护伦理做一次简短的切割。特龙托等人在《照护的边界》里，把照护重新界定为一种基础性的政治与道德实践，一种“让世界维持、延续并修复”的身体性、回应性活动，并把关注、责任、能力、回应性确立为好的照护的核心要素。这一传统有力地批判了把照护视为私人的、次要的、女性化劳动的主流叙事，本书与它在深层是连续的。但这四要素预设了照护者与被照护者之间存在某种最低限度的、可辨认的互动与回应：照护者要“关注”到需求，“回应”需求，并在回应中调整自己。对张姨这样已无法给出任何可辨认的需求信号的对象，这个框架面临一个它迄今未完全正视的极限：当回应性的通道被堵塞，照护是否仍然可能，它依靠什么？位置性存有不是四要素之外的第五个要素，而是让这四个要素得以运作的地基。张姨尚能在被喂饭时张口，“关注”与“回应”还能正常工作；连这点回应也消失了，照护员仍在梳头、擦脸、问好，这一“剩余行为”无法再用回应性来解释，恰恰暴露出一个比“让世界维持下去”更寂静的根基：维系那个“她”在共同世界里的位子，即使她已不再能作为互动的一方参与这个世界。

◆ 四、为什么它先于善与美

一个被逼着现身的概念，还需要一个正面的论证：它为什么在逻辑上优先于照护中的其他价值，尤其是善与美？这里的“优先”不是价值排序，不是说位置性存有比善更重要、比美更高尚。它是在生成的意义上说的：善要成其为善，也就是照护的功能介入要成其为“对一个人的照料”而不是“对一具有机体的管理”，它必须已经预设并立足于被照护者的位置被事先护住这一前提。没有这个

前提，善会发生畸变，它不再带来被尊重的感受，反而带来被管理、被定位、被精准地拂出“人”的位子的暴力感。这不是善的不足，而是善少了让它站稳的地基。

（一）善的次序

回到药盒。从任何功能尺度看，药盒的运作都是善的典范：保护用药安全，降低漏服风险，让女儿及时知道母亲的状态。这些都是实实在在的善。老人体验到的不舒服，不来自善的缺失，而来自善的次序。当女儿的电话在中午响起、追问“为什么晚了”，她所做的“关切”已经先在地预设了母亲首先是一个需要被管理的病人。这个预设不是女儿心里“想”的，女儿爱母亲，在意识层面绝不会把母亲等同于病人。它是行为逻辑自己带着的：当药盒的通报启动“发现问题、关切追问、督促改正”这条反应链时，链条的结构已经把对象预设为一个需要被纠正偏差的人，而不是一个可能有自己理由的人。位置性存有在这一刻，被行为逻辑本身绕过、跨过、踩过。

所以“优先”要求的不是在善与位置之间二选一，不是放弃药盒、放弃用药安全。它要求的是，在善的介入启动之前，先有一个不可省略的动作：先向对方发出一个信号，让她知道，在我为你做这些事之前，我已经知道你是你，你有你不想被打扰的早晨，你有你忘记吃药的理由，你有你认为比吃药更重要的、想在生日这天对女儿说的话。这个“你”不是在我看过你的健康数据之后才被认出的，它是我走近你时第一步就已经承认的。这一步先稳稳跨出去，紧随其后的一切功能性的善，才不再是“管理一个病人”的善，而是“帮助一个人”的善。缺了这一步，善不是变成了恶，而是变成了更难觉察、更难反对的另一种暴力，一种包裹在关怀外衣下的无声篡位。药盒的每项功能拆开来看都是对的，把这些对的零件组装起来，运转的却是一台正在把老人从人的位子上轻轻拂去的机器，因

为它从头到尾没有做过那第一步，它的逻辑从功能到功能，“人”在这个流程里只是功能的承载体。

（二）美的承载体

同样的逻辑在更隐蔽的层面也成立，这就是照护中与“美”有关的行为。照护员给张姨梳头，把头发梳成整齐柔和的样子，花几分钟让毛巾温度刚好，喂饭前用温水润一润她的嘴唇。这些动作，一个失智老人的头发乱一点或整齐一点，对她的健康没有任何影响，拆开来看都没有直接的功能意义。但在照护员的体验里，它们不是可有可无的装饰，而是照护中分量最重的部分，是照护员在说“张姨，你还是张姨”的方式。

现在把问题推到极限。假设张姨对外界接触的一切感知都已丧失，不只是认不出女儿，连皮肤被触碰、耳朵听到声音的感觉都微弱到神经学上可视为“无反应”。这时梳头对谁还有意义？通常的理由，“这让她感觉好”“这让她觉得自己还是个女人”“这保留了她的尊严”，在这一假设下全部失效，因为她已无法“感觉”“觉得”或“保留”任何东西。如果梳头的全部价值都必须落在被照护者的体验改善上，这个行为就成了毫无功能回报的纯消耗。然而照护员仍在做，什么在支撑她？

答案是：这个动作，不管张姨能否感知，都在人类共同世界那个由日常仪式、微小互动、身体性关怀所编织的秩序里，持续维持着张姨作为“一个人”的位子。每一次梳头，都在向这个由女儿、其他照护者、机构、乃至整个社会构成的共同世界，发出一个沉默的声明：她仍在这里，她仍是一个值得每天被精心梳头的人，她还没有被从“人”这张席面上撤走。反过来，如果这个位子没有先被护住，如果照护者自己先在心里把张姨归入“反正她也不知道，随便弄弄就行”，那么梳头哪怕再精细、手法再娴熟，也不再有美的根基。照护中的美，要

能被体验为一种让照护员自己也稍感安心的、在废墟中仍然维持着的秩序与尊严，它必须站在“她仍是一位值得被如此对待的人”这块基石上。

– （三）这个位子不是现成的地板

这里有一个容易产生的误解：既然位置性存有优先于善与美，它是不是一块“本来就在那里”的地基，只等我们去承认？不是。张姨的位子不是一块等着被重新发现的地板，它是被照护员每天的梳头、每天的“今天天气很好哦”、每天翻身时轻手轻脚的不弄疼她，一块砖一块砖砌起来的。正因为它要这样被砌起，它才在逻辑上优先于建立在它之上的善与美：没有这个正在发生着的位子，善就畸变为管理，美就失去承载体。也正因为它是砌起来的，它随时有塌下去的危险。这一点对全书尤其重要，因为它把本章与全书的母题接了起来：前八章讲，生命的答案如果长不出来，是因为被抢先替定了；本章讲，当生命连答案也给不出，位子是不是还在，完全取决于别人是否持续不替他把它定掉。

它不是最动人的，不是最丰盛的，也不是照护中最让人有成就感的部分。它只是一种最低限度的、有时沉默到让人怀疑“这究竟有没有意义”的坚持：坚持承认那个位子还在，坚持用行为维系它，不管它能不能感知、会不会回应。在这个地基之上，善与美才能各自筑起它们的殿宇。

◆ 五、被捧起的灰：一间照护机构里的砖

论证若悬在半空，仍是“深刻的哲学”，而不是可以被检验的实践。位置性存有若不能展示它如何在照护者的具体困境、反复失败与脆弱坚持中被砌起来，它就只是又一种现成框架，只不过换成了生成论的术语。陈晓艳研究中记述了一家社区嵌入式养老机构，住着三十几位高龄、失能、半失智的老人。下面的叙述忠实于这份记述，不是“某机构引入了新理念，效果很好”的成功学报道，而是一个微缩的、充满张力的现场。

（一）“管好”与“护好”

机构的护理主管红姐，没读过养老专业，更没学过什么高深的哲学，此前有十五年临床护士的经验。她的日常工作，在两套逻辑的持续撕扯里度过。用她自己的话说，那是“管好”与“护好”。“管好”是照护中不可回避的功能面向：血压、血糖、药量、翻身次数、三餐热量；几点吃药、几时翻身、怎样给鼻饲老人打流食；还有来自家属的压力，“妈今天血压怎么高了”“是不是护工给盐放多了”“我爸半夜按铃为什么两分钟才到”。在“管好”的逻辑里，老人是一个需要被精密维护的生物学系统，护工是一双双必须精确执行指令的手，主管是保证所有手都不出错的眼睛。

“护好”是红姐自己也解释不太清楚、却固执地认为“这才是我们做这个事的本心”的东西。它不是某一项具体操作：把老人从床上扶起来时，不是机械地喊“一、二、三”，而是先俯在耳边说“刘奶奶，今儿外头大太阳，咱起来去窗边坐坐”；喂饭时老人含着一口粥半天不咽，护工不催，举着勺子静静等她熟悉的吞咽节奏回来；老人失禁、把床弄脏之后，护工收拾时不皱一下眉头，轻轻拍着老人因难堪而簌簌发抖的手背说“没事没事，咱换个干净的”。红姐说，她最怕的不是护工偷懒，不是家属投诉，甚至不是老人突然离世，“到这个年纪了，都知道总有那一天”，而是“我们的人，手上干着‘护好’的活，眼里却慢慢没了‘这个人是哪一个’的光”。

她描述了一种让她觉得“不能再这样下去”的典型退化。新来的护工起初充满热情，会和老人聊天，会记住他们的习惯；几个月后，每天面对十几位老人的翻身、喂饭、换尿布、清理呕吐物，把她磨得精疲力竭，她开始把那些“多出来”的动作，俯在耳边问候、举着勺子等待、拍着手背安慰，一件一件卸掉。因为这些动作在功能清单上不存在，不计入绩效，不被家属看见，也不被大部分老人，尤其是失智老人所回应。她变成一个高效的操作者：动作准，速度快，不出

错，但不再与老人对视。红姐承认，她自己查房时也发现过同样的事：一边用标准化的温柔语调说“张姨，来，翻个身哦”，一边脑子里想着下午的排班表和昨天家属的投诉。

这正是全书母题在照护者这一端的写照。“管好”的逻辑不会自动转化为“护好”，恰恰相反，缺少一种有意识的实践去对抗，它会像水一样悄无声息地渗透、占据、最终吞噬照护的全部空间，因为它更紧迫，更容易量化，更容易被监督。而“护好”没有指标，没有流程，没有考核，它唯一的支撑，是照护者在极度疲惫中仍苦苦撑住的那一丝对“这个人是哪一个”的认出。替定不一定来自传感器，也来自流程本身：当流程的效率高到足以让照护者不必再看一个人的脸，人的位子就已经被流程替掉了。

—（二）次序错了：赵奶奶的“今天不拉”

红姐和团队的一次复盘，回顾了赵奶奶的事。赵奶奶八十二岁，中度失智，有顽固的便秘史。入住前两个月，护工严格按“管好”的逻辑护理：每天定时提醒排便，用医生开的通便药，严重时用开塞露。功能上护理是到位的，排便频率维持在正常范围。但渐渐有人察觉一个细节：赵奶奶每次看到护工走过来，哪怕对方只是路过，都会条件反射般地、一脸紧张地低声说：“今天不拉。”红姐说，那一刻她的“心被狠狠戳了一下”。她们关注的是频率正常不正常、食物结构科学不科学，而赵奶奶这句脱口而出的话里，是一种被功能逻辑彻底淹没的深层恐惧：我知道我作为一个“能自己排便的人”失败了，我让你们失望了，给我点时间，不要用那个东西。

那天红姐在复盘会上做了一件护理规范手册里没有的事。她要求团队，从明天起，赵奶奶排便护理的第一条指令是：每天第一次以排便干预的名义走近她之前，先聊三分钟天，这三分钟里不许提那个“拉”字。可以问昨晚看什么电视，夸今天的衣服好看，说中午食堂有好吃的菜。这三分钟在功能上是多余的，既不

能刺激肠道蠕动，也不能监控排便时间。可它做了一件事：在“排便护理”的动作启动之前，先在赵奶奶的世界里回复一个比“便秘患者”更完整的身份，一个可以看电视、穿好看衣服、期待中午有好吃的菜的赵奶奶。这个身份先被立住，紧随其后的一切护理动作，才不再是对一个“今天不拉”的失败者的管理，而是帮助一个“今天中午想吃好吃的”的赵奶奶解决身体上的一个麻烦。

红姐后来对家属说：“赵奶奶的情况，不是我们照顾便秘的技术不行，是我们一再地用那个技术去提醒她：‘你又不行了’。技术本身是好的，但我们用它的方式，先把她从一个‘有面子的人’变成了一个‘等下要被检查的人’。这个次序要是不对，她就算拉出来，也是屈辱的。”红姐说的“次序”，先让她重新成为一个有面子的人，再帮她解决排便的麻烦，而不是先用技术把她规训成需要排便管理的病人，再用善意的关怀去安抚那个被规训出来的屈辱，正是位置性存有逻辑优先性最具体的实践表达。红姐不知道这个学术名词，但在照护现场的困境与偶然的突破中，她用自己的身体和语言，重新发生了它。

– （三）孙奶奶的手：想不出做什么的时候

另一个案例里，一位年轻的护工面对一位沉默的老人，无所适从。老人姓孙，入住时已被诊断为重度失智，几乎不与人交流。女儿每周来一次，每次待半小时，对着母亲说很多话，外孙的考试，家里换了新沙发，隔壁邻居养了只猫，老人从不回应，甚至不看女儿。女儿走后，护工有时看到老人一个人坐在窗边，眼泪无声地顺着脸颊流下来。护工试图对老人好，每天把被子叠得四四方方，按点喂温水，扶着她在走廊里晒太阳，老人对这一切同样没有回应。护工试着说话，但一个十九岁的姑娘，面对一位八十多岁、沉默失智的陌生人，除了“奶奶，喝水了”“奶奶，吃饭了”，找不到别的词。

有一天下午，她实在不知道还能做什么，就搬了把椅子，坐在孙奶奶旁边，拿出手机，笨拙地给奶奶看老家的照片，自己的老家：山上的树，门口的土狗，

妈妈站在灶台前炒菜的背影。她一边翻一边说，不是“与照护对象交流”，而是忘了自己在上班，把心里的事倒了出来：“这条狗今年死了，我出来打工之前它还好好的”“我妈炒的那个菜难吃死了，但我想吃”。她觉得这是业余的、不符合护理规范的行为，给失智老人看自己老家的土狗，这能叫什么护理？可是当她放下手机、准备去打扫隔壁房间时，孙奶奶突然抓住了她的手。那只手很干，很瘦，指甲有点长，抓得并不有力，但在那一刻，它在护工年轻的生命里所产生的重量，让她站在原地一动不动。老人没有说话，只是看着她。那个眼神，护工后来始终无法向别人准确描述：“不是认出了我，不是要跟我说什么，但就是不一样了。”

这个故事需要谨慎地读。它不能被读成“只要用心，失智老人就会回应”的励志样本，本章没有这个意思，下一节还会专门处理这种误读。它的意义在于红姐的复盘：“我们不能要求所有护工都会画画、唱歌、读诗。但我们可以要求一件事：当你想不出该为这个老人做什么时，你先记住一件事，她是孙奶奶，不是‘那个不说话的’。”红姐把它翻译成团队日常使用的一句简易准则：在你不知道该做什么的每一刻，先做一件只对这个独一无二的“她”做的事，而不是对一个“失智老人”做的事。这句话没有出现在任何护理培训教材里，它是在无数次面对沉默老人的无力、无数次“管好”把“护好”压垮的挫败里，慢慢摸出来的一根救命稻草。

— （四）钱老师的轮椅：一块砖

最后一个场景，红姐至今提起，嗓子还会哑。机构里有一位钱老师，入住时中度失智，从前是中学数学老师，教了一辈子几何。入住后她常处于半梦半醒的状态，清醒时找不到正确的词，糊涂时把护工当成当年的学生，用一根手指在空中比划，仿佛在画一条辅助线。清醒期越来越短，糊涂期越来越长。一天，团队在会议室争论她的照护方案：她肌力显著下降，已无法独立行走，坐在轮椅上有

滑落风险。加装约束带可以有效防止滑落，但对身体自由度和尊严感构成显性的限制；不加，滑落骨折的风险确实存在。安全与自由站在天平两端，怎么选？

争论到一半，红姐打断了大家：“我们能不能想想，钱老师画了一辈子辅助线，如果我们现在给她绑上束缚带，我们用什么脸面在明天早上走进她的房间，跟她说‘钱老师早上好’？”这句话没有正面回答安全与自由如何取舍，它把整个争论的坐标系，从“我们该选哪种管理策略”，拽到了另一个地基上：我们自己将怎样面对，在给她绑上束缚带之后，每天早晨必须重新对她说出的那句“早上好”？这不是哲学分析的结果，是一个在照护现场浸泡多年的人在具体伦理困境里的一次存在论直觉式的跳跃。如果一项管理策略的实施，让照护者无法在道德上承受“明天早晨面对她时自己这双眼睛”，那它无论在安全指标上多么站得住，都已先在地不符合照护之为照护的最根本条件：它让照护者无法维持“她是钱老师，而不是一个需要用束缚带管理的摔跤风险体”的认出。

团队最终没有用约束带。他们调整了人力配置，把钱老师的轮椅从房间里挪到了护工站办公桌的对面，这样任何一名护工一抬头就能看到她，一旦有下滑迹象，几步就能走过去调整坐姿。红姐后来说：“我们这一行，最大的成绩，不是老人的指标全部达标——总有达不了标的那天。我们最大的成绩，是我们一直在想办法，不让她从‘人’的位子上掉下去。哪怕她一个字都说不出来，哪怕她不知道我们在为她做这些。我们自己是知道的。我们守住了这个，晚上就能睡得着觉。不是因为问心无愧——惭愧的事多得很。而是因为，我们明天早上走进去，还对得起那句‘早上好’。”

这段话是对位置性存有最朴素也最精确的描述。它说明这个位置不是一块等着被重新打扫出来的旧地板：钱老师当了一辈子数学老师，她的人格尊严不是自动地、一劳永逸地摆在她身上的。当肌力退化，认知衰退，护理的日常操作每天面对“安全与自由”的挤压时，这个位置要靠照护者在每一次为她的坐姿做出努

力、每一次扔掉约束带、每一次在技术便捷的诱惑面前选择更费力也更尊重的办法时，一块砖一块砖地撑住。它也不是“归位”，因为“归位”暗示它原本就在那里，只是被什么遮蔽了。而钱老师的位子，在照护的每一天都面临滑落、倾斜、甚至消失的风险。它不是被重新发现的，而是被持续的、艰难的、经常失败的坚持，每天重新砌起来的。

红姐和她的团队不总是对的。人手不够，累到极限，家属压力太大的时候，“管好”的逻辑会像洪水一样卷土重来，她们也会掉回功能逻辑里。这正是本章要说的：位置性存有不是一套伦理准则，而是一套必须在照护现场每天重新发明、极易失败、但一旦成功就能让整个照护关系为之一变的实践。它不是从标准教材里学来的，是照护者在失败的废墟里，一点一点自己摸出来、捧起来的灰。这灰的轻，恰恰就是它的重。

◆ 六、这一切关那位老人什么事

位置性存有的论证，在照护伦理的极限情境里要面对一个最刺耳的诘问：这一切，关那位已经失去一切感知的老人什么事？这个诘问不接受任何基于“被照护者能感知”的回答。如果有人论证说，护住张姨的位子很重要，因为她能感到被尊重，一位神经科医生就可以反驳：据我们所知，这位老人很可能感觉不到，她的皮肤触觉也许还在，但在认知层面，她不知道有人对她做什么。那么，这份“尊重”落在了哪里？如果落不到老人身上，它是不是只是照护者自己的安慰，一套精致的、哲学化的“让自己好受一点”的借口？这个问题不能回避，回避它，整个论证在地基处就悬空了。

– （一）不退回“内在主体”

最容易也最廉价的回答，是偷偷退回某种“内在主体”的假设：也许失智老人内心深处还有一个未被科学发现的隐秘自我；也许她的灵魂在别的层面上感知

着一切；也许她的“人格”没有消失，只是被压抑。本章不采取这种回答，因为这在知识上是不诚实的。没有证据说那位老人还能感知，我们必须尊重神经科学与临床观察迄今给出的事实：对于某些深度失智的老人，他们对外界互动的认知性感知，很可能已经极其微弱，甚至不可辨认。上一节孙奶奶抓住护工手的那一刻，同样不能被拿来当作“她其实什么都知道”的证据，叙述者自己说得很清楚：“不是认出了我，不是要跟我说什么。”本章的论证不能建立在这样一个任何时刻都可能被推翻的经验假设之上，它要建立在这个假设被设为最坏情形时依然成立的东西之上。

（二）道德分量不在被感知，而在发生

本章的回答因此要往另一个方向走。它不在被照护者的体验那一端找答案，而在照护行为的持续发生及其对人类共同世界的构成性意义那一端。回到梳头。我们假设张姨完全听不到“今天天气很好哦”，或者声波进入了耳朵，她的大脑已不能把它处理为“有人在对她说话”的信息。在这个假设下，从张姨一端看，这句话确实没有给她任何主观体验上的改善。可是“张姨”这两个字从照护员嘴里说出的那一瞬间，它不仅是一个指向张姨的声音事件，也是发生在一个关系场域中的事件，这个场域由其他照护者、张姨的女儿、机构管理者、任何一个偶然路过走廊的人共同构成。照护员在其中发布了一条无声的声明：张姨还在这里，她仍是那个值得我们用“张姨”来称呼、用“今天天气很好哦”来问候的人，她还没有从这个由人称、问候、日常寒暄所编织的共同世界里退场。

设想如果有一天，所有照护者都停止了这种“多余”的行为，因为“反正她也听不见”。那么在这个微小的社会世界里，张姨就从一个人变成了一具需要被维护的有机体。这不发生在张姨的内心，我们不知道她的内心发生了什么；它发生在她所占据的社会位格上：她的位子，从“一个还有人每天对她问好的人”，变成了“一个不再有人问候的对象”。这个变化，张姨本人也许感知不到，但它

在由照护关系构成的共同世界里的发生是现实的、有重量的。照护员每天早上那句话，是维系位子不塌陷的最后一根细线。这是位置性存有最坚硬的内核：它不在于被照护者的主体还能否感知到自己被尊重，而在于照护者持续的、不依赖对象回应的照护行为，在我们这些尚且健全的人所构成的风俗、制度、共同体的日常互动中，生成出一种不可撤销的道德分量。这个声明的效力，不需要被张姨本人接收到，它在接收者的世界里发挥作用。它守住一个文明社会最后的底线：即使“你是谁”无法被当事人自己说出，也几乎无法被任何人完整地说出时，照护者仍然在替她说出，你还在，你还是你。

这样说，也就同时说明了为什么道德分量必须落在“发生”，而不能落在“被感知”。如果分量落在被感知，那么一个人的位子就变成了一份依赖于他的感知能力的资格，感知越弱，资格越薄，到了完全没有感知的那一天，资格自动作废。这个逻辑正是本书前八章所批评的替定逻辑在最后一步的样子：先由系统规定什么样的人才算“在场”，再据此决定谁可以被撤离。把分量放在发生上，则等于说，这个位子不是由对象的任何指标决定的，它由我们共同世界里持续进行的承认来决定，而承认的责任在承认者这一边，这是它能够无条件的唯一方式。

– （三）不是照护者的自我感动

诘问还有一个来自安提戈涅传统反驳者的版本：如果老人的位置纯粹是照护者在自己的行为中建构出来的，这不就是一种“照护者中心主义”的自我感动？照护者那样痛苦地坚持，不就是为了问心无愧吗？这跟张姨本人还有什么关系？这是一个严肃的挑战，因为它触及位置性存有是否把照护的重心放到了照护者身上，从而偏离了“以被照护者为中心”的照护伦理根本原则。

回答是：自我感动需要燃料。它需要一个可以向自己证明“我做了好事”的叙事，“张姨觉得舒服了”“张姨感激我”“张姨今天因为我的梳头稍感安

宁”，这些都是可以回报给照护者、滋养她继续下去的情感燃料。而当一个照护者确知张姨不可能给出这类回报时，她仍然坚持梳这个头，她恰恰是在做一件没有燃料的事。她面对的是一场没有观众、没有一句感谢、没有一个“被爱”的眼神的道德劳作。她所承受的最大考验，不是“我如何让自己问心无愧”，而是“当对象不能给我任何回报时，我如何还能把我正在做的事仍然看作是在为她做的”。红姐的话也印证了这一点：“不是因为问心无愧，惭愧的事多得很。”她们守住的不是良心的平静，而是一句明天早上还要说出口的“早上好”。

这里再次可以看出与安提戈涅的差异。安提戈涅面对死去的兄弟，仍可以爱他，死者作为所爱之人的记忆充实着她的行为，使她的牺牲虽死犹生。照护员面对张姨，没有这份爱的私密记忆的支撑，她面对的是一个自始至终就不曾完整地出现在她生命中的陌生人。她的照护不是在爱的火焰中纵身一跃，而是抱着一把没有温度的灰，在风中一步一步地走。这个行为不被被照护者的回应所滋养，不被爱的记忆所支撑，不被任何外在的道德观众所奖赏。它唯一剩下的根基，是照护行为本身的持续发生，是照护者在每次说出“张姨”两个字时，自己作为命名者、承诺者、坚持把张姨留在“人”的位子上的人，独自承担的那份无人见证的道德重量。这就是为什么“关张姨什么事”的回答，不是“因为张姨还能感知”，而是：恰恰在张姨很可能毫无感知的前提下，照护者依然坚持护住她的位置，不让她的身体被工具化地操作，不让她的尊严被功能逻辑碾过，不让她的名字退化为一串床号，这个行为本身，才在我们这些作为共同见证者的其他人面前，生成出一种独一无二、不可化约的道德分量。它让照护不至于在“反正她也不知道”的虚无主义面前彻底崩塌。

– （四）两点防误读

这一论证有两处容易被读歪，需要明说。其一，位置性存有不等于不作为，更不等于拒绝技术。药盒的保护用药安全的功能、约束带与不约束带之间的权衡，本章从未要求取消；要求的是次序：先承认，后服务。钱老师的故事里，团队同时调整了人力配置，把轮椅挪到护工站对面，安全问题并没有被一句“尊严优先”搁置，而是被重新设计成不以抹去她的位子为代价的方案。其二，位置性存有不是“被照护者必须被当作完整的人去期待回应”的要求。它恰恰相反，它不期待任何回应，因此才可以无条件。把孙奶奶的那只手读成对护工的回报，等于重新把位子绑回对象的反应上。

◆ 七、证伪条件与边界

一个关于底线的判断，更需要指明它在什么条件下会被推翻，否则“底线”就成了无法检验的宣告。本章层面的证伪条件有三项。第一项，来自神经科学。如果未来的研究能够确切证明，处于晚期失智状态的老人在某个深层水平上仍然“感知”并“回应”照护者的尊重或轻视，那么本章与列维纳斯“面孔”的决裂就需要重新审视。“面孔”可能并未熄灭，只是被语言与行为的障碍遮蔽了。届时位置性存有的独立性将需要根本性的修正，它可能不是“面孔”的替代，而是“面孔”在感知障碍条件下的一种特殊显形方式。注意，这项条件推翻的只是本章对三大传统失效处的划界，而不是对照护义务的论证：即使感知被证明仍在，把位子的分量系于被感知，仍然会把位子变成一份依赖于感知的资格。

第二项，来自跨文化的比较。如果实证研究表明，位置性存有并非照护终极情境中被逼出的普遍辨别面，而只是特定文化传统，例如强调“人格”与“面子”的东亚文化，所特有的伦理直觉，本章的普适性主张就需要降调。本章依据的是一个具体文化语境里的田野观察，赵奶奶的“有面子”、钱老师的“早上好”都带着这个语境的印记；虽然它与列维纳斯、海德格尔、安提戈涅的对话指

向更普遍的伦理地基，但在实证层面，跨文化的变异是一个需要诚实地留待检验的开放问题。

第三项，来自与全书书级证伪条件一致的方向，只是落在照护的底线上：如果在把“以在场者身份被称呼、被告知”作为照护流程的机构里，老人的激越行为、拒食等指标与这类互动的频次毫无关联，本章关于位置性存有优先性的主张就需要更强的论证。这一条也暴露了本章概念的一个性质：位置性存有是一个下限性的概念，它的价值在于设定不可让渡的底线，因而很难给出增量性的检验，更难用“效果”去衡量。可操作的入口是行为编码，即记录照护互动中老人“以在场者身份被称呼、被告知”的频次，再与激越行为、拒食等指标做相关。这里需要诚实地承认：如果相关不存在，被动摇的是本章概念的优先性主张，而不会是照护者应当坚持问候的义务本身。因为本章的核心论证已经说明，这份义务的分量不来自效果。

边界也要说清。位置性存有不提供一套完整的照护方案，它不回答疼痛的处理、临终的决策、资源的分配，也不替代专业的评估。它只是说，所有这些专业的、功能性的善，必须在一个已经被先行承认的位子上进行。它同样不意味着对照护者提出圣徒式的要求。红姐的团队常常掉回“管好”的逻辑，本章并不把这当作失败后需要谴责的缺陷，而当作位置性存有的存在方式：既然是砌起来的，就会塌，塌了再砌。因此，对机构的实践含义不是“要求每个照护者永不倦怠”，而是把进房间先打招呼、离开时说明去向、在老人在场时不用第三人称谈论他，写进流程与培训，而不留给个人善意去碰运气；对智慧养老系统的含义是，设计时需要一条与能力无关的默认在场逻辑，不让“不产生偏好的人”被自动排除出交互；对家属与医护的含义是，在老人在场时避免用第三人称谈论他，这是最常见、也最直接的位置剥夺。

◆ 八、本章小结：全书的底线

本章从王奶奶的抽屉出发，沿三条线往下走。一条线是篡位的过程：药盒不用任何恶意，只需要把“母亲”换成“病人”，就能让一个人在被服务得最好的时候，失去自己的位子。一条线是哲学上的检验：列维纳斯的“面孔”需要他者能以脆弱抵抗我，海德格尔的“此在”需要存在者仍在展开，安提戈涅的义务需要一段可被爱追忆的共同历史，晚期失智的照护现场同时击穿了这三个预设，在三者同时失效的缺口里，位置性存有作为唯一还能抓住照护行为最后分量的东西现身。一条线是实践的检验：红姐的团队没有高深的理论，只有无数次失败，从赵奶奶的三分钟闲聊，到孙奶奶那只抓住护工的手，到钱老师的轮椅被推到护工站对面，那个位子一块砖一块砖地被砌起，又随时可能塌下去。而对“老人已无法感知，照护者痛苦的坚持价值落在何处”的诘问，本章的回答是：道德分量不在被感知，而在发生。它在我们共同的世界里，以不依赖任何回报的持续承认，替那个再也说不出“我是谁”的人说出：你还在。

现在可以回望全书。第一章看到，老人一直在长向某处，那些生迹不长在“需求”的地址上，所以被越周到的照护越稳妥地错过，失认是制度演化沉积出来的壳。第二章看到，比生迹更深的是连老人自己都无法指认的残迹，善意填充是一种不施力、不注视的新权力，把空无填成“照料得很好”。第三章转入医疗，身体的代偿就是身体给出的答案，指南地壳听不见它，反把它当作故障来打击，医生被训练成排雷式的认知者。第四章，算法叙事抢在身体之前开口，在主体能为自己编织栖居叙事之前先占了位。第五章，决定“修复成什么样、走哪条路”的发生权，被技术与制度的复合体从暂时托管滑向终身代管。第六章，“我好了”的内感受判断力被押给体外数据，每一次成功履行都在损耗它要赎回的东西。第七章，替定注定落空，因为靶心在被命中时已不是原来的对象，越准越错。第八章，把判准还给生命：健康不是回到预写的剧本，而是溃散之后能否自

行重组。九章合起来，是同一个结构在越来越深的层面上被追问：先是答案看不见，然后是答案被抢先替定，然后是替得越久越长不出，最后是连“长”的主体本身，也可以被一套不需要他的流程悄悄撤走。

这最后一步，与前面所有的步骤都不同，也因此成为全书的底线。前八章里，被替掉的东西尚可以被还回：撤回药物，减少填充，允许偏离，让身体溃散后自己重组，替定退场，生命仍有机会长出自己的东西。本章面对的是已经什么都长不出来的人。对他，没有“还回判断权”可做，没有“等待自行重组”可期，没有可以被撤回的替定能让他恢复。他能得到的，不是更多的“长”，而是一个不被收回的位子。于是母题在这里得到它最简单、也最难的形式：当生命什么都长不出时，照护最后要守的，就是不替他把这个位子也定掉。不替他定他是否还算一个人，不替他定他的位子该留给谁，不替他定一个“反正他也不知道”的答案。这不是对前八章的补充，而是它们共同的归宿：前面每一章所反对的替定，反对的不只是它替错了，更是它预设了“被替的人要证明自己仍有资格被听见”；本章把这个预设拆到底，说资格无需证明，位子先于证明。

这也是为什么，全书从养老开篇，又在养老结尾。第一章里那些还在长的老人，与本章里什么都不再长的老人，是同一个人生命的不同阶段，也是同一种照护的两端。在前一端，照护要学会听见生迹，在后一端，照护要学会不替他把位子定掉；中间的路，穿过医疗，穿过叙事、发生权、判断力、纠缠与溃散，每一章都在说同一件事：精准的善意越是替得周到，越需要一种自觉的克制，克制的最低限度，就是那条无论如何不可越过的底线。位置性存有不是一块石头，不是一座纪念碑，也不是可以写进章程的权利条款，它是一捧灰：一个人全部的能力、记忆、身份、叙事在时间的风中飘散之后，唯一剩下来的那个最轻的东西，她仍在这里，她仍算是一个人。这捧灰不能自己说话，不能自己站立，甚至不能“是”任何东西，只有在另一双愿意捧起它的手里，才临时地、脆弱地、无声

地聚成一个形状。护住这个形状，让它在照护的双手之间不被风吹散，就是照护的底。

最后留下的问题，已经不是论证，而是可操作的路径：在没有任何一项技术、指南或指标能替我们决定的地方，不替定的照护究竟如何可能，如何从“这条底线”走到每一间病房、每一间养老机构、每一次医患对话里去。这是结语要接的棒。红姐那句最小的准则，“在你想不出还能为这个老人做什么的每一刻，先做一件只对这个独一无二的她做的事”，也许可以作为结语的起点：不是熊熊燃烧的火，不是那个曾经会讲几何题的钱老师、那个会在深夜花一小时给女儿写微信的老母亲，那团火已经烧过。剩下来的是灰。但在这灰被另一双手小心捧起的那一刻，在那句对着没有回应的空气说出的“张姨，今天天气很好哦”里，有什么东西重新燃起来了。不是火光，是火的温度。不够照路，但够让捧灰的人知道，她捧的不是一团无名的灰烬。是张姨，她还是张姨。

◆

结语

不替定的照护何以可能

◆ 一、回望三编：同一个位置上的三次追问

全书从走廊尽头的一句“没事”开始。那位老人没有被忽视，也没有被强迫，他只是在一个所有需求都被周到地覆盖的地方，失去了被人看见“正往哪里走”的机会；记录表上多了一个无事件的空白，而他身体前倾又缩回的那个动作，没有一个字段可以接住。第一编的三章循着这个空白向下挖，挖出了三层生命自己给出的答案。第一章的生迹，是老人在故事进行中透露出的“我正在成为谁”的指向性痕迹，照护系统在制度演化中沉积出一层必然筛除它的壳，这就是失认。第二章的残迹更深，连老人自己也无法事先指认，它们是“未被选中、未被完成、未被记住”却构成生命质地的东西，被善意填充这种不施力、不注视的权力挤压殆尽。第三章把目光移到医疗：身体的代偿反应是身体自己的答案，指南地壳却把它读成需要打击的故障。三章合起来说明了一件事，即答案一直在，只是不在系统的地址上。

第二编转向系统怎样处理这个空位。第四章看到，算法叙事在身体自己的叙事还没有长成之前先开了口，一份基因检测报告里的“23%”占住了受检者本该用自己的话说出“我还好吗”的位置。第五章看到，生命系统决定自己下一个稳态的资格，被技术与制度的复合体代为行使，林女士十二年的病程从“暂时托管”走到“终身代管”，最后她说“我好像已经忘了怎么生这个病了”。第六章看到，“我好了”这一不需要外部背书的整全感觉，被转成了向体外数据缴纳的抵押品，而且每一次履约都在消耗它想要赎回的东西。三章从叙事、决定与判断

三个层次上描述了同一个动作：先于生命自己，替它回答。这个动作没有恶意，大多数时候还伴随着实际的成效，这就是为什么它难以被批评，也难以被叫停。

第三编追问替得越久、生命还能长出什么。第七章给出一个令人不安的结论：替定不仅会使能力萎缩，替定本身也注定落空，因为在因果网络致密的慢性病里，被精准命中的靶心在被命中时已经不是原来的对象，“越准越错”源自姿态本身的限度。第八章把问题翻转过来，不再追问怎样让生命回到某个正确的剧本，而是追问生命在溃散之后能否自行重组出任何一种可以继续下去的秩序，健康因此从名词变回了动词。第九章把追问推到极限：当能力、记忆、身份都已不在，什么也长不出来的时候，老人仍然占着一个位子，照护的最后一件事是护住这个位子。这一编回答的不是“怎样让生命重新长出能力”，而是“在不替定的前提下，还能看见什么、还要守住什么”。

回望之下，三编之间的关系可以用一个很朴素的次序来表达：先看见，再让位，最后守底。看不见是第一道门，门里的东西需要被命名、被分辨，才有可能被保护；抢先替定是第二道门，它要求系统在善意与成功之中学会克制，把还没有说出口的答案留给生命自己；长不出是第三道门，它提醒人们，让位不是一次性的举动，而要持续地承担一段失序与摸索，并且在极端的时刻，仍要为一个什么也长不出的人守住一个位子。本结语要做的，是把九章分散给出的实践入口收到一处，看它们是否确有一个共同的形式，也正视它们彼此之间并不总是相容，再看这个形式是否足以回答书名的问题：不替定的照护何以可能。

◆ 二、八个入口：每一章留下了什么可做的事

九章里的实践入口，在各自的章节中都被刻意写得很小：一句话，一段留白，一道说理的程序，一个撤回的条件，一块不让出的地方。这一节把它们汇列出来，并且特别标明每个入口留出了什么样的空白、守着什么样的底线，因为只

有同时看到这两样，才能判断它们是留白，还是撒手。下表按章序排列，第四章因入口的形式不同，放在表后单独说明。

章	入口	留出的空白	守着的底线
第一章	交接班时的一句话	一个无须记录、无须跟进的“不太一样”的瞬间	两周一次的交叉校验；无法辨别时按抑郁响应流程给最低程度的关怀，严禁强行安排活动
第二章	不过问、不填充、痕迹保护	安全底线之上的沉默、日程表上的无名空白、看见而不登记	三级风险响应；区分性训练、团队复核、一根随时可被拉紧的线
第三章	偏离说理评审	允许基于判断的偏离被合法执行	四问说理、异质评审、以论证质量而非结局为判准
第五章	撤回代管的条件	系统自身练习发生权的空间	撤出标准与启动标准同时定义、安全港条款
第六章	守护“我好了”的飞地	不需要体外数据背书的整全判断	不否认随访的必要，不把世界抵押给随访报告
第七章	扰动—监测—重稳与药物假期	一段被药物掩盖的代偿结构得以显现的时间	严格选择的患者、远高于日常的监测频率
第八章	溃散后自组织验	暂停非维持生命所必需的监测与评判	生命所必需的监测仍在；严重不良事件后只恢复临时、可撤销的安全网；行为正走向不可逆损伤或死亡时干预义务不免除
第九章	护住位置性存有	与能力无关的、先于任何功能操作的承认	在任何技术管理操作之前，先让她知道她首先是一个人

第一章的入口是交接班的五分钟里，在血压数据、用药记录、异常事件全部交接完毕之后，多加一句非强制的口头提问：“今天有没有哪个瞬间，你觉得哪个人和往常不太一样？”不必分析，不必记录，不必跟进措施，只是说一遍，听一遍。这句话为护理员那个无法归类的“不对”第一次提供了一个可以被说出来的语言容器。章中还设计了两道护具：每两周把几位护理员与家属的观察拼在一

起做一次交叉校验，多日多人的拼图显示老人的运动性在持续减少时触发专业评估；无法辨别时，必须优先按抑郁响应流程给予最低程度的关怀，如增加非结构性的探视，同时严禁任何“为了他好”的强行安排。这个入口还有诊断的用途：如果三个月后团队里没有人说得出任何一个“不太一样的瞬间”，说明失认已经沉到照护者的感知器官内部。

第二章的入口是三条消极的纪律。不过问，指在安全底线之上有意识地不去解读老人的状态，在最低风险层（发呆太久错过一次活动、种花划破手指、站在原地看鸟看久了）保持沉默，中风险层给予轻提示，仅在高风险层立即响应。不填充，指排日程时留下一段表上不写任何东西的时间，保护尚未发生的残迹。痕迹保护，指护理员可以看见某个已经发生的残迹，例如老人连续几天在固定时间站到窗边看一棵树，却不把它写进交班记录，也不据此在第二天加一场植物认知活动；在老人自己提起之前，她的职责是让它不被拉到光线下。章中同时给出三道防线来防止“不干预”滑向消极怠工：先准确描述老人的状态再决定干预与否的区分性训练，不把“不干预”变成考核指标的团队复核，以及一根没有拉紧、随时可以拉紧的无形之线。

第三章的入口是为基于判断的偏离修建一条制度通道。医生在偏离指南时，若希望得到制度保护，就要对这次偏离做正式的、有记录的说理，回答四个问题：偏离了指南哪一条；病人的哪些独特情况使这一条在本案可能不适用甚至有害；替代方案的临床推理与即时生理判据是什么；设定了怎样的追踪点来判断偏离是否成功，失败时在什么条件下回到标准路径。评审要有结构性的异质性，纳入相邻专科的医师、临床药师与受过培训的非医学背景的患方代表；判准从事后结局转向事先论证的认知质量；每一例经过评审的偏离，无论成败，都以匿名形式进入一个公开的案例库，让个体的失败成为集体的认知资产。章中没有回避最诚实的反驳：说理评审本身也会变成更高级的地壳。它的回答是，在被吞没之前

的窗口期里，会有一些判断被记录下来，被吞没之后留下的案例库，也会成为下一轮改革的起点。

第五章的入口是撤回代管的三条原则。撤出标准必须与启动标准同时被定义，在注册试验阶段就嵌入预设的撤出臂；在代管期间，系统自身练习发生权的空间必须被刻意保留并测量，章中为此提出由心率变异性的迷走张力、下丘脑—垂体—肾上腺轴的昼夜节律斜率与内感受敏锐度量表得分合成的“发生权指数”，用来追踪同一患者的纵向变化，而不是定义一个正常值；举证责任要重新分配，“终身服用而不尝试撤出”也要在病历里写下理由，并为符合预设条件、征得知情同意的阶段性撤出提供最低限度的免责保护。章中同时划出了适用边界：急性感染、急诊手术、酶替代治疗之类的情境里，外部代理是救援，不是剥夺。

第六章的入口不是一项操作，而是一块要被守住的地方。章中论证，抵押系统无法估值、无法收走的，是那种无须任何外部背书、自己即可确认的“我好了”的整全感觉。这块飞地不是回到技术之前，而是穿过技术之后，在技术够不到的地方为自己重新划下的边界，章中设想了三条走向这块飞地的路：那位软件工程师与家庭医生长谈之后选择停药，走出门去跑五公里；那位经历全部靶向疗程的患者，在春天的傍晚和家人散步时不再需要CT报告上的一行字才能松一口气；那位付不起基因检测的人对自己说“我觉得我没有，就不查了”。三者共同的是，他们并不否认随访的必要，只是不再把自己的世界抵押给随访报告。章中还特别叮嘱，飞地不是比数据健康更本真的状态，它只是一次决断，是发生学意义上的“继续”，而不是“回归”。

第七章的入口是用“扰动—监测—重稳”取代“瞄准—命中—校准”。章中以高血压为例，在严格选择的、血压已稳定达标至少六个月且无高危合并症的患者中，设计一次计划性的药物假期：在医生监督下短暂撤去某一种药物，在四到

八周内以远高于日常随访的频率监测血压的变异模式，同时记录精力、睡眠、情绪与自信心。目的不是看病好了没有，而是让系统从被药物长期压制的僵化平衡里暂时松脱，让被协同掩盖的代偿结构第一次在临床上被观察到，再据此制定与这个病人的网络形态相匹配的重稳策略。章中另设一个雏形：在抗抑郁药起效初期、患者有了一点行动能量却仍受焦虑困扰的第二到第四周，治疗师不急于做认知重建，也不用药物压制焦虑，而是与患者一起设计一次处于其安全边缘的行为实验，例如一位长期不允许自己在同事面前表现脆弱的患者，只说一句“我今天有点累，先回了”，然后记录他以为必定发生的灾难在现实里究竟如何兑现或没有发生。这一入口给出的是姿态的翻转，而不是一份新的方案。

第八章的入口是三个最小接口。当一位长期被精准管理的患者在诊室里说“我受不了了，但我说不出来是哪里受不了”时，医生不需要立刻知道该怎么办，只需要先降低干扰的强度：暂时撤除所有非维持生命所必需的监测与评判，告诉患者，接下来只做一件事，保住你不用再害怕来见我这一个小时。分析步骤共五步：识别溃散，识别正在窒息自组织的外部压力源，撤出最上游的那一个，一个月后回访，只问“你有没有发展出任何一个我从来没有建议过你、甚至不会觉得是‘健康’的、却让你自己觉得还能继续下去的微小习惯”，有的话，保护它不被任何后续干预覆盖。章中同时为这条撤出设了底线：严重不良事件之后恢复的只是一次临时、可撤销的指尖血糖检测，作为安全网，而不恢复持续监测；若行为序列正把人推向不可逆的损伤或死亡，干预的义务并不免除。第三个接口把同一问法迁移到教育、管理与社会工作。

第九章的入口最简单，也最难执行：在你想不出还能为这个老人做什么的每一刻，先做一件只对这个独一无二的“她”做的事；在你为她启动任何一项技术管理操作之前，先用一句话、一个动作、一个停顿，让她，或者让那个由你与她共同构成的照护世界知道，她首先是一个人，其次才是一个服务对象。次序不能

颠倒。章中的红姐在“管好”与“护好”的撕扯中摸索出来的，就是这个次序。对于已经无法感知这一切的老人，这条准则的分量不落在老人的体验上，而落在照护行为的持续发生本身，落在那双每天仍然给她梳头的手上。

第四章没有出现在上面的列表里，因为它的入口是否定形式的：不去画一条正确的接引之路，而是标出接引最容易失败的三条死路。其一，“在交付算法信息之前先问一句你对自己身体的感受”这样的前置提问，一旦被塞进七分钟一位病人的门诊流程，成了电子病历里的必填字段，就会被流程掏空，病人被问了，却没有被聆听。其二，把风险信息“故事化返回”写进指南、培养成沟通话术，就把一个从具体医患关系里长出来的动作变成了可被脱嵌、质检的技能，脚本化的故事是替代者更隐蔽的变体。其三，“容许遗忘”一旦成为医嘱，就在提醒“你现在可以忘了”的那一刻让人重新记起，遗忘许可证成了遗忘的不可能条件。章中据此只提出一条最低限度的制度性原则：在精准医疗实践与研究方案的伦理审查中，独立纳入“叙事权影响评估”，它不自称能解决叙事替代，只让叙事替代不被系统性地忽略。这条否定的入口对其余八个入口都有提醒的作用：凡是被写成了流程、表格和考核指标的留白，都已经开始不再是留白。

◆ 三、共同的形式：留白而不替定

八个入口分处不同的场景，使用不同的术语，面对不同的专业人群，但把它们并排放在一起，可以看到一个反复出现的形状：它们都不是往现有系统里再添加一种内容，而是在系统里留出一个位置，并且阻止系统自己把它填上。交接班的那句话不要求记录，日程表上的空白不要求命名，说理评审不要求偏离必须成功，药物假期不要求病好了，飞地不要求被任何数据确认，溃散之后的回访只问有没有长出一个不是被建议出来的习惯，最后，对于一个什么也长不出来的人，照护者只是在一切操作之前，先让她知道她还是一个人。这个形状可以称为“留

白而不替定”：把本来要由系统给出的答案，换成一个空着的、被保护的位置，里面的东西由生命自己来给。

这种留白与“放任”不同，区别体现在至少四个地方。第一，留白有地方。它被限定在安全底线之上：第二章的三级风险响应，第七章的严格入选与高频监测，第五章对急救情境的排除，都把留白放在一个可以承受后果的范围里。第二，留白有期限和观察。药物假期是四到八周，伴随每周诊室测量与每日两次家庭自测；交接班的校验是每两周一次；溃散之后的回访是一个月。它们都不是撒手，而是以更细、更低强度的方式继续注意。第三，留白有被追问的责任。说理评审要求偏离者写下追踪点和回归条件，撤回要求预先定义撤出标准，“终身服用而不尝试撤出”也要在病历里写下理由。第四，留白保护的是已经出现的东西，不抢先赋予它意义。痕迹保护不把残迹转成服务契机，第八章只保护患者自己长出来的习惯，不拿一套更温和的剧本去覆盖它。

留白的反面是什么？不是放任，而是让位。放任是撤走注意，让位是保持注意而不抢答。第二章把这一点说得很清楚：有意识的不干预，前提是照护者确实注意到了老人的存在状态，并基于对这一状态的判断选择不采取行动，这是“看见之后的克制”；冷漠和疏忽则是“看不见的放弃”。从这个意义上说，不替定的照护比替定的照护要求更多：它要求护理员能准确描述老人此刻在做什么，要求医生写出偏离的推理，要求监测的频率在特定窗口里高于日常，要求照护者承担“万一判断错了”的恐惧，而不是用“一概干预”把恐惧转嫁给老人。

还有一个需要正视的问题：这些入口自己也会被吞没。第三章承认，说理评审可能被简化成四段安全措辞，评议会变成签字盖章的过场；第四章警告，任何接引方案的设计者语法都可能成为新的替代者；第二章指出，连“什么也不做”也会被吸收为一种效能工具，一旦“适当放空有助于提高创造力”，放空就不再是残迹，而是亮起来的、进入意义网络的时间管理；第一章则把交接班那句

话生效的条件设为不增加记录负担、不与绩效挂钩，等于预设了它一旦被写进表格和考核便会重蹈覆辙。所以本书给出的八个入口，没有一个可以当作成品照搬，每一个都带着一条自我怀疑的尾巴。第三章对此的态度值得借用：不承诺一个不会被异化的完美制度，而是在被完全殖民之前的窗口期里，尽可能多地留下后继者可以使用的认知资产，下一轮改革者将从“上一次通道是怎样被异化的”这个更精确的起点出发。

◆ 四、质疑：不替定是否意味着放任，意味着拒绝医疗？

对本书最直接的质疑是：这样的主张是不是在为放任辩护，进而是不是在暗示人们可以轻视甚至拒绝医疗。老人在无人过问的时刻跌倒怎么办？病人因为被告知“要相信自己的感觉”而拖延就医怎么办？医生被允许偏离指南之后，庸医会不会借机开脱？照护者本来就人手不足，再被要求“不填充”，会不会正好成了少做少错的借口？这些质疑不能绕开，本书的回答分几个层次。

首先，本书不否定精准医疗与照护技术的效力，也不主张拒绝医疗。第六章明确站在赫赛汀救了人的事实面前：那些活下来、能陪孩子读完小学的年岁，有重量，也有面孔，任何论述如果不先站在这些面孔面前，就是不负责任的。第七章肯定降压药、抗抑郁药与靶向抗癌药在当下“相对的、不可替代的救命价值”，在缺少更好手段之前，它们仍是必要工具，批评的是把它们拔高为“最终解决方案”的认知框架。第五章在急性感染、急诊手术等情境里，把外部代理定性为救援。第一章与第二章都为刚性需求，防跌倒、用药管理、基本营养，留出了正当的代理空间，严重认知功能障碍的老人在失去产生可解读痕迹的能力之后，需求模型是唯一现实可行的路径。凡有危险信号，任何一章都没有主张可以不去就医。

其次，不替定的要求有明确的层次，它不是“都不管”，而是“在该管的地方管得稳，在不必管的地方不抢先”。第二章把老人在不被命名的时间里的行为分为三个风险等级，只在最低风险层保持沉默，中风险层给予轻提示，高风险层立即响应；技术上，这只需要在现有监测系统里调整警报的触发阈值，让警报仅触发于生命体征异常、跌倒、走失等危险信号，而不触发于“久坐”或“社交频次偏低”。第一章的安全失败规则则规定，在无法辨别时，优先按抑郁响应流程启动最低程度的关怀，这样即便判断错了，也不会出现完全放任的后果。第二章那根随时可以拉紧的线也是一道兜底：老人随时可以通过语言、表情、手势发出“我需要你”的信号，而护理员必须有能力立即响应。

再次，责任的分配是质疑的核心，而本书各章在这点上相当自觉。第一章专门走过护理员的恐惧：如果把辨别生迹与退行的责任交给她，却不给她护具，她只会退回“一概干预”的安全姿态，那样生迹论不但没有化解失认，反而加剧了它；所以才需要团队的交叉校验和可被原谅的操作边界。第三章把偏离的责任从被动的合规检查转向主动的判断陈述，经过合格说理的偏离，即便结局不幸，也应被认定为已尽到合理的专业注意义务，并且防止通道变成庸医的挡箭牌：不负责任的医生若要走这条通道，要付出的认知成本远高于照抄指南。第五章则要求引入“撤出尝试的安全港”条款，让阶段性撤出的医生不必独自面对“你为什么不按指南走”的质疑。

最后，本书承认，这些入口与现行的经济激励之间存在实质的冲突，并不假装它们可以轻易落地。第五章写道，需要终身服用的药在商业上比需要三到五年逐步撤除的药更具可持续性，按服务项目付费的医保天然奖励持续用药而不是成功撤出，不需要为撤出承担举证责任的流程在管理上更“高效”，所以代管难以从内部打破；第二章同样承认，精准匹配范式本身就是在护理资源紧缺的压力下被逼出来的。本书的回答是有限的：在打破这些结构之前，先让被代管的东西有

一个名字，成为可以被讨论、被测量、被写入决策记录的对象；与此同时，把入口设计得足够小，使一个团队、一个科室、一位医生，不必等待整个体系的改革，也可以先在自己手边留出一块白。

◆ 五、各章之间的张力

前面汇列的入口并非天然相容。九章由同一条母题统摄，却面对不同的对象、在不同的层面立论，并排放在一起，有四处立场互相掣肘。本节不打算抹平，因为母题本身就预言了这种掣肘：撤回替定的任何动作，一旦被设计成指标、流程或方案，就有被收编为新一轮替定的危险（见第二章与第四章），所以凡是“不替定”的主张，落到手上时都要在“得做点什么”与“不能替人做”之间两头受力。下面逐对说明张力从何而来、处理方向与留待检验之处。

第一对在第五章与第六章之间。第五章为了给撤回代管找到依据，设想由心率变异性、昼夜节律斜率与经标准化量表测得的内感受敏锐度合成发生权指数，追踪同一患者的纵向变化，并把弹性指标的改善纳入撤出时机的考虑；第六章却论证，内感受判断力一旦被要求向体外数据缴纳担保，就会被降为劣后依据，因而要守住一块不可估值、不被数据征用的“我好了”。张力的来源是：要知道系统还剩多少自行裁决的能力，就得把这种能力变成读数，而变成读数正是估值。这在母题下无法避免，没有读数，撤回的时机只能凭善意去猜，那又回到替定；有了读数，读数又可能成为新的地址。处理方向是限定用途。第六章反对的并非测量本身，它自己就把心跳计数任务当作可立即执行的检验，它反对的是读数在裁决次序中排在当事人的感觉之前。指数因此只可用来问“是否该开始试着撤”，不可反过来宣布“你好了”或“你没好”，更不可变成要患者先达标才准自行判断的门槛。留待检验的有两点：被测量的人，其内感受是否因被测而改变；指数在临床上是否始终只作这一用，而没有悄悄变成评级。

第二对在第七章与第八章之间。第七章的药物假期要在四到八周里以远高于日常的频率监测血压变异，并记录主观体验；第八章则主张，对说出“受不了了”的长期被精准管理者，暂时撤除一切非维持生命所必需的监测与评判，蒋老师的转机出现在停掉持续血糖监测之后。同一个“监测”在两章里承担相反的功能：在第七章，它读取被药物掩盖的代偿结构，并观察系统是走向更有韧性还是逃向更脆弱；在第八章，它是窒息自组织的压力源，“走得对不对”只能留给事后追溯，事中一裁断，判准就退回标准。两者在母题下都是必然的，前者怕撒手变成放任，后者怕读数变成新剧本。处理方向是分对象、分期限、留底线：假期里的监测限于严格选入的患者并有时限，第八章撤的是已被监测窒息者的非必需部分，严重低血糖之后恢复的也只是一次临时、可撤销的指尖检测。须承认，第七章读取重组方向的监测并不中立，已带一点事中评判。留待检验的是：怎样事先分辨“需要被监测才敢松手”与“被监测窒息”的患者，两章没有统一标准；假期中患者对监测的主观体验（第七章本就要求记录）也许可作分流的线索。

第三对在第一章与第二章之间。第一章希望交接班时说出“哪个人和往常不太一样”，说一遍、听一遍，持续三个月以上形成非正式的集体记忆；第二章的痕迹保护则要求护理员看见了残迹，也不写进交班记录、不据此安排活动，在老人自己提起之前不把它拉到光线下。来源在于两层“看不见”深浅不同：生迹要被说出，照护者的感知力才能从失认中重建；残迹一经命名便变质为叙事素材，第二章还承认连保护本身也是一种命名。母题下无可回避，任何让人看见的办法，对更深一层都是一次填充的风险。处理方向是分层：第一章的入口只收粗粒度的感觉，不解释、不入档，第二章禁止的是看见之后的登记、解读与转化为方案；第一章自己也以一个从未上报的案例作为入口的灵感。留待检验：口头提起本身是否已使其变质，第二章认为注视就足以破坏，这只能靠它主张的长时段个案追踪来回答。

第四对在适用对象上。第一章把对象限于心智尚有余力的老人，明言严重认知功能障碍者已无法产生可解读的痕迹，需求模型是唯一可行的路径；第二章却说，对认知障碍重到破坏体验连续性的老人，留白的受益方主要不再是老人，而是对制度的约束，并以陈伯伯认知下降而小动作不减为例，说明残迹不与叙事能力绑定；第九章则把重心放在晚期失智，认为位子的分量不落在被感知，而落在照护行为的持续发生。后两章越过了第一章划的界，凭借的不是“老人仍有痕迹”，而是换了论证：从听见的义务，转到约束的义务，再转到承认的义务。母题下这是必然的，长不出推到尽头，可看的东西没有了，但替定的危险没有消失，只是从替他定好的样子变成替他定他是不是人。处理方向是把三章读作三种论证而非一种，需求模型在深度失智阶段仍是照护的内容，只是要在已被承认的位子上进行（第九章“先承认，后服务”）。留待检验：从“听生迹”转向“守位子”的分界线，各章没有给出标准；第九章提议的行为编码，即记录以在场者身份被称呼的频次，也许可以提供切口，但它自己承认这个概念作为下限，难以做增量检验。

四对张力有同一个形状：一边是必须有办法让生命的答案被听见，一边是任何办法都可能再次替定。它们不是等着尽快补上的漏洞，而是母题在实践层面的回声：凡想让生命自己开口的办法，都得与替定保持一段需要时时校准的距离。本书选择保留这四处张力，请读者在使用各章入口时带着它们。

◆ 六、回收书级证伪条件

导论提出的书级证伪条件，到这里可以对照全书再说一遍。如果撤回替定之后，生命没有出现一段可测的失序与自行重组期，而是能力如常；或在替定越精细的系统里，老人与病人的自我判断、自发行动并不更弱，则母题被推翻。全书的材料在这两个方向上给出的是什么呢？必须承认，全书给出的主要是机制的论

证、临床与田野的现象描述，以及各章提出的、尚待实施的检验设计，并没有哪一项研究已经把上述条件完整地跑过一遍。

所以本书所能说的是：证据的形状与母题的预言相合，但母题尚未被检验到足够严苛的程度。林女士的“我得看化验单才知道自己好不好”与“我好像已经忘了怎么生这个病了”，工程师吞药时那半秒钟的迟疑，周阿姨“日子像别人替我过的”，在叙述层面符合第二个方向的预言，第七章中β受体阻滞剂的初始恶化、药物治疗中靶心的逃逸，则在机制层面可与第一个方向的“失序期”相类比；但个案的契合并不等于检验。各章设计的检验，诸如交接班一句话的长程随访，无症状预警与症状后检测的叙事密度比较，发生权指数的纵向追踪与停药后的保留程度比较，隐蔽给药下的代偿观察，都还停留在设计阶段。严格的检验需要有人去做，而且做的时候要保持对安全底线的尊重。

还需要强调两点。其一，母题的失败有可能在局部发生而不影响整体。例如，某个特定人群或某种特定疾病中，撤回之后确实没有失序，那更可能说明那里的替定尚未深到占住能力的程度，或那里的疾病属于松耦合、靶心近似独立的类型，第七章已经为这样的区域划出了边界。其二，书级条件并不要求每一次撤回都成功。撤回之后复发、失败，恰恰在母题的预言之内，因为“失序”本来就是预言的一部分。会推翻母题的，是撤回之后生命毫发无损，或者替定的精细程度与能力的强弱毫无关系。

◆ 七、边界与未竟问题

本书的边界首先是材料的边界。全书所据是九篇论文与一份手册，案例中有一部分是复合型构造，田野材料不构成系统性的实证数据，一些关键机制，如内感受敏锐度在长期外部警报下的退化，目前主要是论证与假说，等待前瞻性研究的检验。本书在养老与精准医疗两个场景里展开，对教育、管理与社会工作的外

推，只在第八章指出了一个接口，没有展开，把它们当作已经被证明的结论是不恰当的。同样，第一章把失认论的主要对象限定为心智尚有余力的老人，第二章延伸到认知障碍严重到破坏体验连续性的老人，第九章延伸到晚期失智，延伸所凭的论证各不相同，见第五节；医疗部分针对的是慢性、功能性、致密耦合的疾病，不适用于急性期和松耦合的疾病，这些边界前面已经反复交代。

其次是本书自身的方法限制。第五章的附记指出，一个反对把生命系统过度结构化的论证，自己不得不使用高度结构化的框架和精确划定边界的术语网络，这个矛盾不是虚伪，而是任何讨论“发生”的学术写作都必须承受的张力。第六章则提醒，概念的锋利会带来智识上的愉悦，而这种愉悦可能让读者忘记那位工程师在冬天某个早晨花三十秒审查自己空腹感受时的具体、缓慢、没有名字的艰难。本书同样如此：“替定”“留白”这样的概括，只有在回到窗前的老人和诊室里的林女士时才有分量。至于章与章之间尚待协调的立场，已在第五节逐对说明，此处不再重复。

还有一些问题，本书没有回答，也不应在结语里假装回答。如果失认已经沉淀到照护者集体的感知器官里，重建感知的条件是什么？第一章只指出了需要从照护者的培养体系根基处重建，没有展开。第四章里，叙事替代也可能暴露了旧叙事的脆弱，客观上成为新叙事的刺激物，如何在承认这一点的前提下仍然批评替代，是一个悬而未决的问题。第五章里，撤回如果不是归还失物，而是一次风险更高的共同摸索，那么谁来承担这段摸索的成本，在没有基因检测、没有任何精准医疗服务的人群里是否同样成立，第六章中那位“固守在次级抵押区”的人给出了一个提示，但远未展开。这些问题，需要更多的人在各自的现场里去看、去试、去修正。

回到那条走廊。这位老人仍坐在窗前，护理员仍会走过去问：“您需要什么吗？”这个问题没有错，需要被改变的不是这句话，而是它之前和之后的东西：

在它之前，交接班时有人问过“今天有没有谁和往常不太一样”；在它之后，记录表上的空白不再被自动闭合，而是允许继续是空白；在更远的地方，当这位老人有一天什么也说不出、什么也做不成时，会有人在做每一项操作之前，先用一句话、一个动作、一个停顿，让她知道，她首先是一个人，其次才是一个服务对象。“不替定的照护何以可能”，本书的回答是：它靠的不是更多的善意，也不是更精的技术，而是在善意与技术都足够好的时候，仍然愿意把一个位置留给生命自己，并且愿意为这份留白承担它的代价。

附录

身体暗能力的日常养护

本附录把全书的母题落到一个人的日常里。正文各章讨论的是照护者、医生和制度怎样在善意与精准中抢先替生命定下“好”的样子；同样的结构也发生在每个人自己与自己身体的关系之中。健康越被数据化、越被优化，人就越容易接受一套外部的标准先替自己定了“好”是什么：步数、睡眠分数、心率区间、体脂、各项指标的参考范围。这些数字有用，本附录不会让读者去怀疑它们。问题在于，当所有注意力都用来趋近那些可以被衡量的目标时，一种更安静的能力得不到生长的机会，这就是在没有标准答案、甚至应用和专家都说不清的地方，仍能近乎本能地知道自己的身体需要什么、什么对自己合适的判断直觉。它的萎缩与正文里林女士的处境同出一辙：“那会儿我知道自己哪里不好。现在，我得看化验单才知道自己好不好。”下文据一份实践手册改写，保留其分诊、机制与操作，并把它与全书的概念接上，读者可以把它当作一份给自己用的练习说明。

（说明：本附录以作者的实践手册《养护身体的暗能力》为底稿改写。手册原文只给出分诊三问与三个做法的要点；各做法下的分步操作、几处安全边界的表述与第六节的三个疑问，是统稿时增补的，其中一部分采自手册发表时所附评述中的建议，已改写并入。）

◆ 一、前提：这不是让你少看医生

在讲任何方法之前，必须先把一个前提说死：本附录不轻视专业医疗，也不贬低有用的工具，它谈的是怎样养成对自己身体的判断直觉，而不是拒绝必要的照护。危险信号仍须就医。对于有明确症状或既有疾病的人，指标与专业意见优

先；对于正在管理血糖、血压，或处于术后康复期的人，“少看数据”这类建议可能是危险的，哪些指标属于不可协商的监测项，应当听从医生的安排，不能由本附录的任何一句话来改写。本附录能说的只是：在医生要求你测量的事情之外、在测量与测量之间的漫长时间里、在没有任何指标可看的那些说不清的状态中，你能不能保有一份属于自己的判断。这条界线与正文是一致的：全书没有一章主张拒绝医疗，主张的只是不让医疗的答案占住本该由生命自己给出答案的位置。

◆ 二、两种能力：明能力与暗能力

在照顾自己身体这件事上，人有两种截然不同的能力。第一种叫明能力，是那些可以被清楚衡量、清楚评分的健康技能：照着协议去执行，把各项指标做达标，按标准建议去操作。它很重要，也很容易被训练和奖励。第二种叫暗能力，是一套只有在特定条件下才能养成的身体判断直觉：当一个人在长期不被数据评价、不被优化打分的状态里，安静地、沉浸地与自己的身体相处得足够久，会自然生出一种稳定的直觉，让他在没有标准答案的地方，知道自己的身体需要什么。它是面对身体里那些说不清的处境时，一个人最终依靠的东西，也是健康的底盘。

两者的关系对应着正文里的两种地址。明能力住在指标、协议与标准建议这些系统预留的地址上；暗能力住在正文各章反复指认的那片地方：老人没有地址的生迹，身体“被抽空了一样”的累，没有任何仪器确认的“我好了”。暗能力有一个致命的养成条件，叫做不被评价的时间生态：一段安静地、沉浸地与身体相处，却不被数据打分、不被优化评价、不必立刻趋近某个标准的时间。它在优化的账本上是零产出，却是暗能力唯一的土壤。

◆ 三、第一步：分诊三问

先判断自己现在养的是哪一种。下面三个问题可以一次问完，也可以分几天慢慢回答，答案不必告诉任何人。问题一：我是只擅长“照着标准把指标做达标”，还是在“没有标准答案时也懂自己的身体需要什么”？不妨回想最近一次睡不好、累得说不清原因、胃里不太舒服的时候，你是怎样判断下一步该怎么办的。问题二：一旦离开明确的指标和协议，进入一个说不清的身体状态，我是完全无所适从、必须马上找一个外部答案，还是能凭直觉感知自己该怎么办？这里的关键词是“完全”和“必须马上”，偶尔去查一查、问一问并不构成问题。问题三：我有没有一块安静地、沉浸地与身体相处、不被数据打分的时间，还是所有的注意力都被用来趋近可衡量的指标了？

如果答案指向“只精于趋近标准指标，一到无标准处就无所适从，没有不被评价的时间”，就说明明能力在膨胀，暗能力在萎缩，需要守住那块时间生态。这三问并不是在给读者判分。它们的作用与第一章交接班里那句“今天有没有哪个瞬间，你觉得哪个人和往常不太一样”相似，是给一种本来无处安放的感觉一个可以被说出来的语言容器。

◆ 四、第二步：看清暗能力是怎样被挤掉的

暗能力被挤掉的过程可以拆成三个环节，三个环节还会互相加固。第一，暗能力只能在不被评价的时间里养成。对身体的判断直觉无法靠盯数据、靠执行协议养出来，数据与评价一旦持续介入，那种安静的、感受性的相处就变了味，暗能力就长不出来。这与正文第二章对残迹的论证一脉相承：当“什么也不做”被赋予一个功效式的解释，例如“适当放空有助于提高创造力”，它就不再是残迹，而成了意义网络里的一项时间管理。

第二，“健康明能力通胀”在系统性地挤掉这块时间。健康越来越被数据化、被优化、被无处不在的指标衡量，人为了“做得更好”，不得不把越来越多的注意力投入到可以被精确衡量的东西上：盯更多的数据，追更多的指标，把每一刻都用来趋近那个可衡量的最优。于是安静地与身体相处的时间，被这场优化的军备竞赛一点点挤没了。第三，它让人越来越依赖外部，越来越听不见自己。越依赖数据和指标，对自己身体的直觉就越萎缩；直觉越萎缩，就越只能依赖数据和指标。一个人在健康上因此越来越只会执行外部的标准答案，越来越听不见、也信不过自己的身体。结果是一种熟悉的悖论：各项指标都达标，明能力顶尖，却越来越不懂自己的身体，精于趋近标准，拙于在无标准处感知自己。

这个循环，就是正文里“长不出”那一步在个人层面上的样子，每一环单看都是合理的，合起来却让人离自己的身体越来越远。第六章把它说成向体外数据缴纳抵押：以内感受判断力为担保，换取一份“数据告诉我我目前是安全的”的协议，每一次交利息，都在耗损那份不需要外界证明的信任。看清这个循环，才知道养护暗能力需要有意识地逆着“一切都要被数据衡量”的趋势，为自己护住一块和身体安静相处、不被评价的时间。

◆ 五、第三步：守住不被评价的时间生态

养护暗能力，不是再增加一种健康数据，而是逆着优化的趋势，为自己守住一块安静地与身体相处、不被评价的时间生态。下面是三个做法，按重要性排序，每个都附上可以马上开始的操作。需要先记住的只有一句话：把力气从“再多追一个可衡量的健康指标”，转向“为自己护住那块和身体安静相处的时间”，让暗能力这副底盘有机会长出来。

做法一：护出一块安静地和身体相处、不被数据打分的时间。 有意地为自己护出一段时间，在这段时间里安静地感受自己的身体，留意它的状态和需要，

不看任何数据，不做任何优化评价，不必趋近任何标准。具体可以这样做：第一步，每周先固定一个时段，把手环、体重秤和各种应用都放到视线之外，不看步数，不看心率，不称重；第二步，在这段时间里只做一件事，凭体感决定今天动多少、吃多少、什么时候该停，不需要记录；第三步，结束之后不要复盘，不要把这次的感受折算成任何分数。频次比强度重要。这段时间在账本上是“没在为健康做什么”，但它正是暗能力唯一的养成地。

做法二：多在没有标准答案的身体处境里，练习凭直觉判断。 暗能力养成于面对无标准处境的判断，所以要在这些处境里练习相信自己。在安全的范围内，当遇到一个说不清、没有明确标准答案的身体状态时，先不急着找一个外部答案，而是试着凭自己对身体的感受判断该怎么办，一次次练习那种本能的身体判断。操作上可以用三步：先用一两句话把此刻的感觉写下来（设想有人写下“下午三点之后头发沉，不想动，但并不疼”）；再说出自己倾向于怎么办，是休息、吃点东西还是出去走走；然后照做，隔一段时间看看这个判断帮没帮上忙。重要的是，这是在没有危险信号、没有明确症状的状态里练习。凡是出现了危险信号，就不再是练习的范围，该就医就就医。对于需要定期测量指标的慢病与康复期的人，一个可以与临床要求并存的做法是：指标照看，但可以与医生商量调整频率与呈现方式，并在两次测量之间刻意练习不借助仪器的判断，等读数出来之后，再把读数与先前的感觉对一对。

做法三：抵抗把身体的一切都拉进数据评价的冲动。 暗能力最大的敌人，是“一切都要被数据衡量、被优化”的冲动。有意识地抵抗它，意味着不把与身体有关的每一件事都换算成数据、指标和优化，允许一些时刻就是纯粹地感受身体，不接受任何数据的评价。可以给自己划几块“数据的禁区”，比如睡前不看睡眠分数，早上醒来先问自己“我觉得怎么样”，再决定要不要看昨晚的记录；

散步的时候不开计步，运动之后先说一句“我今天觉得如何”，再看手表怎么说。守住这些禁区，就是守住暗能力的土壤。

这三个做法还有一个在家庭和行业里同样适用的版本，它们说明暗能力的养护并不只是个人的事。对身边有人需要照顾的家人，可以像第二章所说的那样，在安全底线之上不过问，不把对方的每一次发呆、每一次静坐都解读为需要处理的信号，也不替对方把一天排满。对做健身与营养指导的从业者，可以把“教会客户不再依赖你”写进服务目标，因为长期以外部计量替代客户自身的判断，会稳定地削弱他离开你之后的能力。

◆ 六、三个常见的疑问

读者在开始练习之前，常会遇到几个相似的疑问，这里一并回答。第一个疑问是：数据让我安心，为什么要放下？数据本身没有问题，附录也不要求任何人扔掉手环。问题在于，当“安心”只能从数据里来时，一旦数据缺席、含糊或者与感受不一致，人就只剩下焦虑；而这种只能被外部确认的安心，正是第六章所说的“抵押”。守出一块不看数据的时间，并不是要放弃安心，而是让安心多一个不依赖仪器的来源。第二个疑问是：我已经很久没有留意过身体的声音了，还来得及吗？第五章提醒过，撤回替定不是归还失物，那个回得去的原初状态并不存在。暗能力也一样，不要指望它一周内变得灵敏。开始的时候，身体的回答常常是含糊的，甚至干脆没有回答，这是正常的，这段时间需要的是耐心，而不是更多的方法。

第三个疑问是：我的直觉会不会出错？会。直觉不是权威，它是众多信息里的一个参与者。在没有危险信号的范围内，一个判断出错的代价通常很小，多睡一小时或少练一次，而练习的目的恰恰是在这些低代价的地方积累对自己身体的了解。出现危险信号，或者直觉与明确的医嘱相冲突时，应当以专业意见为准。

更合适的关系是互相校对：先让自己的感觉说一句，再看读数怎么说，两者一致时多一分把握，两者不一致时，那个差距本身就是值得留意的信息，也可以带给医生。

◆ 七、身体现场的工具箱与四个误区

把上面的内容压缩成四件可以随身携带的小工具。其一，“护出和身体安静相处的时间”：一块不看数据、不做优化、只是感受身体的时间。其二，“在无标准处练习凭直觉”：遇到说不清的身体状态，先凭自己的感受判断，练习本能的身体判断，危险信号就医。其三，“设数据的禁区”：有些时刻纯粹地感受身体，不接受任何数据的评价。其四，“珍视对自己身体的直觉”：重视并信任自己在无标准处对身体的判断，而不是只认数据。

在实践中，有四个误区需要避开。误区一，以为指标达标就等于懂自己的身体。明能力只是能被衡量的那部分，只追指标会养出一个数据达标却听不见自己身体的人。误区二，以为暗能力也能靠盯数据养出来。它只能在安静地与身体相处、不被评价的时间里自然养成，用数据和评价去“养”它，那种感受性的相处就变了味。误区三，把安静地和身体相处的时间当作“没在为健康做什么”而挤掉。这块时间在优化账本上是零产出，却是暗能力唯一的土壤，挤掉它就挤掉了健康的底盘。误区四，随大流地卷入健康优化的通胀，不为暗能力护出空间。“一切都要被数据衡量”是一个强大的趋势，不有意识地逆着它护住不被评价的时间，暗能力就会被挤没。

◆ 八、一张随身清单

面对自己与身体的关系，可以问自己这六个问题，把它们变成习惯。一，我是只精于“照标准把指标做达标”，还是在“没有标准答案时也懂自己的身体需要什么”？二，一进入说不清的身体状态，我是完全无所适从、必须找外部答

案，还是能凭直觉感知该怎么办？三，我有没有一块安静地与身体相处、不被数据打分的时间？四，我有没有为自己护出那块不被评价的时间，哪怕它“没在为健康做什么”？五，我有没有在无标准处练习相信自己对身体的直觉（在安全范围内）？六，我是不是随大流地把注意力都投进了可衡量的指标，没为暗能力护出空间？这六问不需要每天回答，在换了新设备、拿到一份新的检测报告，或者发现自己一天看了很多遍数字的时候，回答一次就够了。

◆ 九、回到全书

读到这里，可以看到这份手册与全书之间的关系。正文里，替定是由外部系统施行的：需求清单、指南路径、算法叙事、风险评分。到了个人日常，替定常常是自己对自己做的：人把别人给的“好”的标准内化，然后用它去替自己的身体先下判断。第六章里那位软件工程师的迟疑，第五章里林女士的“我得看化验单才知道自己好不好”，都是这种内化的结果。本附录给出的做法也没有指望一次性地翻转它，只是在每天里为不被评价的时间留一块地方，让身体有机会先开口，哪怕它说得含糊。

最后重申开头的前提：本附录不轻视医疗和数据，它们有用处，有些时候是救命的。它想反复提醒的是一件最深、也最容易被忽略的事：一个人照顾好自己的底盘，是那副在没有标准答案处仍能感知自己身体的暗能力；它只能在安静地与身体相处、不被评价的时间生态里养成，而这块生态，正被健康优化的通胀系统性地挤掉。你能为自己做的最深的事，不是把可衡量的指标追得更极致，而是逆着这个强大的趋势，为自己守住那块可以让暗能力慢慢长出来的、不被评价的时间。危险信号仍须就医。

版本说明

本版字数、版本与交付

本版是德麦国际专著第 538 号《被照顾得很好之后——精准的善意怎样替生命先定了答案》的初版，2026 年 11 月第 1 版。ISBN 979-8-90690-989-3，定价 US$20.00。

本版正文（前言、导论、编序、九章与结语）实计 195,753 个汉字，约 19.6 万字；章题、节题、表格、参考文献与附录不计入。

本书同时是一个出版单元：全文阅读、九个学习单元（每章一个）、专属智能体的问对。

全书经三审：一审逐章对照原论文核对论证与事实，删去原文没有的事实性内容，补回遗漏的切割与证伪条件；二审统一文字、标点、术语与体例；三审做全书终审，处理各章之间的张力并统稿复核。三审都由同一底座的 AI 完成，只能查错，不算独立评审。

今后若因证伪条件的执行结果或读者指出的错误而改动主张，新版会附一份说明，逐条列出哪些章节的判断因此改变。

全 书 母 题

精准的善意抢先替生命定下“好”的样子；替得越久，生命越长不出自己的答案。

养老院的窗前，一位老人被问到近况时说：“挺好的，什么都不缺。就是……感觉日子像别人替我过的。”风湿科的诊室里，一位指标早已达标的病人说：“现在，我得看化验单才知道自己好不好。”没有人做错什么，照护周到，治疗合乎指南，可他们身上有某种东西悄悄不见了。

这本书的回答是：精准的善意看不见生命自己正在给出的答案，于是抢先替它定下了“好”的样子；替得越久，生命越长不出自己的答案。三编九章，从老人的生迹与残迹、身体的代偿，到算法叙事、发生权代管、健康抵押，再到致密纠缠、溃散后的自组织，最后回到一位什么都长不出来的失智老人：照护最后要守住的，是不替他把“人的位子”也定掉。

这是一部研究性专著初版：由作者九篇论文与一篇实践手册重写，正文由 AI（Claude）协作撰写，没有经过独立学术评审。各章的证伪条件都写成了可观察的情形，尚未执行；书中现场凡属合成或构造，均已注明。

不替定，不是放手不管：是把答案的位置，留给生命自己。

德麦国际出版社 · Demai International Press
德麦国际专著第 538 号 · 三编九章 · 约 20 万字
ISBN 979-8-90690-989-3 · 定价 US$20.00

ISBN 979-8-90690-989-3
9 798906 909893